פרוטוקולים לאישור

חוברת בקרה — כל הפרוטוקולים, ההחלטות והתרופות

טיוטה לבדיקה. טרם אושר ע"י הייעוץ המשפטי וניהול סיכונים. לא לשימוש בפועל.

פרוטוקולי תרופות (מערכות)	13
פריטי תרופות	365
שמות מסחריים	1264
מתאים / בתנאים / הכנה לרופא/ה / רופא בלבד	136 / 191 / 7 / 31
מעקב מעבדה צמוד	49
פרוטוקולים נוספים	אישורים (13) · פניות דיגיטליות (13) · חיסונים (6)
הופק	04.11.2026 · מתוך הכלי שפורסם (asseoy.github.io/medical_aids/protocols-rofan.html)

ד"ר יונתן אסיאו · asseo_y@mac.org.il

תוכן העניינים

#	פרק	פריטים	עמוד פתיחה	רשימה לסימון	פירוט מלא
0	עקרונות כלליים		**3**		
	רשימה מרוכזת: רופא/ה בלבד	**31**	**5**		
1	**לב וכלי דם**	**74**	**8**	**12**	**15**
2	**סוכרת ואנדוקרינולוגיה**	**50**	**101**	**104**	**106**
3	**נשימה ואלרגיה**	**28**	**153**	**154**	**156**
4	**נוירולוגיה**	**45**	**183**	**184**	**187**
5	**פסיכיאטריה**	**57**	**229**	**230**	**233**
6	**עיכול וכבד**	**20**	**288**	**289**	**291**
7	**כליות ודרכי שתן**	**22**	**307**	**308**	**309**
8	**בריאות האישה**	**15**	**327**	**327**	**329**
9	**שלד, מפרקים וכאב**	**20**	**344**	**345**	**347**
10	**דם ויטמינים**	**7**	**365**	**366**	**367**
11	**עיניים ועור**	**9**	**373**	**374**	**375**
12	**חיסון, זיהומים ומומחים**	**13**	**382**	**383**	**385**
13	**תרופות שאינן כרוניות**	**5**	**395**	**396**	**397**
14	**אישורים**	**13**	**401**	**402**	**404**
15	**פניות דיגיטליות**	**13**	**410**	**411**	**412**
16	**חיסונים**	**6**	**417**	**417**	**418**

בכל פרק: א. כללים · ב. תוצאות (באישורים ובפניות) · ג. בדיקות משותפות · ד. החלטות · ה. רשימה לסימון · ו. פירוט מלא של כל פריט עם משבצת אישור.

0. עקרונות כלליים

מה הכלי עושה

סטודנט/ית לרפואה המסייע/ת לרופא/ה (רפואן) מחדש/ת מרשמים כרוניים, מפיק/ה אישורים ועונה לפניות מקוונות לפי רשימת בדיקות קבועה לכל פריט. אין שיחה עם המטופל/ת בחידוש מרשם; הבדיקה מתבססת על הרשומה, הבדיקות והרכישות. הרפואן לא משנה מינון ולא מחליף תרופה.

שלושה מסלולים בחידוש מרשם

מצב	תוצאה	פעולה
כל הבדיקות תקינות	חידוש ל-3 חודשים (קלוזפין: חודש)	—
חסרה מדידה, בדיקה או ביקורת שנתית	חידוש לחודש אחד	זימון למרפאה להשלמה
ערך חריג (מעל סף ההחזרה)	חידוש לחודש אחד	הודעה לרופא/ה
התווית נגד או ערך חמור	לא מחדשים	הודעה לרופא/ה
התראת אינטראקציה, אי-התאמה בכמות, ביחידות או בתדירות, או בקשה מוקדמת בתרופה ממכרת	לא מחדשים עדיין	ממתין לתשובת הרופא/ה

אין התווית נגד ← תמיד מחדשים לפחות לחודש אחד, כדי לא להפסיק טיפול. ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה פעם בשנה (אין ביקור: חידוש לחודש, זימון והודעה לרופא/ה); עד 3 חידושים רצופים ואז ביקור רופא, ובחידוש השלישי הודעה למטופל/ת שמומלצת ביקורת שנתית; רכישות 80% מהימים ומעלה ב-6 החודשים האחרונים.

סימונים

מתאים מתאים לרפואן · בתנאים רק טיפול כרוני במינון קבוע (ותנאים נוספים לפי התרופה) · הכנה לאישור רופא/ה הרפואן בודק ומכין, הרופא/ה מאשר/ת (אופיואידים, בנזודיאזפינים, תרופות שאינן כרוניות) · רופא/ה בלבד חידוש ע"י רופא/ה בלבד — הכלי מציג הודעה ולא רשימת בדיקות · מעקב מעבדה צמוד (⚗) תרופה עם בדיקות תכופות.

תרופות עם כמה התוויות

חוסמי בטא, מעכבי ACE ו-ARB בודדים, MRA, אנטרסטו, פוסיד, פורקסיגה, ג'רדיאנס, אוזמפיק/וגובי ומונג'רו: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות (טווח בטיחות ל"ד במקום יעד; בלי HbA1c). יעד הטיפול נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת.

תפקוד כליות לא תקין

כשפריט תפקוד הכליות לא תקין, הרפואן רושם ערכי eGFR קודמים וסימון אם יש אבחנה של אי-ספיקת כליות כרונית, והם עוברים בהודעה לרופא/ה.

טקסט התיעוד

כותרת הפרוטוקול · "בוצע ע"י סטודנט/ית לרפואה המסייע/ת לרופא/ה" · הפריט · מה נבדק ותקין ומה לא · התוצאה · מה הועבר למטופל/ת · מה הועבר לרופא/ה.

הנחיות כלליות לעבודה (ספר החפיפה, החלטות 3.11.2026)

⚠ תוצאות בדיקה שקופצות בפתיחת התיק: לא ללחוץ "אשר" — לחיצה עליו רושמת שהרופא/ה עבר/ה על התוצאות. ללחוץ רק "הפסק וסגור", להשוות לבדיקות קודמות ולדווח לרופא/ה.

סדר עבודה

- משימות מזכירה קודם, ולסיים אותן באותו יום. פניות דיגיטליות — תוך 8 ימים.
- לפני סגירת תיק במשימת מזכירה: לרשום את מספר תעודת הזהות (המשימה עלולה להימחק בסגירה).
- בתור הדיגיטלי: קודם אישורים, אחר כך תרופות, ואחר כך כל השאר.

תוצאות בדיקות

- תוצאות בדיקה שקופצות בפתיחת התיק: לא ללחוץ "אשר" — לחיצה עליו רושמת שהרופא/ה עבר/ה על התוצאות. ללחוץ רק "הפסק וסגור", להשוות לבדיקות קודמות ולדווח לרופא/ה.
- מטופל/ת שמבקש/ת משוב על תוצאות: הרפואן לא עונה. מסכם/ת את התוצאות עם השוואה לקודמות ומעביר/ה לרופא/ה.

כמות, יחידות ותדירות

- OP = כמות אריזות (2 = 2OP בקבוקים או אריזות).
- לבדוק mg מול mcg.
- יש תרופות שניתנות פעם בשבוע או פעם בחודש (מתוטרקסט, אוזמפיק, אלנדרונט) — לוודא את התדירות.

מרשם בכתב יד

- בקשה להמרת מרשם שנכתב בכתב יד: מציגים לרופא/ה לפענוח. לא מפענחים ולא מקלידים לבד.

אינטראקציות

- כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות ותיקות: החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.

אישורי תרופות

- בקשה לאישור תרופה (מחלקת אישורי תרופות במכבי) היא לא מרשם. הרפואן מכין את הבקשה ומציג לרופא/ה.

הסרת תרופה מהקבועות

- לבקשת המטופל/ת — רק אחרי אישור הרופא/ה, עם הסיבה שכתב/ה המטופל/ת.

אירועים משמעותיים ואבחנות חדשות

- אשפוז חד, פטירה במשפחה, אבחנה חדשה מבית חולים או מרופא/ה יועץ/ת: מציגים לרופא/ה.
- הרופא/ה מחליט/ה מה נכנס לתיק. הרפואן לא משנה את רשימת האבחנות.

סימני טעות

- מטופל/ת שטוען/ת שלא קיבל/ה, או פונה שוב ושוב באותו נושא: עוצרים, מסכמים את ההשתלשלות ומציגים לרופא/ה.

בדיקות מעבדה

- רק בדיקות שגרה: מעקב אחרי מחלה כרונית, או בדיקה תקופתית כל שנה עד שלוש שנים לאדם בריא.
- בקשה בגלל תסמין: לא מפיקים בדיקות. המטופל/ת מוזמן/ת קודם לרופא/ה.
- בדיקה שהמערכת חוסמת, או שם בדיקה לא ברור: לרופא/ה. שואלים, לא מנחשים.

הפניות לרופא/ה יועץ/ת

- אפשר: חידוש מעקב קבוע, או הפניה שהומלצה בכתב ע"י יועץ/ת או בית חולים — לציין את המסמך.
- הפניה חדשה, או בגלל תסמין: לרופא/ה.

בדיקות סקר

- ממוגרפיה ודם סמוי בצואה לזכאים לפי גיל בתוכנית הלאומית: אפשר להפיק.
- קולונוסקופיה בגלל סיפור משפחתי, ובדיקת BRCA: לרופא/ה.

דימות

- רק חידוש של מעקב שגרתי שכבר תוכנן בכתב. דימות חדש: לרופא/ה.

הפניות אחרות

- פיזיותרפיה, פסיכולוג/ית, אביזרים רפואיים, אחיות: חידוש של מה שכבר פעיל ומתועד. בקשה חדשה: לרופא/ה.
- כל עניין של מוקד או מיון: לרופא/ה מיד.

מקורות

ערכים שאין להם הנחיה בפרויקט מסומנים "החלטה מקומית (הצעה)" ומחכים לאישור. שמות מסחריים: מאגר התרופות של משרד הבריאות (קובץ 7.10.2026).

רשימה מרוכזת: תרופות שמחודשות ע"י רופא/ה בלבד (31)

בתרופות אלה הכלי לא מציג רשימת בדיקות: מוצגת הודעה, והבקשה עוברת לרופא/ה (או למומחה/ית). הסיבות: סם מסוכן, תרופה טרטוגנית במעקב מומחה, טיפול שנקבע ומנוטר ע"י מרכז מומחה, או החלטה מקומית. כל פריט מופיע גם בפרק המערכת שלו (המספר בעמודה הראשונה).

#	מערכת	תרופה / קבוצה	שמות מסחריים	ההודעה בכלי	אושר
1.62	לב וכלי דם	**תרופות לב במעקב מומחה** Cardiology specialist drugs	טפמידקס | טאפיס | וינדמקס | וינדאקל | אטרובי | קמזיוס	טפמידיס ומבקמטן נקבעים ע"י קרדיולוג/ית מומחה/ית (מבקמטן מחייב אקו לב). להעביר לרופא/ה.	☐
1.68	לב וכלי דם	**הפרינים במשקל מולקולרי נמוך** Low-molecular-weight heparins	קלקסן | קרוסיה | קרוסיה פורטה | אנוקספרין קמהדע | אנוקספרין קמהדע פורטה | אנוקספרין לדרקסן | פרגמין | אריקסטרה	נוגד קרישה בזריקה: מינון לפי משקל וכליות, משך לפי ההתוויה. חידוש ע"י רופא/ה בלבד.	☐
2.42	סוכרת ואנדוקרינולוגיה	**הורמון גדילה** Growth hormone	גנוטרופין | נורדיטרופין | אנג'נלה	הורמון גדילה נקבע ע"י אנדוקרינולוג/ית (לרוב ילדים). להעביר לרופא/ה.	☐
2.44	סוכרת ואנדוקרינולוגיה	**פנטרמין** Phentermine	רזין	פנטרמין הוא ממריץ (סם מסוכן), לטווח קצר. חידוש ע"י רופא/ה בלבד.	☐
2.45	סוכרת ואנדוקרינולוגיה	**אנלוגים לסומטוסטטין ופגויזומנט** Somatostatin analogues / pegvisomant	אוקטראוסטט | אוקטריאוטייד בנדליס | אולתוטון | סנדוסטטין | סנדוסטטין לאר | לנראותיד תרו | סומטולין אוטוג'ל | סומאברט | סיגניפור לאר	נקבעים ע"י אנדוקרינולוג/ית או אונקולוג/ית. להעביר לרופא/ה.	☐
3.27	נשימה ואלרגיה	**תרופות ליל"ד ריאתי ולפיברוזיס ריאתי** Pulmonary hypertension / IPF drugs	בוסנטן תרו | בוסנטן טבע | טרקליר | אמבריסנטן אס.קיי. | אמבריסנטן טבע | סנטאבניר | ווליבריס | מאציטנטן טבע | אופסומיט | אדמפאס | אפטרבי | רימודולין … (+19)	יל"ד ריאתי ופיברוזיס ריאתי מטופלים ע"י מרכז מומחה (מעקב תפקודי כבד). להעביר לרופא/ה.	☐
3.28	נשימה ואלרגיה	**תרופות לסיסטיק פיברוזיס** Cystic fibrosis modulators	אליפטרק | קליידקו | אורקמבי | סימדקו | טריקפטה	תרופות לסיסטיק פיברוזיס נקבעות ע"י מרכז CF. להעביר לרופא/ה.	☐
4.36	נוירולוגיה	**תרופות להפרעות תנועה במעקב מומחה** Specialist movement-disorder drugs	אפו-גו | אפו-גו פן | קסנזין | אוסטדו	אפומורפין, טטרבנזין ודאוטטרבנזין נקבעים ע"י נוירולוג/ית (טטרבנזין: דיכאון ומחשבות אובדניות). להעביר לרופא/ה.	☐
4.37	נוירולוגיה	**תרופות לאפילפסיה במעקב מומחה** Specialist epilepsy drugs	אינובלון טבליות | רופינאמיד - תרימה | אוספולוט | פינטפלה | אפידיולקס | סטיבקס	רופינאמיד, סולתיאם, קנבידיול ופנפלורמין נקבעים ע"י מרכז אפילפסיה (פנפלורמין: אקו לב). להעביר לרופא/ה.	☐
4.38	נוירולוגיה	**תרופות לנרקולפסיה** Narcolepsy drugs	וואקיקס | סנוסי	פיטוליסנט וסולריאמפטול נקבעים ע"י מרפאת שינה (ל"ד, מצב נפשי). חידוש ע"י רופא/ה בלבד.	☐
4.42	נוירולוגיה	**תרופות לטרשת נפוצה** Multiple sclerosis drugs	דיפומר אס.קיי.120 מ"ג | דימתיל פומרט דקסל | דימתיל פומרט מדומי | דימתיל פומרט תרו | דימתיל פומרט טבע | וומריטי | פינגולימוד - תרימה | פינגולימוד טבע | פינולים | גילניה | זפוסיה | מייזנט … (+15)	תרופות לטרשת נפוצה נקבעות ומנוטרות ע"י הנוירולוג/ית (מרכז MS). להעביר לרופא/ה.	☐
5.35	פסיכיאטריה	**מודפיניל / ארמודפיניל** Modafinil / armodafinil	פרוויג'יל | מודפיניל מדוכמי | נוביג'יל	מודפיניל וארמודפיניל לערנות (נרקולפסיה) במרשם מיוחד. חידוש ע"י רופא/ה בלבד.	☐
6.13	עיכול וכבד	**תרופות נגד הפטיטיס B** Hepatitis B antivirals	ויראד | טנופוביר טבע | ומלידי | אנטקאביר טבע | אנטאבניר | אנטקאביר סנדוז | אנטקאביר אס.קיי. | אנטקאביר אינובמד | אנטקאביר-תרימה | זפיקס	טיפול בהפטיטיס B נקבע ומנוטר ע"י מרפאת הכבד. אסור להפסיק (התלקחות). להעביר לרופא/ה.	☐

#	מערכת	תרופה / קבוצה	שמות מסחריים	ההודעה בכלי	אושר
6.15	עיכול וכבד	**מטוקלופרמיד** Metoclopramide	פראמין	מטוקלופרמיד מעל 12 שבועות מסוכן (דיסקינזיה מאוחרת). טיפול ממושך - חידוש ע"י רופא/ה בלבד.	☐
6.19	עיכול וכבד	**תרופות נגד הפטיטיס C ו-D** Hepatitis C / D antivirals	אפקלוזה | ווסווי | מבירט | הפקלודקס	טיפול בהפטיטיס C או D ניתן ע"י מרפאת הכבד. להעביר לרופא/ה.	☐
6.20	עיכול וכבד	**תרופות מומחה נוספות** Other specialist drugs	אוקליבה | ליבדלזי | ואנראפיה | פבהלטה	תרופות לכבד (PBC) ולכליות במעקב מומחה. להעביר לרופא/ה.	☐
7.13	כליות ודרכי שתן	**מעודדי ייצור דם (אריתרופויאטין)** Erythropoiesis-stimulating agents	אראנספ | אפרקס | בינוקריט	מעודדי ייצור דם נקבעים ומנוטרים ע"י נפרולוג/ית או המטולוג/ית. להעביר לרופא/ה.	☐
7.14	כליות ודרכי שתן	**קושרי זרחן** Phosphate binders	רנוולה | סבלמר תרו | פוסרנול | וולפורו	קושרי זרחן נקבעים ע"י הנפרולוג/ית לפי זרחן וסידן. להעביר לרופא/ה.	☐
7.15	כליות ודרכי שתן	**קושרי אשלגן** Potassium binders	לוקלמה | ולטסה	קושרי אשלגן ניתנים לפי רמת אשלגן עדכנית. חידוש ע"י רופא/ה בלבד.	☐
7.21	כליות ודרכי שתן	**תרופות למחלת עצם בכליות** CKD bone-mineral drugs	פאריקלציטול אינובמד | פרקל | רקסטול | זמפלר | פארסביב	פאריקלציטול ואטלקלצטיד נקבעים ע"י הנפרולוג/ית לפי סידן, זרחן ו-PTH. להעביר לרופא/ה.	☐
9.7	שלד, מפרקים וכאב	**אפרמילסט** Apremilast	אוטזלה | אפרמיל | אפרמילסט סנדוז	נקבע ע"י רופא/ת עור או ראומטולוג/ית. חידוש ע"י רופא/ה (ירידה במשקל, דיכאון).	☐
9.10	שלד, מפרקים וכאב	**תרופות בונות עצם במעקב מומחה** Osteoanabolic (specialist)	איבניטי | אלדינוס	רומוסוזומאב ואבלופרטייד נקבעים ע"י מומחה/ית לעצם, במסגרת קורס מוגבל. להעביר לרופא/ה.	☐
10.5	דם וויטמינים	**תרופות המטולוגיות במעקב מומחה** Haematology specialist drugs	דפרסירוקס תרו | דפראסירוקס טבע | דפירוקס | אקסג'ייד | דפריפרון תרו | פריפרוקס תמיסה | פריפרוקס טבליות | אלטופ | אלטרובניר | רבולייד | אופזורו | אנגריד … (+4)	תרופות אלה נקבעות ומנוטרות ע"י ההמטולוג/ית (ספירות ותפקודי כבד). להעביר לרופא/ה.	☐
11.2	עיניים ועור	**איזוטרטינואין (רואקוטן)** Isotretinoin	קיורטן | איזובניר | רואקוטן	איזוטרטינואין (רואקוטן) מחודש רק ע"י רופא/ת עור, במסגרת תוכנית מניעת היריון ומעקב מעבדה. להעביר את הבקשה לרופא/ת העור המטפל/ת.	☐
11.3	עיניים ועור	**אציטרטין** Acitretin	ניאוטיגאזון	אציטרטין מחודש רק ע"י רופא/ת עור: טרטוגני עד 3 שנים אחרי הפסקה, ומחייב מעקב שומנים ותפקודי כבד. להעביר לרופא/ת העור.	☐
12.5	חיסון, זיהומים ומומחים	**תרופות נגד HIV** HIV antiretrovirals	ביקטארווי | דסקובי | טרובדה | אודפסיי | ג'נדברה | סטריבילד | טיויקיי | טריומק | דובאטו | ג'ולוקה | דלסטריגו | אמטריציטבין/טנופוביר טבע … (+14)	טיפול ב-HIV ומניעה (PrEP) ניתנים ע"י מרפאת האיידס או מרפאת PrEP. להעביר לרופא/ה.	☐
12.6	חיסון, זיהומים ומומחים	**מעכבי קלצינאורין** Calcineurin inhibitors	סנדאימון ניאורל | דקסימון | פרוגרף | אדבגרף | טקרוסל | דייליפורט | אקרולימוס פי.אר.	ציקלוספורין וטקרולימוס במתן סיסטמי מנוטרים ברמה בדם ע"י יחידת ההשתלות או המומחה/ית. להעביר לרופא/ה.	☐
12.8	חיסון, זיהומים ומומחים	**תרופות ביולוגיות** Biologic drugs	אדאלימומאב קמהדע | אמג'ויטה | אמספאריטי | הוליו | יומירה | היירימוז | היירימוז אייץ'. סי. אף | אידסיו | יופלימה | אנברל | אנברל אבקה וממס | ארלזי … (+60)	תרופות ביולוגיות נקבעות ומנוטרות ע"י הרופא/ה המומחה/ית ודורשות אישור מימון. להעביר לרופא/ה.	☐

#	מערכת	תרופה / קבוצה	שמות מסחריים	ההודעה בכלי	אושר
12.9	חיסון, זיהומים ומומחים	**תרופות אונקולוגיות ובמעקב אונקולוגי** Oral oncology and hormonal cancer therapy	אבירטרון - תרימה | אבירטרון מדומי | אבירטרון אס.קיי | אבירטרון סנדוז | אבירטרון תרו | אבירטרון טבע | אביטאבניר | אביבניר | אקיגה | יונסה | זייטיגה | אנז-אבניר … (+56)	תרופות אונקולוגיות (כולל זריקות הורמונליות לסרטן ערמונית) נקבעות ע"י האונקולוג/ית. להעביר לרופא/ה.	☐
12.10	חיסון, זיהומים ומומחים	**מדכאי חיסון להשתלה (mTOR)** Transplant immunosuppressants (mTOR)	רפמיון | רפמיון תמיסה	סירולימוס נקבע ומנוטר ברמה בדם ע"י יחידת ההשתלות. להעביר לרופא/ה.	☐
12.11	חיסון, זיהומים ומומחים	**תרופות למחלות נדירות** Rare metabolic / orphan drugs	טריאנטין הידרוכלוריד מדומי | טריאנטין רז | ווילנטין | ניטיזינון דיפארמה | אורפדין | קובן | סאפרופטרין אינובמד | סאפרופטרין אס.קיי | ספרופטרין טבע | ציסטגון | גאלאפולד | סרדלגה … (+8)	תרופות למחלות נדירות נקבעות ומנוטרות ע"י מרכז מומחה. להעביר לרופא/ה.	☐

רשימה מרוכזת: הרפואן מכין, הרופא/ה מאשר/ת (7)

בתרופות אלה יש רשימת בדיקות, אבל הרפואן לא מנפיק: מכין סיכום, והאישור הסופי בידי הרופא/ה.

#	מערכת	תרופה / קבוצה	מה נבדק	אושר
5.32	פסיכיאטריה	**בנזודיאזפינים ותרופות שינה**	ההחלטה בידי הרופא/ה. הרפואן אוסף את הנתונים, מסמן אותם ומעביר סיכום.	☐
9.6	שלד, מפרקים וכאב	**אופיואידים**	אופיואיד: הרפואן בודק אבחנת כאב, התאמה לתרופה ומרווח זמן, ומכין סיכום. האישור הסופי בידי הרופא/ה.	☐
13.1	תרופות שאינן כרוניות	**טרבינפין (טבליות)**	קורס בלבד: עד 12 שבועות בציפורני רגליים, 6 שבועות בציפורני ידיים. ALT לפני הטיפול ואחרי חודש. האישור בידי הרופא/ה.	☐
13.2	תרופות שאינן כרוניות	**נוגדי דלקת חזקים (במרשם)**	לא תרופה כרונית: האישור בידי הרופא/ה. לפני ההצגה הרפואן בודק כיב קיבה בעבר ותפקוד כליות.	☐
13.3	תרופות שאינן כרוניות	**תרופה שאינה ברשימה הקבועה**	כל תרופה שאינה ברשימה הקבועה (כולל המלצת יועץ/ת, מכתב שחרור, המרת מרשם או מעבר לגנרי) מוצגת לרופא/ה לפני שמתחילים. הרפואן מכין סיכום: איפה תועד, תאריך, שם הרופא/ה ותפקידו/ה, האבחנה וההמלצה.	☐
13.4	תרופות שאינן כרוניות	**טיפות עיניים עם סטרואיד**	טיפול ממושך ללא השגחה מעלה לחץ תוך-עיני. רק כשרופא/ת עיניים קבע/ה טיפול לתקופה ארוכה; אחרת — המלצה חדשה מרופא/ת העיניים.	☐
13.5	תרופות שאינן כרוניות	**משחות וקרמים עם סטרואיד**	שימוש ממושך עלול לגרום לדילול ופגיעה בעור. לא לשימוש כרוני. כשמרשם מאושר — הוראה קבועה למטופל/ת.	☐

1. לב וכלי דם

74 תרופות · מתאים: 26 · בתנאים: 46 · רופא/ה בלבד: 2 · גרסה 2 · חלוקה לפי מערכות · 2.11.2026

מקורות: הנחיות יל"ד ישראל, ההסתדרות הרפואית, מהד' 2, יוני 2026; הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020; ACOG 2023 (סיכום AFP). שאר התחומים: החלטה מקומית; עלון לצרכן לפונקס (עודכן 12/2020). שאר התרופות: החלטה מקומית

1.א כללים

- חידוש רגיל: 3 חודשים
- ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה פעם בשנה
- עד 3 חידושים רצופים, ואז ביקור רופא
- אין התווית נגד ← תמיד מחדשים לפחות לחודש אחד
- חסרה מדידה, בדיקה או ביקורת שנתית: חידוש לחודש אחד + זימון למרפאה
- חריגה מספי ההחזרה: חידוש לחודש אחד + הודעה לרופא/ה
- התווית נגד או ערך חמור: לא מחדשים, הודעה לרופא/ה (הסף של כל תרופה מופיע ברשימה שלה)
- רפואן לא משנה מינון ולא מחליף תרופה. "מעקב מעבדה צמוד" = תרופה עם בדיקות תכופות — לבדוק בקפידה
- ערך חמור ביל"ד: K ≥5.5; באלדקטון eGFR <30; K ≥5.0 ב-ACEi, ARB, תיאזיד ו-MRA; דופק <50
- תרופות עם כמה התוויות (ACEi/ARB בודדים, MRA, אנטרסטו, פוסיד, חוסמי בטא): בלי יעד ל"ד; טווח בטיחות סיסטולי 100 עד מתחת ל-160/100
- נוגדי קרישה ונוגדי טסיות לא נעצרים ע"י רפואן מלבד ערך חמור; דימום ← הודעה דחופה

1.ג בדיקות משותפות

שלב	נושא	מה בודקים	קריטריון	אם לא מתקיים	מקור
לפני כל חידוש	מדידת ל"ד מתועדת	יש מדידה מתועדת (מרפאה או ממוצע ביתי)	מטופל חדש או אחרי שינוי טיפול ב-12 החודשים האחרונים: ב-6 החודשים האחרונים. אחרים: ב-12 החודשים האחרונים. ביתית: 2 בבוקר + 2 בערב, 4-7 ימים, לפי ממוצע	אין מדידה בזמן ← חידוש לחודש אחד + בקשת מדידה	החלטה יל"ד-9; פרק 1 עמ' 11; פרק 10 עמ' 86-87
לפני כל חידוש	ל"ד ביעד	הממוצע האחרון בין הרצפה ליעד	ביעד: ≥130/80 וגם ≥120/70	סיסטולי ≥131 או דיאסטולי ≥81 ← לרופא. סיסטולי <120 או דיאסטולי <70 ← לרופא	החלטות יל"ד-2-3
לפני כל חידוש	גיל 80+	מדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים	ביעד: סיסטולי 130-150 ודיאסטולי ≥70 (במקום היעד הכללי). נפילות וסחרחורת נבדקות בביקורת אצל הרופא/ה, לא בחידוש	מחוץ לטווח ← לרופא	פרק 6 עמ' 52; פרק 11 עמ' 92-96
לפני כל חידוש	רכישות	כיסוי ימים ב-6 החודשים האחרונים	≥80% מהימים	פחות ← לרופא/אחות לשיחת היענות	החלטה יל"ד-8
לפני כל חידוש	בדיקות שנתיות	בוצעו ב-12 החודשים האחרונים	תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז, HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן	באיחור ← חידוש לחודש אחד + הפניה לבדיקות	החלטה יל"ד-11; פרק 10 עמ' 87
לפני כל חידוש	בדיקות אחרי שינוי	אם היה שינוי: האם בוצעו	קריאטינין, K ו-Na תוך 4 שבועות מהשינוי	לא בוצעו או חריגים ← לרופא	החלטה יל"ד-1
לפני כל חידוש	ספי מעבדה	התוצאות האחרונות	K: ≥5.0 תחת ספירונולקטון, אחרת מחוץ לטווח. Na: מחוץ לטווח. קריאטינין: עלייה >30% מהקודמת או eGFR <30	חריגה ← לרופא	החלטות יל"ד-4-6
לפני כל חידוש	ביקורת שנתית	ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה	ב-12 החודשים האחרונים	אין ביקור ← חידוש לחודש אחד + זימון לביקורת במרפאה	החלטה יל"ד-14
לפני כל חידוש	רצף חידושים	כמה חידושים רצופים מאז ביקור רופא	חידוש ל-3 חודשים; עד 4 רצופים	3 חידושים כבר בוצעו ← ביקור רופא	החלטה יל"ד-10

שלב	נושא	מה בודקים	קריטריון	אם לא מתקיים	מקור
החזרה מיידית לרופא	ל"ד גבוה מאוד	המדידה האחרונה	≥180/110: מעקב רופא תוך שבועיים לכל היותר. ≥220/120 במדידה חוזרת: לרופא עכשיו	חידוש לחודש אחד + העברה לרופא/ה (≥220/120: לרופא עכשיו)	פרק 8 עמ' 64; כלי האחיות
החזרה מיידית לרופא	תסמינים חריפים	תלונה בפנייה	כאב חזה, קוצר נשימה, כאב ראש פתאומי וחמור, חולשה, קושי בדיבור, הפרעת ראייה, בלבול	דחוף - לרופא עכשיו	פרק 19 עמ' 183
החזרה מיידית לרופא	היריון	היריון, ייתכן היריון או תכנון היריון	ACEi, ARB וספירונולקטון אסורים בהיריון	לרופא	פרק 8 עמ' 72-73; פרק 26
החזרה מיידית לרופא	נפילה או עילפון	מופיע בפנייה או ברשומה: סחרחורת בעמידה, נפילה, עילפון	חשד לתת-ל"ד תנוחתי	לרופא	פרק 1 עמ' 11; פרק 11
החזרה מיידית לרופא	תרופה חדשה שמעלה ל"ד	תרופה חדשה ברשימה	NSAIDs כרוני, סטרואידים, גלולות עם אסטרוגן, נוגדי גודש, ממריצים, ציקלוספורין/טקרולימוס, ונלפקסין, ליקוריץ	לרופא	פרק 9 עמ' 83
החזרה מיידית לרופא	דופק לא סדיר	במדידה	-	לרופא	פרק 10 עמ' 88
לפני כל חידוש	בדיקת מעקב	לפי התרופה	שומנים: LDL; לבותירוקסין: TSH; אלופורינול/פבוקסוסטט: חומצה אורית — מ-12 החודשים האחרונים	אין ← חידוש לחודש + זימון לבדיקה	הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52; החלטה כללי-1
לפני כל חידוש	ערך המעקב	לעומת הבדיקה הקודמת או היעד	LDL לא עלה ב-30% ומעלה; TSH בטווח המעבדה; חומצה אורית מתחת ל-6	לא ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה	החלטות כללי-2-4
לפני כל חידוש	רמה או ספירה מתועדת	לפי התרופה	ליתיום: 6 חודשים; דיגוקסין: 12 חודשים; קלוזפין: 4 שבועות	אין ← חידוש לחודש + זימון לבדיקה	החלטות מעקב-1, 3, 5
לפני כל חידוש	רמה בטווח	הבדיקה האחרונה	ליתיום 0.6-1.0; דיגוקסין עד 1.2; קלוזפין WBC ≥3,500 ונויטרופילים ≥2,000	מחוץ לטווח ← חידוש לחודש + הודעה; ערך חמור ← לא מחדשים	החלטות מעקב-2, 4, 5
לפני כל חידוש	תרופות חדשות	רשימת התרופות	ליתיום: NSAIDs, ACEi, ARB, משתנים. דיגוקסין: אמיודרון, ורפמיל, דילטיאזם, קלריתרומיצין	יש ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה	החלטות מעקב-2, 4
החזרה מיידית לרופא	חשד לרעילות	מופיע בפנייה או ברשומה	ליתיום: רעד, הקאות, שלשול, בלבול. דיגוקסין: בחילות, הפרעות ראייה, בלבול	דחוף - לרופא עכשיו	החלטות מעקב-2, 4

1.ד החלטות

#	נושא	מה ההנחיה אומרת	ההחלטה לפרוטוקול	סוג	מקור
יל"ד-1	בדיקות אחרי שינוי טיפול	קריאטינין ואלקטרוליטים 2-3 שבועות (פרק 8) או 2-4 שבועות (פרקים 10, 13); נתרן 7-14 ימים אחרי תיאזיד	קריאטינין, K ו-Na תוך 4 שבועות מכל התחלה או שינוי מינון. לא בוצעו או חריגים ← לרופא	הכרעה	פרק 8 עמ' 66; פרק 10 עמ' 86; פרק 13 עמ' 142
יל"ד-2	יעד ל"ד	טבלה 4: "130/80"; פרק 6 ושאר הפרקים: "<130/80"	ביעד = ממוצע ≥130/80. סיסטולי ≥131 או דיאסטולי ≥81 ← לרופא	הכרעה	פרק 1 עמ' 13; פרק 6 עמ' 52
יל"ד-3	רצפת ל"ד	פרק 6: לא מתחת ל-120/70; פרק 11 (גיל 65-79): 120/60	סיסטולי <120 או דיאסטולי <70 ← לרופא (לשקול הפחתת טיפול)	הכרעה	פרק 6 עמ' 52; פרק 11 עמ' 92

#	נושא	מה ההנחיה אומרת	ההחלטה לפרוטוקול	סוג	מקור
יל"ד-4	אשלגן	"היפרקלמיה עיקשת או חמורה" ← הפסקה; ערך מספרי רק ל-MRA (>4.5 זהירות, >5.0 להימנע)	ספירונולקטון (אלדקטון): K ≥5.0 ← לרופא. כל שאר התרופות: K מחוץ לטווח המעבדה ← לרופא	החלטה מקומית	פרק 8 עמ' 63, 71
יל"ד-5	נתרן	לא מופיע בהנחיות	Na מחוץ לטווח המעבדה ← לרופא	החלטה מקומית	פרק 8 עמ' 71
יל"ד-6	קריאטינין	עלייה >30% מערך הבסיס ← הפסקה; עד 30% צפוי. "בסיס" לא מוגדר במטופל יציב	עלייה >30% לעומת התוצאה הקודמת, או eGFR <30 ← לרופא. חל על ACEi, ARB ותיאזידים	הנחיה + החלטה מקומית (הגדרת הבסיס)	פרק 8 עמ' 66, 71; פרק 13 עמ' 142
יל"ד-7	דופק תחת חוסם בטא	"ברדיקרדיה עקשנית" ← הפסקה; אין ערך מספרי	דופק במנוחה <55 ← לרופא	החלטה מקומית	פרק 8 עמ' 72
יל"ד-8	רכישות סדירות	ניטור רכישות מוזכר כדרך לבחון היענות; אין סף	רכישות שמכסות ≥80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← לרופא/אחות לשיחת היענות	החלטה מקומית	פרק 8 עמ' 67; פרק 9 עמ' 82
יל"ד-9	עדכניות מדידת ל"ד	למדוד בכל ביקור; אין מרווח מוגדר	מטופל חדש או אחרי שינוי טיפול ב-12 החודשים האחרונים: מדידה ב-6 החודשים האחרונים. כל השאר: ב-12 החודשים האחרונים. אין מדידה בזמן ← חידוש לחודש אחד + בקשת מדידה	החלטה מקומית	פרק 10 עמ' 86-87
יל"ד-10	משך חידוש ורצף	ביקור רופא 1-2 בשנה במטופל יציב (2-4 בשנה הראשונה)	חידוש ל-3 חודשים; עד 3 חידושים רצופים ואז ביקור רופא	החלטה מקומית	פרק 10 עמ' 86-87
יל"ד-11	מדידה או בדיקות שנתיות באיחור	לא מופיע בהנחיות	חידוש חד-פעמי לחודש אחד + הפניה להשלמה. החידוש הבא רק עם התוצאות	החלטה מקומית	פרק 10 עמ' 87
יל"ד-12	תרופות קו מתקדם או התוויה לא שגרתית	ההנחיה מגדירה אותן כקו רביעי ואילך, נישה או התוויה אחרת; לא מתייחסת לחידוש	הרפואן מחדש בתנאי: טיפול כרוני קבוע, ובכפוף לכל ספי ההחזרה	החלטה מקומית	פרק 8 עמ' 63-75
יל"ד-13	שיחה עם המטופל/ת	לא מופיע בהנחיות	החידוש הוא פעולה אדמיניסטרטיבית ללא שיחה עם המטופל/ת. הרפואן לא שואל על תלונות. תלונות שמחייבות החלפה או הפסקה נבדקות בביקורת השנתית אצל הרופא/ה. אם תלונה כזו מופיעה בפנייה או ברשומה, מעבירים לרופא/ה.	החלטה מקומית	-
יל"ד-14	ביקורת שנתית במרפאה	ביקור רופא 1-2 בשנה במטופל יציב (2-4 בשנה הראשונה)	כל חידוש מחייב ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אין ביקור ← חידוש לחודש אחד וזימון לביקורת במרפאה. חל על כל התרופות.	החלטה מקומית	פרק 10 עמ' 86-87
יל"ד-15	מתי לא מחדשים	לא מופיע בהנחיות	אין התווית נגד ← תמיד מחדשים לפחות לחודש אחד. חסר (מדידה, בדיקות, ביקורת שנתית) ← חידוש לחודש + זימון למרפאה. חריגה מספי ההחזרה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	החלטה מקומית	-
יל"ד-16	ערכים חמורים	לא מופיע בהנחיות	ערך חמור נחשב התווית נגד: K ≥5.5 (באלדקטון K ≥5.0); eGFR <30 ב-ACEi, ARB, תיאזיד ו-MRA; דופק במנוחה <50 בחוסם בטא או בחוסם תעלות סידן לא דיהידרופירידיני. לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	החלטה מקומית	-
יל"ד-17	תרופות עם כמה התוויות	-	חוסמי בטא (ביסופרולול, מטופרולול, קרבדילול, פרופרנולול), מעכבי ACE ו-ARB בודדים (לא בשילוב קבוע), ספירונולקטון, אפלרנון, פינרנון, אנטרסטו ופוסיד: בלי יעד ל"ד ובלי סעיף גיל 80; במקום זה טווח בטיחות: סיסטולי 100 ומעלה ומתחת ל-160/100. דופק, אשלגן וכליות כמו קודם	החלטה מקומית (2.11.2026)	-

#	נושא	מה ההנחיה אומרת	ההחלטה לפרוטוקול	סוג	מקור
כללי-1	בדיקות מעקב	שומנים: פרופיל כל 6-12 חודשים אחרי השגת היעד. TSH וחומצה אורית: לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	LDL, TSH וחומצה אורית מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש + זימון	החלטה מקומית (הצעה)	הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52
כללי-5	נוגדי טסיות	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	אספירין 75-100 מ"ג בלבד. נוגד קרישה במקביל ← הודעה. דימום ← התווית נגד. קלופידוגרל רק כטיפול כרוני לטווח ארוך	החלטה מקומית (הצעה)	-
כללי-7	אלופורינול ופבוקסוסטט	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	חומצה אורית ≥6 ← הודעה. אלופורינול: eGFR <30 ← הודעה (מינון). פריחה ← התווית נגד, דחוף	החלטה מקומית (הצעה)	-
כללי-11	מעכבי PCSK9 (רפאטה, פראלואנט)	בסל באינדיקציות מצומצמות; רוב המטופלים דרך שב"ן או ביטוח. סבילות טובה, תגובה מקומית	בתנאים: אישור מימון בתוקף וטיפול כרוני; מעקב LDL כמו בסטטין. אין אישור ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה	החלטה מקומית (הצעה)	הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 (פרק מעכבי PCSK9)
כללי-12	תרופות כרוניות נוספות (2)	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	בזאפיברט, גבפנטין, פרגבלין, SSRI/SNRI (נתרן בגיל 65+), מעכבי ארומטאז, טמוקסיפן, רלוקסיפן, טרבינפין ואיטרקונזול (קורס): לפי הרשימה של כל תרופה	החלטה מקומית (הצעה)	-
כללי-16	ברזל, B12, חומצה פולית	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	ברזל: ספירת דם ופריטין מ-6 חודשים; טיפול מעל 6 חודשים בלי התוויה ← הודעה. B12: רמה שנתית	החלטה מקומית (הצעה)	-
כללי-17	קרדיולוגיה	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	טיקגרלור ופרסוגרל: לפי משך שנקבע; נוגד קרישה במקביל ← דחוף. פלקאיניד, פרופפנון, דרונדרון: אק"ג שנתי ושלילת מחלה מבנית. אנטרסטו: בפרוטוקול יל"ד	החלטה מקומית (הצעה)	-
כללי-20	השלמות מהמאגר (2.11.2026)	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	טרזוסין, פינסטריד, אינקליסירן, ורדנאפיל, טיפות לגלאוקומה (ביקורת עיניים שנתית; טימולול: דופק ואסתמה), NSAID ממושך (כליות, אשלגן, ל"ד, דימום, הגנת קיבה), אנטיהיסטמינים, ציננריזין, דומפרידון, מבברין, סידן, מידודרין, פנטוקסיפילין, דיפירידמול, ולציקלוביר מונע, חומצה זולדרונית	החלטה מקומית (הצעה)	-
כללי-21	תרופות מומחה נוספות	-	מטוקלופרמיד ממושך, ממריצים/מודפיניל, ביולוגיות, טרשת נפוצה, אונקולוגיה, יל"ד ריאתי/IPF, סירולימוס, הורמון גדילה, המטולוגיה, CF, טפמידיס/מבקמטן: הודעה בלבד, חידוש ע"י רופא/ה	החלטה מקומית	-
כללי-22	השלמות 2 מהמאגר (2.11.2026)	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	ויטמין D, בטאהיסטין, חומצה במפדואית, אומגה 3/איקוזפנט, ציפרופיברט, וריסיגואט, ניטרוגליצרין תת-לשוני, פזולינטנט/אלינזנטנט (ALT), דואביב, אינטראروסה, סיאנה, אורליסטט, פרוקלופריד, משלשלים, טטרציקלינים ממושכים, מניעת זיהומי שתן, משככי כאב ממושכים, ביקרבונט. רופא/ה בלבד: פנטרמין, בונות עצם, הפרינים, תרופות עצם בכליות, אנלוגי סומטוסטטין, הפטיטיס C/D, מחלות נדירות	החלטה מקומית (הצעה)	-
מעקב-3	דיגוקסין: תדירות	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	רמה מ-12 החודשים האחרונים; אשלגן וקריאטינין מ-6 החודשים האחרונים	החלטה מקומית (הצעה)	-
מעקב-4	דיגוקסין: ערכים	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	רמה עד 1.2 ng/mL ← תקין. מעל ← הודעה; ≥2.0 ← ערך חמור. K <3.0 או דופק <50 ← ערך חמור	החלטה מקומית (הצעה)	-
מעקב-9	אמיודרון	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	TSH ו-ALT מ-6 החודשים האחרונים; צילום חזה ובדיקת עיניים שנתיים; דופק	החלטה מקומית (הצעה)	-
מעקב-10	וורפרין (קומדין)	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	INR מ-6 השבועות האחרונים ובטווח היעד; INR ≥5 או דימום ← הודעה דחופה. לא נעצר ע"י רפואן	החלטה מקומית (הצעה)	-

#	נושא	מה ההנחיה אומרת	ההחלטה לפרוטוקול	סוג	מקור
מעקב-11	NOACs	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	קריאטינין וספירת דם מ-12 חודשים (גיל 75+ או eGFR <60: 6 חודשים). eGFR <50 ← הודעה (מינון). אפיקסבן/ריברוקסבן eGFR <15, דביגטרן eGFR <30 ← ערך חמור. ירידה ב-Hb או דימום ← הודעה	החלטה מקומית (הצעה)	-

1.ה רשימת התרופות (לסימון)

#	שם	גנרי	קבוצה	התאמה	אושר	הערות
1.1	אנלפריל	Enalapril	מעכב ACE	מתאים	☐	
1.2	רמיפריל	Ramipril	מעכב ACE	מתאים	☐	
1.3	סילזפריל	Cilazapril	מעכב ACE	מתאים	☐	
1.4	קפטופריל	Captopril	מעכב ACE	בתנאים	☐	
1.5	לוסרטן	Losartan	ARB	מתאים	☐	
1.6	קנדסרטן	Candesartan	ARB	מתאים	☐	
1.7	ולסרטן	Valsartan	ARB	מתאים	☐	
1.8	הידרוכלורותיאזיד	Hydrochlorothiazide	משתן תיאזידי	בתנאים	☐	
1.9	אינדפמיד	Indapamide	משתן דמוי-תיאזיד	בתנאים	☐	
1.10	אמלודיפין	Amlodipine	חוסם תעלות סידן DHP	מתאים	☐	
1.11	לבאמלודיפין	Levamlodipine	חוסם תעלות סידן DHP	מתאים	☐	
1.12	לרקנידיפין	Lercanidipine	חוסם תעלות סידן DHP	מתאים	☐	
1.13	ניפדיפין	Nifedipine	חוסם תעלות סידן DHP	בתנאים	☐	
1.14	ביסופרולול	Bisoprolol	חוסם בטא	בתנאים	☐	
1.15	מטופרולול	Metoprolol	חוסם בטא	בתנאים	☐	
1.16	אטנולול	Atenolol	חוסם בטא	בתנאים	☐	
1.17	קרבדילול	Carvedilol	חוסם בטא + אלפא	בתנאים	☐	
1.18	פרופרנולול	Propranolol	חוסם בטא	בתנאים	☐	
1.19	לבטלול	Labetalol	חוסם בטא + אלפא	בתנאים	☐	
1.20	ורפמיל	Verapamil	חוסם תעלות סידן non-DHP	בתנאים	☐	
1.21	דילטיאזם	Diltiazem	חוסם תעלות סידן non-DHP	בתנאים	☐	
1.22	ספירונולקטון	Spironolactone	חוסם קולטן מינרלוקורטיקואידי	בתנאים	☐	
1.23	אפלרנון	Eplerenone	חוסם קולטן מינרלוקורטיקואידי	בתנאים	☐	
1.24	פינרנון	Finerenone	MRA לא-סטרואידלי	בתנאים	☐	
1.25	פורוסמיד	Furosemide	משתן לולאה	בתנאים	☐	
1.26	דוקסזוסין	Doxazosin	חוסם אלפא	בתנאים	☐	
1.27	קלונידין	Clonidine	אגוניסט אלפא מרכזי	בתנאים	☐	
1.28	מתילדופה	Methyldopa	אגוניסט אלפא מרכזי	בתנאים	☐	
1.29	מינוקסידיל	Minoxidil	מרחיב כלי דם ישיר	בתנאים	☐	
1.30	הידרלזין	Hydralazine	מרחיב כלי דם ישיר	בתנאים	☐	
1.31	אמילוריד + הידרוכלורותיאזיד	Amiloride + HCTZ	משתן שומר אשלגן + תיאזיד	בתנאים	☐	
1.32	סקוביטריל/ולסרטן	Sacubitril/Valsartan	ARNI	בתנאים	☐	

#	שם	גנרי	קבוצה	התאמה	אושר	הערות
1.33	רמיפריל + הידרוכלורותיאזיד	Ramipril + HCTZ	משולב: ACEi + תיאזיד	בתנאים	☐	
1.34	סילזפריל + הידרוכלורותיאזיד	Cilazapril + HCTZ	משולב: ACEi + תיאזיד	בתנאים	☐	
1.35	לוסרטן + הידרוכלורותיאזיד	Losartan + HCTZ	משולב: ARB + תיאזיד	בתנאים	☐	
1.36	קנדסרטן + הידרוכלורותיאזיד	Candesartan + HCTZ	משולב: ARB + תיאזיד	בתנאים	☐	
1.37	ולסרטן + הידרוכלורותיאזיד	Valsartan + HCTZ	משולב: ARB + תיאזיד	בתנאים	☐	
1.38	אנלפריל + לרקנידיפין	Enalapril + Lercanidipine	משולב: ACEi + CCB	מתאים	☐	
1.39	ולסרטן + אמלודיפין	Valsartan + Amlodipine	משולב: ARB + CCB	מתאים	☐	
1.40	אטורבסטטין	Atorvastatin	שומנים · סטטין	מתאים	☐	
1.41	רוזובסטטין	Rosuvastatin	שומנים · סטטין	מתאים	☐	
1.42	סימבסטטין	Simvastatin	שומנים · סטטין	מתאים	☐	
1.43	פרבסטטין	Pravastatin	שומנים · סטטין	מתאים	☐	
1.44	אזטימיב	Ezetimibe	שומנים · מעכב ספיגת כולסטרול	מתאים	☐	
1.45	אטורבסטטין + אזטימיב	Atorvastatin + Ezetimibe	שומנים · סטטין + אזטימיב	מתאים	☐	
1.46	רוזובסטטין + אזטימיב	Rosuvastatin + Ezetimibe	שומנים · סטטין + אזטימיב	מתאים	☐	
1.47	אבולוקומאב	Evolocumab	שומנים · מעכב PCSK9 (זריקה)	בתנאים	☐	
1.48	אלירוקומאב	Alirocumab	שומנים · מעכב PCSK9 (זריקה)	בתנאים	☐	
1.49	אספירין במינון נמוך	Aspirin (low dose)	נוגדי טסיות · נוגד טסיות	מתאים	☐	
1.50	קלופידוגרל	Clopidogrel	נוגדי טסיות · נוגד טסיות	בתנאים	☐	
1.51	בזאפיברט	Bezafibrate	שומנים · פיברט	מתאים	☐	
1.52	טיקגרלור	Ticagrelor	נוגד טסיות (P2Y12)	בתנאים	☐	
1.53	פרסוגרל	Prasugrel	נוגד טסיות (P2Y12)	בתנאים	☐	
1.54	איזוסורביד מונוניטרט	Isosorbide mononitrate	ניטרט	מתאים	☐	
1.55	פלקאיניד	Flecainide	נוגד הפרעות קצב (IC)	בתנאים	☐	
1.56	פרופפנון	Propafenone	נוגד הפרעות קצב (IC)	בתנאים	☐	
1.57	דרונדרון	Dronedarone	נוגד הפרעות קצב	בתנאים	☐	
1.58	אינקליסירן	Inclisiran	שומנים · siRNA נגד PCSK9 (זריקה כל 6 חודשים)	בתנאים	☐	
1.59	מידודרין	Midodrine	יל"ד אורתוסטטי	בתנאים	☐	
1.60	פנטוקסיפילין	Pentoxifylline	צליעה לסירוגין	מתאים	☐	
1.61	דיפירידמול	Dipyridamole	נוגד טסיות	בתנאים	☐	
1.62	תרופות לב במעקב מומחה	Cardiology specialist drugs	קרדיולוגיה - מומחה	רופא/ה בלבד	☐	
1.63	חומצה במפדואית	Bempedoic acid	שומנים · מעכב ACL	מתאים	☐	

#	שם	גנרי	קבוצה	התאמה	אושר	הערות
1.64	אומגה 3 / איקוזפנט אתיל	Omega-3 / icosapent ethyl	שומנים · אומגה 3 מרשמית	מתאים	☐	
1.65	ציפרופיברט	Ciprofibrate	שומנים · פיברט	מתאים	☐	
1.66	וריסיגואט	Vericiguat	אי-ספיקת לב · מעורר sGC	בתנאים	☐	
1.67	ניטרוגליצרין (תת-לשוני)	Nitroglycerin (sublingual)	ניטרט לפי הצורך	מתאים	☐	
1.68	הפרינים במשקל מולקולרי נמוך	Low-molecular-weight heparins	נוגד קרישה בזריקה	רופא/ה בלבד	☐	
1.69	דיגוקסין	Digoxin	גליקוזיד לבבי	בתנאים ⚗	☐	
1.70	אמיודרון	Amiodarone	נוגד הפרעות קצב	בתנאים ⚗	☐	
1.71	וורפרין	Warfarin	נוגד קרישה (אנטגוניסט ויטמין K)	בתנאים ⚗	☐	
1.72	אפיקסבן	Apixaban	נוגד קרישה ישיר (NOAC)	בתנאים ⚗	☐	
1.73	ריברוקסבן	Rivaroxaban	נוגד קרישה ישיר (NOAC)	בתנאים ⚗	☐	
1.74	דביגטרן	Dabigatran	נוגד קרישה ישיר (NOAC)	בתנאים ⚗	☐	

1.1 פירוט מלא

1.1 **אנלפריל** · Enalapril מתאים

מעכב ACE

שמות מסחריים (2)	אנלדקס · Enaladex | אנלפרי · Enalapri
נימוק / הערה	תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: יל"ד, אי-ספיקת לב, מחלת כליות כרונית, אחרי אוטם. קו ראשון; ספי מעבדה ברורים

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מדידת ל"ד מתועדת	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	ל"ד בטווח בטיחות	ל"ד אחרון: סיסטולי 100 ומעלה ומתחת ל-160/100, בלי סחרחורת או עילפון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן.	זימון
6	בדיקות אחרי שינוי שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם?	אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי.	שאלה
7	אשלגן (K) תקין	בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים	
8	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים	
9	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
10	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
11	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
12	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
13	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; שילוב ACEi עם ARB; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; NSAIDs באופן קבוע. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	קריאטינין, K, Na תוך 4 שבועות מכל שינוי; שנתי: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, אלבומין/קריאטינין בשתן
ספי החזרה לרופא/ה	K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם
ערך חמור	K ≥5.5; eGFR <30
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; שילוב ACEi עם ARB; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; NSAIDs באופן קבוע; ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30
תלונות בפנייה או ברשומה	שיעול יבש ← הפסקה ומעבר ל-ARB
מקור	פרק 8 עמ' 61, 71-72

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.2 רמיפריל · Ramipril מתאים

מעכב ACE

שמות מסחריים (4)	טריטייס · Tritace | רמיטנס 10 · Ramitens 10 | רמיפריל אינובמד · Ramipril Inovamed | רמיפריל טבע 5 · Ramipril Teva 5
נימוק / הערה	תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: יל"ד, אי-ספיקת לב, מחלת כליות כרונית, אחרי אוטם. קו ראשון; ספי מעבדה ברורים

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מדידת ל"ד מתועדת	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	ל"ד בטווח בטיחות	ל"ד אחרון: סיסטולי 100 ומעלה ומתחת ל-160/100, בלי סחרחורת או עילפון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן.	זימון
6	בדיקות אחרי שינוי שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם?	אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי.	שאלה
7	אשלגן (K) תקין	בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים	
8	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים	
9	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
10	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
11	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
12	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
13	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; שילוב ACEi עם ARB; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; NSAIDs באופן קבוע. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	קריאטינין, K, Na תוך 4 שבועות מכל שינוי; שנתי: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, אלבומין/קריאטינין בשתן
ספי החזרה לרופא/ה	K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם
ערך חמור	K ≥5.5; eGFR <30
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; שילוב ACEi עם ARB; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; NSAIDs באופן קבוע; ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30
תלונות בפנייה או ברשומה	שיעול יבש ← הפסקה ומעבר ל-ARB

מקור	
פרק 8 עמ' 72	

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.3 סילזפריל · Cilazapril מתאים

מעכב ACE

שמות מסחריים (1)	סילריל · Cilaril
נימוק / הערה	תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: יל"ד, אי-ספיקת לב, מחלת כליות כרונית, אחרי אוטם. קו ראשון; ספי מעבדה ברורים

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מדידת ל"ד מתועדת	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	ל"ד בטווח בטיחות	ל"ד אחרון: סיסטולי 100 ומעלה ומתחת ל-160/100, בלי סחרחורת או עילפון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן.	זימון
6	בדיקות אחרי שינוי שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם?	אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי.	שאלה
7	אשלגן (K) תקין	בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים	
8	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים	
9	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
10	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
11	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
12	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
13	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; שילוב ACEi עם ARB; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; NSAIDs באופן קבוע. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	קריאטינין, K, Na תוך 4 שבועות מכל שינוי; שנתי: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, אלבומין/קריאטינין בשתן
ספי החזרה לרופא/ה	K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם
ערך חמור	K ≥5.5; eGFR <30
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; שילוב ACEi עם ARB; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; NSAIDs באופן קבוע; ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30
תלונות בפנייה או ברשומה	שיעול יבש ← הפסקה ומעבר ל-ARB
מקור	פרק 8 עמ' 72

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.4 קפטופריל · Captopril בתנאים

מעכב ACE

שמות מסחריים (2)	אסריל · Aceril 12.5, 25 | Aceril 50 · אסריל 50 (לאימות מול מאגר משרד הבריאות)
נימוק / הערה	תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: יל"ד, אי-ספיקת לב, מחלת כליות כרונית, אחרי אוטם. 2-3 מנות ביום; לוודא שזה טיפול קבוע ולא לפי צורך

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מדידת ל"ד מתועדת	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	ל"ד בטווח בטיחות	ל"ד אחרון: סיסטולי 100 ומעלה ומתחת ל-160/100, בלי סחרחורת או עילפון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן.	זימון
6	בדיקות אחרי שינוי שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם?	אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי.	שאלה
7	אשלגן (K) תקין	בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים	
8	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים	
9	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
10	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
11	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
12	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
13	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; שילוב ACEi עם ARB; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; NSAIDs באופן קבוע. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	קריאטינין, K, Na תוך 4 שבועות מכל שינוי; שנתי: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, אלבומין/קריאטינין בשתן
ספי החזרה לרופא/ה	K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם
ערך חמור	K ≥5.5; eGFR <30
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; שילוב ACEi עם ARB; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; NSAIDs באופן קבוע; ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30
תלונות בפנייה או ברשומה	שיעול יבש ← הפסקה ומעבר ל-ARB
מקור	פרק 8 עמ' 72

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.5 לוסרטן · Losartan מתאים

ARB

שמות מסחריים (4)	אוקסאאר · Ocsaar 50 | לוסרטה · Losarta | לוסרדקס · Losardex | לוטן · Lotan
נימוק / הערה	תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: יל"ד, אי-ספיקת לב, מחלת כליות כרונית, אחרי אוטם. קו ראשון; ספי מעבדה ברורים

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מדידת ל"ד מתועדת	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	ל"ד בטווח בטיחות	ל"ד אחרון: סיסטולי 100 ומעלה ומתחת ל-160/100, בלי סחרחורת או עילפון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן.	זימון
6	בדיקות אחרי שינוי שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם?	אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי.	שאלה
7	אשלגן (K) תקין	בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים	
8	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים	
9	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
10	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
11	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
12	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
13	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; שילוב ARB עם ACEi; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; NSAIDs באופן קבוע. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	קריאטינין, K, Na תוך 4 שבועות מכל שינוי; שנתי: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, אלבומין/קריאטינין בשתן
ספי החזרה לרופא/ה	K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם
ערך חמור	K ≥5.5; eGFR <30
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; שילוב ARB עם ACEi; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; NSAIDs באופן קבוע; ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30
מקור	פרק 8 עמ' 71-72

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.6 קנדסרטן · Candesartan מתאים

ARB

שמות מסחריים (2)	אטקנד · Atacand | קנדור · Candor
נימוק / הערה	תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: יל"ד, אי-ספיקת לב, מחלת כליות כרונית, אחרי אוטם. קו ראשון; ספי מעבדה ברורים

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מדידת ל"ד מתועדת	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	ל"ד בטווח בטיחות	ל"ד אחרון: סיסטולי 100 ומעלה ומתחת ל-160/100, בלי סחרחורת או עילפון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן.	זימון
6	בדיקות אחרי שינוי שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם?	אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי.	שאלה
7	אשלגן (K) תקין	בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים	
8	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים	
9	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
10	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
11	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
12	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
13	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; שילוב ARB עם ACEi; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; NSAIDs באופן קבוע. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	קריאטינין, K, Na תוך 4 שבועות מכל שינוי; שנתי: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, אלבומין/קריאטינין בשתן
ספי החזרה לרופא/ה	K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם
ערך חמור	K ≥5.5; eGFR <30
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; שילוב ARB עם ACEi; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; NSAIDs באופן קבוע; ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30
מקור	פרק 8 עמ' 72

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.7 ולסרטן · Valsartan מתאים

ARB

שמות מסחריים (4)	דיובן · Diovan | וקטור · Vector | ואלסרטן דקסל · Valsartan Dexcel | ואלסרטן מדו · Valsartan-Medo
נימוק / הערה	תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: יל"ד, אי-ספיקת לב, מחלת כליות כרונית, אחרי אוטם. קו ראשון; ספי מעבדה ברורים

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מדידת ל"ד מתועדת	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	ל"ד בטווח בטיחות	ל"ד אחרון: סיסטולי 100 ומעלה ומתחת ל-160/100, בלי סחרחורת או עילפון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן.	זימון
6	בדיקות אחרי שינוי שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם?	אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי.	שאלה
7	אשלגן (K) תקין	בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים	
8	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים	
9	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
10	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
11	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
12	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
13	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; שילוב ARB עם ACEi; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; NSAIDs באופן קבוע. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	קריאטינין, K, Na תוך 4 שבועות מכל שינוי; שנתי: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, אלבומין/קריאטינין בשתן
ספי החזרה לרופא/ה	K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם
ערך חמור	K ≥5.5; eGFR <30
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; שילוב ARB עם ACEi; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; NSAIDs באופן קבוע; ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30
מקור	פרק 8 עמ' 72

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.8 הידרוכלורותיאזיד · Hydrochlorothiazide בתנאים

משתן תיאזידי

שמות מסחריים (1)	דיזותיאזיד · Disothiazide 25
נימוק / הערה	רק אחרי בדיקת Na ראשונה תקינה ובדיקות שנתיות בזמן

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מדידת ל"ד מתועדת	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	ל"ד ביעד	ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	גיל 80+ שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה?	בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
4	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן, סידן, חומצה אורית.	זימון
7	בדיקות אחרי שינוי שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם?	אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי.	שאלה
8	אשלגן (K) תקין	בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים	
9	נתרן (Na) תקין	בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
10	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים	
11	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
12	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
13	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
14	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
15	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): גאוט פעיל ללא אלופורינול/פבוקסוסטט; eGFR <30; סידן גבוה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	Na, K, קריאטינין תוך 4 שבועות מהתחלה (בייחוד נשים מעל 65); שנתי: Na, K, Ca, חומצה אורית, קריאטינין
ספי החזרה לרופא/ה	Na מחוץ לטווח המעבדה; K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם
ערך חמור	K ≥5.5; eGFR <30
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	גאוט פעיל ללא אלופורינול/פבוקסוסטט; eGFR <30; סידן גבוה; ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30

תלונות בפנייה או ברשומה	התקף גאוט ← הפסקה אם אין טיפול באלופורינול/פבוקסוסטט; חולשה או בלבול (חשד להיפונתרמיה) ← בדיקת Na; היפונתרמיה ← הפסקה; סידן גבוה בבדיקה ← בירור ומעבר לפורוסמיד
מקור	פרק 8 עמ' 62, 66, 71-73

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.9 **אינדפמיד** · Indapamide בתנאים

משתן דמוי-תיאזיד

שמות מסחריים (1)	פמיד · Pamid 2.5
נימוק / הערה	כמו תיאזיד; המשתן המועדף בהנחיה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**מדידת ל"ד מתועדת**	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	**ל"ד ביעד**	ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	**גיל 80+** שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה?	בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
4	**רכישות**	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
5	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	**בדיקות שנתיות**	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן, סידן, חומצה אורית.	זימון
7	**בדיקות אחרי שינוי** שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם?	אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי.	שאלה
8	**אשלגן (K) תקין**	בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים	
9	**נתרן (Na) תקין**	בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
10	**תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין**	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים	
11	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
12	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
13	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
14	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
15	**אין התוויות נגד**	אין התוויות נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): גאוט פעיל ללא אלופורינול/פבוקסוסטט; eGFR <30; סידן גבוה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	Na, K, קריאטינין תוך 4 שבועות מהתחלה (בייחוד נשים מעל 65); שנתי: Na, K, Ca, חומצה אורית, קריאטינין
ספי החזרה לרופא/ה	Na מחוץ לטווח המעבדה; K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם
ערך חמור	K ≥5.5; eGFR <30
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	גאוט פעיל ללא אלופורינול/פבוקסוסטט; eGFR <30; סידן גבוה; ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30

תלונות בפנייה או ברשומה	התקף גאוט ← הפסקה אם אין טיפול באלופורינול/פבוקסוסטט; חולשה או בלבול (חשד להיפונתרמיה) ← בדיקת Na; היפונתרמיה ← הפסקה; סידן גבוה בבדיקה ← בירור ומעבר לפורוסמיד
מקור	פרק 8 עמ' 62, 73; פרק 9 עמ' 84

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.10 **אמלודיפין** · Amlodipine מתאים

חוסם תעלות סידן DHP

שמות מסחריים (4)	נורווסק · Norvasc | אמלו · Amlow | אמלודי · Amlody | אמלודיפין טבע · Amlodipine Teva
נימוק / הערה	ללא דרישת מעבדה; תופעות לוואי קלות לזיהוי

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**מדידת ל"ד מתועדת**	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	**ל"ד ביעד**	ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	**גיל 80+** שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה?	בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
4	**רכישות**	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
5	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	**בדיקות שנתיות**	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן.	זימון
7	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
11	**אין התווית נגד**	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): מינון שנקבע בגלל היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	אין בדיקה ייעודית; הבדיקות השנתיות הכלליות
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	מינון שנקבע בגלל היריון
תלונות בפנייה או ברשומה	בצקת ברגליים ← הפחתת מינון או מעבר ללרקנידיפין; עיבוי חניכיים ← הפסקה
מקור	פרק 8 עמ' 61, 71, 73

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.11 **לבאמלודיפין** · Levamlodipine מתאים

חוסם תעלות סידן DHP

שמות מסחריים (1)	קונג'ופרי · Conjupri 2.5, 5
נימוק / הערה	ללא דרישת מעבדה; פחות בצקת

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**מדידת ל"ד מתועדת**	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	**ל"ד ביעד**	ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	**גיל 80+** שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה?	בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
4	**רכישות**	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
5	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	**בדיקות שנתיות**	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן.	זימון
7	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
11	**אין התווית נגד**	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): מינון שנקבע בגלל היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	אין בדיקה ייעודית; הבדיקות השנתיות הכלליות
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	מינון שנקבע בגלל היריון
תלונות בפנייה או ברשומה	בצקת ברגליים ← הפחתת מינון או מעבר ללרקנידיפין; עיבוי חניכיים ← הפסקה
מקור	פרק 8 עמ' 61, 73

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.12 לרקנידיפין · Lercanidipine מתאים

חוסם תעלות סידן DHP

שמות מסחריים (3)	וזודיפ · Vasodip 10 | לרקפרס · Lercapress 10, 20 | וזודיפ 20 · Vasodip 20 (לאימות מול מאגר משרד הבריאות)
נימוק / הערה	ללא דרישת מעבדה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מדידת ל"ד מתועדת	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	ל"ד ביעד	ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	גיל 80+ שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה?	בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
4	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן.	זימון
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
11	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): מינון שנקבע בגלל היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	אין בדיקה ייעודית; הבדיקות השנתיות הכלליות
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	מינון שנקבע בגלל היריון
תלונות בפנייה או ברשומה	בצקת ברגליים ← הפחתת מינון; עיבוי חניכיים ← הפסקה
מקור	פרק 8 עמ' 71, 73

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.13 ניפדיפין · Nifedipine בתנאים

חוסם תעלות סידן DHP

שמות מסחריים (2)	ניפדילונג · Nifedilong 30, 60 | טנסיפין · Tensipine MR (לא רשום; יבוא תקנה 29)
נימוק / הערה	רק אם לא נרשם בהקשר של היריון

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מדידת ל"ד מתועדת	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	ל"ד ביעד	ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	גיל 80+ שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה?	בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
4	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן.	זימון
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
11	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): מינון שנקבע בגלל היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	אין בדיקה ייעודית; הבדיקות השנתיות הכלליות
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	מינון שנקבע בגלל היריון
תלונות בפנייה או ברשומה	בצקת ברגליים ← הפחתת מינון או מעבר ללרקנידיפין; עיבוי חניכיים ← הפסקה
מקור	פרק 8 עמ' 73; פרק 26 עמ' 251

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.14 ביסופרולול · Bisoprolol בתנאים

חוסם בטא

שמות מסחריים (4)	קונקור · Concor | קרדילוק · Cardiloc | ביסופרולול אינובמד · Bisoprolol Inovamed | ביסופרולול ד.ק.ל. · Bisoprolol D.K.L.
נימוק / הערה	תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: יל"ד, אי-ספיקת לב, פרפור, מחלת לב איסכמית. רק עם התוויה מתועדת ודופק מתועד

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מדידת ל"ד מתועדת	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	ל"ד בטווח בטיחות	ל"ד אחרון: סיסטולי 100 ומעלה ומתחת ל-160/100, בלי סחרחורת או עילפון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	דופק במנוחה תקין	במדידה האחרונה דופק במנוחה תקין. חריג: מתחת ל-55 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים	
4	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן.	זימון
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
11	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): שילוב עם ורפמיל או דילטיאזם; אסתמה; אין התוויה מתועדת (מחלת לב איסכמית, אי ספיקת לב, פרפור). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	דופק במנוחה בכל חידוש; אין בדיקת מעבדה ייעודית
ספי החזרה לרופא/ה	דופק במנוחה <55
ערך חמור	דופק במנוחה <50
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	שילוב עם ורפמיל או דילטיאזם; אסתמה; אין התוויה מתועדת (מחלת לב איסכמית, אי ספיקת לב, פרפור); לא להפסיק בפתאומיות; ערך חמור: דופק במנוחה <50
תלונות בפנייה או ברשומה	דופק איטי מתמשך או עייפות שפוגעת בתפקוד ← התאמת מינון או הפסקה; החמרה באסתמה ← הפסקה
מקור	פרק 8 עמ' 62-63, 70-74

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.15 **מטופרולול** · Metoprolol בתנאים

חוסם בטא

שמות מסחריים (2)	ניאובלוק · Neobloc | לופרסור דיויטבס · Lopresor Divitabs (לאימות מול מאגר משרד הבריאות)
נימוק / הערה	תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: יל"ד, אי-ספיקת לב, פרפור, מחלת לב איסכמית. רק עם התוויה מתועדת ודופק מתועד

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מדידת ל"ד מתועדת	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	ל"ד בטווח בטיחות	ל"ד אחרון: סיסטולי 100 ומעלה ומתחת ל-160/100, בלי סחרחורת או עילפון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	דופק במנוחה תקין	במדידה האחרונה דופק במנוחה תקין. חריג: מתחת ל-55 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים	
4	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן.	זימון
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
11	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): שילוב עם ורפמיל או דילטיאזם; אסתמה; אין התוויה מתועדת (מחלת לב איסכמית, אי ספיקת לב, פרפור). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	דופק במנוחה בכל חידוש; אין בדיקת מעבדה ייעודית
ספי החזרה לרופא/ה	דופק במנוחה <55
ערך חמור	דופק במנוחה <50
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	שילוב עם ורפמיל או דילטיאזם; אסתמה; אין התוויה מתועדת (מחלת לב איסכמית, אי ספיקת לב, פרפור); לא להפסיק בפתאומיות; ערך חמור: דופק במנוחה <50
תלונות בפנייה או ברשומה	דופק איטי מתמשך או עייפות שפוגעת בתפקוד ← התאמת מינון או הפסקה; החמרה באסתמה ← הפסקה
מקור	פרק 8 עמ' 74

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.16 **אטנולול** · Atenolol בתנאים

חוסם בטא

שמות מסחריים (2)	נורמלול · Normalol | נורמיטן · Normiten
נימוק / הערה	רק עם התוויה מתועדת ודופק מתועד; פינוי כלייתי

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מדידת ל"ד מתועדת	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	ל"ד ביעד	ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	גיל 80+ שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה?	בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
4	דופק במנוחה תקין	במדידה האחרונה דופק במנוחה תקין. חריג: מתחת ל-55 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים	
5	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן.	זימון
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
12	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): שילוב עם ורפמיל או דילטיאזם; אסתמה; אין התוויה מתועדת (מחלת לב איסכמית, אי ספיקת לב, פרפור). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	דופק במנוחה בכל חידוש; אין בדיקת מעבדה ייעודית
ספי החזרה לרופא/ה	דופק במנוחה <55
ערך חמור	דופק במנוחה <50
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	שילוב עם ורפמיל או דילטיאזם; אסתמה; אין התוויה מתועדת (מחלת לב איסכמית, אי ספיקת לב, פרפור); לא להפסיק בפתאומיות; ערך חמור: דופק במנוחה <50
תלונות בפנייה או ברשומה	דופק איטי מתמשך או עייפות שפוגעת בתפקוד ← התאמת מינון או הפסקה; החמרה באסתמה ← הפסקה
מקור	פרק 8 עמ' 74

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.17 קרבדילול · Carvedilol בתנאים

חוסם בטא + אלפא

שמות מסחריים (2)	קרבדקסון · Carvedexxon | קרוודילול טבע · Carvedilol Teva
נימוק / הערה	תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: יל"ד, אי-ספיקת לב, מחלת לב איסכמית. בדרך כלל באי ספיקת לב; רק אם הרופא קבע טיפול יציב

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מדידת ל"ד מתועדת	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	ל"ד בטווח בטיחות	ל"ד אחרון: סיסטולי 100 ומעלה ומתחת ל-160/100, בלי סחרחורת או עילפון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	דופק במנוחה תקין	במדידה האחרונה דופק במנוחה תקין. חריג: מתחת ל-55 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים	
4	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן.	זימון
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
11	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): שילוב עם ורפמיל או דילטיאזם; אסתמה; אין התוויה מתועדת (מחלת לב איסכמית, אי ספיקת לב, פרפור). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	דופק במנוחה בכל חידוש; אין בדיקת מעבדה ייעודית
ספי החזרה לרופא/ה	דופק במנוחה <55
ערך חמור	דופק במנוחה <50
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	שילוב עם ורפמיל או דילטיאזם; אסתמה; אין התוויה מתועדת (מחלת לב איסכמית, אי ספיקת לב, פרפור); לא להפסיק בפתאומיות; ערך חמור: דופק במנוחה <50
תלונות בפנייה או ברשומה	דופק איטי מתמשך או עייפות שפוגעת בתפקוד ← התאמת מינון או הפסקה; החמרה באסתמה ← הפסקה
מקור	פרק 8 עמ' 74

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.18 **פרופרנולול** · Propranolol בתנאים

חוסם בטא

שמות מסחריים (2)	פרולול · Prolol 10, 40 | בטא-פרוגרן · Beta-Programe (לא רשום; יבוא תקנה 29)
נימוק / הערה	תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: יל"ד, רעד, מניעת מיגרנה, דליות ושט. רק טיפול כרוני קבוע. רקע: לא סלקטיבי; לרוב בהתוויות שאינן יל"ד

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מדידת ל"ד מתועדת	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	ל"ד בטווח בטיחות	ל"ד אחרון: סיסטולי 100 ומעלה ומתחת ל-160/100, בלי סחרחורת או עילפון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	דופק במנוחה תקין	במדידה האחרונה דופק במנוחה תקין. חריג: מתחת ל-55 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים	
4	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן.	זימון
7	טיפול כרוני	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
12	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): שילוב עם ורפמיל או דילטיאזם; אסתמה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	דופק במנוחה בכל חידוש; אין בדיקת מעבדה ייעודית
ספי החזרה לרופא/ה	דופק במנוחה <55
ערך חמור	דופק במנוחה <50
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	שילוב עם ורפמיל או דילטיאזם; אסתמה; לא להפסיק בפתאומיות; ערך חמור: דופק במנוחה <50
תלונות בפנייה או ברשומה	דופק איטי מתמשך או עייפות שפוגעת בתפקוד ← התאמת מינון או הפסקה; החמרה באסתמה ← הפסקה
מקור	פרק 8 עמ' 74

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.19 **לבטלול** · Labetalol בתנאים

חוסם בטא + אלפא

שמות מסחריים (1)	טרנדייט · Trandate 100, 200
נימוק / הערה	רק טיפול כרוני קבוע. רקע: שימוש עיקרי בהיריון

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מדידת ל"ד מתועדת	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	ל"ד ביעד	ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	גיל 80+ שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה?	בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
4	דופק במנוחה תקין	במדידה האחרונה דופק במנוחה תקין. חריג: מתחת ל-55 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים	
5	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן.	זימון
8	טיפול כרוני	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע.	
9	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
10	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
11	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
12	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
13	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): שילוב עם ורפמיל או דילטיאזם; אסתמה; היריון ← לרופא (לפי כללי ההחזרה). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	דופק במנוחה בכל חידוש; אין בדיקת מעבדה ייעודית
ספי החזרה לרופא/ה	דופק במנוחה <55
ערך חמור	דופק במנוחה <50
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	שילוב עם ורפמיל או דילטיאזם; אסתמה; היריון ← לרופא (לפי כללי ההחזרה); לא להפסיק בפתאומיות; ערך חמור: דופק במנוחה <50
תלונות בפנייה או ברשומה	דופק איטי מתמשך או עייפות שפוגעת בתפקוד ← התאמת מינון או הפסקה; החמרה באסתמה ← הפסקה
מקור	פרק 8 עמ' 74; פרק 26 עמ' 251

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.20 ורפמיל · Verapamil בתנאים

חוסם תעלות סידן non-DHP

שמות מסחריים (2)	קורדמיל · Cordamil 40, 80 | ורפרס · Verapress 240 SR
נימוק / הערה	רק טיפול כרוני קבוע. רקע: אינטראקציות רבות; בדרך כלל בהתוויה לבבית

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מדידת ל"ד מתועדת	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	ל"ד ביעד	ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	גיל 80+ שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה?	בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
4	דופק במנוחה תקין	במדידה האחרונה דופק במנוחה תקין. חריג: מתחת ל-55 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים	
5	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן.	זימון
8	טיפול כרוני	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע.	
9	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
10	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
11	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
12	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
13	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): שילוב עם חוסם בטא (אסור); תרופה חדשה ברשימה (אינטראקציות CYP3A4 ו-P-gp). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	דופק במנוחה בכל חידוש
ספי החזרה לרופא/ה	דופק במנוחה <55
ערך חמור	דופק במנוחה <50
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	שילוב עם חוסם בטא (אסור); תרופה חדשה ברשימה (אינטראקציות CYP3A4 ו-P-gp); ערך חמור: דופק במנוחה <50
תלונות בפנייה או ברשומה	דופק איטי ← לרופא
מקור	פרק 8 עמ' 62, 65, 75

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.21 **דילטיאזם** · Diltiazem בתנאים

חוסם תעלות סידן non-DHP

שמות מסחריים (2)	דילאטם · Dilatam 120 SR | אדיזם · Adizem CD
נימוק / הערה	רק טיפול כרוני קבוע. רקע: אינטראקציות רבות; בדרך כלל בהתוויה לבבית

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מדידת ל"ד מתועדת	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	ל"ד ביעד	ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	גיל 80+ שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה?	בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
4	דופק במנוחה תקין	במדידה האחרונה דופק במנוחה תקין. חריג: מתחת ל-55 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים	
5	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן.	זימון
8	טיפול כרוני	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע.	
9	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
10	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
11	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
12	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
13	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): שילוב עם חוסם בטא (אסור); תרופה חדשה ברשימה (אינטראקציות CYP3A4 ו-P-gp). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	דופק במנוחה בכל חידוש
ספי החזרה לרופא/ה	דופק במנוחה <55
ערך חמור	דופק במנוחה <50
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	שילוב עם חוסם בטא (אסור); תרופה חדשה ברשימה (אינטראקציות CYP3A4 ו-P-gp); ערך חמור: דופק במנוחה <50
תלונות בפנייה או ברשומה	דופק איטי ← לרופא
מקור	פרק 8 עמ' 62, 75

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.22 ספירונולקטון · Spironolactone בתנאים

חוסם קולטן מינרלוקורטיקואידי

שמות מסחריים (3)	אלדקטון · Aldactone 25 | אלדקטון 100 · Aldactone 100 (לאימות מול מאגר משרד הבריאות) | ספירונולקטון טבע · Spironolactone Teva
נימוק / הערה	תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: יל"ד, אי-ספיקת לב, בצקות, היפרקלמיה נמוכה/אלדוסטרון. רק טיפול כרוני קבוע. רקע: קו רביעי ביל"ד עמיד; סיכון היפרקלמיה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מדידת ל"ד מתועדת	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	ל"ד בטווח בטיחות	ל"ד אחרון: סיסטולי 100 ומעלה ומתחת ל-160/100, בלי סחרחורת או עילפון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן.	זימון
6	בדיקות אחרי שינוי שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם?	אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן תוך 4 שבועות מהשינוי.	שאלה
7	אשלגן (K) תקין	בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חמור: K ≥5.0 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד
8	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם או eGFR ≤45 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים	
9	טיפול כרוני	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע.	
10	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
11	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
12	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
13	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
14	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון; דרוספירנון במקביל. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	K וקריאטינין (תדירות בטיפול כרוני: לא מופיע בהנחיות)
ספי החזרה לרופא/ה	קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם; eGFR ≤45
ערך חמור	K ≥5.0; eGFR <30
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון; דרוספירנון במקביל; ערך חמור: K ≥5.0; eGFR <30
תלונות בפנייה או ברשומה	הגדלת שד כואבת, הפרעה בזקפה ← מעבר לאפלרנון
מקור	פרק 8 עמ' 63, 73; פרק 9 עמ' 83

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.23 אפלרנון · Eplerenone (בתנאים)

חוסם קולטן מינרלוקורטיקואידי

שמות מסחריים (1)	אינספרה · Inspra 25, 50
נימוק / הערה	תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: אי-ספיקת לב, יל"ד. רק טיפול כרוני קבוע. רקע: קו רביעי ביל"ד עמיד; סיכון היפרקלמיה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מדידת ל"ד מתועדת	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	ל"ד בטווח בטיחות	ל"ד אחרון: סיסטולי 100 ומעלה ומתחת ל-160/100, בלי סחרחורת או עילפון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן.	זימון
6	בדיקות אחרי שינוי שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם?	אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן תוך 4 שבועות מהשינוי.	שאלה
7	אשלגן (K) תקין	בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים	
8	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם או eGFR ≤45 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים	
9	טיפול כרוני	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע.	
10	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
11	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
12	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
13	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
14	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	K וקריאטינין (תדירות בטיפול כרוני: לא מופיע בהנחיות)
ספי החזרה לרופא/ה	K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם; eGFR ≤45
ערך חמור	K ≥5.5; eGFR <30
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון; ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30
תלונות בפנייה או ברשומה	תסמיני היפרקלמיה (חולשה, דפיקות לב) ← לרופא
מקור	פרק 8 עמ' 63, 73; פרק 9 עמ' 83

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.24 פינרנון · Finerenone בתנאים

MRA לא-סטרואידלי

שמות מסחריים (1)	קרנדיאה · Kerendia 10, 20
נימוק / הערה	תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: מחלת כליות סוכרתית, אי-ספיקת לב. רק טיפול כרוני קבוע. רקע: אין התוויה ליל"ד; ניתן ב-CKD עם סוכרת

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מדידת ל"ד מתועדת	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	ל"ד בטווח בטיחות	ל"ד אחרון: סיסטולי 100 ומעלה ומתחת ל-160/100, בלי סחרחורת או עילפון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן.	זימון
6	בדיקות אחרי שינוי שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם?	אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן תוך 4 שבועות מהשינוי.	שאלה
7	אשלגן (K) תקין	בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים	
8	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התוויות נגד
9	טיפול כרוני	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע.	
10	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
11	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
12	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
13	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
14	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): לחדש רק כהמשך טיפול קיים (התוויה: CKD עם סוכרת). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התוויות נגד

מעקב מעבדה	K וקריאטינין (תדירות בטיפול כרוני: לא מופיע בהנחיות)
ספי החזרה לרופא/ה	K מחוץ לטווח המעבדה
ערך חמור	K ≥5.5; eGFR <30
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	לחדש רק כהמשך טיפול קיים (התוויה: CKD עם סוכרת); ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30
תלונות בפנייה או ברשומה	תסמיני היפרקלמיה ← לרופא
מקור	פרק 8 עמ' 68; פרק 13 עמ' 143

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.25 **פורוסמיד** · Furosemide בתנאים

משתן לולאה

שמות מסחריים (2)	פוזיד · Fusid | פורוסמיד אינובמד · Furosemide Inovamed
נימוק / הערה	תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: בצקות, אי-ספיקת לב, מחלת כליות, יל"ד. רק טיפול כרוני קבוע. רקע: התוויות מורכבות (eGFR <30, אי ספיקת לב)

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**מדידת ל"ד מתועדת**	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	**ל"ד בטווח בטיחות**	ל"ד אחרון: סיסטולי 100 ומעלה ומתחת ל-160/100, בלי סחרחורת או עילפון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	**רכישות**	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
4	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	**בדיקות שנתיות**	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן.	זימון
6	**בדיקות אחרי שינוי** שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם?	אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי.	שאלה
7	**אשלגן (K) תקין**	בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים	
8	**נתרן (Na) תקין**	בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
9	**טיפול כרוני**	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע.	
10	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
11	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
12	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
13	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	תפקודי כליה ואלקטרוליטים (תדירות: לא מופיע בהנחיות)
ספי החזרה לרופא/ה	Na או K מחוץ לטווח המעבדה
ערך חמור	K ≥5.5
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	לא להפסיק בפתאומיות (אצירת נוזלים); ערך חמור: K ≥5.5
תלונות בפנייה או ברשומה	ירידה במשקל, סחרחורת, התייבשות ← לרופא
מקור	פרק 8 עמ' 67, 73

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.26 דוקסזוסין · Doxazosin בתנאים

חוסם אלפא

שמות מסחריים (1)	קדקס · Cadex 1, 2, 4
נימוק / הערה	רק טיפול כרוני קבוע. רקע: סיכון סחרחורת בעמידה ונפילות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מדידת ל"ד מתועדת	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	ל"ד ביעד	ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	גיל 80+ שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה?	בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
4	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן.	זימון
7	טיפול כרוני	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
12	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): שבריריות או נפילות. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	ל"ד בעמידה בקשישים
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	שבריריות או נפילות
תלונות בפנייה או ברשומה	סחרחורת בעמידה, נפילה ← לרופא
מקור	פרק 8 עמ' 63, 75; פרק 11 עמ' 92

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.27 קלונידין · Clonidine בתנאים

אגוניסט אלפא מרכזי

שמות מסחריים (2)	נורמופרסאן · Normopresan | קלוניריט · Clonnirit
נימוק / הערה	רק טיפול כרוני קבוע. רקע: קו מתקדם; סיכון בהפסקה פתאומית

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מדידת ל"ד מתועדת	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	ל"ד ביעד	ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	גיל 80+ שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה?	בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
4	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן.	זימון
7	טיפול כרוני	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	לא מופיע בהנחיות
ספי החזרה לרופא/ה	לא מופיע בהנחיות
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	לא להפסיק בפתאומיות
תלונות בפנייה או ברשומה	הפסקה או החמצת מנות ← דחוף - סיכון להתקף היפרטנסיבי
מקור	פרק 8 עמ' 63, 67, 75

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.28 **מתילדופה** · Methyldopa בתנאים

אגוניסט אלפא מרכזי

שמות מסחריים (1)	אלדומין · Aldomin (לא רשום; יבוא תקנה 29)
נימוק / הערה	רק טיפול כרוני קבוע. רקע: בעיקר בהיריון

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מדידת ל"ד מתועדת	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	ל"ד ביעד	ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	גיל 80+ שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה?	בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
4	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן.	זימון
7	טיפול כרוני	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
12	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון ← לרופא (לפי כללי ההחזרה). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	לא מופיע בהנחיות
ספי החזרה לרופא/ה	לא מופיע בהנחיות
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון ← לרופא (לפי כללי ההחזרה)
תלונות בפנייה או ברשומה	הפרעה בתפקודי כבד ← לרופא
מקור	פרק 8 עמ' 75; פרק 26

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.29 מינוקסידיל · Minoxidil בתנאים

מרחיב כלי דם ישיר

שמות מסחריים (1)	מינוקסידיל · Minoxidil (פומי) (לא רשום; יבוא תקנה 29)
נימוק / הערה	רק טיפול כרוני קבוע. רקע: קו אחרון

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מדידת ל"ד מתועדת	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	ל"ד ביעד	ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	גיל 80+ שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה?	בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
4	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן.	זימון
7	טיפול כרוני	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
12	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): אין במקביל חוסם בטא ומשתן לולאה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	לא מופיע בהנחיות
ספי החזרה לרופא/ה	לא מופיע בהנחיות
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	אין במקביל חוסם בטא ומשתן לולאה
תלונות בפנייה או ברשומה	דופק מהיר, בצקות, שיעור יתר ← לרופא
מקור	פרק 8 עמ' 75; פרק 9 עמ' 84

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.30 הידרלזין · Hydralazine בתנאים

מרחיב כלי דם ישיר

שמות מסחריים (1)	הידרלזין · Hydralazine (לא רשום; יבוא תקנה 29)
נימוק / הערה	רק טיפול כרוני קבוע. רקע: קו אחרון

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מדידת ל"ד מתועדת	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	ל"ד ביעד	ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	גיל 80+ שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה?	בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
4	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן.	זימון
7	טיפול כרוני	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	לא מופיע בהנחיות
ספי החזרה לרופא/ה	לא מופיע בהנחיות
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	-
תלונות בפנייה או ברשומה	כאבי מפרקים, פריחה (תסמינים דמויי לופוס) ← לרופא
מקור	פרק 8 עמ' 75

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.31 אמילוריד + הידרוכלורותיאזיד · Amiloride + HCTZ בתנאים

משתן שומר אשלגן + תיאזיד

שמות מסחריים (1)	קלוריל · Kaluril
נימוק / הערה	רק טיפול כרוני קבוע. רקע: סיכון היפרקלמיה בשילוב עם ACEi/ARB

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מדידת ל"ד מתועדת	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	ל"ד ביעד	ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	גיל 80+ שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה?	בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
4	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן, סידן, חומצה אורית.	זימון
7	בדיקות אחרי שינוי שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם?	אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי.	שאלה
8	אשלגן (K) תקין	בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים	
9	נתרן (Na) תקין	בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
10	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים	
11	טיפול כרוני	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע.	
12	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
13	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
14	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
15	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
16	אין התוויות נגד	אין התוויות נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): גאוט פעיל ללא אלופורינול/פבוקסוסטט; eGFR <30. התוויות נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התוויות נגד

מעקב מעבדה	Na, K, קריאטינין תוך 4 שבועות מהתחלה (בייחוד נשים מעל 65); שנתי: Na, K, Ca, חומצה אורית, קריאטינין
ספי החזרה לרופא/ה	Na מחוץ לטווח המעבדה; K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם
ערך חמור	K ≥5.5; eGFR <30
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	גאוט פעיל ללא אלופורינול/פבוקסוסטט; eGFR <30; ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30

תלונות בפנייה או ברשומה	התקף גאוט ← הפסקה אם אין טיפול באלופורינול/פבוקסוסטט; חולשה או בלבול (חשד להיפונתרמיה) ← בדיקת Na; היפונתרמיה ← הפסקה; סידן גבוה בבדיקה ← בירור ומעבר לפורוסמיד
מקור	פרק 8 עמ' 76; פרק 9 עמ' 83-84

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.32 סקוביטריל/ולסרטן · Sacubitril/Valsartan (בתנאים)

ARNI

שמות מסחריים (2)	אנטרסטו · Entresto | סקטור · Sector
נימוק / הערה	תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: אי-ספיקת לב. רק טיפול כרוני קבוע. רקע: התוויה: אי ספיקת לב, לא יל"ד

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מדידת ל"ד מתועדת	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	ל"ד בטווח בטיחות	ל"ד אחרון: סיסטולי 100 ומעלה ומתחת ל-160/100, בלי סחרחורת או עילפון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן.	זימון
6	בדיקות אחרי שינוי שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם?	אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי.	שאלה
7	אשלגן (K) תקין	בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים	
8	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים	
9	טיפול כרוני	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע.	
10	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
11	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
12	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
13	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
14	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): לחדש רק כהמשך טיפול קיים (התוויה: אי ספיקת לב); היריון; שילוב עם ACEi. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	קריאטינין, K, Na תוך 4 שבועות מכל שינוי; שנתי: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, אלבומין/קריאטינין בשתן
ספי החזרה לרופא/ה	K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם
ערך חמור	K ≥5.5; eGFR <30
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	לחדש רק כהמשך טיפול קיים (התוויה: אי ספיקת לב); היריון; שילוב עם ACEi; ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30
מקור	פרק 8 עמ' 69

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.33 רמיפריל + הידרוכלורותיאזיד · Ramipril + HCTZ בתנאים

משולב: ACEi + תיאזיד

שמות מסחריים (2)	טריטייס קומפ · Tritace Comp | רמיפריל פלוס · Ramipril Plus (לאימות מול מאגר משרד הבריאות)
נימוק / הערה	כל רכיב לפי התנאים שלו

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מדידת ל"ד מתועדת	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	ל"ד ביעד	ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	גיל 80+ שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה?	בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
4	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן.	זימון
7	בדיקות אחרי שינוי שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם?	אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי.	שאלה
8	אשלגן (K) תקין	בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה או K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים	
9	נתרן (Na) תקין	בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
10	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים	
11	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
12	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
13	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
14	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
15	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; שילוב ACEi עם ARB; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; NSAIDs באופן קבוע; גאוט פעיל ללא אלופורינול/פבוקסוסטט; eGFR <30; סידן גבוה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	קריאטינין, K, Na תוך 4 שבועות מכל שינוי; שנתי: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, אלבומין/קריאטינין בשתן
ספי החזרה לרופא/ה	K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם; Na מחוץ לטווח המעבדה; K מחוץ לטווח המעבדה

ערך חמור	K ≥5.5; eGFR <30
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; שילוב ACEi עם ARB; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; NSAIDs באופן קבוע; גאוט פעיל ללא אלופורינול/פבוקסוסטט; eGFR <30; סידן גבוה; ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30
תלונות בפנייה או ברשומה	שיעול יבש ← הפסקה ומעבר ל-ARB; התקף גאוט ← הפסקה אם אין טיפול באלופורינול/פבוקסוסטט; חולשה או בלבול (חשד להיפונתרמיה) ← בדיקת Na; היפונתרמיה ← הפסקה; סידן גבוה בבדיקה ← בירור ומעבר לפורוסמיד
מקור	פרק 8 עמ' 76

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.34 סילזפריל + הידרוכלורותיאזיד · Cilazapril + HCTZ בתנאים

משולב: ACEi + תיאזיד

שמות מסחריים (1)	סילריל פלוס · Cilaril Plus
נימוק / הערה	כל רכיב לפי התנאים שלו

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מדידת ל"ד מתועדת	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	ל"ד ביעד	ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	גיל 80+ שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה?	בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
4	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן.	זימון
7	בדיקות אחרי שינוי שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם?	אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי.	שאלה
8	אשלגן (K) תקין	בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה או K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים	
9	נתרן (Na) תקין	בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
10	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים	
11	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
12	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
13	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
14	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
15	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; שילוב ACEi עם ARB; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; NSAIDs באופן קבוע; גאוט פעיל ללא אלופורינול/פבוקסוסטט; eGFR <30; סידן גבוה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	קריאטינין, K, Na תוך 4 שבועות מכל שינוי; שנתי: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, אלבומין/קריאטינין בשתן
ספי החזרה לרופא/ה	K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם; Na מחוץ לטווח המעבדה; K מחוץ לטווח המעבדה

ערך חמור	K ≥5.5; eGFR <30
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; שילוב ACEi עם ARB; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; NSAIDs באופן קבוע; גאוט פעיל ללא אלופורינול/פבוקסוסטט; eGFR <30; סידן גבוה; ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30
תלונות בפנייה או ברשומה	שיעול יבש ← הפסקה ומעבר ל-ARB; התקף גאוט ← הפסקה אם אין טיפול באלופורינול/פבוקסוסטט; חולשה או בלבול (חשד להיפונתרמיה) ← בדיקת Na; היפונתרמיה ← הפסקה; סידן גבוה בבדיקה ← בירור ומעבר לפורוסמיד
מקור	פרק 8 עמ' 76

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.35 לוסרטן + הידרוכלורותיאזיד · Losartan + HCTZ בתנאים

משולב: ARB + תיאזיד

שמות מסחריים (4)	אוקסאאר פלוס · Ocsaar Plus	לוטן פלוס · Lotan Plus	לוסרטה פלוס · Losarta Plus	לוסרדקס פלוס · Losardex Plus
נימוק / הערה	כל רכיב לפי התנאים שלו

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מדידת ל"ד מתועדת	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	ל"ד ביעד	ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	גיל 80+ שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה?	בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
4	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן.	זימון
7	בדיקות אחרי שינוי שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם?	אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי.	שאלה
8	אשלגן (K) תקין	בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה או K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים	
9	נתרן (Na) תקין	בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
10	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים	
11	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
12	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
13	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
14	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
15	אין התוויות נגד	אין התוויות נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; שילוב ARB עם ACEi; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; NSAIDs באופן קבוע; גאוט פעיל ללא אלופורינול/פבוקסוסטט; eGFR <30; סידן גבוה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התוויות נגד

מעקב מעבדה	קריאטינין, K, Na תוך 4 שבועות מכל שינוי; שנתי: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, אלבומין/קריאטינין בשתן

ספי החזרה לרופא/ה	K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם; Na מחוץ לטווח המעבדה; K מחוץ לטווח המעבדה
ערך חמור	K ≥5.5; eGFR <30
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; שילוב ARB עם ACEi; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; NSAIDs באופן קבוע; גאוט פעיל ללא אלופורינול/פבוקסוסטט; eGFR <30; סידן גבוה; ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30
תלונות בפנייה או ברשומה	התקף גאוט ← הפסקה אם אין טיפול באלופורינול/פבוקסוסטט; חולשה או בלבול (חשד להיפונתרמיה) ← בדיקת Na; היפונתרמיה ← הפסקה; סידן גבוה בבדיקה ← בירור ומעבר לפורוסמיד
מקור	פרק 8 עמ' 76

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.36 קנדסרטן + הידרוכלורותיאזיד · Candesartan + HCTZ בתנאים

משולב: ARB + תיאזיד

שמות מסחריים (2)	אטקנד פלוס · Atacand Plus | קנדור פלוס · Candor Plus
נימוק / הערה	כל רכיב לפי התנאים שלו

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מדידת ל"ד מתועדת	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	ל"ד ביעד	ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	גיל 80+ שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה?	בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
4	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן.	זימון
7	בדיקות אחרי שינוי שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם?	אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי.	שאלה
8	אשלגן (K) תקין	בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה או K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים	
9	נתרן (Na) תקין	בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
10	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים	
11	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
12	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
13	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
14	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
15	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; שילוב ARB עם ACEi; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; NSAIDs באופן קבוע; גאוט פעיל ללא אלופורינול/פבוקסוסטט; eGFR <30; סידן גבוה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	קריאטינין, K, Na תוך 4 שבועות מכל שינוי; שנתי: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, אלבומין/קריאטינין בשתן
ספי החזרה לרופא/ה	K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם; Na מחוץ לטווח המעבדה; K מחוץ לטווח המעבדה

ערך חמור	K ≥5.5; eGFR <30
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; שילוב ARB עם ACEi; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; NSAIDs באופן קבוע; גאוט פעיל ללא אלופורינול/פבוקסוסטט; eGFR <30; סידן גבוה; ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30
תלונות בפנייה או ברשומה	התקף גאוט ← הפסקה אם אין טיפול באלופורינול/פבוקסוסטט; חולשה או בלבול (חשד להיפונתרמיה) ← בדיקת Na; היפונתרמיה ← הפסקה; סידן גבוה בבדיקה ← בירור ומעבר לפורוסמיד
מקור	פרק 8 עמ' 76

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.37 ולסרטן + הידרוכלורותיאזיד · Valsartan + HCTZ בתנאים

משולב: ARB + תיאזיד

שמות מסחריים (2)	קו-דיובאן · Co-Diovan | וקטור פלוס · Vector Plus
נימוק / הערה	כל רכיב לפי התנאים שלו

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מדידת ל"ד מתועדת	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	ל"ד ביעד	ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	גיל 80+ שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה?	בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
4	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן.	זימון
7	בדיקות אחרי שינוי שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם?	אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי.	שאלה
8	אשלגן (K) תקין	בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה או K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים	
9	נתרן (Na) תקין	בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
10	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים	
11	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
12	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
13	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
14	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
15	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; שילוב ARB עם ACEi; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; NSAIDs באופן קבוע; גאוט פעיל ללא אלופורינול/פבוקסוסטט; eGFR <30; סידן גבוה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	קריאטינין, K, Na תוך 4 שבועות מכל שינוי; שנתי: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, אלבומין/קריאטינין בשתן
ספי החזרה לרופא/ה	K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם; Na מחוץ לטווח המעבדה; K מחוץ לטווח המעבדה

ערך חמור	K ≥5.5; eGFR <30
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; שילוב ARB עם ACEi; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; NSAIDs באופן קבוע; גאוט פעיל ללא אלופורינול/פבוקסוסטט; eGFR <30; סידן גבוה; ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30
תלונות בפנייה או ברשומה	התקף גאוט ← הפסקה אם אין טיפול באלופורינול/פבוקסוסטט; חולשה או בלבול (חשד להיפונתרמיה) ← בדיקת Na; היפונתרמיה ← הפסקה; סידן גבוה בבדיקה ← בירור ומעבר לפורוסמיד
מקור	פרק 8 עמ' 76

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.38 אנלפריל + לרקנידיפין · Enalapril + Lercanidipine מתאים

משולב: ACEi + CCB

שמות מסחריים (2)	וזודיפ קומבו · Vasodip Combo | לרקאנפריל טבע · Lercanapril Teva
נימוק / הערה	שילוב מועדף; ניטור כמו ACEi

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מדידת ל"ד מתועדת	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	ל"ד ביעד	ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	גיל 80+ שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה?	בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
4	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן.	זימון
7	בדיקות אחרי שינוי שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם?	אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי.	שאלה
8	אשלגן (K) תקין	בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים	
9	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים	
10	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
11	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
12	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
13	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
14	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; שילוב ACEi עם ARB; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; NSAIDs באופן קבוע; מינון שנקבע בגלל היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	קריאטינין, K, Na תוך 4 שבועות מכל שינוי; שנתי: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, אלבומין/קריאטינין בשתן
ספי החזרה לרופא/ה	K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם
ערך חמור	K ≥5.5; eGFR <30
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; שילוב ACEi עם ARB; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; NSAIDs באופן קבוע; מינון שנקבע בגלל היריון; ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30
תלונות בפנייה או ברשומה	שיעול יבש ← הפסקה ומעבר ל-ARB; בצקת ברגליים ← הפחתת מינון; עיבוי חניכיים ← הפסקה

מקור	
פרק 8 עמ' 65, 76	

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.39 ולסרטן + אמלודיפין · Valsartan + Amlodipine מתאים

משולב: ARB + CCB

שמות מסחריים (4)	אקספורג' · Exforge | דופלקס · Duplex | אמלוואל · Amloval | אמלודיפין/ולסרטן דקסל · Amlodipine/Valsartan Dexcel
נימוק / הערה	שילוב מועדף; ניטור כמו ARB

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מדידת ל"ד מתועדת	נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר.	זימון
2	ל"ד ביעד	ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	גיל 80+ שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה?	בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
4	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול).	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן.	זימון
7	בדיקות אחרי שינוי שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם?	אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי.	שאלה
8	אשלגן (K) תקין	בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים	
9	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים	
10	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
11	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
12	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
13	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
14	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; שילוב ARB עם ACEi; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; NSAIDs באופן קבוע; מינון שנקבע בגלל היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	קריאטינין, K, Na תוך 4 שבועות מכל שינוי; שנתי: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, אלבומין/קריאטינין בשתן
ספי החזרה לרופא/ה	K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם
ערך חמור	K ≥5.5; eGFR <30
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; שילוב ARB עם ACEi; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; NSAIDs באופן קבוע; מינון שנקבע בגלל היריון; ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30

תלונות בפנייה או ברשומה	בצקת ברגליים ← הפחתת מינון או מעבר ללרקנידיפין; עיבוי חניכיים ← הפסקה
מקור	פרק 8 עמ' 65, 76

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.40 **אטורבסטטין** · Atorvastatin מתאים

שומנים · סטטין

שמות מסחריים (4)	ליפיטור · Lipitor | ליטורבה · Litorva | טורבה · Torva | אטורבה-דקס · Atorva-Dex
נימוק / הערה	מעקב LDL; ללא בדיקות כבד ושריר שגרתיות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	LDL מתועד	פרופיל שומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	LDL יציב	LDL לא עלה ב-30% או יותר לעומת הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	תפקודי כבד (ALT) תקין	בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון (אם נבדק) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
6	CPK (אם נבדק) תקין	בבדיקה האחרונה CPK (אם נבדק) תקין. חמור: CPK מעל פי 10 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התוויות נגד
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
11	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; מחלת כבד פעילה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התוויות נגד

מעקב מעבדה	פרופיל שומנים כל 6-12 חודשים; ALT ו-CPK רק לפי תסמינים
ספי החזרה לרופא/ה	ALT מעל פי 3 מהגבול העליון (אם נבדק)
ערך חמור	CPK מעל פי 10 מהגבול העליון
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; מחלת כבד פעילה
תלונות בפנייה או ברשומה	כאבי שרירים או חולשה ← לרופא + CPK; שתן כהה עם חולשת שרירים ← דחוף
מקור	הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 50-53

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.41 רוזובסטטין · Rosuvastatin מתאים

שומנים · סטטין

שמות מסחריים (7)	קרסטור · Crestor	סטטור · Stator	רוזובסטטין מדו · Rosuvastatin Medo	רוזובסטטין אינובמד · Rosuvastatin Inovamed	רוזובסטטין סנדוז · Rosuvastatin Sandoz	רוזובסטטין טבע · Rosuvastatin Teva	רוסובסטטין ויטאמד · Rosuvastatin Vitamed
נימוק / הערה	מעקב LDL

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	LDL מתועד	פרופיל שומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	LDL יציב	LDL לא עלה ב-30% או יותר לעומת הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	תפקודי כבד (ALT) תקין	בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון (אם נבדק) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
6	CPK (אם נבדק) תקין	בבדיקה האחרונה CPK (אם נבדק) תקין. חמור: CPK מעל פי 10 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התוויות נגד
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
11	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; מחלת כבד פעילה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התוויות נגד

מעקב מעבדה	פרופיל שומנים כל 6-12 חודשים; ALT ו-CPK רק לפי תסמינים
ספי החזרה לרופא/ה	ALT מעל פי 3 מהגבול העליון (אם נבדק)
ערך חמור	CPK מעל פי 10 מהגבול העליון
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; מחלת כבד פעילה
תלונות בפנייה או ברשומה	כאבי שרירים או חולשה ← לרופא + CPK; שתן כהה עם חולשת שרירים ← דחוף
מקור	הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 50-53

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.42 סימבסטטין · Simvastatin מתאים

שומנים · סטטין

שמות מסחריים (3)	סימבקור · Simvacor | סימבקסון · Simvaxon | סימבסטאטין טבע · Simvastatin Teva
נימוק / הערה	מעקב LDL

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	LDL מתועד	פרופיל שומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	LDL יציב	LDL לא עלה ב-30% או יותר לעומת הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	תפקודי כבד (ALT) תקין	בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון (אם נבדק) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
6	CPK (אם נבדק) תקין	בבדיקה האחרונה CPK (אם נבדק) תקין. חמור: CPK מעל פי 10 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התוויית נגד
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
11	אין התוויית נגד	אין התוויית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; מחלת כבד פעילה. התוויית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התוויית נגד

מעקב מעבדה	פרופיל שומנים כל 6-12 חודשים; ALT ו-CPK רק לפי תסמינים
ספי החזרה לרופא/ה	ALT מעל פי 3 מהגבול העליון (אם נבדק)
ערך חמור	CPK מעל פי 10 מהגבול העליון
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; מחלת כבד פעילה
תלונות בפנייה או ברשומה	כאבי שרירים או חולשה ← לרופא + CPK; שתן כהה עם חולשת שרירים ← דחוף
מקור	הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 50-53

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.43 פרבסטטין · Pravastatin מתאים

שומנים · סטטין

שמות מסחריים (3)	פרבליפ · Pravalip | פרבה טבע · Prava Teva | פרבסטאטין טבע · Pravastatin Teva
נימוק / הערה	מעקב LDL

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	LDL מתועד	פרופיל שומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	LDL יציב	LDL לא עלה ב-30% או יותר לעומת הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	תפקודי כבד (ALT) תקין	בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון (אם נבדק) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
6	CPK (אם נבדק) תקין	בבדיקה האחרונה CPK (אם נבדק) תקין. חמור: CPK מעל פי 10 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התוויית נגד
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
11	אין התוויית נגד	אין התוויית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; מחלת כבד פעילה. התוויית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התוויית נגד

מעקב מעבדה	פרופיל שומנים כל 6-12 חודשים; ALT ו-CPK רק לפי תסמינים
ספי החזרה לרופא/ה	ALT מעל פי 3 מהגבול העליון (אם נבדק)
ערך חמור	CPK מעל פי 10 מהגבול העליון
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; מחלת כבד פעילה
תלונות בפנייה או ברשומה	כאבי שרירים או חולשה ← לרופא + CPK; שתן כהה עם חולשת שרירים ← דחוף
מקור	הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 50-53

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.44 אזטימיב · Ezetimibe מתאים

שומנים · מעכב ספיגת כולסטרול

שמות מסחריים (5)	אזטרול · Ezetrol | אזקור · Ezecor | אזטימיב סנדוז · Ezetimibe Sandoz | אזטימיב תרו · Ezetimibe Taro | אזטימיב טבע · Ezetimibe Teva
נימוק / הערה	מעקב LDL

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	LDL מתועד	פרופיל שומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	LDL יציב	LDL לא עלה ב-30% או יותר לעומת הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
9	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	פרופיל שומנים כל 6-12 חודשים
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון
מקור	הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.45 אטורבסטטין + אזטימיב · Atorvastatin + Ezetimibe מתאים

שומנים · סטטין + אזטימיב

שמות מסחריים (4)	אטוזט · Atozet | אזאטור אס.קיי. · Ezator S.K | אזהאטורבה · Ezeatorva | טורז · Torez
נימוק / הערה	מעקב LDL

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	LDL מתועד	פרופיל שומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	LDL יציב	LDL לא עלה ב-30% או יותר לעומת הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	תפקודי כבד (ALT) תקין	בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון (אם נבדק) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
6	CPK (אם נבדק) תקין	בבדיקה האחרונה CPK (אם נבדק) תקין. חמור: CPK מעל פי 10 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התוויות נגד
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
11	אין התוויות נגד	אין התוויות נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; מחלת כבד פעילה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התוויות נגד

מעקב מעבדה	פרופיל שומנים כל 6-12 חודשים; ALT ו-CPK רק לפי תסמינים; פרופיל שומנים כל 6-12 חודשים
ספי החזרה לרופא/ה	ALT מעל פי 3 מהגבול העליון (אם נבדק)
ערך חמור	CPK מעל פי 10 מהגבול העליון
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; מחלת כבד פעילה
תלונות בפנייה או ברשומה	כאבי שרירים או חולשה ← לרופא + CPK; שתן כהה עם חולשת שרירים ← דחוף
מקור	הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 53-50; הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.46 רוזובסטטין + אזטימיב · Rosuvastatin + Ezetimibe מתאים

שומנים · סטטין + אזטימיב

שמות מסחריים (2)	רוזט טבע · Rozet Teva | רוסטמיב אס.קיי. · Rosetemib S.K.
נימוק / הערה	מעקב LDL

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	LDL מתועד	פרופיל שומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	LDL יציב	LDL לא עלה ב-30% או יותר לעומת הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	תפקודי כבד (ALT) תקין	בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון (אם נבדק) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
6	CPK (אם נבדק) תקין	בבדיקה האחרונה CPK (אם נבדק) תקין. חמור: CPK מעל פי 10 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התוויות נגד
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
11	אין התוויות נגד	אין התוויות נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; מחלת כבד פעילה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התוויות נגד

מעקב מעבדה	פרופיל שומנים כל 6-12 חודשים; ALT ו-CPK רק לפי תסמינים; פרופיל שומנים כל 6-12 חודשים
ספי החזרה לרופא/ה	ALT מעל פי 3 מהגבול העליון (אם נבדק)
ערך חמור	CPK מעל פי 10 מהגבול העליון
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; מחלת כבד פעילה
תלונות בפנייה או ברשומה	כאבי שרירים או חולשה ← לרופא + CPK; שתן כהה עם חולשת שרירים ← דחוף
מקור	הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 53-50; הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.47 **אבולוקומאב** · Evolocumab בתנאים

שומנים · מעכב PCSK9 (זריקה)

שמות מסחריים (1)	רפאטה · Repatha
נימוק / הערה	רק אישור סל או שב"ן בתוקף, וטיפול כרוני קבוע. נקבע ע"י רופא/ה; מחודש רק עם אישור מימון בתוקף. מעקב LDL

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	LDL מתועד	פרופיל שומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	LDL יציב	LDL לא עלה ב-30% או יותר לעומת הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	אישור מימון בתוקף	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשיש אישור סל או שב"ן בתוקף, וטיפול כרוני קבוע. אין ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
10	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	פרופיל שומנים כל 6-12 חודשים
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון
תלונות בפנייה או ברשומה	תגובה מקומית קשה באזור ההזרקה ← לרופא; תסמיני שפעת מתמשכים ← לרופא
מקור	הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 (פרק מעכבי PCSK9); עמ' 52

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.48 **אלירוקומאב** · Alirocumab בתנאים

שומנים · מעכב PCSK9 (זריקה)

שמות מסחריים (1)	פראלואנט · Praluent
נימוק / הערה	רק אישור סל או שב"ן בתוקף, וטיפול כרוני קבוע. נקבע ע"י רופא/ה; מחודש רק עם אישור מימון בתוקף. מעקב LDL

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	LDL מתועד	פרופיל שומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	LDL יציב	LDL לא עלה ב-30% או יותר לעומת הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	אישור מימון בתוקף	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשיש אישור סל או שב"ן בתוקף, וטיפול כרוני קבוע. אין ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
10	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	פרופיל שומנים כל 6-12 חודשים
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון
תלונות בפנייה או ברשומה	תגובה מקומית קשה באזור ההזרקה ← לרופא; תסמיני שפעת מתמשכים ← לרופא
מקור	הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 (פרק מעכבי PCSK9); עמ' 52

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.49 אספירין במינון נמוך · Aspirin (low dose) מתאים

נוגדי טסיות · נוגד טסיות

שמות מסחריים (6)	אספירין קרדיו · Aspirin Cardio	קרטיה · Cartia	מיקרופירין · Micropirin	גודמד · Godamed	מדיפירין · Medipirin	טבעפירין · Tevapirin
נימוק / הערה	רק 75-100 מ"ג ליום; ללא נוגד קרישה במקביל

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין נוגד קרישה במקביל	ברשימת התרופות הפעילה אין נוגד קרישה. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: ספירת דם. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
9	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): דימום פעיל או דימום משמעותי מאז הביקור האחרון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	ספירת דם שנתית
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	דימום פעיל או דימום משמעותי מאז הביקור האחרון
תלונות בפנייה או ברשומה	צואה שחורה או דם בצואה ← דחוף; חבורות או דימומים חריגים ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.50 קלופידוגרל · Clopidogrel בתנאים

נוגדי טסיות · נוגד טסיות

שמות מסחריים (4)	פלויקס · Plavix | קלוד · Clood | קלופידקסל · Clopidexcel | קלופידוגרל טבע · Clopidogrel Teva
נימוק / הערה	רק טיפול כרוני קבוע. רק טיפול כרוני שנקבע לטווח ארוך; טיפול קצוב אחרי צנתור ← רופא

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין נוגד קרישה במקביל	ברשימת התרופות הפעילה אין נוגד קרישה. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: ספירת דם. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
5	טיפול כרוני	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע.	
6	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
10	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): דימום פעיל או דימום משמעותי מאז הביקור האחרון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	ספירת דם שנתית
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	דימום פעיל או דימום משמעותי מאז הביקור האחרון
תלונות בפנייה או ברשומה	צואה שחורה או דם בצואה ← דחוף; חבורות או דימומים חריגים ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.51 בזאפיברט · Bezafibrate מתאים

שומנים · פיברט

שמות מסחריים (2)	נורליפ · Norlip | בזאפיבראט מדומי · Bezafibrate Medomie
נימוק / הערה	מעקב כליות וכבד

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	בדיקות מתועדות	קריאטינין/eGFR, ALT ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR >60 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <15 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <15 ← לא מחדשים	
3	תפקודי כבד (ALT) תקין	בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	קריאטינין ו-ALT שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR >60 (לבדיקת מינון); ALT מעל פי 3 מהגבול העליון
ערך חמור	eGFR <15
תלונות בפנייה או ברשומה	כאבי שרירים או חולשה ← לרופא + CPK
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.52 **טיקגרלור** · Ticagrelor בתנאים

נוגד טסיות (P2Y12)

שמות מסחריים (8)	ברילינטה · Brilinta	טיקאטה · Ticata	טיקבניר · Ticavenir	טיקגרלור טבע · Ticagrelor Teva	טיקגרלור תרו · Ticagrelor Taro	טיקגרלור אס.קיי. · Ticagrelor S.K.	טיקגרלור אינובמד · Ticagrelor Inovamed	טיקגרלור פרופארם · Ticagrelor Propharm
נימוק / הערה	משך הטיפול נקבע ע"י הקרדיולוג/ית (לרוב 12 חודשים אחרי אירוע). אספירין עד 100 מ"ג

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	בתוך משך הטיפול שנקבע	תאריך סיום הטיפול מתועד במכתב הקרדיולוג/ית ועוד לא הגיע. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	אין דימום מתועד	ברשומה או בפנייה אין צואה שחורה, דם בצואה או דימום משמעותי. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	אין נוגד קרישה במקביל	ברשימת התרופות אין נוגד קרישה (קומדין, אליקוויס, קסרלטו, פרדקסה). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
4	אספירין עד 100 מ"ג	אם יש אספירין: מינון 75-100 מ"ג. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י קרדיולוג/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	דימום ← דחוף; קוצר נשימה חדש ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.53 פרסוגרל · Prasugrel בתנאים

נוגד טסיות (P2Y12)

שמות מסחריים (2)	פרסוגרל טבע · Prasugrel Teva | פרסוגרל-תרימה · Prasugrel-Trima
נימוק / הערה	אסור אחרי שבץ; גיל 75+ או משקל מתחת ל-60 ק"ג - מינון מופחת

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	בתוך משך הטיפול שנקבע	תאריך סיום הטיפול מתועד במכתב הקרדיולוג/ית ועוד לא הגיע. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	אין דימום מתועד	ברשומה או בפנייה אין צואה שחורה, דם בצואה או דימום משמעותי. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	אין נוגד קרישה במקביל	ברשימת התרופות אין נוגד קרישה (קומדין, אליקוויס, קסרלטו, פרדקסה). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י קרדיולוג/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
11	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): שבץ או אירוע מוחי חולף בעבר. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	שבץ או אירוע מוחי חולף בעבר
תלונות בפנייה או ברשומה	דימום ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.54 איזוסורביד מונוניטרט · Isosorbide mononitrate (מתאים)

ניטרט

שמות מסחריים (1)	מונוקורד · Monocord
נימוק / הערה	אסור עם מעכבי PDE5 (ויאגרה, סיאליס)

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין החמרה בתעוקה	ברשומה או בפנייה אין כאב בחזה חדש או מחמיר. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
2	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
5	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
6	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
7	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
8	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): מעכב PDE5 (סילדנאפיל, טדלפיל). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	מעכב PDE5 (סילדנאפיל, טדלפיל)
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב בחזה במנוחה ← דחוף - מיון; סחרחורת או עילפון ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.55 פלקאיניד · Flecainide בתנאים

נוגד הפרעות קצב (IC)

שמות מסחריים (2)	טמבוקור · Tambocor | פלקאיניד אמ.בי.איי · Flecainide MBI
נימוק / הערה	אסור במחלת לב מבנית או איסכמית. אק"ג שנתי

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אק"ג וקריאטינין מתועדים	אק"ג וקריאטינין/eGFR מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	אק"ג ללא שינוי	QRS לא התרחב ואין הפרעת הולכה חדשה לפי פענוח האק"ג. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <35 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י קרדיולוג/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 OP = 2 אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
11	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): מחלת לב איסכמית או אוטם בעבר; אי-ספיקת לב או ירידה בתפקוד החדר השמאלי. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	אק"ג שנתי; קריאטינין שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <35 (לבדיקת מינון)
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	מחלת לב איסכמית או אוטם בעבר; אי-ספיקת לב או ירידה בתפקוד החדר השמאלי
תלונות בפנייה או ברשומה	עילפון או דפיקות לב ← דחוף; כאב בחזה או קוצר נשימה ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.56 פרופפנון · Propafenone בתנאים

נוגד הפרעות קצב (IC)

שמות מסחריים (2)	ריתמונורם · Rytmonorm | פרופקס · Profex
נימוק / הערה	אסור במחלת לב מבנית או איסכמית. אק"ג שנתי

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אק"ג וקריאטינין מתועדים	אק"ג וקריאטינין/eGFR מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	אק"ג ללא שינוי	QRS לא התרחב ואין הפרעת הולכה חדשה לפי פענוח האק"ג. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <35 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י קרדיולוג/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 OP = 2 אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
11	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): מחלת לב איסכמית או אוטם בעבר; אי-ספיקת לב או ירידה בתפקוד החדר השמאלי. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	אק"ג שנתי; קריאטינין שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <35 (לבדיקת מינון)
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	מחלת לב איסכמית או אוטם בעבר; אי-ספיקת לב או ירידה בתפקוד החדר השמאלי
תלונות בפנייה או ברשומה	עילפון או דפיקות לב ← דחוף; כאב בחזה או קוצר נשימה ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.57 דרונדרון · Dronedarone בתנאים

נוגד הפרעות קצב

שמות מסחריים (2)	מולטאק · Multaq | דרונקור · Droncor
נימוק / הערה	אסור באי-ספיקת לב מתקדמת ובפרפור פרוזדורים קבוע. אינטראקציות (דביגטרן, דיגוקסין)

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	בדיקות מתועדות	ALT וקריאטינין/eGFR מ-6 החודשים האחרונים; אק"ג מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה ב-30% ומעלה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים	
3	תפקודי כבד (ALT) תקין	בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
4	אין תרופה עם אינטראקציה	ברשימת התרופות אין דביגטרן (פרדקסה), דיגוקסין או סימבסטטין מעל 10 מ"ג. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י קרדיולוג/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
12	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): אי-ספיקת לב מתקדמת; פרפור פרוזדורים קבוע. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	ALT וקריאטינין כל 6 חודשים; אק"ג שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	ALT מעל פי 3 מהגבול העליון; קריאטינין עלה ב-30% ומעלה
ערך חמור	eGFR <30
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	אי-ספיקת לב מתקדמת; פרפור פרוזדורים קבוע
תלונות בפנייה או ברשומה	קוצר נשימה או בצקות ← דחוף; צהבת או שתן כהה ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.58 **אינקליסירן** · Inclisiran בתנאים

שומנים · siRNA נגד PCSK9 (זריקה כל 6 חודשים)

שמות מסחריים (1)	לקוויו · Leqvio
נימוק / הערה	רק אישור סל או שב"ן בתוקף, וטיפול כרוני קבוע. זריקה במרפאה פעם ב-6 חודשים (אחרי מנת העמסה). מעקב LDL

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	LDL מתועד	פרופיל שומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	LDL יציב	LDL לא עלה ב-30% או יותר לעומת הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	אישור מימון בתוקף	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשיש אישור סל או שב"ן בתוקף, וטיפול כרוני קבוע. אין ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
10	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	פרופיל שומנים כל 6-12 חודשים
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון
תלונות בפנייה או ברשומה	תגובה מקומית קשה באזור ההזרקה ← לרופא; תסמיני שפעת מתמשכים ← לרופא
מקור	הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 (פרק מעכבי PCSK9); עמ' 52

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.59 מידודרין · Midodrine בתנאים

יל"ד אורתוסטטי

שמות מסחריים (1)	מידודרין מורנינגסייד · Midodrine Morningside
נימוק / הערה	יל"ד בשכיבה; לא ליטול לפני שינה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	ל"ד מתועד	מדידת ל"ד מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	ל"ד בשכיבה מתחת ל-160/90	ל"ד אחרון (בשכיבה או בישיבה) מתחת ל-160/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	אין אצירת שתן	ברשומה או בפנייה אין אצירת שתן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ה מומחה/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	ל"ד בשכיבה ובעמידה
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב ראש חזק או דפיקות לב בשכיבה ← לרופא; קושי במתן שתן ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.60 פנטוקסיפילין · Pentoxifylline מתאים

צליעה לסירוגין

שמות מסחריים (1)	אוקסופורין · Oxopurin
נימוק / הערה	תועלת מוגבלת; זהירות עם נוגדי קרישה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין דימום מתועד	ברשומה או בפנייה אין צואה שחורה, דם בצואה או דימום משמעותי. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
2	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
5	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
6	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
7	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
תלונות בפנייה או ברשומה	דימום ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.61 **דיפירידמול** · Dipyridamole בתנאים

נוגד טסיות

שמות מסחריים (1)	קורוסן · Corosan
נימוק / הערה	לרוב עם אספירין אחרי שבץ

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין דימום מתועד	ברשומה או בפנייה אין צואה שחורה, דם בצואה או דימום משמעותי. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
2	אין נוגד קרישה במקביל	ברשימת התרופות אין נוגד קרישה (קומדין, אליקוויס, קסרלטו, פרדקסה). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
6	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
תלונות בפנייה או ברשומה	דימום ← דחוף; כאב בחזה ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.62 **תרופות לב במעקב מומחה** · Cardiology specialist drugs רופא/ה בלבד

קרדיולוגיה - מומחה

שמות מסחריים (6)	טפמידקס · Tafamidex | טאפיס · Tafis | וינדמקס · Vyndamax | וינדאקל · Vyndaqel | אטרובי · Attruby | קמזיוס · Camzyos
נימוק / הערה	טפמידיס ומבקמטן נקבעים ע"י קרדיולוג/ית מומחה/ית (מבקמטן מחייב אקו לב). להעביר לרופא/ה.
הנחיה	**טפמידיס ומבקמטן נקבעים ע"י קרדיולוג/ית מומחה/ית (מבקמטן מחייב אקו לב). להעביר לרופא/ה.**

מקור	-

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.63 חומצה במפדואית · Bempedoic acid מתאים

שומנים · מעכב ACL

שמות מסחריים (2)	נקסלטול · Nexletol | נקסליזט · Nexlizet (עם אזטימיב)
נימוק / הערה	מעקב LDL; חומצה אורית עלולה לעלות (שיגדון)

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	LDL מתועד	פרופיל שומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	LDL יציב	LDL לא עלה ב-30% או יותר לעומת הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
9	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	פרופיל שומנים כל 6-12 חודשים
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון
מקור	הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.64 אומגה 3 / איקוזפנט אתיל · Omega-3 / icosapent ethyl מתאים

שומנים · אומגה 3 מרשמית

שמות מסחריים (3)	וסקפה · Vazkepa | אומקור · Omacor | ליפופלוס · Lipoplus
נימוק / הערה	מעקב שומנים; איקוזפנט: פרפור ודימום (זהירות עם נוגדי קרישה)

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	LDL מתועד	פרופיל שומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	LDL יציב	LDL לא עלה ב-30% או יותר לעומת הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
9	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	פרופיל שומנים כל 6-12 חודשים
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון
מקור	הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.65 **ציפרופיברט** · Ciprofibrate מתאים

שומנים · פיברט

שמות מסחריים (1)	ליפנור · Lipanor
נימוק / הערה	מעקב כליות וכבד

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	בדיקות מתועדות	קריאטינין/eGFR, ALT ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <60 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים	
3	תפקודי כבד (ALT) תקין	בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	קריאטינין ו-ALT שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <60 (לבדיקת מינון); ALT מעל פי 3 מהגבול העליון
ערך חמור	eGFR <30
תלונות בפנייה או ברשומה	כאבי שרירים או חולשה ← לרופא + CPK
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.66 וריסיגואט · Vericiguat בתנאים

אי-ספיקת לב · מעורר sGC

שמות מסחריים (1)	וורקובו · Verquvo
נימוק / הערה	אסור עם ניטרטים ומעכבי PDE5; ל"ד נמוך

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	ל"ד מתועד	מדידת ל"ד מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	סיסטולי 100 ומעלה	ל"ד סיסטולי אחרון 100 ומעלה, בלי סחרחורת או עילפון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י קרדיולוג/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
6	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
10	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): ניטרטים; מעכב PDE5 (סילדנאפיל, טדלפיל); ריוציגואט; היריון או תכנון היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	ל"ד והמוגלובין
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	ניטרטים; מעכב PDE5 (סילדנאפיל, טדלפיל); ריוציגואט; היריון או תכנון היריון
תלונות בפנייה או ברשומה	סחרחורת או עילפון ← לרופא; קוצר נשימה מחמיר ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.67 ניטרוגליצרין (תת-לשוני) · Nitroglycerin (sublingual) מתאים

ניטרט לפי הצורך

שמות מסחריים (1)	ניטרולינגואל ספריי · Nitrolingual Spray
נימוק / הערה	שימוש תכוף או מחמיר = תעוקה לא יציבה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	שימוש לא תכוף	פחות ממכל אחד בחודשיים לפי הרכישות, ואין החמרה בשימוש. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
2	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
3	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
4	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
5	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
6	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
7	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): מעכב PDE5 (סילדנאפיל, טדלפיל, ורדנאפיל); וריסיגואט או ריוציגואט. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	מעכב PDE5 (סילדנאפיל, טדלפיל, ורדנאפיל); וריסיגואט או ריוציגואט
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב בחזה שלא חולף אחרי 3 מנות (15 דקות) ← דחוף - 101; כאב בחזה במנוחה או בתדירות עולה ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.68 הפרינים במשקל מולקולרי נמוך · Low-molecular-weight heparins רופא/ה בלבד

נוגד קרישה בזריקה

שמות מסחריים (8)	קלקסן · Clexane | קרוסיה · Crusia | קרוסיה פורטה · Crusia Forte | אנוקספרין קמהדע · Enoxaparin Kamada | אנוקספרין קמהדע פורטה · Enoxaparin Kamada Forte | אנוקספרין לדרקסן · Enoxaparin Ledraxen | פרגמין · Fragmin | אריקסטרה · Arixtra
נימוק / הערה	נוגד קרישה בזריקה: מינון לפי משקל וכליות, משך לפי ההתוויה. חידוש ע"י רופא/ה בלבד.
הנחיה	**נוגד קרישה בזריקה: מינון לפי משקל וכליות, משך לפי ההתוויה. חידוש ע"י רופא/ה בלבד.**

מקור	-

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.69 **דיגוקסין** · Digoxin בתנאים מעקב מעבדה צמוד

גליקוזיד לבבי

שמות מסחריים (2)	דיגוקסין קרן פארמה · Digoxin Kern Pharma | לאנוקסין · Lanoxin (תמיסה)
נימוק / הערה	רמה, אשלגן ותפקוד כליות. לא נעצר ע"י רפואן, מלבד ערך חמור. הרפואן לא משנה מינון

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	רמת דיגוקסין מתועדת	בדיקה מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	רמת התרופה בדם בטווח	בבדיקה האחרונה רמת התרופה בדם בטווח. חריג: רמה מעל 1.2 ng/mL ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: רמה 2.0 ng/mL ומעלה ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: רמה 2.0 ng/mL ומעלה ← לא מחדשים	
3	אשלגן (K) תקין	בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K <3.0 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: K <3.0 ← לא מחדשים	
4	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
5	דופק במנוחה תקין	במדידה האחרונה דופק במנוחה תקין. חריג: מתחת ל-55 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים	
6	בדיקות כל 6 חודשים	מ-6 החודשים האחרונים: אשלגן, קריאטינין/eGFR. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
7	אין תרופה חדשה שמעלה רמה	ברשימת התרופות אין אמיודרון, ורפמיל, דילטיאזם, קלריתרומיצין או משתן שנוסף מאז הבדיקה האחרונה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
8	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
9	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
10	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
11	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
12	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
13	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
14	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	רמת דיגוקסין שנתית; אשלגן וקריאטינין כל 6 חודשים
ספי החזרה לרופא/ה	רמה מעל 1.2 ng/mL; K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם; דופק במנוחה <55
ערך חמור	רמה 2.0 ng/mL ומעלה; K <3.0; דופק במנוחה <50
תלונות בפנייה או ברשומה	בחילות, הקאות, הפרעות ראייה (צבעים) או בלבול (חשד לרעילות) ← דחוף - לרופא עכשיו; דפיקות לב או סחרחורת ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.70 **אמיודרון** · Amiodarone בתנאים מעקב מעבדה צמוד

נוגד הפרעות קצב

שמות מסחריים (2)	פרוקור · Procor | אמיאוקרד · Amiocard
נימוק / הערה	נקבע ע"י קרדיולוג/ית. מעקב תריס, כבד, ריאות ועיניים. הרפואן לא משנה מינון

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	TSH ו-ALT מתועדים	מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	TSH בטווח	TSH בטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	תפקודי כבד (ALT) תקין	בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 2 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
4	דופק במנוחה תקין	במדידה האחרונה דופק במנוחה תקין. חריג: מתחת ל-55 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים	
5	צילום חזה ובדיקת עיניים	מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
6	אין תרופה חדשה עם אינטראקציה	ברשימת התרופות אין וורפרין, דיגוקסין או סימבסטטין שנוסף מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
7	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
8	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
9	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י קרדיולוג/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
10	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
11	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
12	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
13	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	TSH ו-ALT כל 6 חודשים; צילום חזה ובדיקת עיניים שנתית
ספי החזרה לרופא/ה	ALT מעל פי 2 מהגבול העליון; דופק במנוחה <55
ערך חמור	דופק במנוחה <50
תלונות בפנייה או ברשומה	שיעול או קוצר נשימה חדשים ← דחוף; ירידה בראייה ← לרופא; רגישות לשמש או גוון כחלחל בעור ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.71 וורפרין · Warfarin בתנאים מעקב מעבדה צמוד

נוגד קרישה (אנטגוניסט ויטמין K)

שמות מסחריים (1)	קומדין · Coumadin
נימוק / הערה	INR מנוהל ע"י מרפאת נוגדי קרישה או הרופא/ה. לא נעצר ע"י רפואן; הרפואן לא משנה מינון

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	INR מתועד	INR מ-6 השבועות האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	INR בטווח היעד	INR בטווח היעד שתועד (בדרך כלל 2-3; מסתם מכני 2.5-3.5); 5 INR ומעלה ← הודעה דחופה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	אין דימום מתועד	ברשומה או בפנייה אין דימום (צואה שחורה, דם בשתן או בצואה, דימום ממושך) מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
4	אין תרופה חדשה עם אינטראקציה	ברשימת התרופות אין אנטיביוטיקה, אמיודרון, NSAID, נוגד טסיות או נוגד פטרת שנוסף מאז ה-INR האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
6	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
7	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
8	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני; המינון נקבע ע"י מרפאת נוגדי קרישה או הרופא/ה. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
9	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
10	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
11	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
12	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	INR לפחות כל 6 שבועות (לפי מרפאת נוגדי קרישה)
תלונות בפנייה או ברשומה	דימום, צואה שחורה או דם בשתן ← דחוף; חבורות מרובות ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.72 אפיקסבן · Apixaban בתנאים מעקב מעבדה צמוד

נוגד קרישה ישיר (NOAC)

שמות מסחריים (10)	אליקוויס · Eliquis | אפיקס · Apix | אפיקסבן דקסל · Apixaban Dexcel | אפיקסבן אינובמד · Apixaban Inovamed | אפיקסבן פרופארם · Apixaban Propharm | אפיקסבן אס.קיי. · Apixaban S.K. | אפיקסבן סנדוז · Apixaban Sandoz | אפיקסבן תרו · Apixaban Taro | אפיקסבן טבע · Apixaban Teva | אפיקסבן-אבניר · Apixaban-Avenir
נימוק / הערה	מעקב כליות וספירת דם. הרפואן לא משנה מינון

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	קריאטינין וספירת דם מתועדים	מ-12 החודשים האחרונים; בגיל 75+ או eGFR <60 — מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	המוגלובין (Hb) תקין	בבדיקה האחרונה המוגלובין (Hb) תקין. חריג: Hb ירד ב-2 g/dL ומעלה לעומת הקודם או Hb מתחת ל-10 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
3	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <50 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <15 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <15 ← לא מחדשים	
4	אין דימום מתועד	ברשומה או בפנייה אין דימום (צואה שחורה, דם בשתן או בצואה, דימום ממושך) מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
5	אין שילוב מסוכן	ברשימת התרופות אין נוגד קרישה נוסף, נוגד טסיות או NSAID שנוסף מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
7	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
8	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
9	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
10	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
11	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
12	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	קריאטינין/eGFR וספירת דם שנתית (גיל 75+ או eGFR <60: כל 6 חודשים)
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <50 (לבדיקת מינון); Hb ירד ב-2 g/dL ומעלה לעומת הקודם או Hb מתחת ל-10
ערך חמור	eGFR <15
תלונות בפנייה או ברשומה	דימום, צואה שחורה או דם בשתן ← דחוף; חבורות מרובות ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.73 ריברוקסבן · Rivaroxaban

בתנאים | מעקב מעבדה צמוד

נוגד קרישה ישיר (NOAC)

שמות מסחריים (10)	קסרלטו · Xarelto	ריבר טבע · Rivar Teva	ריברוקסבאן תרימה · Rivaroxaban Trima	ריברוקסבן דקסל · Rivaroxaban Dexcel	ריברוקסבן מדו · Rivaroxaban Medo	ריברוקסבאן אן אייץ' · Rivaroxaban NH	ריברוקסבאן פרופארם · Rivaroxaban Propharm	ריברוקסבאן אס.קיי. · Rivaroxaban S.K.	ריברוקסבן סנדוז · Rivaroxaban Sandoz	ריברוקסבן תרו · Rivaroxaban Taro
נימוק / הערה	מעקב כליות וספירת דם. 15/20 מ"ג נלקחים עם ארוחה. הרפואן לא משנה מינון

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	קריאטינין וספירת דם מתועדים	מ-12 החודשים האחרונים; בגיל 75+ או eGFR <60 — מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	המוגלובין (Hb) תקין	בבדיקה האחרונה המוגלובין (Hb) תקין. חריג: Hb ירד ב-2 g/dL ומעלה לעומת הקודם או Hb מתחת ל-10 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
3	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <50 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <15 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <15 ← לא מחדשים	
4	אין דימום מתועד	ברשומה או בפנייה אין דימום (צואה שחורה, דם בשתן או בצואה, דימום ממושך) מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
5	אין שילוב מסוכן	ברשימת התרופות אין נוגד קרישה נוסף, נוגד טסיות או NSAID שנוסף מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
7	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
8	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
9	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
10	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
11	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
12	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	קריאטינין/eGFR וספירת דם שנתית (גיל 75+ או eGFR <60: כל 6 חודשים)
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <50 (לבדיקת מינון); Hb ירד ב-2 g/dL ומעלה לעומת הקודם או Hb מתחת ל-10
ערך חמור	eGFR <15
תלונות בפנייה או ברשומה	דימום, צואה שחורה או דם בשתן ← דחוף; חבורות מרובות ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

1.74 **דביגטרן** · Dabigatran בתנאים מעקב מעבדה צמוד

נוגד קרישה ישיר (NOAC)

שמות מסחריים (3)	פרדקסה · Pradaxa | דביגטרן אס.קיי · Dabigatran S.K. | דביגאטרן טבע · Dabigatran Teva
נימוק / הערה	הכי תלוי בכליות מבין ה-NOACs. הרפואן לא משנה מינון

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	קריאטינין וספירת דם מתועדים	מ-12 החודשים האחרונים; בגיל 75+ או eGFR <60 — מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	המוגלובין (Hb) תקין	בבדיקה האחרונה המוגלובין (Hb) תקין. חריג: Hb ירד ב-2 g/dL ומעלה לעומת הקודם או Hb מתחת ל-10 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
3	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <50 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים	
4	אין דימום מתועד	ברשומה או בפנייה אין דימום (צואה שחורה, דם בשתן או בצואה, דימום ממושך) מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
5	אין שילוב מסוכן	ברשימת התרופות אין נוגד קרישה נוסף, נוגד טסיות או NSAID שנוסף מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
7	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
8	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
9	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
10	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
11	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
12	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	קריאטינין/eGFR וספירת דם שנתית (גיל 75+ או eGFR <60: כל 6 חודשים)
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <50 (לבדיקת מינון); Hb ירד ב-2 g/dL ומעלה לעומת הקודם או Hb מתחת ל-10
ערך חמור	eGFR <30
תלונות בפנייה או ברשומה	דימום, צואה שחורה או דם בשתן ← דחוף; חבורות מרובות ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2. סוכרת ואנדוקרינולוגיה

50 תרופות · מתאים: 20 · בתנאים: 27 · רופא/ה בלבד: 3 · גרסה 2 · חלוקה לפי מערכות · 2.11.2026

מקורות: ADA Standards of Care 2026 (פרקים 6, 9); קווי הכוונה לטיפול בסוכרת סוג 2 (עדכון 13.01.2021); הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020; ACOG 2023 (סיכום AFP). שאר התחומים: החלטה מקומית; עלון לצרכן לפונקס (עודכן 12/2020). שאר התרופות: החלטה מקומית

2.א כללים

- חידוש רגיל: 3 חודשים
- ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה פעם בשנה
- עד 3 חידושים רצופים, ואז ביקור רופא
- אין התווית נגד ← תמיד מחדשים לפחות לחודש אחד
- חסרה מדידה, בדיקה או ביקורת שנתית: חידוש לחודש אחד + זימון למרפאה
- חריגה מספי ההחזרה: חידוש לחודש אחד + הודעה לרופא/ה
- התווית נגד או ערך חמור: לא מחדשים, הודעה לרופא/ה (הסף של כל תרופה מופיע ברשימה שלה)
- רפואן לא משנה מינון ולא מחליף תרופה. "מעקב מעבדה צמוד" = תרופה עם בדיקות תכופות — לבדוק בקפידה
- ערך חמור בסוכרת: מטפורמין eGFR <30; גליבנקלמיד eGFR <60; סולפונילאוריאה eGFR <15; פיוגליטזון ALT מעל פי 2.5
- אינסולין בטיפול קבוע וכל הבדיקות תקינות: 3 חודשים. כל חריגה ← חודש באותו מינון + הודעה; אינסולין לא נעצר ע"י רפואן
- פורקסיגה, ג'רדיאנס, אוזמפיק/וגובי ומונג'רו (כמה התוויות): בלי HbA1c; יעד הטיפול נבדק ע"י הרופא/ה
- לבותירוקסין, הידרוקורטיזון וסטרואידים לא נעצרים ע"י רפואן: כל חריגה ← חודש + הודעה

2.ג בדיקות משותפות

שלב	נושא	מה בודקים	קריטריון	אם לא מתקיים	מקור
לפני כל חידוש	HbA1c מתועד	בדיקה מ-6 החודשים האחרונים	לפחות פעמיים בשנה	אין ← חידוש לחודש אחד + זימון לבדיקה	ADA פרק 6 עמ' 132-133; החלטה סוכרת-1
לפני כל חידוש	HbA1c יציב	הערך האחרון לעומת הבדיקה הקודמת	לא עלה ב-0.5% או יותר. בתרופה שגורמת להיפוגליקמיה (אינסולין, סולפונילאוריאה, רפגליניד): לא מתחת ל-6.5%	עלייה, ערך נמוך או אין בדיקה קודמת ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה; ≥10% ← הודעה דחופה באותו יום	החלטות סוכרת-2-4
לפני כל חידוש	היפוגליקמיה	רשומה מאז הביקור האחרון (רק בתרופות שגורמות להיפוגליקמיה)	אין סוכר מתחת ל-70, פנייה למיון או טיפול בגלוקגון	יש ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה	ADA פרק 6 עמ' 144-145; החלטה סוכרת-5
לפני כל חידוש	רכישות	כיסוי ימים ב-6 החודשים האחרונים	80% מהימים ומעלה	פחות ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה	החלטה מקומית (כמו ביל"ד)
לפני כל חידוש	ביקורת שנתית	ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה	ב-12 החודשים האחרונים	אין ביקור ← חידוש לחודש + זימון לביקורת במרפאה	החלטה מקומית (כמו ביל"ד)
לפני כל חידוש	בדיקות שנתיות	ב-12 החודשים האחרונים	קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים; מטפורמין: B12 כל שנתיים; פיוגליטזון: ALT	חסר ← חידוש לחודש + זימון לבדיקות	קווי הכוונה עמ' 17, 23; ADA פרק 9 עמ' 203; החלטה סוכרת-12
לפני כל חידוש	תפקוד כליות	eGFR האחרון	ספים לפי התרופה (ראו בכל תרופה)	חריגה ← חידוש לחודש + הודעה; ערך חמור ← לא מחדשים	החלטות סוכרת-6-9
לפני כל חידוש	רצף חידושים	כמה חידושים רצופים מאז ביקור רופא	פחות מ-3	3 חידושים כבר בוצעו ← ביקור רופא	החלטה מקומית (כמו ביל"ד)
החזרה מיידית לרופא	סוכר גבוה מאוד	הבדיקה האחרונה	HbA1c ≥10% או סוכר ≥300 מ"ג/ד"ל	חידוש לחודש + הודעה דחופה באותו יום	ADA פרק 9 עמ' 198, 203
החזרה מיידית לרופא	היפוגליקמיה חמורה	מופיע בפנייה או ברשומה	איבוד הכרה, עזרת אדם אחר, פנייה למיון	חידוש לחודש + הודעה דחופה	ADA פרק 6 עמ' 145

שלב	נושא	מה בודקים	קריטריון	אם לא מתקיים	מקור
החזרה מיידית לרופא	היריון	היריון או תכנון היריון	תרופות פומיות ו-GLP-1: לא מחדשים. אינסולין: חידוש לחודש	הודעה דחופה לרופא/ה	ADA פרק 9 עמ' 211-212
החזרה מיידית לרופא	חשד ל-DKA או לדלקת לבלב	מופיע בפנייה או ברשומה	SGLT2: הקאות, כאבי בטן, חולשה. GLP-1/DPP-4: כאב בטן עליון חזק	דחוף - לרופא עכשיו	ADA פרק 9 עמ' 193-195
לפני כל חידוש	בדיקת מעקב	לפי התרופה	שומנים: LDL; לבותירוקסין: TSH; אלופורינול/פבוקסוסטט: חומצה אורית — מ-12 החודשים האחרונים	אין ← חידוש לחודש + זימון לבדיקה	הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52; החלטה כללי-1

2.ד החלטות

#	נושא	מה ההנחיה אומרת	ההחלטה לפרוטוקול	סוג	מקור
סוכרת-1	תדירות HbA1c	ADA: לפחות פעמיים בשנה; כל 3 חודשים כשלא ביעד או אחרי שינוי	נדרש HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש + זימון לבדיקה	הנחיה	ADA 6.2, עמ' 132-133
סוכרת-2	HbA1c לעומת הבדיקה הקודמת	ADA: יעד אישי; <7% לרוב המבוגרים, עד 8% במצב בריאותי מורכב; קווי הכוונה: <7%	אין סף קבוע: משווים לבדיקה הקודמת. עלייה של 0.5% או יותר, או אין בדיקה קודמת ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. בכל מקרה מחדשים לפחות לחודש	החלטה מקומית	ADA 6.3a-6.5, עמ' 135, 138; קווי הכוונה עמ' 12
סוכרת-3	HbA1c גבוה מאוד	ADA: לשקול אינסולין ב->10% HbA1c או סוכר ≥300	HbA1c ≥10% ← חידוש לחודש + הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום	החלטה מקומית	ADA 9.20, עמ' 198
סוכרת-4	סף תחתון בתרופות שגורמות להיפוגליקמיה	ADA: להפחית אינסולין, סולפונילאוריאה ומגליטיניד בסיכון גבוה להיפוגליקמיה	באינסולין, סולפונילאוריאה ורפגלינידי: HbA1c <6.5% ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה (בכל גיל)	החלטה מקומית	ADA 6.6, טבלה 6.5, עמ' 135, 140
סוכרת-5	היפוגליקמיה מתועדת	ADA: אירוע דרגה 2 או 3 מחייב הערכה מחדש של הטיפול	תיעוד היפוגליקמיה מאז הביקור האחרון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה	הנחיה	ADA 6.19, עמ' 145
סוכרת-6	מטפורמין ותפקוד כליות	ADA וקווי הכוונה: הפחתת מינון ב-eGFR <45; התווית נגד ב-eGFR <30	eGFR <45 ← חידוש לחודש + הודעה (בדיקת מינון). eGFR <30 ← ערך חמור, לא מחדשים	הנחיה	ADA עמ' 193, 205; קווי הכוונה עמ' 42
סוכרת-7	SGLT2 ותפקוד כליות	קווי הכוונה 2021: להפסיק אמפגליפלוזין <45. ADA 2026: להמשיך עד דיאליזה; להתחיל אם eGFR >20	eGFR <45 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה, שמכריע בין המקורות. לא ערך חמור	הכרעה	ADA עמ' 193, 197, 205; קווי הכוונה עמ' 44-45
סוכרת-8	DPP-4 ותפקוד כליות	סיטגליפטין, וילדגליפטין: הפחתת מינון ב-eGFR <50; לינגליפטין: ללא התאמה	eGFR <50 ← חידוש לחודש + הודעה (בדיקת מינון). לינגליפטין: אין סף	הנחיה	ADA עמ' 195; קווי הכוונה עמ' 51
סוכרת-9	סולפונילאוריאה ותפקוד כליות	קווי הכוונה: גליבנקלמיד להפסיק ב-eGFR <60; גלימפיריד בזהירות <60; לא ב-ESRF	גליבנקלמיד: eGFR <60 ← ערך חמור. גלימפיריד: eGFR <60 ← הודעה; <15 ← ערך חמור	הנחיה	ADA עמ' 195; קווי הכוונה עמ' 54
סוכרת-10	שילובים לא מומלצים	ADA: לא לשלב DPP-4 עם GLP-1 או טירזפטייד; להגביל סולפונילאוריאה ומגליטיניד עם אינסולין	שילוב כזה ברשימת התרופות ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה	הנחיה	ADA 9.18, עמ' 192, 197, 201

#	נושא	מה ההנחיה אומרת	ההחלטה לפרוטוקול	סוג	מקור
סוכרת-11	פיוגליטזון	ADA וקווי הכוונה: אסור באי-ספיקת לב ובסרטן שלפוחית; קווי הכוונה: אסור ב-ALT מעל פי 2.5	אי-ספיקת לב או סרטן שלפוחית ← התווית נגד. ALT מעל פי 2.5 ← ערך חמור	הנחיה	ADA עמ' 195; קווי הכוונה עמ' 56
סוכרת-12	B12 במטפורמין	ADA: בדיקה תקופתית; קווי הכוונה: אחרי כשנה, ואחת לשנה-שנתיים	B12 מ-24 החודשים האחרונים, כחלק מהבדיקות השנתיות	החלטה מקומית	ADA עמ' 203; קווי הכוונה עמ' 23
סוכרת-13	אינסולין	ADA: הפסקת אינסולין מסוכנת; הרפואן אינו מתאים מינון	טיפול קבוע (אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים) וכל הבדיקות תקינות ← חידוש ל-3 חודשים. כל חריגה, כולל היריון, היפוגליקמיה או ירידה בתפקוד הכליות ← חידוש לחודש באותו מינון + הודעה לרופא/ה. אינסולין לא נעצר ע"י רפואן	החלטה מקומית	ADA פרק 6 עמ' 144-147; פרק 9 עמ' 200-201
סוכרת-14	מונג'רו ו-וויגובי	וויגובי רשום בישראל להשמנה; מונג'רו לסוכרת ולהשמנה	שניהם בפרוטוקול באותם תנאים (וויגובי תחת סמגלוטייד בהזרקה). Saxenda אינו בפרוטוקול	החלטה מקומית	מאגר התרופות 7.10.2026
סוכרת-15	מקור ישראלי	קווי ההכוונה 2021 ישנים מ-ADA 2026 ואינם כוללים טירזפטייד וסמגלוטייד פומי	בסתירה: ADA 2026 קובע, והסתירה מסומנת "הכרעה" לאישור	הכרעה	-
סוכרת-16	תרופות עם כמה התוויות	-	דפגליפלוזין ואמפגליפלוזין: בלי HbA1c; eGFR מתחת ל-25 ← הודעה (במקום 45). סמגלוטייד וטירזפטייד: בלי HbA1c; מדידת משקל שנתית	החלטה מקומית (2.11.2026)	-
כללי-1	בדיקות מעקב	שומנים: פרופיל כל 6-12 חודשים אחרי השגת היעד. TSH וחומצה אורית: לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	LDL, TSH וחומצה אורית מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש + זימון	החלטה מקומית (הצעה)	הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52
כללי-4	לבותירוקסין	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	TSH מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה. היריון ← הודעה דחופה. לא נעצר ע"י רפואן	החלטה מקומית (הצעה)	-
כללי-8	ערמונית	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	חוסמי אלפא ו-5ARI: ללא מעקב מעבדה; רק רכישות וביקורת שנתית	החלטה מקומית (הצעה)	-
כללי-9	ביספוספונטים	להפסיק אחרי 5 שנים טיפול פומי בסיכון שאינו גבוה; עד 10 שנים בסיכון גבוה. אסור ב-eGFR ≤35	5 שנות טיפול ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. eGFR <35 ← ערך חמור	הנחיה	ACOG 2023 (סיכום AFP) עמ' 101-102
כללי-18	גסטרו ואנדוקרינולוגיה	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	מסאלזין: קריאטינין שנתי. הידרוקורטיזון: לא נעצר, הנחיות מחלה. אלפקלצידול וסינקלצט: סידן. דסמופרסין: נתרן	החלטה מקומית (הצעה)	-
כללי-21	תרופות מומחה נוספות	-	מטוקלופרמיד ממושך, ממריצים/מודפיניל, ביולוגיות, טרשת נפוצה, אונקולוגיה, יל"ד ריאתי/IPF, סירולימוס, הורמון גדילה, המטולוגיה, CF, טפמידיס/מבקמטן: הודעה בלבד, חידוש ע"י רופא/ה	החלטה מקומית	-
כללי-22	השלמות 2 מהמאגר (2.11.2026)	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	ויטמין D, בטאהיסטין, חומצה במפדואית, אומגה 3/איקוזפנט, ציפרופיברט, וריסיגואט, ניטרוגליצרין תת-לשוני, פזולינטנט/אלינזנטנט (ALT), דואביב, אינטראורוסה, סיאנה, אורליסטט, פרוקלופריד, משלשלים, טטרציקלינים ממושכים, מניעת זיהומי שתן, משככי כאב ממושכים, ביקרבונט. רופא/ה בלבד: פנטרמין, בונות עצם, הפרינים, תרופות עצם בכליות, אנלוגי סומטוסטטין, הפטיטיס C/D, מחלות נדירות	החלטה מקומית (הצעה)	-

#	נושא	מה ההנחיה אומרת	ההחלטה לפרוטוקול	סוג	מקור
מעקב-12	תרופות למעקב צמוד נוספות	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	מתימזול/PTU, לפלונומיד, אזתיופרין, סולפסלזין, מיקופנולט, מעכבי JAK, הידרוקסיאוריאה, הידרוקסיכלורוקווין, נוגדי פסיכוזה, טסטוסטרון, סטרואידים כרוניים, ניטרופורנטואין, קולכיצין, דנוסומאב, טריפרטייד: בדיקות לפי התרופה; חריגה ← חודש + הודעה; ערך חמור ← לא מחדשים	החלטה מקומית (הצעה)	-
מעקב-13	נוגדי פסיכוזה נוספים	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	הלופרידול, פליפרידון, קריפרזין, זיפרזידון, פרפנזין: מעקב מטבולי כמו בשאר; אק"ג בגיל 50+ בהלופרידול וזיפרזידון	החלטה מקומית (הצעה)	-

2.ה רשימת התרופות (לסימון)

#	שם	גנרי	קבוצה	התאמה	אושר	הערות
2.1	מטפורמין	Metformin	ביגואניד	מתאים	☐	
2.2	אמפגליפלוזין	Empagliflozin	מעכב SGLT2	מתאים	☐	
2.3	דפגליפלוזין	Dapagliflozin	מעכב SGLT2	מתאים	☐	
2.4	ארטוגליפלוזין	Ertugliflozin	מעכב SGLT2	מתאים	☐	
2.5	סיטגליפטין	Sitagliptin	מעכב DPP-4	מתאים	☐	
2.6	וילדגליפטין	Vildagliptin	מעכב DPP-4	מתאים	☐	
2.7	לינגליפטין	Linagliptin	מעכב DPP-4	מתאים	☐	
2.8	סיטגליפטין + מטפורמין	Sitagliptin + Metformin	מעכב DPP-4 + ביגואניד	מתאים	☐	
2.9	וילדגליפטין + מטפורמין	Vildagliptin + Metformin	מעכב DPP-4 + ביגואניד	מתאים	☐	
2.10	לינגליפטין + מטפורמין	Linagliptin + Metformin	מעכב DPP-4 + ביגואניד	מתאים	☐	
2.11	אמפגליפלוזין + מטפורמין	Empagliflozin + Metformin	מעכב SGLT2 + ביגואניד	מתאים	☐	
2.12	דפגליפלוזין + מטפורמין	Dapagliflozin + Metformin	מעכב SGLT2 + ביגואניד	מתאים	☐	
2.13	אמפגליפלוזין + לינגליפטין	Empagliflozin + Linagliptin	מעכב SGLT2 + מעכב DPP-4	מתאים	☐	
2.14	פיוגליטזון + מטפורמין	Pioglitazone + Metformin	תיאזולידינדיון + ביגואניד	בתנאים	☐	
2.15	סמגלוטייד בהזרקה	Semaglutide	אגוניסט GLP-1	מתאים	☐	
2.16	סמגלוטייד פומי	Semaglutide (oral)	אגוניסט GLP-1	מתאים	☐	
2.17	דולגלוטייד	Dulaglutide	אגוניסט GLP-1	מתאים	☐	
2.18	טירזפטייד	Tirzepatide	אגוניסט כפול GIP/GLP-1	מתאים	☐	
2.19	גלימפיריד	Glimepiride	סולפונילאוריאה	בתנאים	☐	
2.20	גליבנקלמיד	Glibenclamide	סולפונילאוריאה	בתנאים	☐	
2.21	רפגליניד	Repaglinide	מגליטיניד	בתנאים	☐	
2.22	פיוגליטזון	Pioglitazone	תיאזולידינדיון	בתנאים	☐	
2.23	אקרבוז	Acarbose	מעכב אלפא-גלוקוזידאז	מתאים	☐	
2.24	אינסולין גלרגין	Insulin glargine	אינסולין בזאלי	בתנאים	☐	
2.25	אינסולין דגלודק	Insulin degludec	אינסולין בזאלי	בתנאים	☐	
2.26	אינסולין דטמיר	Insulin detemir	אינסולין בזאלי	בתנאים	☐	
2.27	אינסולין איקודק	Insulin icodec	אינסולין בזאלי שבועי	בתנאים	☐	
2.28	אינסולין NPH	Insulin NPH (human)	אינסולין בינוני (NPH)	בתנאים	☐	

#	שם	גנרי	קבוצה	התאמה	אושר	הערות
2.29	אינסולין אספרט	Insulin aspart	אינסולין מהיר	בתנאים	☐	
2.30	אינסולין ליספרו	Insulin lispro	אינסולין מהיר	בתנאים	☐	
2.31	אינסולין גלוליזין	Insulin glulisine	אינסולין מהיר	בתנאים	☐	
2.32	אינסולין רגיל	Insulin regular (human)	אינסולין קצר	בתנאים	☐	
2.33	אינסולין מעורב	Insulin premixed	אינסולין מעורב	בתנאים	☐	
2.34	דגלודק + ליראגלוטייד	Insulin degludec + Liraglutide	אינסולין + GLP-1	בתנאים	☐	
2.35	גלרגין + ליקסיסנטייד	Insulin glargine + Lixisenatide	אינסולין + GLP-1	בתנאים	☐	
2.36	לבותירוקסין	Levothyroxine	בלוטת התריס · הורמון בלוטת התריס	מתאים	☐	
2.37	הידרוקורטיזון (תחליפי)	Hydrocortisone (replacement)	אי-ספיקת אדרנל	בתנאים	☐	
2.38	אלפקלצידול	Alfacalcidol	ויטמין D פעיל	בתנאים	☐	
2.39	סינקלצט	Cinacalcet	קלצימימטי	בתנאים	☐	
2.40	קברגולין	Cabergoline	אגוניסט לדופמין	בתנאים	☐	
2.41	דסמופרסין	Desmopressin	אנלוג ADH	בתנאים	☐	
2.42	הורמון גדילה	Growth hormone	אנדוקרינולוגיה	רופא/ה בלבד	☐	
2.43	אורליסטט	Orlistat	השמנה	מתאים	☐	
2.44	פנטרמין	Phentermine	השמנה · ממריץ	רופא/ה בלבד	☐	
2.45	אנלוגים לסומטוסטטין ופגויזומנט	Somatostatin analogues / pegvisomant	אנדוקרינולוגיה	רופא/ה בלבד	☐	
2.46	מתימזול	Methimazole	נוגד פעילות יתר של התריס	בתנאים ⚗	☐	
2.47	פרופילתיאוראציל (PTU)	Propylthiouracil	נוגד פעילות יתר של התריס	בתנאים ⚗	☐	
2.48	טסטוסטרון	Testosterone	הורמון גברי	בתנאים ⚗	☐	
2.49	פרדניזון (טיפול כרוני)	Prednisone (chronic)	סטרואיד	בתנאים ⚗	☐	
2.50	מתילפרדניזולון (טיפול כרוני)	Methylprednisolone (chronic)	סטרואיד	בתנאים ⚗	☐	

1.2 פירוט מלא

2.1 **מטפורמין** · Metformin מתאים

ביגואניד

שמות מסחריים (5)	גלוקומין · Glucomin | גלוקופג' XR · Glucophage XR | מטפורמין טבע · Metformin Teva | אינובמד · Metformin Inovamed | מטפורמין גלניקום · Metformin Galenicum
נימוק / הערה	קו ראשון; ספי כליה ברורים

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	HbA1c מתועד	נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	HbA1c יציב	משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים, B12 (ב-24 החודשים האחרונים). חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
6	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <45 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
11	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי; B12 כל שנתיים
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <45
ערך חמור	eGFR <30
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון
תלונות בפנייה או ברשומה	שלשולים או אי-נוחות בטן מתמשכים ← לרופא לשקול תכשיר XR או הפחתה; הקאות, שלשול חריף או התייבשות ← הפסקה זמנית, לרופא
מקור	ADA פרק 9 עמ' 197, 205; קווי הכוונה עמ' 42

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.2 **אמפגליפלוזין** · Empagliflozin מתאים

מעכב SGLT2

שמות מסחריים (2)	ג'ארדיאנס · Jardiance | אמפזין אס.קיי. · Empazin S.K.
נימוק / הערה	תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: סוכרת, אי-ספיקת לב, מחלת כליות כרונית. תועלת לב-כליה; ספי כליה ברורים

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
3	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
4	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <25 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
9	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; סוכרת סוג 1. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <25
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; סוכרת סוג 1
תלונות בפנייה או ברשומה	זיהומים חוזרים בדרכי השתן או זיהום פטרייתי באברי המין ← לרופא לשקול החלפה; כאב, אודם או נפיחות באזור איברי המין (חשד לפורנייה) ← דחוף; הקאות, כאבי בטן או חולשה ניכרת (חשד ל-DKA) ← דחוף
מקור	ADA פרק 9 עמ' 193, 199, 214; קווי הכוונה עמ' 44-45

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.3 דפגליפלוזין · Dapagliflozin מתאים

מעכב SGLT2

שמות מסחריים (6)	פורסיגה · Forxiga | דפגליפלוזין סנדוז · Dapagliflozin Sandoz | דאפאגליפלוזין תרו · Dapagliflozin Taro | דאפאגליפלוזין טבע · Dapagliflozin Teva | דאפאמד · Dapamed | דיפו · Dippo
נימוק / הערה	תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: סוכרת, אי-ספיקת לב, מחלת כליות כרונית. תועלת לב-כליה; ספי כליה ברורים

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
3	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
4	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <25 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
9	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; סוכרת סוג 1. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <25
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; סוכרת סוג 1
תלונות בפנייה או ברשומה	זיהומים חוזרים בדרכי השתן או זיהום פטרייתי באברי המין ← לרופא לשקול החלפה; כאב, אודם או נפיחות באזור איברי המין (חשד לפורנייה) ← דחוף; הקאות, כאבי בטן או חולשה ניכרת (חשד ל-DKA) ← דחוף
מקור	ADA פרק 9 עמ' 193, 199, 214; קווי הכוונה עמ' 44-45

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.4 ארטוגליפלוזין · Ertugliflozin מתאים

מעכב SGLT2

שמות מסחריים (1)	סטגלטרו · Steglatro
נימוק / הערה	ספי כליה ברורים

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	HbA1c מתועד	נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	HbA1c יציב	משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
6	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <45 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
11	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; סוכרת סוג 1. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <45
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; סוכרת סוג 1
תלונות בפנייה או ברשומה	זיהומים חוזרים בדרכי השתן או זיהום פטרייתי באברי המין ← לרופא לשקול החלפה; כאב, אודם או נפיחות באזור איברי המין (חשד לפורנייה) ← דחוף; הקאות, כאבי בטן או חולשה ניכרת (חשד ל-DKA) ← דחוף
מקור	ADA פרק 9 עמ' 193, 199, 214; קווי הכוונה עמ' 44-45

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.5 סיטגליפטין · Sitagliptin מתאים

מעכב DPP-4

שמות מסחריים (8)	ג'נוביה · Januvia · סיטגליפטין אס.קיי. · Sitagliptin S.K. · סיטגליפטין סנדוז · Sitagliptin Sandoz · סיטגליפטין תרו · Sitagliptin Taro · סיטאגליפטין טבע · Sitagliptin Teva · סיטגליפטין ויטאמד · Sitagliptin Vitamed · סיטאר · Sitar · סיטין · Sitin
נימוק / הערה	ללא היפוגליקמיה; מינון לפי כליות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	HbA1c מתועד	נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	HbA1c יציב	משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
6	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <50 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
7	אין שילוב לא מומלץ	ברשימת התרופות הפעילה אין: מעכב DPP-4 יחד עם GLP-1 או טירזפטייד. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
12	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <50 (לבדיקת מינון)
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב בטן עליון חזק (חשד לדלקת לבלב) ← הפסקה, דחוף; שלפוחיות בעור (חשד לפמפיגואיד) ← הפסקה, לרופא; כאבי פרקים קשים ← לרופא לשקול הפסקה
מקור	ADA פרק 9 עמ' 195; קווי הכוונה עמ' 51

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.6 **וילדגליפטין** · Vildagliptin מתאים

מעכב DPP-4

שמות מסחריים (2)	גאלבוס · Galvus | וילדאגליפטין אס.קיי. · Vildagliptin S.K.
נימוק / הערה	ללא היפוגליקמיה; מינון לפי כליות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	HbA1c מתועד	נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	HbA1c יציב	משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
6	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <50 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
7	אין שילוב לא מומלץ	ברשימת התרופות הפעילה אין: מעכב DPP-4 יחד עם GLP-1 או טירזפטייד. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
12	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <50 (לבדיקת מינון)
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב בטן עליון חזק (חשד לדלקת לבלב) ← הפסקה, דחוף; שלפוחיות בעור (חשד לפמפיגואיד) ← הפסקה, לרופא; כאבי פרקים קשים ← לרופא לשקול הפסקה
מקור	ADA פרק 9 עמ' 195; קווי הכוונה עמ' 51

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.7 לינגליפטין · Linagliptin מתאים

מעכב DPP-4

שמות מסחריים (5)	טרג'נטה · Trajenta | לינגליפטין אינובמד · Linagliptin Inovamed | לינגליפטין אס.קיי. · Linagliptin S.K. | לינגליפטין תרו · Linagliptin Taro | לינגליפטין טבע · Linagliptin Teva
נימוק / הערה	ללא היפוגליקמיה; ללא התאמה לכליות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	HbA1c מתועד	נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	HbA1c יציב	משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
6	אין שילוב לא מומלץ	ברשימת התרופות הפעילה אין: מעכב DPP-4 יחד עם GLP-1 או טירזפטייד. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
11	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב בטן עליון חזק (חשד לדלקת לבלב) ← הפסקה, דחוף; שלפוחיות בעור (חשד לפמפיגואיד) ← הפסקה, לרופא; כאבי פרקים קשים ← לרופא לשקול הפסקה
מקור	ADA פרק 9 עמ' 195; קווי הכוונה עמ' 51

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.8 סיטגליפטין + מטפורמין · Sitagliptin + Metformin מתאים

מעכב DPP-4 + ביגואניד

שמות מסחריים (11)	ג'נואט · Januet	ג'נואט XR · Januet XR	סימטרין · Simetrin	סיטאפורמין טבע · Sitaformin Teva	סיטפורמין ויטאמד · Sitaformin Vitamed	סיטגליפטין קומבו סנדוז · Sitagliptin Combo Sandoz	סיטאגמט אס.קיי. · Sitagmet S.K	סיטמט-אבניר · Sitamet-Avenir	סיטאמין · Sitamin	סיטאר פלוס · Sitar Plus	סיטפורמין תרו · Sitformin Taro
נימוק / הערה	שילוב קבוע; ספי כליה של שני הרכיבים

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	HbA1c מתועד	נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	HbA1c יציב	משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים, B12 (ב-24 החודשים האחרונים). חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
6	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <50 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים	
7	אין שילוב לא מומלץ	ברשימת התרופות הפעילה אין: מעכב DPP-4 יחד עם GLP-1 או טירזפטייד. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
12	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי; HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי; B12 כל שנתיים
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <50 (לבדיקת מינון)
ערך חמור	eGFR <30
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב בטן עליון חזק (חשד לדלקת לבלב) ← הפסקה, דחוף; שלפוחיות בעור (חשד לפמפיגואיד) ← הפסקה, לרופא; כאבי פרקים קשים ← לרופא לשקול הפסקה; שלשולים או אי-נוחות בטן מתמשכים ← לרופא לשקול תכשיר XR או הפחתה; הקאות, שלשול חריף או התייבשות ← הפסקה זמנית, לרופא
מקור	ADA פרק 9 עמ' 195; קווי הכוונה עמ' 51; ADA פרק 9 עמ' 197, 205; קווי הכוונה עמ' 42

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.9 **וילדגליפטין + מטפורמין** · Vildagliptin + Metformin מתאים

מעכב DPP-4 + ביגואניד

שמות מסחריים (5)	יוקריאס · Eucreas | מטילדה · Metilda | ויפורמין · Viformin | וילדאמד אס.קיי. · Vildamed S.K. | ויולט · Violet
נימוק / הערה	שילוב קבוע; ספי כליה של שני הרכיבים

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	HbA1c מתועד	נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	HbA1c יציב	משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים, B12 (ב-24 החודשים האחרונים). חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
6	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <50 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים	
7	אין שילוב לא מומלץ	ברשימת התרופות הפעילה אין: מעכב DPP-4 יחד עם GLP-1 או טירזפטייד. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
12	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי; HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי; B12 כל שנתיים
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <50 (לבדיקת מינון)
ערך חמור	eGFR <30
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב בטן עליון חזק (חשד לדלקת לבלב) ← הפסקה, דחוף; שלפוחיות בעור (חשד לפמפיגואיד) ← הפסקה, לרופא; כאבי פרקים קשים ← לרופא לשקול הפסקה; שלשולים או אי-נוחות בטן מתמשכים ← לרופא לשקול תכשיר XR או הפחתה; הקאות, שלשול חריף או התייבשות ← הפסקה זמנית, לרופא
מקור	ADA פרק 9 עמ' 195; קווי הכוונה עמ' 51; ADA פרק 9 עמ' 197, 205; קווי הכוונה עמ' 42

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.10 **לינגליפטין + מטפורמין** · Linagliptin + Metformin מתאים

מעכב DPP-4 + ביגואניד

שמות מסחריים (1)	טרג'נטה דואו · Trajenta Duo
נימוק / הערה	שילוב קבוע; ספי הכליה של מטפורמין

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	HbA1c מתועד	נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	HbA1c יציב	משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים, B12 (ב-24 החודשים האחרונים). חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
6	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <45 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים	
7	אין שילוב לא מומלץ	ברשימת התרופות הפעילה אין: מעכב DPP-4 יחד עם GLP-1 או טירזפטייד. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
12	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי; HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי; B12 כל שנתיים
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <45
ערך חמור	eGFR <30
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב בטן עליון חזק (חשד לדלקת לבלב) ← הפסקה, דחוף; שלפוחיות בעור (חשד לפמפיגואיד) ← הפסקה, לרופא; כאבי פרקים קשים ← לרופא לשקול הפסקה; שלשולים או אי-נוחות בטן מתמשכים ← לרופא לשקול תכשיר XR או הפחתה; הקאות, שלשול חריף או התייבשות ← הפסקה זמנית, לרופא
מקור	ADA פרק 9 עמ' 195; קווי הכוונה עמ' 51; ADA פרק 9 עמ' 197, 205; קווי הכוונה עמ' 42

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.11 אמפגליפלוזין + מטפורמין · Empagliflozin + Metformin מתאים

מעכב SGLT2 + ביגואניד

שמות מסחריים (1)	ג'ארדיאנס דואו · Jardiance Duo
נימוק / הערה	שילוב קבוע; ספי כליה של שני הרכיבים

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	HbA1c מתועד	נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	HbA1c יציב	משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים, B12 (ב-24 החודשים האחרונים). חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
6	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <45 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
11	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; סוכרת סוג 1. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי; HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי; B12 כל שנתיים
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <45
ערך חמור	eGFR <30
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; סוכרת סוג 1
תלונות בפנייה או ברשומה	זיהומים חוזרים בדרכי השתן או זיהום פטרייתי באברי המין ← לרופא לשקול החלפה; כאב, אודם או נפיחות באזור איברי המין (חשד לפורנייה) ← דחוף; הקאות, כאבי בטן או חולשה ניכרת (חשד ל-DKA) ← דחוף; שלשולים או אי-נוחות בטן מתמשכים ← לרופא לשקול תכשיר XR או הפחתה; הקאות, שלשול חריף או התייבשות ← הפסקה זמנית, לרופא
מקור	ADA פרק 9 עמ' 193, 199, 214; קווי הכוונה עמ' 44-45; ADA פרק 9 עמ' 197, 205; קווי הכוונה עמ' 42

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.12 דפגליפלוזין + מטפורמין · Dapagliflozin + Metformin מתאים

מעכב SGLT2 + ביגואניד

שמות מסחריים (1)	קסיגדו Xigduo XR · XR
נימוק / הערה	שילוב קבוע; ספי כליה של שני הרכיבים

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	HbA1c מתועד	נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	HbA1c יציב	משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים, B12 (ב-24 החודשים האחרונים). חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
6	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <45 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
11	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; סוכרת סוג 1. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי; HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי; B12 כל שנתיים
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <45
ערך חמור	eGFR <30
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; סוכרת סוג 1
תלונות בפנייה או ברשומה	זיהומים חוזרים בדרכי השתן או זיהום פטרייתי באברי המין ← לרופא לשקול החלפה; כאב, אודם או נפיחות באזור איברי המין (חשד לפורנייה) ← דחוף; הקאות, כאבי בטן או חולשה ניכרת (חשד ל-DKA) ← דחוף; שלשולים או אי-נוחות בטן מתמשכים ← לרופא לשקול תכשיר XR או הפחתה; הקאות, שלשול חריף או התייבשות ← הפסקה זמנית, לרופא
מקור	ADA פרק 9 עמ' 193, 199, 214; קווי הכוונה עמ' 44-45; ADA פרק 9 עמ' 197, 205; קווי הכוונה עמ' 42

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.13 אמפגליפלוזין + לינגליפטין · Empagliflozin + Linagliptin מתאים

מעכב SGLT2 + מעכב DPP-4

שמות מסחריים (1)	גליקסמבי · Glyxambi
נימוק / הערה	שילוב קבוע

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	HbA1c מתועד	נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	HbA1c יציב	משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
6	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <45 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
7	אין שילוב לא מומלץ	ברשימת התרופות הפעילה אין: מעכב DPP-4 יחד עם GLP-1 או טירזפטייד. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
12	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; סוכרת סוג 1; דלקת לבלב בעבר. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <45
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; סוכרת סוג 1; דלקת לבלב בעבר
תלונות בפנייה או ברשומה	זיהומים חוזרים בדרכי השתן או זיהום פטרייתי באברי המין ← לרופא לשקול החלפה; כאב, אודם או נפיחות באזור איברי המין (חשד לפורנייה) ← דחוף; הקאות, כאבי בטן או חולשה ניכרת (חשד ל-DKA) ← דחוף; כאב בטן עליון חזק (חשד לדלקת לבלב) ← הפסקה, דחוף; שלפוחיות בעור (חשד לפמפיגואיד) ← הפסקה, לרופא; כאבי פרקים קשים ← לרופא לשקול הפסקה
מקור	ADA פרק 9 עמ' 193, 199, 214; קווי הכוונה עמ' 44-45; ADA פרק 9 עמ' 195; קווי הכוונה עמ' 51

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.14 פיוגליטזון + מטפורמין · Pioglitazone + Metformin בתנאים

תיאזולידינדיון + ביגואניד

שמות מסחריים (1)	קומפטקט · Competact
נימוק / הערה	רק טיפול כרוני קבוע. סיכון אי-ספיקת לב ובצקות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	HbA1c מתועד	נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	HbA1c יציב	משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים, B12 (ב-24 החודשים האחרונים), תפקודי כבד (ALT). חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
6	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <45 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים	
7	תפקודי כבד (ALT) תקין	בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חמור: ALT מעל פי 2.5 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התוויות נגד
8	טיפול כרוני	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע.	
9	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
10	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
11	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
12	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
13	אין התוויות נגד	אין התוויות נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; אי-ספיקת לב; סרטן שלפוחית השתן (פעיל או בעבר). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התוויות נגד

מעקב מעבדה	HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR, שומנים ו-ALT שנתי; HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי; B12 כל שנתיים
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <45
ערך חמור	ALT מעל פי 2.5 מהגבול העליון; eGFR <30
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; אי-ספיקת לב; סרטן שלפוחית השתן (פעיל או בעבר)
תלונות בפנייה או ברשומה	בצקות ברגליים או קוצר נשימה ← לרופא (חשד לאי-ספיקת לב); עלייה מהירה במשקל ← לרופא; דם בשתן ← לרופא; שלשולים או אי-נוחות בטן מתמשכים ← לרופא לשקול תכשיר XR או הפחתה; הקאות, שלשול חריף או התייבשות ← הפסקה זמנית, לרופא
מקור	ADA פרק 9 עמ' 195; קווי הכוונה עמ' 56; ADA פרק 9 עמ' 197, 205; קווי הכוונה עמ' 42

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.15 סמגלוטייד בהזרקה · Semaglutide מתאים

אגוניסט GLP-1

שמות מסחריים (2)	אוזמפיק · Ozempic | וויגובי · Wegovy (התוויה להשמנה)
נימוק / הערה	תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: סוכרת (אוזמפיק), השמנה (וגובי), מניעה קרדיווסקולרית. הזרקה שבועית; ללא היפוגליקמיה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	משקל מתועד	מדידת משקל מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
5	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <15 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
6	אין שילוב לא מומלץ	ברשימת התרופות הפעילה אין: מעכב DPP-4 יחד עם GLP-1 או טירזפטייד. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
11	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר; סרטן מדולרי של בלוטת התריס או MEN2 (אישי או במשפחה). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <15
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר; סרטן מדולרי של בלוטת התריס או MEN2 (אישי או במשפחה)
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב בטן עליון חזק (חשד לדלקת לבלב) ← הפסקה, דחוף; הקאות או שלשולים מתמשכים ← לרופא; כאב בבטן הימנית העליונה (חשד לאבנים בכיס המרה) ← לרופא
מקור	ADA פרק 9 עמ' 194-195, 199; קווי הכוונה עמ' 49

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.16 סמגלוטייד פומי · Semaglutide (oral) מתאים

אגוניסט GLP-1

שמות מסחריים (1)	ריבלסוס · Rybelsus
נימוק / הערה	ללא היפוגליקמיה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	HbA1c מתועד	נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	HbA1c יציב	משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
6	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <15 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
7	אין שילוב לא מומלץ	ברשימת התרופות הפעילה אין: מעכב DPP-4 יחד עם GLP-1 או טירזפטייד. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
12	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר; סרטן מדולרי של בלוטת התריס או MEN2 (אישי או במשפחה). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <15
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר; סרטן מדולרי של בלוטת התריס או MEN2 (אישי או במשפחה)
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב בטן עליון חזק (חשד לדלקת לבלב) ← הפסקה, דחוף; הקאות או שלשולים מתמשכים ← לרופא; כאב בבטן הימנית העליונה (חשד לאבנים בכיס המרה) ← לרופא
מקור	ADA פרק 9 עמ' 194-195, 199; קווי הכוונה עמ' 49

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.17 דולגלוטייד · Dulaglutide מתאים

אגוניסט GLP-1

שמות מסחריים (1)	טרוליסיטי · Trulicity
נימוק / הערה	הזרקה שבועית; ללא היפוגליקמיה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	HbA1c מתועד	נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	HbA1c יציב	משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
6	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <15 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
7	אין שילוב לא מומלץ	ברשימת התרופות הפעילה אין: מעכב DPP-4 יחד עם GLP-1 או טירזפטייד. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
12	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר; סרטן מדולרי של בלוטת התריס או MEN2 (אישי או במשפחה). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <15
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר; סרטן מדולרי של בלוטת התריס או MEN2 (אישי או במשפחה)
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב בטן עליון חזק (חשד לדלקת לבלב) ← הפסקה, דחוף; הקאות או שלשולים מתמשכים ← לרופא; כאב בבטן הימנית העליונה (חשד לאבנים בכיס המרה) ← לרופא
מקור	ADA פרק 9 עמ' 194-195, 199; קווי הכוונה עמ' 49

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.18 טירזפטייד · Tirzepatide מתאים

אגוניסט כפול GIP/GLP-1

שמות מסחריים (1)	מאונג'רו · Mounjaro
נימוק / הערה	תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: סוכרת, השמנה. הזרקה שבועית; ללא היפוגליקמיה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	משקל מתועד	מדידת משקל מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
5	אין שילוב לא מומלץ	ברשימת התרופות הפעילה אין: מעכב DPP-4 יחד עם GLP-1 או טירזפטייד. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
10	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר; סרטן מדולרי של בלוטת התריס או MEN2 (אישי או במשפחה). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר; סרטן מדולרי של בלוטת התריס או MEN2 (אישי או במשפחה)
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב בטן עליון חזק (חשד לדלקת לבלב) ← הפסקה, דחוף; הקאות או שלשולים מתמשכים ← לרופא; כאב בבטן הימנית העליונה (חשד לאבנים בכיס המרה) ← לרופא
מקור	ADA פרק 9 עמ' 194-195, 211-212 (אינו בקווי ההכוונה 2021)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.19 גלימפיריד · Glimepiride בתנאים

סולפונילאוריאה

שמות מסחריים (2)	אמריל · Amaryl | גלימפירייד טבע · Glimepiride Teva
נימוק / הערה	רק טיפול כרוני קבוע. סיכון להיפוגליקמיה: נדרש HbA1c בטווח וללא היפוגליקמיה מתועדת

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	HbA1c מתועד	נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	HbA1c יציב	משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר, או ערך מתחת ל-6.5% (תרופה שגורמת להיפוגליקמיה) ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה.	
3	אין היפוגליקמיה מתועדת	ברשומה מאז הביקור האחרון אין תיעוד של סוכר מתחת ל-70 מ"ג/ד"ל, פנייה למיון או טיפול בגלוקגון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
7	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <60 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <15 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <15 ← לא מחדשים	
8	אין שילוב לא מומלץ	ברשימת התרופות הפעילה אין: סולפונילאוריאה או רפגליניד יחד עם אינסולין. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
9	טיפול כרוני	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע.	
10	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
11	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
12	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
13	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
14	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <60 (לבדיקת מינון)
ערך חמור	eGFR <15
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון
תלונות בפנייה או ברשומה	אירועי היפוגליקמיה ← לרופא להפחתה או החלפה; עלייה ניכרת במשקל ← לרופא
מקור	ADA פרק 6 עמ' 141, 144-145; פרק 9 עמ' 195; קווי הכוונה עמ' 54

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.20 **גליבנקלמיד** · Glibenclamide בתנאים

סולפונילאוריאה

שמות מסחריים (2)	גלובן · Gluben | גליבטיק · Glibetic (לאימות מול מאגר משרד הבריאות)
נימוק / הערה	רק טיפול כרוני קבוע. סיכון להיפוגליקמיה: נדרש HbA1c בטווח וללא היפוגליקמיה מתועדת; הסיכון הגבוה בקבוצה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	HbA1c מתועד	נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	HbA1c יציב	משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר, או ערך מתחת ל-6.5% (תרופה שגורמת להיפוגליקמיה) ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה.	
3	אין היפוגליקמיה מתועדת	ברשומה מאז הביקור האחרון אין תיעוד של סוכר מתחת ל-70 מ"ג/ד"ל, פנייה למיון או טיפול בגלוקגון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
7	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חמור: eGFR <60 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התוויות נגד
8	אין שילוב לא מומלץ	ברשימת התרופות הפעילה אין: סולפונילאוריאה או רפגליניד יחד עם אינסולין. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
9	טיפול כרוני	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע.	
10	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
11	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
12	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
13	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
14	אין התוויות נגד	אין התוויות נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התוויות נגד

מעקב מעבדה	HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי
ערך חמור	eGFR <60
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון
תלונות בפנייה או ברשומה	אירועי היפוגליקמיה ← לרופא להפחתה או החלפה; עלייה ניכרת במשקל ← לרופא
מקור	ADA פרק 6 עמ' 141, 144-145; פרק 9 עמ' 195; קווי הכוונה עמ' 54

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.21 רפגליניד · Repaglinide בתנאים

מגליטיניד

שמות מסחריים (3)	נובונורם · NovoNorm | רפאגליניד טבע · Repaglinide Teva | ריפאליד · Ripalid
נימוק / הערה	רק טיפול כרוני קבוע. סיכון להיפוגליקמיה: נדרש HbA1c בטווח וללא היפוגליקמיה מתועדת

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	HbA1c מתועד	נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	HbA1c יציב	משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר, או ערך מתחת ל-6.5% (תרופה שגורמת להיפוגליקמיה) ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה.	
3	אין היפוגליקמיה מתועדת	ברשומה מאז הביקור האחרון אין תיעוד של סוכר מתחת ל-70 מ"ג/ד"ל, פנייה למיון או טיפול בגלוקגון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
7	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <30 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
8	אין שילוב לא מומלץ	ברשימת התרופות הפעילה אין: סולפונילאוריאה או רפגליניד יחד עם אינסולין. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
9	טיפול כרוני	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע.	
10	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
11	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
12	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
13	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
14	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <30
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון
תלונות בפנייה או ברשומה	אירועי היפוגליקמיה ← לרופא להפחתה או החלפה
מקור	ADA פרק 6 עמ' 145-144; קווי הכוונה עמ' 54

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.22 פיוגליטזון · Pioglitazone בתנאים

תיאזולידינדיון

שמות מסחריים (3)	אקטוס · Actos | פיוגליטזון טבע · Pioglitazone Teva | פיוגליטזון אינובמד · Pioglitazone Inovamed
נימוק / הערה	רק טיפול כרוני קבוע. סיכון אי-ספיקת לב, בצקות ושברים

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	HbA1c מתועד	נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	HbA1c יציב	משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים, תפקודי כבד (ALT). חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
6	תפקודי כבד (ALT) תקין	בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חמור: ALT מעל פי 2.5 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד
7	טיפול כרוני	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
12	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; אי-ספיקת לב; סרטן שלפוחית השתן (פעיל או בעבר). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR, שומנים ו-ALT שנתי
ערך חמור	ALT מעל פי 2.5 מהגבול העליון
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; אי-ספיקת לב; סרטן שלפוחית השתן (פעיל או בעבר)
תלונות בפנייה או ברשומה	בצקות ברגליים או קוצר נשימה ← לרופא (חשד לאי-ספיקת לב); עלייה מהירה במשקל ← לרופא; דם בשתן ← לרופא
מקור	ADA פרק 9 עמ' 195; קווי הכוונה עמ' 56

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.23 **אקרבוז** · Acarbose מתאים

מעכב אלפא-גלוקוזידאז

שמות מסחריים (2)	אקרוז · Acrose | פרנדאזה · Prandase (לאימות מול מאגר משרד הבריאות)
נימוק / הערה	ללא היפוגליקמיה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	HbA1c מתועד	נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	HbA1c יציב	משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
6	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
10	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון
תלונות בפנייה או ברשומה	גזים או שלשולים שמגבילים את הטיפול ← לרופא לשקול החלפה
מקור	ADA פרק 6 עמ' 147; קווי הכוונה עמ' 55

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.24 **אינסולין גלרגין** · Insulin glargine בתנאים

אינסולין בזאלי

שמות מסחריים (4)	לנטוס · Lantus | בסגלר · Basaglar | טוג'או · Toujeo | סמגלי · Semglee
נימוק / הערה	רק טיפול כרוני קבוע במינון קבוע. טיפול קבוע וכל הבדיקות תקינות ← חידוש ל-3 חודשים. כל חריגה ← חידוש לחודש באותו מינון והודעה לרופא/ה; לא נעצר ע"י רפואן. הרפואן לא משנה מינון.

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	HbA1c מתועד	נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	HbA1c יציב	משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר, או ערך מתחת ל-6.5% (תרופה שגורמת להיפוגליקמיה) ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה.	
3	אין היפוגליקמיה מתועדת	ברשומה מאז הביקור האחרון אין תיעוד של סוכר מתחת ל-70 מ"ג/ד"ל, פנייה למיון או טיפול בגלוקגון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
7	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
8	אין שילוב לא מומלץ	ברשימת התרופות הפעילה אין: סולפונילאוריאה או רפגליניד יחד עם אינסולין. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
9	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה (לא מפסיקים אינסולין).	
10	טיפול כרוני במינון קבוע	אינסולין מחודש ע"י רפואן רק כטיפול כרוני באותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. שינוי מינון או בקשה לשינוי ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
11	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
12	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
13	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
14	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון)
תלונות בפנייה או ברשומה	אירועי היפוגליקמיה ← לרופא להתאמת מינון; גושים באזורי ההזרקה ← לאחות להדרכה
מקור	ADA פרק 6 עמ' 141, 147-144; פרק 9 עמ' 196, 201-200, 208

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.25 אינסולין דגלודק · Insulin degludec בתנאים

אינסולין בזאלי

שמות מסחריים (2)	טרגלודק · Tregludec | טרסיבה · Tresiba (לאימות מול מאגר משרד הבריאות)
נימוק / הערה	רק טיפול כרוני קבוע במינון קבוע. טיפול קבוע וכל הבדיקות תקינות ← חידוש ל-3 חודשים. כל חריגה ← חידוש לחודש באותו מינון והודעה לרופא/ה; לא נעצר ע"י רפואן. הרפואן לא משנה מינון.

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	HbA1c מתועד	נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	HbA1c יציב	משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר, או ערך מתחת ל-6.5% (תרופה שגורמת להיפוגליקמיה) ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה.	
3	אין היפוגליקמיה מתועדת	ברשומה מאז הביקור האחרון אין תיעוד של סוכר מתחת ל-70 מ"ג/ד"ל, פנייה למיון או טיפול בגלוקגון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
7	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
8	אין שילוב לא מומלץ	ברשימת התרופות הפעילה אין: סולפונילאוריאה או רפגליניד יחד עם אינסולין. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
9	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה (לא מפסיקים אינסולין).	
10	טיפול כרוני במינון קבוע	אינסולין מחודש ע"י רפואן רק כטיפול כרוני באותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. שינוי מינון או בקשה לשינוי ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
11	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
12	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
13	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
14	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון)
תלונות בפנייה או ברשומה	אירועי היפוגליקמיה ← לרופא להתאמת מינון; גושים באזורי ההזרקה ← לאחות להדרכה
מקור	ADA פרק 6 עמ' 141, 147-144; פרק 9 עמ' 196, 201-200, 208

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.26 **אינסולין דטמיר** · Insulin detemir בתנאים

אינסולין בזאלי

שמות מסחריים (1)	לבמיר · Levemir
נימוק / הערה	רק טיפול כרוני קבוע במינון קבוע. טיפול קבוע וכל הבדיקות תקינות ← חידוש ל-3 חודשים. כל חריגה ← חידוש לחודש באותו מינון והודעה לרופא/ה; לא נעצר ע"י רפואן. הרפואן לא משנה מינון.

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	HbA1c מתועד	נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	HbA1c יציב	משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר, או ערך מתחת ל-6.5% (תרופה שגורמת להיפוגליקמיה) ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה.	
3	אין היפוגליקמיה מתועדת	ברשומה מאז הביקור האחרון אין תיעוד של סוכר מתחת ל-70 מ"ג/ד"ל, פנייה למיון או טיפול בגלוקגון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
7	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
8	אין שילוב לא מומלץ	ברשימת התרופות הפעילה אין: סולפונילאוריאה או רפגליניד יחד עם אינסולין. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
9	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה (לא מפסיקים אינסולין).	
10	טיפול כרוני במינון קבוע	אינסולין מחודש ע"י רפואן רק כטיפול כרוני באותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. שינוי מינון או בקשה לשינוי ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
11	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
12	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
13	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
14	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון)
תלונות בפנייה או ברשומה	אירועי היפוגליקמיה ← לרופא להתאמת מינון; גושים באזורי ההזרקה ← לאחות להדרכה
מקור	ADA פרק 6 עמ' 141, 147-144; פרק 9 עמ' 196, 201-200, 208

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.27 אינסולין איקודק · Insulin icodec בתנאים

אינסולין בזאלי שבועי

שמות מסחריים (1)	אוויקלי · Awiqli
נימוק / הערה	רק טיפול כרוני קבוע במינון קבוע. טיפול קבוע וכל הבדיקות תקינות ← חידוש ל-3 חודשים. כל חריגה ← חידוש לחודש באותו מינון והודעה לרופא/ה; לא נעצר ע"י רפואן. הרפואן לא משנה מינון.

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	HbA1c מתועד	נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	HbA1c יציב	משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר, או ערך מתחת ל-6.5% (תרופה שגורמת להיפוגליקמיה) ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה.	
3	אין היפוגליקמיה מתועדת	ברשומה מאז הביקור האחרון אין תיעוד של סוכר מתחת ל-70 מ"ג/ד"ל, פנייה למיון או טיפול בגלוקגון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
7	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
8	אין שילוב לא מומלץ	ברשימת התרופות הפעילה אין: סולפונילאוריאה או רפגליניד יחד עם אינסולין. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
9	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה (לא מפסיקים אינסולין).	
10	טיפול כרוני במינון קבוע	אינסולין מחודש ע"י רפואן רק כטיפול כרוני באותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. שינוי מינון או בקשה לשינוי ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
11	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
12	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
13	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
14	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון)
תלונות בפנייה או ברשומה	אירועי היפוגליקמיה ← לרופא להתאמת מינון; גושים באזורי ההזרקה ← לאחות להדרכה
מקור	ADA פרק 6 עמ' 141, 147-144; פרק 9 עמ' 196, 201-200, 208

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.28 **אינסולין NPH** · Insulin NPH (human) בתנאים

אינסולין בינוני (NPH)

שמות מסחריים (1)	אינסולטרד · Insulatard
נימוק / הערה	רק טיפול כרוני קבוע במינון קבוע. טיפול קבוע וכל הבדיקות תקינות ← חידוש ל-3 חודשים. כל חריגה ← חידוש לחודש באותו מינון והודעה לרופא/ה; לא נעצר ע"י רפואן. הרפואן לא משנה מינון.

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	HbA1c מתועד	נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	HbA1c יציב	משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר, או ערך מתחת ל-6.5% (תרופה שגורמת להיפוגליקמיה) ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה.	
3	אין היפוגליקמיה מתועדת	ברשומה מאז הביקור האחרון אין תיעוד של סוכר מתחת ל-70 מ"ג/ד"ל, פנייה למיון או טיפול בגלוקגון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
7	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
8	אין שילוב לא מומלץ	ברשימת התרופות הפעילה אין: סולפונילאוריאה או רפגליניד יחד עם אינסולין. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
9	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה (לא מפסיקים אינסולין).	
10	טיפול כרוני במינון קבוע	אינסולין מחודש ע"י רפואן רק כטיפול כרוני באותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. שינוי מינון או בקשה לשינוי ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
11	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
12	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
13	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
14	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון)
תלונות בפנייה או ברשומה	אירועי היפוגליקמיה ← לרופא להתאמת מינון; גושים באזורי ההזרקה ← לאחות להדרכה
מקור	ADA פרק 6 עמ' 141, 147-144; פרק 9 עמ' 196, 201-200, 208

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.29 **אינסולין אספרט** · Insulin aspart · בתנאים

אינסולין מהיר

שמות מסחריים (2)	נובורפיד · NovoRapid | פיאספ · Fiasp
נימוק / הערה	רק טיפול כרוני קבוע במינון קבוע. טיפול קבוע וכל הבדיקות תקינות ← חידוש ל-3 חודשים. כל חריגה ← חידוש לחודש באותו מינון והודעה לרופא/ה; לא נעצר ע"י רפואן. הרפואן לא משנה מינון.

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	HbA1c מתועד	נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	HbA1c יציב	משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר, או ערך מתחת ל-6.5% (תרופה שגורמת להיפוגליקמיה) ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה.	
3	אין היפוגליקמיה מתועדת	ברשומה מאז הביקור האחרון אין תיעוד של סוכר מתחת ל-70 מ"ג/ד"ל, פנייה למיון או טיפול בגלוקגון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
7	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
8	אין שילוב לא מומלץ	ברשימת התרופות הפעילה אין: סולפונילאוריאה או רפגליניד יחד עם אינסולין. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
9	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה (לא מפסיקים אינסולין).	
10	טיפול כרוני במינון קבוע	אינסולין מחודש ע"י רפואן רק כטיפול כרוני באותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. שינוי מינון או בקשה לשינוי ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
11	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
12	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
13	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
14	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון)
תלונות בפנייה או ברשומה	אירועי היפוגליקמיה ← לרופא להתאמת מינון; גושים באזורי ההזרקה ← לאחות להדרכה
מקור	ADA פרק 6 עמ' 141, 147-144; פרק 9 עמ' 196, 201-200, 208

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.30 **אינסולין ליספרו** · Insulin lispro בתנאים

אינסולין מהיר

שמות מסחריים (2)	הומלוג · Humalog | ליומג'ב · Lyumjev
נימוק / הערה	רק טיפול כרוני קבוע במינון קבוע. טיפול קבוע וכל הבדיקות תקינות ← חידוש ל-3 חודשים. כל חריגה ← חידוש לחודש באותו מינון והודעה לרופא/ה; לא נעצר ע"י רפואן. הרפואן לא משנה מינון.

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	HbA1c מתועד	נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	HbA1c יציב	משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר, או ערך מתחת ל-6.5% (תרופה שגורמת להיפוגליקמיה) ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה.	
3	אין היפוגליקמיה מתועדת	ברשומה מאז הביקור האחרון אין תיעוד של סוכר מתחת ל-70 מ"ג/ד"ל, פנייה למיון או טיפול בגלוקגון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
7	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
8	אין שילוב לא מומלץ	ברשימת התרופות הפעילה אין: סולפונילאוריאה או רפגליניד יחד עם אינסולין. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
9	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה (לא מפסיקים אינסולין).	
10	טיפול כרוני במינון קבוע	אינסולין מחודש ע"י רפואן רק כטיפול כרוני באותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. שינוי מינון או בקשה לשינוי ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
11	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
12	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
13	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
14	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון)
תלונות בפנייה או ברשומה	אירועי היפוגליקמיה ← לרופא להתאמת מינון; גושים באזורי ההזרקה ← לאחות להדרכה
מקור	ADA פרק 6 עמ' 141, 147-144; פרק 9 עמ' 196, 201-200, 208

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.31 אינסולין גלולזיזין · Insulin glulisine בתנאים

אינסולין מהיר

שמות מסחריים (1)	אפידרה · Apidra
נימוק / הערה	רק טיפול כרוני קבוע במינון קבוע. טיפול קבוע וכל הבדיקות תקינות ← חידוש ל-3 חודשים. כל חריגה ← חידוש לחודש באותו מינון והודעה לרופא/ה; לא נעצר ע"י רפואן. הרפואן לא משנה מינון.

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	HbA1c מתועד	נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	HbA1c יציב	משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר, או ערך מתחת ל-6.5% (תרופה שגורמת להיפוגליקמיה) ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה.	
3	אין היפוגליקמיה מתועדת	ברשומה מאז הביקור האחרון אין תיעוד של סוכר מתחת ל-70 מ"ג/ד"ל, פנייה למיון או טיפול בגלוקגון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
7	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
8	אין שילוב לא מומלץ	ברשימת התרופות הפעילה אין: סולפונילאוריאה או רפגליניד יחד עם אינסולין. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
9	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה (לא מפסיקים אינסולין).	
10	טיפול כרוני במינון קבוע	אינסולין מחודש ע"י רפואן רק כטיפול כרוני באותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. שינוי מינון או בקשה לשינוי ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
11	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
12	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
13	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
14	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון)
תלונות בפנייה או ברשומה	אירועי היפוגליקמיה ← לרופא להתאמת מינון; גושים באזורי ההזרקה ← לאחות להדרכה
מקור	ADA פרק 6 עמ' 141, 147-144; פרק 9 עמ' 196, 201-200, 208

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.32 **אינסולין רגיל** · Insulin regular (human) בתנאים

אינסולין קצר

שמות מסחריים (1)	אקטרפיד · Actrapid
נימוק / הערה	רק טיפול כרוני קבוע במינון קבוע. טיפול קבוע וכל הבדיקות תקינות ← חידוש ל-3 חודשים. כל חריגה ← חידוש לחודש באותו מינון והודעה לרופא/ה; לא נעצר ע"י רפואן. הרפואן לא משנה מינון.

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	HbA1c מתועד	נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	HbA1c יציב	משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר, או ערך מתחת ל-6.5% (תרופה שגורמת להיפוגליקמיה) ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה.	
3	אין היפוגליקמיה מתועדת	ברשומה מאז הביקור האחרון אין תיעוד של סוכר מתחת ל-70 מ"ג/ד"ל, פנייה למיון או טיפול בגלוקגון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
7	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
8	אין שילוב לא מומלץ	ברשימת התרופות הפעילה אין: סולפונילאוריאה או רפגליניד יחד עם אינסולין. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
9	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה (לא מפסיקים אינסולין).	
10	טיפול כרוני במינון קבוע	אינסולין מחודש ע"י רפואן רק כטיפול כרוני באותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. שינוי מינון או בקשה לשינוי ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
11	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
12	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
13	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
14	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון)
תלונות בפנייה או ברשומה	אירועי היפוגליקמיה ← לרופא להתאמת מינון; גושים באזורי ההזרקה ← לאחות להדרכה
מקור	ADA פרק 6 עמ' 141, 147-144; פרק 9 עמ' 196, 201-200, 208

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.33 **אינסולין מעורב** · Insulin premixed בתנאים

אינסולין מעורב

שמות מסחריים (4)	נובומיקס 30 · NovoMix 30 | הומלוג מיקס 25 · Humalog Mix 25 | הומלוג מיקס 50 · Humalog Mix 50 | מיקסטרד 30 · Mixtard 30
נימוק / הערה	רק טיפול כרוני קבוע במינון קבוע. טיפול קבוע וכל הבדיקות תקינות ← חידוש ל-3 חודשים. כל חריגה ← חידוש לחודש באותו מינון והודעה לרופא/ה; לא נעצר ע"י רפואן. הרפואן לא משנה מינון.

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	HbA1c מתועד	נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	HbA1c יציב	משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר, או ערך מתחת ל-6.5% (תרופה שגורמת להיפוגליקמיה) ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה.	
3	אין היפוגליקמיה מתועדת	ברשומה מאז הביקור האחרון אין תיעוד של סוכר מתחת ל-70 מ"ג/ד"ל, פנייה למיון או טיפול בגלוקגון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
7	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
8	אין שילוב לא מומלץ	ברשימת התרופות הפעילה אין: סולפונילאוריאה או רפגליניד יחד עם אינסולין. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
9	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה (לא מפסיקים אינסולין).	
10	טיפול כרוני במינון קבוע	אינסולין מחודש ע"י רפואן רק כטיפול כרוני באותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. שינוי מינון או בקשה לשינוי ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
11	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
12	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
13	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
14	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון)
תלונות בפנייה או ברשומה	אירועי היפוגליקמיה ← לרופא להתאמת מינון; גושים באזורי ההזרקה ← לאחות להדרכה
מקור	ADA פרק 6 עמ' 141, 147-144; פרק 9 עמ' 196, 201-200, 208

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.34 דגלודק + ליראגלוטייד · Insulin degludec + Liraglutide בתנאים

אינסולין + GLP-1

שמות מסחריים (1)	זולטופיי · Xultophy
נימוק / הערה	רק טיפול כרוני קבוע במינון קבוע. טיפול קבוע וכל הבדיקות תקינות ← חידוש ל-3 חודשים. כל חריגה ← חידוש לחודש באותו מינון והודעה לרופא/ה; לא נעצר ע"י רפואן. הרפואן לא משנה מינון.

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	HbA1c מתועד	נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	HbA1c יציב	משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר, או ערך מתחת ל-6.5% (תרופה שגורמת להיפוגליקמיה) ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה.	
3	אין היפוגליקמיה מתועדת	ברשומה מאז הביקור האחרון אין תיעוד של סוכר מתחת ל-70 מ"ג/ד"ל, פנייה למיון או טיפול בגלוקגון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
7	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
8	אין שילוב לא מומלץ	ברשימת התרופות הפעילה אין: מעכב DPP-4 יחד עם GLP-1 או טירזפטייד; סולפונילאוריאה או רפגליניד יחד עם אינסולין. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
9	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה (לא מפסיקים אינסולין).	
10	טיפול כרוני במינון קבוע	אינסולין מחודש ע"י רפואן רק כטיפול כרוני באותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. שינוי מינון או בקשה לשינוי ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
11	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
12	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
13	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
14	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון)
תלונות בפנייה או ברשומה	אירועי היפוגליקמיה ← לרופא להתאמת מינון; גושים באזורי ההזרקה ← לאחות להדרכה
מקור	ADA פרק 6 עמ' 141, 147-144; פרק 9 עמ' 196, 201-200, 208

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.35 גלרגין + ליקסיסנטייד · Insulin glargine + Lixisenatide בתנאים

אינסולין + GLP-1

שמות מסחריים (1)	סוליקווה · Suliqua
נימוק / הערה	רק טיפול כרוני קבוע במינון קבוע. טיפול קבוע וכל הבדיקות תקינות ← חידוש ל-3 חודשים. כל חריגה ← חידוש לחודש באותו מינון והודעה לרופא/ה; לא נעצר ע"י רפואן. הרפואן לא משנה מינון.

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	HbA1c מתועד	נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	HbA1c יציב	משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר, או ערך מתחת ל-6.5% (תרופה שגורמת להיפוגליקמיה) ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה.	
3	אין היפוגליקמיה מתועדת	ברשומה מאז הביקור האחרון אין תיעוד של סוכר מתחת ל-70 מ"ג/ד"ל, פנייה למיון או טיפול בגלוקגון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
7	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
8	אין שילוב לא מומלץ	ברשימת התרופות הפעילה אין: מעכב DPP-4 יחד עם GLP-1 או טירזפטייד; סולפונילאוריאה או רפגליניד יחד עם אינסולין. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
9	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה (לא מפסיקים אינסולין).	
10	טיפול כרוני במינון קבוע	אינסולין מחודש ע"י רפואן רק כטיפול כרוני באותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. שינוי מינון או בקשה לשינוי ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
11	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
12	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
13	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
14	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון)
תלונות בפנייה או ברשומה	אירועי היפוגליקמיה ← לרופא להתאמת מינון; גושים באזורי ההזרקה ← לאחות להדרכה
מקור	ADA פרק 6 עמ' 141, 147-144; פרק 9 עמ' 196, 201-200, 208

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.36 **לבותירוקסין** · Levothyroxine מתאים

בלוטת התריס · הורמון בלוטת התריס

שמות מסחריים (3)	אלטרוקסין · Eltroxin | יוטירוקס · Euthyrox | סינתרואיד · Synthroid
נימוק / הערה	מעקב TSH שנתי; היריון ← הודעה דחופה, לא מפסיקים

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**TSH מתועד**	בדיקה מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	**TSH בטווח**	בטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	**אין היריון**	אין היריון או תכנון היריון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה (לא מפסיקים את הטיפול).	
4	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	TSH שנתי
תלונות בפנייה או ברשומה	דפיקות לב, ירידה במשקל או רעד ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.37 **הידרוקורטיזון (תחליפי)** · Hydrocortisone (replacement) בתנאים

אי-ספיקת אדרנל

שמות מסחריים (3)	הידרוקורטיזון · Hydrocortisone | אלקינדי · Alkindi | אפמודי · Efmody
נימוק / הערה	אסור להפסיק. מינון כפול בזמן מחלה; הקאות ← זריקה ומיון

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**הנחיות מחלה מתועדות**	יש תיעוד של הסבר על הכפלת מינון בזמן מחלה ותעודת מטופל. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	**טיפול כרוני במינון קבוע**	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י אנדוקרינולוג/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
5	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	הקאות, שלשולים או חולשה קשה ← דחוף - מיון; חום ← לרופא - הכפלת מינון
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.38 **אלפקלצידול** · Alfacalcidol בתנאים

ויטמין D פעיל

שמות מסחריים (1)	אלפא די · Alpha D3
נימוק / הערה	סידן גבוה; נקבע ע"י נפרולוג/ית או אנדוקרינולוג/ית

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**סידן וקריאטינין מתועדים**	סידן וקריאטינין מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	**סידן לא גבוה**	סידן בטווח המעבדה או נמוך ממנו (סידן גבוה = לא מחדשים). לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה.	התווית נגד
3	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	**טיפול כרוני במינון קבוע**	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ה מומחה/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
6	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	סידן וקריאטינין כל 6 חודשים
תלונות בפנייה או ברשומה	צמא, בחילות או בלבול ← דחוף - סידן
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.39 **סינקלצט** · Cinacalcet בתנאים

קלצימימטי

שמות מסחריים (2)	סינאקלסט תרו · Cinacalcet Taro | סינאקלצט תרימה · Cinacalcet Trima
נימוק / הערה	סידן נמוך; נקבע ע"י נפרולוג/ית או אנדוקרינולוג/ית

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**סידן מתועד**	סידן מ-3 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	**סידן לא נמוך**	סידן בטווח המעבדה (סידן נמוך = לא מחדשים). לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה.	התווית נגד
3	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	**טיפול כרוני במינון קבוע**	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ה מומחה/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
6	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	סידן כל 3 חודשים
תלונות בפנייה או ברשומה	עוויתות או נימול ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.40 קברגולין · Cabergoline בתנאים

אגוניסט לדופמין

שמות מסחריים (2)	דוסטינקס · Dostinex | קבותרים · Cabotrim
נימוק / הערה	פרולקטין; במינון גבוה (מעל 2 מ"ג בשבוע) - אקו לב

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	פרולקטין מתועד	פרולקטין מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	אקו לב מתועד שאלה: מינון מעל 2 מ"ג בשבוע?	אקו לב מ-24 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
3	אין התנהגות כפייתית מתועדת	ברשומה או בפנייה אין הימורים, קניות כפייתיות או שינוי בהתנהגות המינית. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י אנדוקרינולוג/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	פרולקטין שנתי
תלונות בפנייה או ברשומה	קוצר נשימה או בצקות ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.41 **דסמופרסין** · Desmopressin בתנאים

אנלוג ADH

שמות מסחריים (5)	מינירין · Minirin	מינירין מלט · Minirin Melt	דסמופרסין טבע · Desmopressin Teva	דסמופרסין אס.קיי · Desmopressin S.K.	דסמופרסין סנדוז · Desmopressin Sandoz
נימוק / הערה	נתרן נמוך, בעיקר בגיל 65+

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	נתרן מתועד	נתרן מ-6 החודשים האחרונים (גיל 65+: מ-3 החודשים האחרונים). אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	נתרן (Na) תקין	בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מתחת ל-135 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: Na מתחת ל-130 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: Na מתחת ל-130 ← לא מחדשים	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
6	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	נתרן כל 6 חודשים (גיל 65+: כל 3 חודשים)
ספי החזרה לרופא/ה	Na מתחת ל-135
ערך חמור	Na מתחת ל-130
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב ראש, בחילה או בלבול ← דחוף - נתרן
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.42 **הורמון גדילה** · Growth hormone רופא/ה בלבד

אנדוקרינולוגיה

שמות מסחריים (3)	גנוטרופין · Genotropin	נורדיטרופין · Norditropin	אנג'נלה · Ngenla
נימוק / הערה	הורמון גדילה נקבע ע"י אנדוקרינולוג/ית (לרוב ילדים). להעביר לרופא/ה.
הנחיה	**הורמון גדילה נקבע ע"י אנדוקרינולוג/ית (לרוב ילדים). להעביר לרופא/ה.**

מקור	-

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.43 **אורליסטט** · Orlistat · מתאים

השמנה

שמות מסחריים (1)	קסניקל · Xenical
נימוק / הערה	תועלת צנועה; תופעות במערכת העיכול

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	משקל מתועד	מדידת משקל מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	ירידה במשקל	ירידה של 5% לפחות מתחילת הטיפול (אחרי 3 חודשים). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
9	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): תת-ספיגה כרונית; כולסטזיס. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	משקל כל 3-6 חודשים
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	תת-ספיגה כרונית; כולסטזיס
תלונות בפנייה או ברשומה	שלשולים שומניים קשים ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.44 **פנטרמין** · Phentermine · רופא/ה בלבד

השמנה · ממריץ

שמות מסחריים (1)	רזין · Razin
נימוק / הערה	פנטרמין הוא ממריץ (סם מסוכן), לטווח קצר. חידוש ע"י רופא/ה בלבד.
הנחיה	**פנטרמין הוא ממריץ (סם מסוכן), לטווח קצר. חידוש ע"י רופא/ה בלבד.**

מקור	-

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.45 אנלוגים לסומטוסטטין ופגויזומנט · Somatostatin analogues / pegvisomant

רופא/ה בלבד

אנדוקרינולוגיה

שמות מסחריים (9)	אוקטראוסטט · Octreostat | אוקטריאוטייד בנדליס · Octreotide Bendalis | אולתוטון · Olatuton | סנדוסטטין · Sandostatin | סנדוסטטין לאר · Sandostatin Lar | לנראותיד תרו · Lanreotide Taro | סומטולין אוטוג'ל · Somatuline Autogel | סומאברט · Somavert | סיגניפור לאר · Signifor Lar
נימוק / הערה	נקבעים ע"י אנדוקרינולוג/ית או אונקולוג/ית. להעביר לרופא/ה.
הנחיה	**נקבעים ע"י אנדוקרינולוג/ית או אונקולוג/ית. להעביר לרופא/ה.**

מקור	-

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.46 מתימזול · Methimazole

בתנאים

מעקב מעבדה צמוד

נוגד פעילות יתר של התריס

שמות מסחריים (1)	מרקפטיזול · Mercaptizol
נימוק / הערה	TSH ו-T4 חופשי; חום או כאב גרון ← ספירת דם דחופה (אגרנולוציטוזיס)

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	TSH ו-T4 חופשי מתועדים	מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	TSH בטווח	TSH בטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	תפקודי כבד (ALT) תקין	בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
4	אין חום או זיהום מתועד	ברשומה או בפנייה אין חום, כאב גרון, פצעים בפה או זיהום. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
5	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
6	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
7	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
8	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ה מומחה/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
9	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
10	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
11	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
12	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	TSH ו-T4 חופשי כל 6 חודשים; ALT
ספי החזרה לרופא/ה	ALT מעל פי 3 מהגבול העליון
תלונות בפנייה או ברשומה	חום, כאב גרון או פצעים בפה ← דחוף - ספירת דם היום; פריחה או גרד ← לרופא; צהבת או שתן כהה ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.47 פרופילתיאוראציל (PTU) · Propylthiouracil בתנאים מעקב מעבדה צמוד

נוגד פעילות יתר של התריס

שמות מסחריים (1)	פרופיל תיוציל · Propyl-Thiocil
נימוק / הערה	TSH ו-T4 חופשי; סיכון לפגיעה כבדית; חום ← ספירת דם דחופה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	TSH, T4 חופשי ו-ALT מתועדים	מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	TSH בטווח	TSH בטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	תפקודי כבד (ALT) תקין	בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 2 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים	
4	אין חום או זיהום מתועד	ברשומה או בפנייה אין חום, כאב גרון, פצעים בפה או זיהום. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
5	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
6	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
7	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
8	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ה מומחה/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
9	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
10	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
11	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
12	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	TSH, T4 חופשי ו-ALT כל 6 חודשים
ספי החזרה לרופא/ה	ALT מעל פי 2 מהגבול העליון
ערך חמור	ALT מעל פי 3 מהגבול העליון
תלונות בפנייה או ברשומה	חום, כאב גרון או פצעים בפה ← דחוף - ספירת דם היום; צהבת, שתן כהה או כאבי בטן ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.48 טסטוסטרון · Testosterone בתנאים מעקב מעבדה צמוד

הורמון גברי

שמות מסחריים (5)	אנדרוג'ל · Androgel | נבידו · Nebido | טסטווירון דפו · Testoviron Depot | טסטומקס · Testomax | טסטוסטרון טבע · Testosterone Teva
נימוק / הערה	נקבע ע"י רופא/ה או אנדוקרינולוג/ית. המטוקריט ו-PSA

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	בדיקות מתועדות	המטוקריט, PSA ורמת טסטוסטרון מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	המטוקריט (Hct) תקין	בבדיקה האחרונה המטוקריט (Hct) תקין. חריג: Hct מעל 50% ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: Hct מעל 54% ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: Hct מעל 54% ← לא מחדשים	
3	PSA תקין	PSA מתחת ל-4 ולא עלה ב-1.4 ומעלה לעומת הקודם. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
11	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): סרטן ערמונית או שד. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	המטוקריט, PSA ורמת טסטוסטרון שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	Hct מעל 50%
ערך חמור	Hct מעל 54%
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	סרטן ערמונית או שד
תלונות בפנייה או ברשומה	קשיי השתנה חדשים ← לרופא; כאב ונפיחות ברגל ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.49 פרדניזון (טיפול כרוני) · Prednisone (chronic) בתנאים מעקב מעבדה צמוד

סטרואיד

שמות מסחריים (1)	פרדניזון רקח · Prednisone Rekah
נימוק / הערה	לא נעצר בפתאומיות (סיכון לאי-ספיקת אדרנל). מעקב סוכר, ל"ד ועצם

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מעקב מתועד	גלוקוז/HbA1c ומדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים; צפיפות עצם מ-24 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	הגנה על העצם מתועדת	סידן וויטמין D (או ביספוספונט) ברשימת התרופות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	תוכנית מינון מתועדת	מינון ומשך מתועדים ע"י הרופא/ה; לא מפסיקים בפתאומיות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני שנקבע ע"י רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	גלוקוז/HbA1c ול"ד שנתי; צפיפות עצם כל שנתיים
תלונות בפנייה או ברשומה	חום או זיהום ← לרופא; כאב בטן עליון או צואה שחורה ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

2.50 מתילפרדניזולון (טיפול כרוני) · Methylprednisolone (chronic) בתנאים מעקב מעבדה צמוד

סטרואיד

שמות מסחריים (1)	מדרול · Medrol
נימוק / הערה	לא נעצר בפתאומיות (סיכון לאי-ספיקת אדרנל). מעקב סוכר, ל"ד ועצם

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מעקב מתועד	גלוקוז/HbA1c ומדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים; צפיפות עצם מ-24 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	הגנה על העצם מתועדת	סידן וויטמין D (או ביספוספונט) ברשימת התרופות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	תוכנית מינון מתועדת	מינון ומשך מתועדים ע"י הרופא/ה; לא מפסיקים בפתאומיות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני שנקבע ע"י רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	גלוקוז/HbA1c ול"ד שנתי; צפיפות עצם כל שנתיים
תלונות בפנייה או ברשומה	חום או זיהום ← לרופא; כאב בטן עליון או צואה שחורה ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

3. נשימה ואלרגיה

28 תרופות · מתאים: 16 · בתנאים: 10 · רופא/ה בלבד: 2 · גרסה 2 · חלוקה לפי מערכות · 2.11.2026

מקורות: GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט). שאר הערכים: החלטה מקומית; הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020; ACOG 2023 (סיכום AFP). שאר התחומים: החלטה מקומית

3.א כללים

- חידוש רגיל: 3 חודשים
- ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה פעם בשנה
- עד 3 חידושים רצופים, ואז ביקור רופא
- אין התווית נגד ← תמיד מחדשים לפחות לחודש אחד
- חסרה מדידה, בדיקה או ביקורת שנתית: חידוש לחודש אחד + זימון למרפאה
- חריגה מספי ההחזרה: חידוש לחודש אחד + הודעה לרופא/ה
- התווית נגד או ערך חמור: לא מחדשים, הודעה לרופא/ה (הסף של כל תרופה מופיע ברשימה שלה)
- רפואן לא משנה מינון ולא מחליף תרופה. "מעקב מעבדה צמוד" = תרופה עם בדיקות תכופות — לבדוק בקפידה
- 3 משאפי הרגעה ומעלה בשנה או התקף ב-12 החודשים האחרונים: חודש + הודעה
- LABA או LAMA-LABA בלי סטרואיד אצל מטופל/ת עם אסתמה: חודש + הודעה דחופה
- משאף הרגעה לפי הצורך: לא בודקים כיסוי רכישות, אלא כמות משאפים בשנה

3.ג בדיקות משותפות

שלב	נושא	מה בודקים	קריטריון	אם לא מתקיים	מקור
לפני כל חידוש	משאפי הרגעה	כמה משאפי SABA נרכשו ב-12 החודשים האחרונים	פחות מ-3	3 ומעלה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה	GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט) עמ' 13
לפני כל חידוש	התקפים	קורס סטרואידים, מיון או אשפוז ב-12 החודשים האחרונים	אין	יש ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה	GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט) עמ' 37
לפני כל חידוש	טיפול מונע	באסתמה: יש ICS ברשימה	LABA או LAMA-LABA בלי ICS רק ב-COPD	אסתמה בלי ICS ← חידוש לחודש + הודעה (דחופה אם LABA)	GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט) עמ' 26-27
לפני כל חידוש	רכישות	כיסוי ימים ב-6 החודשים האחרונים (משאף מונע)	80% מהימים ומעלה	פחות ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה	כמו בי"ל
לפני כל חידוש	ביקורת שנתית	ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה	ב-12 החודשים האחרונים	אין ← חידוש לחודש + זימון לביקורת	כמו בי"ל
החזרה מיידית לרופא	קוצר נשימה	מופיע בפנייה או ברשומה	קוצר נשימה במנוחה או קושי לדבר	דחוף - מיון	GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט)
לפני כל חידוש	רצף חידושים	כמה חידושים רצופים מאז ביקור רופא	פחות מ-3	3 ← ביקור רופא	כמו בי"ל

3.ד החלטות

#	נושא	מה ההנחיה אומרת	ההחלטה לפרוטוקול	סוג	מקור
נשימה-1	שימוש יתר ב-SABA	3 משאפים ומעלה בשנה = גורם סיכון להתקפים; משאף בחודש ומעלה = סיכון למוות	3 ומעלה ב-12 חודשים ← חידוש לחודש + הודעה	הנחיה	GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט) עמ' 13
נשימה-2	התקף בשנה האחרונה	יותר מקורס סטרואידים אחד בשנה ← הפניה למומחה	כל קורס סטרואידים, מיון או אשפוז ← חידוש לחודש + הודעה	החלטה מקומית (הצעה)	GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט) עמ' 37

#	נושא	מה ההנחיה אומרת	ההחלטה לפרוטוקול	סוג	מקור
נשימה-3	LABA בלי ICS	באסתמה תמיד טיפול שמכיל ICS; LABA לבד אסור	LABA או LAMA-LABA בלי ICS ובלי אבחנת COPD ← חידוש לחודש + הודעה דחופה	הנחיה	GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט) עמ' 26
נשימה-4	SABA בלבד	לא מומלץ באסתמה; עדיף ICS-פורמוטרול לפי הצורך	SABA בלי ICS ובלי COPD ← חידוש לחודש + הודעה	הנחיה	GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט) עמ' 26
נשימה-5	מונטלוקאסט	פחות יעיל מ-ICS; סיכון לתופעות נפשיות	תופעות נפשיות ← חידוש לחודש + הודעה דחופה	הנחיה	GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט) עמ' 27
נשימה-6	תאופילין	GINA לא ממליצה	רמה שנתית; מעל 15 ← הודעה; מעל 20 ← לא מחדשים	החלטה מקומית (הצעה)	GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט) עמ' 27
נשימה-7	אזיתרומיצין ממושך	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	רק בהמלצת רופא/ת ריאות; אק"ג ו-ALT שנתי; QTc מוארך ← הודעה דחופה	החלטה מקומית (הצעה)	-
כללי-20	השלמות מהמאגר (2.11.2026)	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	טרזוסין, פינסטריד, אינקליסירן, ורדנאפיל, טיפות לגלאוקומה (ביקורת עיניים שנתית; טימולול: דופק ואסתמה), NSAID ממושך (כליות, אשלגן, ל"ד, דימום, הגנת קיבה), אנטיהיסטמינים, ציננריזין, דומפרידון, מברין, סידן, מידודרין, פנטוקסיפילין, דיפירידמול, ולציקלוביר מונע, חומצה זולדרונית	החלטה מקומית (הצעה)	-
כללי-21	תרופות מומחה נוספות	-	מטוקלופרמיד ממושך, ממריצים/מודפיניל, ביולוגיות, טרשת נפוצה, אונקולוגיה, יל"ד ריאתי/IPF, סירולימוס, הורמון גדילה, המטולוגיה, CF, טפמידיס/מבקמטן: הודעה בלבד, חידוש ע"י רופא/ה	החלטה מקומית	-

3.ה רשימת התרופות (לסימון)

#	שם	גנרי	קבוצה	התאמה	אושר	הערות
3.1	פלוטיקזון (משאף)	Fluticasone (inhaled)	ICS · סטרואיד בשאיפה	מתאים	☐	
3.2	בקלומטזון (משאף)	Beclometasone (inhaled)	ICS · סטרואיד בשאיפה	מתאים	☐	
3.3	בודזוניד (אינהלציה)	Budesonide (nebulised)	ICS · סטרואיד בשאיפה	מתאים	☐	
3.4	בודזוניד + פורמוטרול	Budesonide + formoterol	ICS-LABA	מתאים	☐	
3.5	בקלומטזון + פורמוטרול	Beclometasone + formoterol	ICS-LABA	מתאים	☐	
3.6	פלוטיקזון + סלמטרול	Fluticasone + salmeterol	ICS-LABA	מתאים	☐	
3.7	פלוטיקזון + פורמוטרול	Fluticasone + formoterol	ICS-LABA	מתאים	☐	
3.8	פלוטיקזון פוראט + וילנטרול	Fluticasone furoate + vilanterol	ICS-LABA	מתאים	☐	
3.9	סלמטרול	Salmeterol	LABA בלבד	בתנאים	☐	
3.10	פורמוטרול	Formoterol	LABA בלבד	בתנאים	☐	
3.11	טיוטרופיום	Tiotropium	LAMA	בתנאים	☐	

#	שם	גנרי	קבוצה	התאמה	אושר	הערות
3.12	אומקלידיניום	Umeclidinium	LAMA	בתנאים	☐	
3.13	גליקופירוניום (משאף)	Glycopyrronium (inhaled)	LAMA	בתנאים	☐	
3.14	אומקלידיניום + וילנטרול	Umeclidinium + vilanterol	LAMA-LABA	בתנאים	☐	
3.15	אינדקטרול + גליקופירוניום	Indacaterol + glycopyrronium	LAMA-LABA	בתנאים	☐	
3.16	טיוטרופיום + אולודטרול	Tiotropium + olodaterol	LAMA-LABA	בתנאים	☐	
3.17	פלוטיקזון + אומקלידיניום + וילנטרול	Fluticasone + umeclidinium + vilanterol	טיפול משולש (ICS-LAMA-LABA)	מתאים	☐	
3.18	בקלומטזון + פורמוטרול + גליקופירוניום	Beclometasone + formoterol + glycopyrronium	טיפול משולש (ICS-LAMA-LABA)	מתאים	☐	
3.19	בודזוניד + גליקופירוניום + פורמוטרול	Budesonide + glycopyrronium + formoterol	טיפול משולש (ICS-LAMA-LABA)	מתאים	☐	
3.20	סלבוטמול	Salbutamol	SABA · משאף הרגעה	מתאים	☐	
3.21	טרבוטלין	Terbutaline	SABA · משאף הרגעה	מתאים	☐	
3.22	איפרטרופיום	Ipratropium	SAMA · משאף הרגעה	מתאים	☐	
3.23	מונטלוקאסט	Montelukast	אנטגוניסט ללויקוטריאנים	מתאים	☐	
3.24	תאופילין	Theophylline	מתילקסנטין	בתנאים	☐	
3.25	אזיתרומיצין (טיפול ממושך)	Azithromycin (long-term)	מקרוליד למניעת התלקחויות	בתנאים	☐	
3.26	אנטיהיסטמינים (דור שני)	Antihistamines (2nd generation)	אלרגיה	מתאים	☐	
3.27	תרופות ליל"ד ריאתי ולפיברוזיס ריאתי	Pulmonary hypertension / IPF drugs	ריאות - מומחה	רופא/ה בלבד	☐	
3.28	תרופות לסיסטיק פיברוזיס	Cystic fibrosis modulators	CF	רופא/ה בלבד	☐	

1.3 פירוט מלא

3.1 **פלוטיקזון (משאף)** · Fluticasone (inhaled) מתאים

ICS · סטרואיד בשאיפה

שמות מסחריים (2)	פליקסוטייד דיסקוס · Flixotide Diskus | פליקסוטייד משאף · Flixotide Inhaler
נימוק / הערה	טיפול מונע; שימוש יתר במשאף הרגעה או התקף ← הודעה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	פחות מ-3 משאפי הרגעה בשנה	ברכישות: פחות מ-3 משאפי הרגעה (ונטולין, סלבוטרים, בריקלין) ב-12 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	אין התקף ב-12 החודשים האחרונים	ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה)
מקור	GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

3.2 בקלומטזון (משאף) · Beclometasone (inhaled) מתאים

ICS · סטרואיד בשאיפה

שמות מסחריים (1)	קיואר · Qvar
נימוק / הערה	טיפול מונע; שימוש יתר במשאף הרגעה או התקף ← הודעה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	פחות מ-3 משאפי הרגעה בשנה	ברכישות: פחות מ-3 משאפי הרגעה (ונטולין, סלבוטרים, בריקלין) ב-12 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	אין התקף ב-12 החודשים האחרונים	ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה)
מקור	GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

3.3 בודזוניד (אינהלציה) · Budesonide (nebulised) מתאים

ICS · סטרואיד בשאיפה

שמות מסחריים (2)	בודיקורט רספולס · Budicort Respules | בודזונייד סטרינבז טבע · Budesonide Sterinebs Teva
נימוק / הערה	טיפול מונע, בעיקר בילדים

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	פחות מ-3 משאפי הרגעה בשנה	ברכישות: פחות מ-3 משאפי הרגעה (ונטולין, סלבוטרים, בריקלין) ב-12 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	אין התקף ב-12 החודשים האחרונים	ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה)
מקור	GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

3.4 **בודזוניד + פורמוטרול** · Budesonide + formoterol מתאים

ICS-LABA

שמות מסחריים (3)	סימביקורט טורבוהלר · Symbicort Turbuhaler	דואורספ ספירומקס · Duoresp Spiromax	בודמול אס.קיי. · Budemol S.K.
נימוק / הערה	טיפול מונע ומרגיע (MART); שימוש תכוף מאוד ← הודעה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**אין התקף ב-12 החודשים האחרונים**	ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
5	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
6	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
7	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה)
מקור	GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

3.5 בקלומטזון + פורמוטרול · Beclometasone + formoterol מתאים

ICS-LABA

שמות מסחריים (1)	פוסטר · Foster
נימוק / הערה	טיפול מונע ומרגיע (MART)

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין התקף ב-12 החודשים האחרונים	ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
5	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
6	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
7	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה)
מקור	GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

3.6 **פלוטיקזון + סלמטרול** · Fluticasone + salmeterol · מתאים

ICS-LABA

שמות מסחריים (2)	סרטייד דיסקוס · Seretide Diskus | פלוסלמר אס.קיי. · Flusalmer S.K.
נימוק / הערה	טיפול מונע

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**פחות מ-3 משאפי הרגעה בשנה**	ברכישות: פחות מ-3 משאפי הרגעה (ונטולין, סלבוטרים, בריקלין) ב-12 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	**אין התקף ב-12 החודשים האחרונים**	ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה)
מקור	GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

3.7 פלוטיקזון + פורמוטרול · Fluticasone + formoterol מתאים

ICS-LABA

שמות מסחריים (1)	פלוטיפורם · Flutiform
נימוק / הערה	טיפול מונע

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	פחות מ-3 משאפי הרגעה בשנה	ברכישות: פחות מ-3 משאפי הרגעה (ונטולין, סלבוטרים, בריקלין) ב-12 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	אין התקף ב-12 החודשים האחרונים	ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה)
מקור	GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

3.8 פלוטיקזון פוראט + וילנטרול · Fluticasone furoate + vilanterol מתאים

ICS-LABA

שמות מסחריים (1)	רלוואר אליפטה · Relvar Ellipta
נימוק / הערה	טיפול מונע

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	פחות מ-3 משאפי הרגעה בשנה	ברכישות: פחות מ-3 משאפי הרגעה (ונטולין, סלבוטרים, בריקלין) ב-12 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	אין התקף ב-12 החודשים האחרונים	ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה)
מקור	GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

3.9 סלמטרול · Salmeterol בתנאים

LABA בלבד

שמות מסחריים (2)	סרוונט דיסקוס · Serevent Diskus | סרוונט משאף · Serevent Inhaler
נימוק / הערה	LABA בלי סטרואיד אסור באסתמה (סיכון למוות מאסתמה)

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אבחנת COPD מתועדת, או משאף עם סטרואיד ברשימה	יש אבחנת COPD ואין אבחנת אסתמה, או שיש משאף עם סטרואיד (ICS) ברשימת התרופות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
2	פחות מ-3 משאפי הרגעה בשנה	ברכישות: פחות מ-3 משאפי הרגעה (ונטולין, סלבוטרים, בריקלין) ב-12 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	אין התקף ב-12 החודשים האחרונים	ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה)
מקור	GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

3.10 פורמוטרול · Formoterol בתנאים

LABA בלבד

שמות מסחריים (2)	אוקסיס טורבוהלר · Oxis Turbuhaler | פוראדיל · Foradil
נימוק / הערה	LABA בלי סטרואיד אסור באסתמה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אבחנת COPD מתועדת, או משאף עם סטרואיד ברשימה	יש אבחנת COPD ואין אבחנת אסתמה, או שיש משאף עם סטרואיד (ICS) ברשימת התרופות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
2	פחות מ-3 משאפי הרגעה בשנה	ברכישות: פחות מ-3 משאפי הרגעה (ונטולין, סלבוטרים, בריקלין) ב-12 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	אין התקף ב-12 החודשים האחרונים	ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה)
מקור	GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

3.11 **טיוטרופיום** · Tiotropium בתנאים

LAMA

שמות מסחריים (2)	ספיריבה · Spiriva | ספיריבה רספימט · Spiriva Respimat
נימוק / הערה	COPD; באסתמה רק בתוספת ל-ICS-LABA

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**אבחנת COPD מתועדת, או משאף עם סטרואיד ברשימה**	יש אבחנת COPD ואין אבחנת אסתמה, או שיש משאף עם סטרואיד (ICS) ברשימת התרופות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
2	**אין התקף ב-12 החודשים האחרונים**	ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה); קושי במתן שתן ← לרופא; כאב עיניים או ראייה מטושטשת ← דחוף
מקור	GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

3.12 **אומקלידיניום** · Umeclidinium בתנאים

LAMA

שמות מסחריים (1)	אינקרוז אליפטה · Incruse Ellipta
נימוק / הערה	COPD

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**אבחנת COPD מתועדת, או משאף עם סטרואיד ברשימה**	יש אבחנת COPD ואין אבחנת אסתמה, או שיש משאף עם סטרואיד (ICS) ברשימת התרופות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
2	**אין התקף ב-12 החודשים האחרונים**	ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה)
מקור	GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

3.13 גליקופירוניום (משאף) · Glycopyrronium (inhaled) בתנאים

LAMA

שמות מסחריים (1)	ריברילה · Rybrila (לאימות מול מאגר משרד הבריאות)
נימוק / הערה	COPD

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אבחנת COPD מתועדת, או משאף עם סטרואיד ברשימה	יש אבחנת COPD ואין אבחנת אסתמה, או שיש משאף עם סטרואיד (ICS) ברשימת התרופות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
2	אין התקף ב-12 החודשים האחרונים	ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה)
מקור	GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

3.14 אומקלידיניום + וילנטרול · Umeclidinium + vilanterol בתנאים

LAMA-LABA

שמות מסחריים (1)	אנורו אליפטה · Anoro Ellipta
נימוק / הערה	COPD בלבד; אסור באסתמה בלי ICS

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אבחנת COPD מתועדת, או משאף עם סטרואיד ברשימה	יש אבחנת COPD ואין אבחנת אסתמה, או שיש משאף עם סטרואיד (ICS) ברשימת התרופות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
2	אין התקף ב-12 החודשים האחרונים	ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה)
מקור	GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

3.15 אינדקטרול + גליקופירוניום · Indacaterol + glycopyrronium בתנאים

LAMA-LABA

שמות מסחריים (1)	אולטיברו בריזהלר · Ultibro Breezhaler
נימוק / הערה	COPD בלבד

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אבחנת COPD מתועדת, או משאף עם סטרואיד ברשימה	יש אבחנת COPD ואין אבחנת אסתמה, או שיש משאף עם סטרואיד (ICS) ברשימת התרופות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
2	אין התקף ב-12 החודשים האחרונים	ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה)
מקור	GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

3.16 טיוטרופיום + אולודטרול · Tiotropium + olodaterol בתנאים

LAMA-LABA

שמות מסחריים (1)	ספיולטו רספימט · Spiolto Respimat
נימוק / הערה	COPD בלבד

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אבחנת COPD מתועדת, או משאף עם סטרואיד ברשימה	יש אבחנת COPD ואין אבחנת אסתמה, או שיש משאף עם סטרואיד (ICS) ברשימת התרופות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
2	אין התקף ב-12 החודשים האחרונים	ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה)
מקור	GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

3.17 פלוטיקזון + אומקלידיניום + וילנטרול · Fluticasone + umeclidinium + vilanterol מתאים

טיפול משולש (ICS-LAMA-LABA)

שמות מסחריים (1)	טרלג'י אליפטה · Trelegy Ellipta
נימוק / הערה	COPD או אסתמה קשה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין התקף ב-12 החודשים האחרונים	ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
5	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
6	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
7	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה)
מקור	GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

3.18 בקלומטזון + פורמוטרול + גליקופירוניום · Beclometasone + formoterol + glycopyrronium מתאים

טיפול משולש (ICS-LAMA-LABA)

שמות מסחריים (1)	טרימבו · Trimbow
נימוק / הערה	COPD או אסתמה קשה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין התקף ב-12 החודשים האחרונים	ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
5	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
6	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
7	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה)
מקור	GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

3.19 בודזוניד + גליקופירוניום + פורמוטרול · Budesonide + glycopyrronium + formoterol מתאים

טיפול משולש (ICS-LAMA-LABA)

שמות מסחריים (1)	טריקסאו אירוספיר · Trixeo Aerosphere
נימוק / הערה	COPD

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין התקף ב-12 החודשים האחרונים	ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
5	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
6	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
7	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה)
מקור	GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

3.20 **סלבוטמול** · Salbutamol מתאים

SABA · משאף הרגעה

שמות מסחריים (5)	ונטולין משאף · Ventolin Inhaler | ונטולין דיסקוס · Ventolin Diskus | סלבוטרים · Salbutrim | ונטולין תמיסה לאינהלציה · Ventolin Respirator Solution | סלבוטק · Salbutec
נימוק / הערה	לפי הצורך. SABA בלבד באסתמה לא מומלץ; 3 משאפים ומעלה בשנה = לא מאוזן

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**משאף מונע עם סטרואיד ברשימה, או אבחנת COPD**	ברשימת התרופות יש משאף עם סטרואיד (ICS), או שהאבחנה היא COPD. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	**פחות מ-3 משאפי הרגעה בשנה**	ברכישות: פחות מ-3 משאפי הרגעה (ונטולין, סלבוטרים, בריקלין) ב-12 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	**אין התקף ב-12 החודשים האחרונים**	ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה; ספירת משאפים שנרכשו
תלונות בפנייה או ברשומה	קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה)
מקור	GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

3.21 **טרבוטלין** · Terbutaline מתאים

SABA · משאף הרגעה

שמות מסחריים (1)	בריקלין טורבוהלר · Bricalin Turbuhaler
נימוק / הערה	לפי הצורך. SABA בלבד באסתמה לא מומלץ

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**משאף מונע עם סטרואיד ברשימה, או אבחנת COPD**	ברשימת התרופות יש משאף עם סטרואיד (ICS), או שהאבחנה היא COPD. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	**פחות מ-3 משאפי הרגעה בשנה**	ברכישות: פחות מ-3 משאפי הרגעה (ונטולין, סלבוטרים, בריקלין) ב-12 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	**אין התקף ב-12 החודשים האחרונים**	ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה; ספירת משאפים שנרכשו
תלונות בפנייה או ברשומה	קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה)
מקור	GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

3.22 **איפרטרופיום** · Ipratropium מתאים

SAMA · משאף הרגעה

שמות מסחריים (3)	ארוונט · Aerovent | איפרטרים · Ipratrim | איירווייז תמיסה לאינהלציה · Airways Respiratory Solution
נימוק / הערה	COPD; לא יחד עם LAMA (טיוטרופיום ודומיו)

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין LAMA במקביל	ברשימת התרופות אין טיוטרופיום, אומקלידיניום או גליקופירוניום. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	אין התקף ב-12 החודשים האחרונים	ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
5	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
6	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
7	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה)
מקור	GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

3.23 מונטלוקאסט · Montelukast מתאים

אנטגוניסט ללויקוטריאנים

שמות מסחריים (3)	סינגולייר · Singulair | מונטאייר · Montair | מונטלוקאסט-תרימה · Montelukast-Trima
נימוק / הערה	פחות יעיל מ-ICS; סיכון לתופעות נפשיות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין תופעות נפשיות מתועדות	ברשומה או בפנייה אין שינויי התנהגות, סיוטים, דיכאון או מחשבות אובדניות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
2	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
5	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
6	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
7	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	שינויי התנהגות, דיכאון או מחשבות אובדניות ← דחוף - הפסקה; סיוטים או הפרעות שינה ← לרופא
מקור	GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

3.24 תאופילין · Theophylline בתנאים

מתילקסנטין

שמות מסחריים (1)	תאוטרים · Theotrim
נימוק / הערה	GINA לא ממליצה (תופעות לוואי). טווח טיפולי צר, אינטראקציות רבות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	רמת תאופילין מתועדת	רמה מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	רמת התרופה בדם בטווח	בבדיקה האחרונה רמת התרופה בדם בטווח. חריג: רמה מעל 15 מ"ג/ל ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: רמה מעל 20 מ"ג/ל ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: רמה מעל 20 מ"ג/ל ← לא מחדשים	
3	אין תרופה חדשה עם אינטראקציה	ברשימת התרופות אין ציפרופלוקסצין, קלריתרומיצין, אריתרומיצין או פלובוקסמין. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	רמה בדם שנתית ובכל שינוי
ספי החזרה לרופא/ה	רמה מעל 15 מ"ג/ל
ערך חמור	רמה מעל 20 מ"ג/ל
תלונות בפנייה או ברשומה	בחילות, הקאות או דפיקות לב ← דחוף - רמה בדם; פרכוס ← דחוף - מיון
מקור	GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט) עמ' 27

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

3.25 אזיתרומיצין (טיפול ממושך) · Azithromycin (long-term) בתנאים

מקרוליד למניעת התלקחויות

שמות מסחריים (5)	אזניל · Azenil | זטו · Zeto | אזיתרו טבע · Azithro Teva | אזיתרומיצין אינובמד · Azithromycin Inovamed | אזיתרובניר · Azithrovenir
נימוק / הערה	רק בהמלצת רופא/ת ריאות. QT מוארך, שמיעה, ALT

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אק"ג ו-ALT מתועדים	אק"ג ו-ALT מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	QTc תקין באק"ג	QTc באק"ג האחרון מתחת ל-450 (גברים) או 470 (נשים). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	תפקודי כבד (ALT) תקין	בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
4	אין תרופה נוספת שמאריכה QT	ברשימת התרופות אין אמיודרון, סוטלול, ציטלופרם, הלופרידול או מתדון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
5	אין ירידה בשמיעה מתועדת	ברשומה או בפנייה אין ירידה בשמיעה או טנטון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
7	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
8	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ת ריאות, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
9	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
10	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
11	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
12	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אק"ג ו-ALT שנתי; שמיעה לפי תסמינים
ספי החזרה לרופא/ה	ALT מעל פי 3 מהגבול העליון
תלונות בפנייה או ברשומה	דפיקות לב או עילפון ← דחוף; ירידה בשמיעה ← לרופא; שלשולים ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

3.26 **אנטיהיסטמינים (דור שני)** · Antihistamines (2nd generation) מתאים

אלרגיה

שמות מסחריים (16)	היסטזין · Histazine · זילרג'י · Zyllergy · אן-אלרגיה · N-Alergya · אלרג'י-קאר · Allergy-Care · לורטדים · Loratadim · לורסטין · Lorastine · לורתרים · Loratrim · אריוס · Aerius · דס-לורטדים · Des-Loratadim · טלפסט · Telfast · פקסי · Fexy · פקסופנאדין-תרימה · Fexofenadine-Trima · בילקסטן · Bilaxten · ליסטומד · Listomed · בילסטין-תרימה · Bilastine-Trima · רופפין · Rupafin
נימוק / הערה	בטוחים; מינון מופחת של צטיריזין באי-ספיקת כליות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
3	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
4	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
5	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
6	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
תלונות בפנייה או ברשומה	קושי בנשימה או נפיחות בפנים ← דחוף - מיון
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

3.27 **תרופות ליל"ד ריאתי ולפיברוזיס ריאתי** · Pulmonary hypertension / IPF drugs רופא/ה בלבד

ריאות - מומחה

שמות מסחריים (31)	בוסנטן תרו · Bosentan Taro · בוסנטן טבע · Bosentan Teva · טרקליר · Tracleer · אמבריסנטן אס.קיי. · Ambrisentan S.K. · אמבריסנטן טבע · Ambrisentan Teva · סנטאבניר · Sentavenir · וולובריס · Volibris · מאציטנטן טבע · Macitentan Teva · אופסומיט · Opsumit · אדמפאס · Adempas · אפטרבי · Uptravi · רימודולין · Remodulin · טרפרוסטיניל אס.קיי. · Treprostinil S.K · טרפרוסטיניל אס.קיי. · Treprostinil S.K. · טייבסו · Tyvaso · אילומדין · Ilomedin · אילופרוסט אמ.בי.איי · Iloprost Mbi · ונטויס · Ventavis · אסברייט · Esbriet · פירפנידון אינובמד · Pirfenidone Inovamed · פירפנידון סנדוז · Pirfenidone Sandoz · פירפנידון טבע · Pirfenidone Teva · פירון · Piron · נינפב טבע · Ninfev Teva · נינטדניב אס.קיי. · Nintedanib S.K. · נינטדניב סנדוז · Nintedanib Sandoz · נינטומד · Nintomed · אופב · Ofev · ורדאניב טבע · Vardanib Teva · וארגטף · Vargatef · רוויטו · Revatio
נימוק / הערה	יל"ד ריאתי ופיברוזיס ריאתי מטופלים ע"י מרכז מומחה (מעקב תפקודי כבד). להעביר לרופא/ה.
הנחיה	**יל"ד ריאתי ופיברוזיס ריאתי מטופלים ע"י מרכז מומחה (מעקב תפקודי כבד). להעביר לרופא/ה.**

מקור	-

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

3.28 **תרופות לסיסטיק פיברוזיס** · Cystic fibrosis modulators (רופא/ה בלבד)

CF

שמות מסחריים (5)	אליפטרק · Alyftrek | קליידקו · Kalydeco | אורקמבי · Orkambi | סימדקו · Symdeko | טריקפטה · Trikafta
נימוק / הערה	תרופות לסיסטיק פיברוזיס נקבעות ע"י מרכז CF. להעביר לרופא/ה.
הנחיה	**תרופות לסיסטיק פיברוזיס נקבעות ע"י מרכז CF. להעביר לרופא/ה.**

מקור	-

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4. נוירולוגיה

45 תרופות · בתנאים: 35 · מתאים: 6 · רופא/ה בלבד: 4 · גרסה 2 · חלוקה לפי מערכות · 2.11.2026

מקורות: אין הנחיה בפרויקט לתחומים אלה: כל הערכים הם החלטה מקומית (הצעה); הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020; ACOG 2023 (סיכום AFP). שאר התחומים: החלטה מקומית; עלון לצרכן לפונקס (עודכן 12/2020). שאר התרופות: החלטה מקומית

4.א כללים

- חידוש רגיל: 3 חודשים
- ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה פעם בשנה
- עד 3 חידושים רצופים, ואז ביקור רופא
- אין התווית נגד ← תמיד מחדשים לפחות לחודש אחד
- חסרה מדידה, בדיקה או ביקורת שנתית: חידוש לחודש אחד + זימון למרפאה
- חריגה מספי ההחזרה: חידוש לחודש אחד + הודעה לרופא/ה
- התווית נגד או ערך חמור: לא מחדשים, הודעה לרופא/ה (הסף של כל תרופה מופיע ברשימה שלה)
- רפואן לא משנה מינון ולא מחליף תרופה. "מעקב מעבדה צמוד" = תרופה עם בדיקות תכופות — לבדוק בקפידה
- נוגדי פרכוסים, תרופות לפרקינסון, בקלופן וגואנפצין לא נעצרים ע"י רפואן: כל חריגה ← חודש + הודעה
- פריחה בלמוטריגין, התנהגות כפייתית או החמרה במיאסתניה ← הודעה דחופה
- טריפטנים לפי הצורך: 10 ימי טיפול ומעלה בחודש ← הודעה

4.ג בדיקות משותפות

שלב	נושא	מה בודקים	קריטריון	אם לא מתקיים	מקור
לפני כל חידוש	בדיקת מעקב	לפי התרופה	קריאטינין (לבטירצטם, פרמיפקסול, אמנטדין, ממנטין, בקלופן); נתרן (אוקסקרבזפין); רמה (פניטואין); דופק (דונפזיל, ריבסטיגמין)	אין ← חידוש לחודש + זימון לבדיקה	החלטה נוירו-2
לפני כל חידוש	רכישות	כיסוי ימים ב-6 החודשים האחרונים	80% מהימים ומעלה	פחות ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה	כמו ביל"ד
לפני כל חידוש	ביקורת שנתית	ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה	ב-12 החודשים האחרונים	אין ← חידוש לחודש + זימון לביקורת	כמו ביל"ד
לפני כל חידוש	רצף חידושים	כמה חידושים רצופים מאז ביקור רופא	פחות מ-3	3 ← ביקור רופא	כמו ביל"ד

4.ד החלטות

#	נושא	מה ההנחיה אומרת	ההחלטה לפרוטוקול	סוג	מקור
נוירו-1	תרופות שלא נעצרות	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	נוגדי פרכוסים, פרקינסון, בקלופן, גואנפצין: רפואן לא עוצר; חריגה ← חידוש לחודש + הודעה	החלטה מקומית (הצעה)	-
נוירו-2	בדיקות מעקב	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	קריאטינין שנתי בתרופות שמינון לפי כליות; נתרן באוקסקרבזפין (מתחת ל-133 ← הודעה, מתחת ל-125 ← לא מחדשים); רמת פניטואין 10-20 (מעל 25 ← לא מחדשים); דופק במעכבי כולינאסטרז (מתחת ל-55 ← הודעה, מתחת ל-50 ← לא מחדשים)	החלטה מקומית (הצעה)	-
נוירו-3	סימנים דחופים	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	מחשבות אובדניות, פריחה בלמוטריגין, התנהגות כפייתית באגוניסטים לדופמין, החמרה במיאסתניה ← הודעה דחופה	החלטה מקומית (הצעה)	-
נוירו-4	טופירמט	טרטוגני (אזהרת EMA 2023)	אישה בגיל הפוריות: אמצעי מניעה מתועד; אחרת ← הודעה. היריון ← לא מחדשים	החלטה מקומית (הצעה)	-
נוירו-7	השלמות (2.11.2026)	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	פרימידון, פנוברביטל (רמה 40-15), אסליקרבזפין (נתרן), פרמפנל, צנובמט, אנטי-כולינרגיים (גיל 65+: קוגניציה), מיאנסרין, מפרוטילין, דוקספין	החלטה מקומית (הצעה)	-

#	נושא	מה ההנחיה אומרת	ההחלטה לפרוטוקול	סוג	מקור
נוירו-8	השלמות 2 (2.11.2026)	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	בוספירון, אנטגוניסטי אורקסין, גפנטים, נרטריפטן, מילנציפרן, רבוקסטין, אופיקפון, סלג'ילין, רילוזול (ALT). רופא/ה בלבד: אפומורפין/טטרבנזין, תרופות אפילפסיה מומחה, נרקולפסיה	החלטה מקומית (הצעה)	-
כללי-12	תרופות כרוניות נוספות (2)	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	בזאפיברט, גבפנטין, פרגבלין, SSRI/SNRI (נתרן בגיל 65+), מעכבי ארומטאז, טמוקסיפן, רלוקסיפן, טרבינפין ואיטרקונזול (קורס): לפי הרשימה של כל תרופה	החלטה מקומית (הצעה)	-
כללי-14	הורמונים לנשים	NAMS 2022: אסטרוגן מערכתי עם רחם ← פרוגסטוגן; דימום לא סדיר ← בירור; התוויות נגד: סרטן שד, פקקת, אוטם/שבץ, מחלת כבד	אסטרוגן בלי פרוגסטוגן כשיש רחם ← הודעה; דימום ← הודעה דחופה; ממוגרפיה לפי התוכנית; ל"ד שנתי. אמצעי מניעה משולב: ל"ד מתחת ל-140/90, עישון בגיל 35+, מיגרנה עם הילה ופקקת = התווית נגד	הנחיה + החלטה מקומית	NAMS 2022; נייר העמדה הישראלי לטיפול הורמונלי (בפרויקט)
כללי-20	השלמות מהמאגר (2.11.2026)	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	טרזוסין, פינסטריד, אינקליסירן, ורדנאפיל, טיפות לגלאוקומה (ביקורת עיניים שנתית; טימולול: דופק ואסתמה), NSAID ממושך (כליות, אשלגן, ל"ד, דימום, הגנת קיבה), אנטיהיסטמינים, ציננריזין, דומפרידון, מבברין, סידן, מידודרין, פנטוקסיפילין, דיפירידמול, ולציקלוביר מונע, חומצה זולדרונית	החלטה מקומית (הצעה)	-
כללי-21	תרופות מומחה נוספות	-	מטוקלופרמיד ממושך, ממריצים/מודפיניל, ביולוגיות, טרשת נפוצה, אונקולוגיה, יל"ד ריאתי/IPF, סירולימוס, הורמון גדילה, המטולוגיה, CF, טפמידיס/מבקמטן: הודעה בלבד, חידוש ע"י רופא/ה	החלטה מקומית	-
כללי-22	השלמות 2 מהמאגר (2.11.2026)	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	ויטמין D, בטאהיסטין, חומצה במפדואית, אומגה 3/איקוזפנט, ציפרופיברט, וריסיגואט, ניטרוגליצרין תת-לשוני, פזולינטנט/אלינזנטנט (ALT), דואביב, אינטראروסה, סיאנה, אורליסטט, פרוקלופריד, משלשלים, טטרציקלינים ממושכים, מניעת זיהומי שתן, משככי כאב ממושכים, ביקרבונט. רופא/ה בלבד: פנטרמין, בונות עצם, הפרינים, תרופות עצם בכליות, אנלוגי סומטוסטטין, הפטיטיס C/D, מחלות נדירות	החלטה מקומית (הצעה)	-
מעקב-7	קרבמזפין וולפרואט	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	רמה, נתרן (קרבמזפין), ALT וספירת דם מ-12 החודשים האחרונים. ולפרואט באישה בגיל הפוריות: אמצעי מניעה מתועד. היריון ← הודעה דחופה, לא מפסיקים	החלטה מקומית (הצעה)	-

4.ה רשימת התרופות (לסימון)

#	שם	גנרי	קבוצה	התאמה	אושר	הערות
4.1	לבטירצטם	Levetiracetam	נוגד פרכוסים	בתנאים	☐	
4.2	בריברצטם	Brivaracetam	נוגד פרכוסים	בתנאים	☐	
4.3	למוטריגין	Lamotrigine	נוגד פרכוסים / מייצב מצב רוח	בתנאים	☐	
4.4	טופירמט	Topiramate	נוגד פרכוסים / מניעת מיגרנה	בתנאים	☐	
4.5	אוקסקרבזפין	Oxcarbazepine	נוגד פרכוסים	בתנאים	☐	
4.6	לקוסמיד	Lacosamide	נוגד פרכוסים	בתנאים	☐	
4.7	פניטואין	Phenytoin	נוגד פרכוסים	בתנאים	☐	
4.8	לבודופה / קרבידופה	Levodopa / carbidopa	פרקינסון	בתנאים	☐	
4.9	פרמיפקסול	Pramipexole	פרקינסון / רגליים חסרות מנוחה	בתנאים	☐	
4.10	רופינירול	Ropinirole	פרקינסון / רגליים חסרות מנוחה	בתנאים	☐	
4.11	רסג'ילין	Rasagiline	פרקינסון · מעכב MAO-B	בתנאים	☐	
4.12	ספינמיד	Safinamide	פרקינסון · מעכב MAO-B	בתנאים	☐	

#	שם	גנרי	קבוצה	התאמה	אושר	הערות
4.13	אמנטדין	Amantadine	פרקינסון	בתנאים	☐	
4.14	דונפזיל	Donepezil	דמנציה · מעכב כולינאסטרז	בתנאים	☐	
4.15	ריבסטיגמין	Rivastigmine	דמנציה · מעכב כולינאסטרז	בתנאים	☐	
4.16	ממנטין	Memantine	דמנציה · אנטגוניסט NMDA	בתנאים	☐	
4.17	סומטריפטן	Sumatriptan	מיגרנה · טריפטן (לפי הצורך)	מתאים	☐	
4.18	ריזטריפטן	Rizatriptan	מיגרנה · טריפטן (לפי הצורך)	מתאים	☐	
4.19	אלטריפטן	Eletriptan	מיגרנה · טריפטן (לפי הצורך)	מתאים	☐	
4.20	זולמיטריפטן	Zolmitriptan	מיגרנה · טריפטן (לפי הצורך)	מתאים	☐	
4.21	בקלופן	Baclofen	מרפה שרירים (ספסטיות)	בתנאים	☐	
4.22	פיридוסטיגמין	Pyridostigmine	מיאסתניה גרביס	בתנאים	☐	
4.23	פרימידון	Primidone	רעד / נוגד פרכוסים	בתנאים	☐	
4.24	פנוברביטל	Phenobarbital	נוגד פרכוסים	בתנאים	☐	
4.25	אסליקרבזפין	Eslicarbazepine	נוגד פרכוסים	בתנאים	☐	
4.26	פרמפנל	Perampanel	נוגד פרכוסים	בתנאים	☐	
4.27	צנובמט	Cenobamate	נוגד פרכוסים	בתנאים	☐	
4.28	טריהקסיפנידיל	Trihexyphenidyl	אנטי-כולינרגי (פרקינסון / תופעות חוץ-פירמידליות)	בתנאים	☐	
4.29	ביפרידן	Biperiden	אנטי-כולינרגי (פרקינסון / תופעות חוץ-פירמידליות)	בתנאים	☐	
4.30	פרוציקלידין	Procyclidine	אנטי-כולינרגי (פרקינסון / תופעות חוץ-פירמידליות)	בתנאים	☐	
4.31	גפנטים (מיגרנה)	Gepants (migraine)	מיגרנה · אנטגוניסט CGRP	בתנאים	☐	
4.32	נרטריפטן	Naratriptan	מיגרנה · טריפטן (לפי הצורך)	מתאים	☐	
4.33	אופיקפון	Opicapone	פרקינסון · מעכב COMT	בתנאים	☐	
4.34	סלג'ילין	Selegiline	פרקינסון · מעכב MAO-B	בתנאים	☐	
4.35	רילוזול	Riluzole	ALS	בתנאים	☐	
4.36	תרופות להפרעות תנועה במעקב מומחה	Specialist movement-disorder drugs	נוירולוגיה - מומחה	רופא/ה בלבד	☐	
4.37	תרופות לאפילפסיה במעקב מומחה	Specialist epilepsy drugs	נוירולוגיה - מומחה	רופא/ה בלבד	☐	
4.38	תרופות לנרקולפסיה	Narcolepsy drugs	הפרעות שינה	רופא/ה בלבד	☐	
4.39	גבפנטין	Gabapentin	כאב נוירופתי / נוגד פרכוסים	בתנאים	☐	
4.40	פרגבלין	Pregabalin	כאב נוירופתי / נוגד פרכוסים	בתנאים	☐	
4.41	ציננריזין	Cinnarizine	סחרחורת · אנטיהיסטמין	בתנאים	☐	
4.42	תרופות לטרשת נפוצה	Multiple sclerosis drugs	טרשת נפוצה	רופא/ה בלבד	☐	
4.43	בטאהיסטין	Betahistine	סחרחורת (מנייר)	מתאים	☐	

#	שם	גנרי	קבוצה	התאמה	אושר	הערות
4.44	קרבמזפין	Carbamazepine	נוגד פרכוסים	בתנאים ⚗	☐	
4.45	ולפרואט	Valproate	נוגד פרכוסים / מייצב מצב רוח	בתנאים ⚗	☐	

1.4 פירוט מלא

4.1 **לבטירצטם** · Levetiracetam בתנאים

נוגד פרכוסים

שמות מסחריים (5)	קפרה · Keppra	לוותרים · Levetrim	לוובון · Levebon	לבטיראצטם דקסל · Levetiracetam Dexcel	לבטיראצטם אלטן · Levetiracetam Altan
נימוק / הערה	לא נעצר בפתאומיות. מינון לפי כליות; תופעות התנהגותיות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין פרכוס מאז הביקור האחרון	ברשומה או בפנייה אין פרכוס חדש מאז הביקור האחרון אצל הנוירולוג/ית או הרופא/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	קריאטינין מתועד	קריאטינין/eGFR מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
3	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <50 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
4	אין שינוי התנהגותי מתועד	ברשומה או בפנייה אין עצבנות קשה, תוקפנות, דיכאון או מחשבות אובדניות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	קריאטינין שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <50 (לבדיקת מינון)
תלונות בפנייה או ברשומה	פרכוס ← לרופא; פרכוס ממושך - מיון; פריחה, חום או פצעים בפה ← דחוף; ישנוניות או חוסר יציבות ← לרופא; עצבנות קשה או דיכאון ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.2 **בריברצטם** · Brivaracetam בתנאים

נוגד פרכוסים

שמות מסחריים (1)	בריביאקט · Briviact
נימוק / הערה	לא נעצר בפתאומיות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין פרכוס מאז הביקור האחרון	ברשומה או בפנייה אין פרכוס חדש מאז הביקור האחרון אצל הנוירולוג/ית או הרופא/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	אין החמרה מתועדת	ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
6	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	פרכוס ← לרופא; פרכוס ממושך - מיון; פריחה, חום או פצעים בפה ← דחוף; ישנוניות או חוסר יציבות ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.3 **למוטריגין** · Lamotrigine בתנאים

נוגד פרכוסים / מייצב מצב רוח

שמות מסחריים (3)	למיקטל · Lamictal | למודקס · Lamodex | למוג'ין · Lamogine
נימוק / הערה	פריחה ← הפסקה מיידית (SJS). ולפרואט מכפיל את הרמה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין פרכוס מאז הביקור האחרון	ברשומה או בפנייה אין פרכוס חדש מאז הביקור האחרון אצל הנוירולוג/ית או הרופא/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	אין פריחה מתועדת	ברשומה או בפנייה אין פריחה, חום או פצעים בפה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	אין ולפרואט חדש	לא נוסף ולפרואט (דפלפט, ולפרואט) מאז קביעת המינון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	פריחה, חום או פצעים בפה ← דחוף - הפסקה; פרכוס ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.4 טופירמט · Topiramate בתנאים

נוגד פרכוסים / מניעת מיגרנה

שמות מסחריים (2)	טופמקס · Topamax | טופיתרים · Topitrim
נימוק / הערה	טרטוגני: נשים בגיל הפוריות רק עם אמצעי מניעה. אבנים בכליות, ירידה במשקל

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין פרכוס מאז הביקור האחרון	ברשומה או בפנייה אין פרכוס חדש מאז הביקור האחרון אצל הנוירולוג/ית או הרופא/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	אמצעי מניעה יעיל מתועד שאלה: אישה בגיל הפוריות?	אמצעי מניעה יעיל מתועד, או החלטה מתועדת של הרופא/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
3	אין החמרה מתועדת	ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
11	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	ביקרבונט וקריאטינין לפי תסמינים
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון
תלונות בפנייה או ברשומה	פרכוס ← לרופא; פרכוס ממושך - מיון; פריחה, חום או פצעים בפה ← דחוף; ישנוניות או חוסר יציבות ← לרופא; כאב עיניים או ירידה בראייה ← דחוף; כאב גב חד או דם בשתן ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.5 אוקסקרבזפין · Oxcarbazepine בתנאים

נוגד פרכוסים

שמות מסחריים (1)	טרילפטין · Trileptin
נימוק / הערה	נתרן נמוך שכיח, בעיקר בגיל מבוגר או עם משתנים

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין פרכוס מאז הביקור האחרון	ברשומה או בפנייה אין פרכוס חדש מאז הביקור האחרון אצל הנוירולוג/ית או הרופא/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	נתרן מתועד	נתרן מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
3	נתרן (Na) תקין	בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מתחת ל-133 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: Na מתחת ל-125 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: Na מתחת ל-125 ← לא מחדשים	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	נתרן שנתי (כל 6 חודשים בגיל 65+ או עם משתן)
ספי החזרה לרופא/ה	Na מתחת ל-133
ערך חמור	Na מתחת ל-125
תלונות בפנייה או ברשומה	פרכוס ← לרופא; פרכוס ממושך - מיון; פריחה, חום או פצעים בפה ← דחוף; ישנוניות או חוסר יציבות ← לרופא; בלבול, כאב ראש או בחילה (נתרן נמוך) ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.6 לקוסמיד · Lacosamide בתנאים

נוגד פרכוסים

שמות מסחריים (3)	וימפט · Vimpat | לאקומייד · Lacomide | לקוסמיד טבע · Lacosamide Teva
נימוק / הערה	מאריך PR; זהירות במחלת הולכה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין פרכוס מאז הביקור האחרון	ברשומה או בפנייה אין פרכוס חדש מאז הביקור האחרון אצל הנוירולוג/ית או הרופא/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	אק"ג מתועד שאלה: יש מחלת לב, הפרעת הולכה או טיפול נוסף שמאט הולכה?	אק"ג מ-12 החודשים האחרונים ללא חסם הולכה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
6	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אק"ג לפי מחלת לב
תלונות בפנייה או ברשומה	פרכוס ← לרופא; פרכוס ממושך - מיון; פריחה, חום או פצעים בפה ← דחוף; ישנוניות או חוסר יציבות ← לרופא; עילפון או דופק איטי ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.7 פניטואין · Phenytoin בתנאים

נוגד פרכוסים

שמות מסחריים (2)	אפנוטין · Epanutin | דילנטין · Dilantin
נימוק / הערה	טווח טיפולי צר; אינטראקציות רבות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין פרכוס מאז הביקור האחרון	ברשומה או בפנייה אין פרכוס חדש מאז הביקור האחרון אצל הנוירולוג/ית או הרופא/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	רמת פניטואין מתועדת	רמה ואלבומין מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
3	רמת התרופה בדם בטווח	בבדיקה האחרונה רמת התרופה בדם בטווח. חריג: רמה מחוץ לטווח 10-20 מק"ג/מ"ל ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: רמה מעל 25 מק"ג/מ"ל ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: רמה מעל 25 מק"ג/מ"ל ← לא מחדשים	
4	תפקודי כבד (ALT) תקין	בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	רמה בדם ואלבומין שנתי; ALT
ספי החזרה לרופא/ה	רמה מחוץ לטווח 10-20 מק"ג/מ"ל; ALT מעל פי 3 מהגבול העליון
ערך חמור	רמה מעל 25 מק"ג/מ"ל
תלונות בפנייה או ברשומה	פרכוס ← לרופא; פרכוס ממושך - מיון; פריחה, חום או פצעים בפה ← דחוף; ישנוניות או חוסר יציבות ← לרופא; ראייה כפולה, חוסר יציבות או דיבור לא ברור ← דחוף - רמה בדם
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.8 **לבודופה / קרבידופה** · Levodopa / carbidopa בתנאים

פרקינסון

שמות מסחריים (4)	דופיקר · Dopicar | סינמט סי.אר · Sinemet CR | קרבידופה/לוודופה מדו · Carbidopa/Levodopa Medo | סטאלבו · Stalevo (עם אנטקפון)
נימוק / הערה	לא נעצר בפתאומיות. משאבות (דואודופה, לסיגון) - רק ע"י היחידה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**אין נפילות או הזיות מתועדות**	ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	**טיפול כרוני במינון קבוע**	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
5	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	נפילות או הזיות ← לרופא; נוקשות עם חום ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.9 **פרמיפקסול** · Pramipexole בתנאים

פרקינסון / רגליים חסרות מנוחה

שמות מסחריים (1)	סיפרול Sifrol ER · ER
נימוק / הערה	התנהגות כפייתית, ישנוניות פתאומית. מינון לפי כליות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**אין נפילות או הזיות מתועדות**	ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	**אין התנהגות כפייתית מתועדת**	ברשומה או בפנייה אין הימורים, קניות כפייתיות או שינוי בהתנהגות המינית. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	**קריאטינין מתועד**	קריאטינין/eGFR מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
4	**תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין**	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <50 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
5	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	**טיפול כרוני במינון קבוע**	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
8	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	קריאטינין שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <50 (לבדיקת מינון)
תלונות בפנייה או ברשומה	הימורים או קניות כפייתיות ← דחוף; הירדמות פתאומית ← לרופא - נהיגה
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.10 **רופינירול** · Ropinirole בתנאים

פרקינסון / רגליים חסרות מנוחה

שמות מסחריים (1)	רקוויפ מודוטאב · Requip Modutab
נימוק / הערה	התנהגות כפייתית, ישנוניות פתאומית

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**אין נפילות או הזיות מתועדות**	ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	**אין התנהגות כפייתית מתועדת**	ברשומה או בפנייה אין הימורים, קניות כפייתיות או שינוי בהתנהגות המינית. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	**טיפול כרוני במינון קבוע**	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
6	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	הימורים או קניות כפייתיות ← דחוף; הירדמות פתאומית ← לרופא - נהיגה
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.11 רסג'ילין · Rasagiline בתנאים

פרקינסון · מעכב MAO-B

שמות מסחריים (5)	אזילקט · Azilect | רסג'ילין-תרימה · Rasagiline-Trima | ראסאג'ילין אינובמד · Rasagiline Inovamed | רסג'ילין סנדוז · Rasagiline Sandoz | רז-אג'ילין · Raz-Agiline
נימוק / הערה	אינטראקציות מסוכנות (תסמונת סרוטונין)

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין נפילות או הזיות מתועדות	ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	אין תרופה עם אינטראקציה	ברשימת התרופות אין טרמדול, פתידין, מתדון, דקסטרומתורפן או מעכב MAO נוסף. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
6	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	אי-שקט, חום ורעד (תסמונת סרוטונין) ← דחוף - מיון
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.12 **ספינמיד** · Safinamide בתנאים

פרקינסון · מעכב MAO-B

שמות מסחריים (1)	קסדגו · Xadago
נימוק / הערה	אינטראקציות כמו רסג'ילין

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**אין נפילות או הזיות מתועדות**	ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	**אין תרופה עם אינטראקציה**	ברשימת התרופות אין טרמדול, פתידין, מתדון, דקסטרומתורפן או מעכב MAO נוסף. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	**טיפול כרוני במינון קבוע**	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
6	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.13 **אמנטדין** · Amantadine בתנאים

פרקינסון

שמות מסחריים (1)	אמנדין · Amandin
נימוק / הערה	מינון לפי כליות; בלבול והזיות בגיל מבוגר

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין נפילות או הזיות מתועדות	ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	קריאטינין מתועד	קריאטינין/eGFR מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
3	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <60 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <15 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <15 ← לא מחדשים	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	קריאטינין שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <60 (לבדיקת מינון)
ערך חמור	eGFR <15
תלונות בפנייה או ברשומה	בלבול או הזיות ← לרופא; בצקות ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.14 דונפזיל · Donepezil בתנאים

דמנציה · מעכב כולינאסטרז

שמות מסחריים (3)	אסנטה · Asenta | ממוריט · Memorit | דונפזיל טבע · Donepezil Teva
נימוק / הערה	האטת דופק ועילפון

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	דופק מתועד	מדידת דופק מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	דופק במנוחה תקין	במדידה האחרונה דופק במנוחה תקין. חריג: מתחת ל-55 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים	
3	אין עילפון או נפילות מתועדים	ברשומה או בפנייה אין עילפון, סחרחורת או נפילות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י גריאטר/ית, נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	דופק ומשקל בביקורת
ספי החזרה לרופא/ה	דופק מתחת ל-55
ערך חמור	דופק מתחת ל-50
תלונות בפנייה או ברשומה	עילפון או סחרחורת ← דחוף; ירידה בתיאבון ובמשקל ← לרופא; הקאות או שלשולים ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.15 ריבסטיגמין · Rivastigmine בתנאים

דמנציה · מעכב כולינאסטרז

שמות מסחריים (3)	אקסלון מדבקה · Exelon Patch | ריבסטיגמין דקסל · Rivastigmine Dexcel | ריבסטיגמין מדבקה דקסל · Rivastigmine Patch Dexcel
נימוק / הערה	האטת דופק ועילפון

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	דופק מתועד	מדידת דופק מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	דופק במנוחה תקין	במדידה האחרונה דופק במנוחה תקין. חריג: מתחת ל-55 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים	
3	אין עילפון או נפילות מתועדים	ברשומה או בפנייה אין עילפון, סחרחורת או נפילות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י גריאטר/ית, נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	דופק ומשקל בביקורת
ספי החזרה לרופא/ה	דופק מתחת ל-55
ערך חמור	דופק מתחת ל-50
תלונות בפנייה או ברשומה	עילפון או סחרחורת ← דחוף; ירידה בתיאבון ובמשקל ← לרופא; הקאות או שלשולים ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.16 **ממנטין** · Memantine בתנאים

דמנציה · אנטגוניסט NMDA

שמות מסחריים (5)	אביקסה · Ebixa | ממוקס · Memox | נמדטין · Nemdatine | וי-מנטין · V-Mantine | ממנטין גרינדקס · Memantine Grindeks
נימוק / הערה	מינון לפי כליות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	קריאטינין מתועד	קריאטינין/eGFR מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <30 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י גריאטר/ית, נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
6	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	קריאטינין שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <30 (לבדיקת מינון)
תלונות בפנייה או ברשומה	בלבול או אי-שקט חדשים ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.17 סומטריפטן · Sumatriptan מתאים

מיגרנה · טריפטן (לפי הצורך)

שמות מסחריים (2)	אימיטרקס · Imitrex | סומטרידקס · Sumatridex
נימוק / הערה	אסור במחלת לב, שבץ או ל"ד לא מאוזן. שימוש 10 ימים ומעלה בחודש = כאב ראש משימוש יתר

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	פחות מ-10 ימי טיפול בחודש	לפי הרכישות: פחות מ-10 מנות בחודש בממוצע ב-3 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	מדידת ל"ד מתועדת	מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
3	ל"ד מתחת ל-140/90	מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
9	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): מחלת לב איסכמית; שבץ או אירוע מוחי חולף; מחלת כלי דם היקפית. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	מחלת לב איסכמית; שבץ או אירוע מוחי חולף; מחלת כלי דם היקפית
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב או לחץ בחזה ← דחוף - מיון; כאב ראש שונה מהרגיל או חולשה בצד אחד ← דחוף - מיון
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.18 ריזטריפטן · Rizatriptan מתאים

מיגרנה · טריפטן (לפי הצורך)

שמות מסחריים (3)	ריזלט · Rizalt | ריזלט אר.פי.די · Rizalt RPD | ריזטריפטן אינובמד · Rizatriptan Inovamed
נימוק / הערה	אסור במחלת לב, שבץ או ל"ד לא מאוזן. שימוש 10 ימים ומעלה בחודש = כאב ראש משימוש יתר

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	פחות מ-10 ימי טיפול בחודש	לפי הרכישות: פחות מ-10 מנות בחודש בממוצע ב-3 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	מדידת ל"ד מתועדת	מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
3	ל"ד מתחת ל-140/90	מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
9	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): מחלת לב איסכמית; שבץ או אירוע מוחי חולף; מחלת כלי דם היקפית. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	מחלת לב איסכמית; שבץ או אירוע מוחי חולף; מחלת כלי דם היקפית
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב או לחץ בחזה ← דחוף - מיון; כאב ראש שונה מהרגיל או חולשה בצד אחד ← דחוף - מיון
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.19 **אלטריפטן** · Eletriptan מתאים

מיגרנה · טריפטן (לפי הצורך)

שמות מסחריים (3)	רילרט · Relert | אלטריפטן-תרימה · Eletriptan-Trima | אלטריפטאן אינובמד · Eletriptan Inovamed
נימוק / הערה	אסור במחלת לב, שבץ או ל"ד לא מאוזן. שימוש 10 ימים ומעלה בחודש = כאב ראש משימוש יתר

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**פחות מ-10 ימי טיפול בחודש**	לפי הרכישות: פחות מ-10 מנות בחודש בממוצע ב-3 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	**מדידת ל"ד מתועדת**	מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
3	**ל"ד מתחת ל-140/90**	מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
9	**אין התווית נגד**	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): מחלת לב איסכמית; שבץ או אירוע מוחי חולף; מחלת כלי דם היקפית. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	מחלת לב איסכמית; שבץ או אירוע מוחי חולף; מחלת כלי דם היקפית
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב או לחץ בחזה ← דחוף - מיון; כאב ראש שונה מהרגיל או חולשה בצד אחד ← דחוף - מיון
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.20 זולמיטריפטן · Zolmitriptan מתאים

מיגרנה · טריפטן (לפי הצורך)

שמות מסחריים (1)	זומיג · Zomig
נימוק / הערה	אסור במחלת לב, שבץ או ל"ד לא מאוזן. שימוש 10 ימים ומעלה בחודש = כאב ראש משימוש יתר

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**פחות מ-10 ימי טיפול בחודש**	לפי הרכישות: פחות מ-10 מנות בחודש בממוצע ב-3 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	**מדידת ל"ד מתועדת**	מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
3	**ל"ד מתחת ל-140/90**	מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
9	**אין התווית נגד**	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): מחלת לב איסכמית; שבץ או אירוע מוחי חולף; מחלת כלי דם היקפית. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	מחלת לב איסכמית; שבץ או אירוע מוחי חולף; מחלת כלי דם היקפית
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב או לחץ בחזה ← דחוף - מיון; כאב ראש שונה מהרגיל או חולשה בצד אחד ← דחוף - מיון
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.21 **בקלופן** · Baclofen בתנאים

מרפה שרירים (ספסטיות)

שמות מסחריים (2)	בקלוסל · Baclosal | בקלופן סינטטיקה · Baclofen Sintetica
נימוק / הערה	לא נעצר בפתאומיות (פרכוסים, הזיות). מצטבר באי-ספיקת כליות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	קריאטינין מתועד	קריאטינין/eGFR מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <60 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים	
3	אין נפילות או הזיות מתועדות	ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	קריאטינין שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <60 (לבדיקת מינון)
ערך חמור	eGFR <30
תלונות בפנייה או ברשומה	ישנוניות קשה או בלבול ← דחוף; חולשה ונפילות ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.22 פיריזוסטיגמין · Pyridostigmine בתנאים

מיאסתניה גרביס

שמות מסחריים (2)	מסטינון · Mestinon | פיריזוסטיגמין · Pyridostigmine
נימוק / הערה	נקבע ע"י נוירולוג/ית. החמרה במיאסתניה = מצב דחוף

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין החמרה מתועדת	ברשומה או בפנייה אין קושי בבליעה, בדיבור או בנשימה, או חולשה מחמירה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
2	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	קושי בבליעה או בנשימה ← דחוף - מיון; שלשולים, הזעה או התכווציות ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.23 פרימידון · Primidone בתנאים

רעד / נוגד פרכוסים

שמות מסחריים (1)	פריזולין · Prysoline
נימוק / הערה	ישנוניות ונפילות; לא נעצר בפתאומיות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין נפילות או הזיות מתועדות	ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	ישנוניות או חוסר יציבות ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.24 פנוברביטל · Phenobarbital בתנאים

נוגד פרכוסים

שמות מסחריים (1)	פנוברביטון רקח · Phenobarbitone Rekah
נימוק / הערה	רמה בדם; ישנוניות ונפילות; אינטראקציות רבות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין פרכוס מאז הביקור האחרון	ברשומה או בפנייה אין פרכוס חדש מאז הביקור האחרון אצל הנוירולוג/ית או הרופא/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	רמה מתועדת	רמת פנוברביטל מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
3	רמת התרופה בדם בטווח	בבדיקה האחרונה רמת התרופה בדם בטווח. חריג: רמה מחוץ לטווח 15-40 מק"ג/מ"ל ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
4	אין נפילות או הזיות מתועדות	ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	רמה בדם שנתית
ספי החזרה לרופא/ה	רמה מחוץ לטווח 15-40 מק"ג/מ"ל
תלונות בפנייה או ברשומה	פרכוס ← לרופא; פרכוס ממושך - מיון; פריחה, חום או פצעים בפה ← דחוף; ישנוניות או חוסר יציבות ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.25 אסליקרבזפין · Eslicarbazepine בתנאים

נוגד פרכוסים

שמות מסחריים (1)	זביניקס · Zebinix
נימוק / הערה	נתרן נמוך כמו באוקסקרבזפין

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין פרכוס מאז הביקור האחרון	ברשומה או בפנייה אין פרכוס חדש מאז הביקור האחרון אצל הנוירולוג/ית או הרופא/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	נתרן מתועד	נתרן מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
3	נתרן (Na) תקין	בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מתחת ל-133 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: Na מתחת ל-125 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: Na מתחת ל-125 ← לא מחדשים	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	נתרן שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	Na מתחת ל-133
ערך חמור	Na מתחת ל-125
תלונות בפנייה או ברשומה	פרכוס ← לרופא; פרכוס ממושך - מיון; פריחה, חום או פצעים בפה ← דחוף; ישנוניות או חוסר יציבות ← לרופא; בלבול או בחילה (נתרן נמוך) ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.26 פרמפנל · Perampanel בתנאים

נוגד פרכוסים

שמות מסחריים (1)	פייקומפה · Fycompa
נימוק / הערה	תוקפנות ושינויי התנהגות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין פרכוס מאז הביקור האחרון	ברשומה או בפנייה אין פרכוס חדש מאז הביקור האחרון אצל הנוירולוג/ית או הרופא/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	אין שינוי התנהגותי מתועד	ברשומה או בפנייה אין תוקפנות, עצבנות קשה או מחשבות אובדניות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
6	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	פרכוס ← לרופא; פרכוס ממושך - מיון; פריחה, חום או פצעים בפה ← דחוף; ישנוניות או חוסר יציבות ← לרופא; תוקפנות או מחשבות אובדניות ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.27 צנובמט · Cenobamate בתנאים

נוגד פרכוסים

שמות מסחריים (1)	אקסקופרי · Xcopri
נימוק / הערה	מקצר QT; פריחה (DRESS) בתחילת טיפול

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין פרכוס מאז הביקור האחרון	ברשומה או בפנייה אין פרכוס חדש מאז הביקור האחרון אצל הנוירולוג/ית או הרופא/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	אין פריחה מתועדת	ברשומה או בפנייה אין פריחה או חום. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
6	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	פרכוס ← לרופא; פרכוס ממושך - מיון; פריחה, חום או פצעים בפה ← דחוף; ישנוניות או חוסר יציבות ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.28 טריהקסיפנידיל · Trihexyphenidyl בתנאים

אנטי-כולינרגי (פרקינסון / תופעות חוץ-פירמידליות)

שמות מסחריים (2)	פרטאן · Partane | רודנל · Rodenal
נימוק / הערה	בלבול, עצירות ואצירת שתן בגיל מבוגר

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין ירידה קוגניטיבית מתועדת שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה?	אין בלבול או ירידה בזיכרון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
2	אין אצירת שתן	ברשומה או בפנייה אין אצירת שתן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
6	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
תלונות בפנייה או ברשומה	בלבול או הזיות ← לרופא; קושי במתן שתן ← לרופא; כאב עיניים ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.29 **ביפרידן** · Biperiden בתנאים

אנטי-כולינרגי (פרקינסון / תופעות חוץ-פירמידליות)

שמות מסחריים (1)	דקינט · Dekinet
נימוק / הערה	בלבול, עצירות ואצירת שתן בגיל מבוגר

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**אין ירידה קוגניטיבית מתועדת** שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה?	אין בלבול או ירידה בזיכרון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
2	**אין אצירת שתן**	ברשומה או בפנייה אין אצירת שתן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	**טיפול כרוני במינון קבוע**	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
6	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
תלונות בפנייה או ברשומה	בלבול או הזיות ← לרופא; קושי במתן שתן ← לרופא; כאב עיניים ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.30 פרוציקלידין · Procyclidine בתנאים

אנטי-כולינרגי (פרקינסון / תופעות חוץ-פירמידליות)

שמות מסחריים (1)	קמדרין · Kemadrin
נימוק / הערה	בלבול, עצירות ואצירת שתן בגיל מבוגר

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין ירידה קוגניטיבית מתועדת שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה?	אין בלבול או ירידה בזיכרון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
2	אין אצירת שתן	ברשומה או בפנייה אין אצירת שתן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
6	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
תלונות בפנייה או ברשומה	בלבול או הזיות ← לרופא; קושי במתן שתן ← לרופא; כאב עיניים ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.31 גפנטים (מיגרנה) · Gepants (migraine) בתנאים

מיגרנה · אנטגוניסט CGRP

שמות מסחריים (3)	קיוליפטה · Qulipta (מניעה) | נורטק או.די.טי · Nurtec ODT (התקף או מניעה) | אוברלוי · Ubrelvy (התקף)
נימוק / הערה	נקבע לרוב ע"י נוירולוג/ית; אינטראקציות עם מעכבי CYP3A4

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	הוערכה תועלת	ירידה בימי מיגרנה מתועדת ב-12 החודשים האחרונים (מניעה). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	אין מעכב CYP3A4 חזק	ברשימת התרופות אין קלריתרומיצין, איטרקונזול או קטוקונזול. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
6	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב ראש שונה מהרגיל או חולשה בצד אחד ← דחוף - מיון
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.32 נרטריפטן · Naratriptan מתאים

מיגרנה · טריפטן (לפי הצורך)

שמות מסחריים (1)	נרמיג · Naramig
נימוק / הערה	אסור במחלת לב או שבץ. 10 ימים ומעלה בחודש = כאב ראש משימוש יתר

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	פחות מ-10 ימי טיפול בחודש	לפי הרכישות: פחות מ-10 מנות בחודש בממוצע ב-3 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	מדידת ל"ד מתועדת	מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
3	ל"ד מתחת ל-140/90	מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
9	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): מחלת לב איסכמית; שבץ או אירוע מוחי חולף; מחלת כלי דם היקפית. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	מחלת לב איסכמית; שבץ או אירוע מוחי חולף; מחלת כלי דם היקפית
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב או לחץ בחזה ← דחוף - מיון
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.33 **אופיקפון** · Opicapone בתנאים

פרקינסון · מעכב COMT

שמות מסחריים (1)	אונג'נטיס · Ongentys
נימוק / הערה	תוספת ללבודופה; דיסקינזיה והזיות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**אין נפילות או הזיות מתועדות**	ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	**טיפול כרוני במינון קבוע**	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
5	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
תלונות בפנייה או ברשומה	תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; הזיות ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.34 סלג'ילין · Selegiline בתנאים

פרקינסון · מעכב MAO-B

שמות מסחריים (1)	סלג'ין · Selgin
נימוק / הערה	אינטראקציות מסוכנות (תסמונת סרוטונין)

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין נפילות או הזיות מתועדות	ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	אין תרופה עם אינטראקציה	ברשימת התרופות אין טרמדול, פתידין, מתדון, דקסטרומתורפן או מעכב MAO נוסף. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
6	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
תלונות בפנייה או ברשומה	אי-שקט, חום ורעד ← דחוף - מיון
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.35 רילוזול · Riluzole בתנאים

ALS

שמות מסחריים (1)	רילוטק · Rilutek
נימוק / הערה	נקבע ע"י נוירולוג/ית. ALT וספירת דם

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	ALT וספירת דם מתועדים	ALT וספירת דם מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	תפקודי כבד (ALT) תקין	בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: ALT מעל פי 5 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: ALT מעל פי 5 מהגבול העליון ← לא מחדשים	
3	אין חום מתועד	ברשומה או בפנייה אין חום או זיהום. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	ALT כל 3 חודשים בשנה הראשונה, אחר כך כל 6 חודשים; ספירת דם
ספי החזרה לרופא/ה	ALT מעל פי 3 מהגבול העליון
ערך חמור	ALT מעל פי 5 מהגבול העליון
תלונות בפנייה או ברשומה	חום ← דחוף - ספירת דם; שיעול או קוצר נשימה ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.36 תרופות להפרעות תנועה במעקב מומחה · Specialist movement-disorder drugs רופא/ה בלבד

נוירולוגיה - מומחה

שמות מסחריים (4)	אפו-גו · Apo-Go | אפו-גו פן · Apo Go Pen | קסנזין · Xenazine | אוסטדו · Austedo
נימוק / הערה	אפומורפין, טטרבנזין ודאוטטרבנזין נקבעים ע"י נוירולוג/ית (טטרבנזין: דיכאון ומחשבות אובדניות). להעביר לרופא/ה.
הנחיה	**אפומורפין, טטרבנזין ודאוטטרבנזין נקבעים ע"י נוירולוג/ית (טטרבנזין: דיכאון ומחשבות אובדניות). להעביר לרופא/ה.**

מקור	-

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.37 **תרופות לאפילפסיה במעקב מומחה** · Specialist epilepsy drugs רופא/ה בלבד

נוירולוגיה - מומחה

שמות מסחריים (6)	אינובלון טבליות · Inovelon | רופינאמיד - תרימה · Rufinamide – Trima | אוספולוט · Ospolot | פינטפלה · Fintepla | אפידיולקס · Epidiolex | סטיבקס · Sativex
נימוק / הערה	רופינאמיד, סולתיאם, קנבידיול ופנפלורמין נקבעים ע"י מרכז אפילפסיה (פנפלורמין: אקו לב). להעביר לרופא/ה.
הנחיה	**רופינאמיד, סולתיאם, קנבידיול ופנפלורמין נקבעים ע"י מרכז אפילפסיה (פנפלורמין: אקו לב). להעביר לרופא/ה.**
מקור	-

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.38 **תרופות לנרקולפסיה** · Narcolepsy drugs רופא/ה בלבד

הפרעות שינה

שמות מסחריים (2)	וואקיקס · Wakix | סנוסי · Sunosi
נימוק / הערה	פיטוליסנט וסולריאמפטול נקבעים ע"י מרפאת שינה (ל"ד, מצב נפשי). חידוש ע"י רופא/ה בלבד.
הנחיה	**פיטוליסנט וסולריאמפטול נקבעים ע"י מרפאת שינה (ל"ד, מצב נפשי). חידוש ע"י רופא/ה בלבד.**
מקור	-

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.39 גבפנטין · Gabapentin בתנאים

כאב נוירופתי / נוגד פרכוסים

שמות מסחריים (2)	נאורונטין · Neurontin | גאבאפנטין טבע · Gabapentin Teva
נימוק / הערה	מינון לפי כליות; סיכון לשימוש לרעה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	קריאטינין מתועד	קריאטינין/eGFR מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <60 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
3	אין סימני שימוש לרעה	אין בקשות מוקדמות או רכישות מעל 110% מהכמות שנרשמה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	אין אופיואיד או בנזודיאזפין במקביל	ברשימת התרופות אין אופיואיד או בנזודיאזפין שנוסף. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	קריאטינין שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <60 (לבדיקת מינון)
תלונות בפנייה או ברשומה	ישנוניות או סחרחורת קשה ← לרופא; בצקות ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.40 פרגבלין · Pregabalin בתנאים

כאב נוירופתי / נוגד פרכוסים

שמות מסחריים (5)	ליריקה · Lyrica	בליסק · Blisk	פרגבלין דקסל · Pregabalin Dexcel	פרגבלין אינובמד · Pregabalin Inovamed	פרגבלין טבע · Pregabalin Teva
נימוק / הערה	מינון לפי כליות; סיכון לשימוש לרעה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	קריאטינין מתועד	קריאטינין/eGFR מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <60 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
3	אין סימני שימוש לרעה	אין בקשות מוקדמות או רכישות מעל 110% מהכמות שנרשמה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	אין אופיואיד או בנזודיאזפין במקביל	ברשימת התרופות אין אופיואיד או בנזודיאזפין שנוסף. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	קריאטינין שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <60 (לבדיקת מינון)
תלונות בפנייה או ברשומה	ישנוניות או סחרחורת קשה ← לרופא; בצקות ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.41 **ציננריזין** · Cinnarizine בתנאים

סחרחורת · אנטיהיסטמין

שמות מסחריים (1)	סטונרון · Stunarone
נימוק / הערה	לא מומלץ לטיפול ממושך; בגיל מבוגר - נפילות ותופעות פרקינסוניות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**התוויה מתועדת לטיפול ממושך**	החלטה מתועדת של הרופא/ה על טיפול ממושך. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	**אין נפילות או הזיות מתועדות**	ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	**טיפול כרוני במינון קבוע**	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
6	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
תלונות בפנייה או ברשומה	רעד או נוקשות חדשים ← לרופא; נפילות ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.42 **תרופות לטרשת נפוצה** · Multiple sclerosis drugs רופא/ה בלבד

טרשת נפוצה

שמות מסחריים (27)	דיפומר אס.קיי.120 מ"ג · Difumar S.K. | דימתיל פומרט דקסל · Dimethyl Fumarate Dexcel | דימתיל פומרט מדומי · Dimethyl Fumarate Medomie | דימתיל פומרט תרו · Dimethyl Fumarate Taro | דימתיל פומרט טבע · Dimethyl Fumarate Teva | וומריטי · Vumerity | פינגולימוד - תרימה · Fingolimod - Trima | פינגולימוד טבע · Fingolimod Teva | פינולים · Finolim | גילניה · Gilenya | זפוסיה · Zeposia | מייזנט · Mayzent | אובג'יו · Aubagio | טריפלונומיד מדומי · Teriflunomide Medomie | טריפלונומיד תרו · Teriflunomide Taro | טריפלונומיד טבע · Teriflunomide Teva | ליטק · Litak | מייבנקלאד · Mavenclad | קופקסון · Copaxone | אוונקס תמיסה להזרקה · Avonex Solution For Injection | בטאפרון · Betaferon | פלגרידי · Plegridy | רביף · Rebif | אוקרוואס · Ocrevus | קיסימפטה · Kesimpta | טיירוקו · Tyruko | טייסברי תוך ורידי · Tysabri I.V
נימוק / הערה	תרופות לטרשת נפוצה נקבעות ומנוטרות ע"י הנוירולוג/ית (מרכז MS). להעביר לרופא/ה.
הנחיה	**תרופות לטרשת נפוצה נקבעות ומנוטרות ע"י הנוירולוג/ית (מרכז MS). להעביר לרופא/ה.**

מקור	-

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.43 בטאהיסטין · Betahistine מתאים

סחרחורת (מנייר)

שמות מסחריים (3)	בטיסטין · Betistine | אגיסרק · Agiserc | בטאהיסטין טבע · Betahistine Teva
נימוק / הערה	בטוח; זהירות באסתמה ובכיב פעיל

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
3	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
4	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
5	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
6	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
תלונות בפנייה או ברשומה	סחרחורת עם חולשה, הפרעת דיבור או ראייה ← דחוף - מיון; ירידה חדשה בשמיעה ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.44 קרבמזפין · Carbamazepine בתנאים מעקב מעבדה צמוד

נוגד פרכוסים

שמות מסחריים (3)	טגרטול · Tegretol | טריל · Teril | טימוניל · Timonil
נימוק / הערה	נקבע ע"י נוירולוג/ית או פסיכיאטר/ית. לא נעצר ע"י רפואן, מלבד ערך חמור. הרפואן לא משנה מינון

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	רמה ובדיקות מתועדות	רמת קרבמזפין, נתרן, ספירת דם ו-ALT מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	רמת התרופה בדם בטווח	בבדיקה האחרונה רמת התרופה בדם בטווח. חריג: רמה מחוץ לטווח 4-12 mg/L ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
3	ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה	בבדיקה האחרונה ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה. חריג: WBC מתחת ל-3,500 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: WBC מתחת ל-3,000 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: WBC מתחת ל-3,000 ← לא מחדשים	
4	נתרן (Na) תקין	בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: Na <125 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: Na <125 ← לא מחדשים	
5	תפקודי כבד (ALT) תקין	בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
6	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
7	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
8	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
9	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או פסיכיאטר/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
10	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
11	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
12	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
13	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	רמה, נתרן, ספירת דם ו-ALT שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	רמה מחוץ לטווח 4-12 mg/L; Na מחוץ לטווח המעבדה; WBC מתחת ל-3,500; ALT מעל פי 3 מהגבול העליון
ערך חמור	Na <125; WBC מתחת ל-3,000
תלונות בפנייה או ברשומה	פריחה, שלפוחיות או פצעים בפה ← הפסקה, דחוף; חום או כאב גרון ← דחוף - ספירת דם; סחרחורת, ראייה כפולה או חוסר יציבות ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

4.45 ולפרואט · Valproate

בתנאים | מעקב מעבדה צמוד

נוגד פרכוסים / מייצב מצב רוח

שמות מסחריים (2)	דפלפט · Depalept | דפלפט כרונו · Depalept Chrono
נימוק / הערה	נקבע ע"י נוירולוג/ית או פסיכיאטר/ית. מסוכן בהיריון: באישה בגיל הפוריות נדרש אמצעי מניעה מתועד. הרפואן לא משנה מינון

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	רמה ובדיקות מתועדות	רמת ולפרואט, ALT וספירת דם מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	רמת התרופה בדם בטווח	בבדיקה האחרונה רמת התרופה בדם בטווח. חריג: רמה מחוץ לטווח 50-100 mg/L ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
3	ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה	בבדיקה האחרונה ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה. חריג: WBC או טסיות מתחת לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-50,000 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-50,000 ← לא מחדשים	
4	תפקודי כבד (ALT) תקין	בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
5	אמצעי מניעה מתועד שאלה: המטופלת אישה בגיל הפוריות?	אישה בגיל הפוריות: אמצעי מניעה יעיל מתועד ברשומה. אין ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	שאלה
6	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
7	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
8	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
9	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או פסיכיאטר/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
10	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
11	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
12	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
13	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	רמה, ALT וספירת דם (טסיות) שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	רמה מחוץ לטווח 50-100 mg/L; ALT מעל פי 3 מהגבול העליון; WBC או טסיות מתחת לטווח המעבדה
ערך חמור	WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-50,000
תלונות בפנייה או ברשומה	כאבי בטן חזקים או הקאות (חשד לדלקת לבלב) ← דחוף; צהבת או חולשה ניכרת ← דחוף; חבורות או דימומים ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5. פסיכיאטריה

57 תרופות · מתאים: 23 · בתנאים: 32 · הכנה לאישור רופא/ה: 1 · רופא/ה בלבד: 1 · גרסה 2 · חלוקה לפי מערכות · 2.11.2026

מקורות: אין הנחיה בפרויקט לתחומים אלה: כל הערכים הם החלטה מקומית (הצעה); הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020; ACOG 2023 (סיכום AFP). שאר התחומים: החלטה מקומית; עלון לצרכן לפונקס (עודכן 12/2020). שאר התרופות: החלטה מקומית

5.א כללים

- חידוש רגיל: 3 חודשים
- ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה פעם בשנה
- עד 3 חידושים רצופים, ואז ביקור רופא
- אין התווית נגד ← תמיד מחדשים לפחות לחודש אחד
- חסרה מדידה, בדיקה או ביקורת שנתית: חידוש לחודש אחד + זימון למרפאה
- חריגה מספי ההחזרה: חידוש לחודש אחד + הודעה לרופא/ה
- התווית נגד או ערך חמור: לא מחדשים, הודעה לרופא/ה (הסף של כל תרופה מופיע ברשימה שלה)
- רפואן לא משנה מינון ולא מחליף תרופה. "מעקב מעבדה צמוד" = תרופה עם בדיקות תכופות — לבדוק בקפידה
- מחשבות אובדניות או החמרה נפשית ← הודעה דחופה
- קלוזפין: חידוש לחודש אחד בלבד, לפי ספירת דם
- ממריצים, בנזודיאזפינים ותרופות שינה Z: חידוש ע"י רופא/ה בלבד
- נוגדי פסיכוזה: מעקב מטבולי שנתי; לא נעצרים ע"י רפואן מלבד ערך חמור

5.ג בדיקות משותפות

שלב	נושא	מה בודקים	קריטריון	אם לא מתקיים	מקור
לפני כל חידוש	רכישות	כיסוי ימים ב-6 החודשים האחרונים	80% מהימים ומעלה	פחות ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה	כמו בי"ל
לפני כל חידוש	ביקורת שנתית	ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה	ב-12 החודשים האחרונים	אין ← חידוש לחודש + זימון לביקורת	כמו בי"ל
לפני כל חידוש	רצף חידושים	כמה חידושים רצופים מאז ביקור רופא	פחות מ-3	3 ← ביקור רופא	כמו בי"ל
לפני כל חידוש	רמה או ספירה מתועדת	לפי התרופה	ליתיום: 6 חודשים; דיגוקסין: 12 חודשים; קלוזפין: 4 שבועות	אין ← חידוש לחודש + זימון לבדיקה	החלטות מעקב-1, 3, 5
לפני כל חידוש	רמה בטווח	הבדיקה האחרונה	ליתיום 0.6-1.0; דיגוקסין עד 1.2; קלוזפין WBC ≥3,500 ונויטרופילים ≥2,000	מחוץ לטווח ← חידוש לחודש + הודעה; ערך חמור ← לא מחדשים	החלטות מעקב-2, 4, 5
לפני כל חידוש	תרופות חדשות	רשימת התרופות	ליתיום: NSAIDs, ACEi, ARB, משתנים. דיגוקסין: אמיודרון, ורפמיל, דילטיאזם, קלריתרומיצין	יש ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה	החלטות מעקב-2, 4
החזרה מיידית לרופא	חשד לרעילות	מופיע בפנייה או ברשומה	ליתיום: רעד, הקאות, שלשול, בלבול. דיגוקסין: בחילות, הפרעות ראייה, בלבול	דחוף - לרופא עכשיו	החלטות מעקב-2, 4
החזרה מיידית לרופא	חום בקלוזפין	מופיע בפנייה או ברשומה	חום, כאב גרון, זיהום	דחוף - ספירת דם היום	עלון לצרכן לפונקס (עודכן 12/2020)

5.ד החלטות

#	נושא	מה ההנחיה אומרת	ההחלטה לפרוטוקול	סוג	מקור
נוירו-1	תרופות שלא נעצרות	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	נוגדי פרכוסים, פרקינסון, בקלופן, גואנפצין: רפואן לא עוצר; חריגה ← חידוש לחודש + הודעה	החלטה מקומית (הצעה)	-

#	נושא	מה ההנחיה אומרת	ההחלטה לפרוטוקול	סוג	מקור
נוירו-7	השלמות (2.11.2026)	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	פרימידון, פנוברביטל (רמה 40-15), אסליקרבזפין (נתרן), פרמפנל, צנובמט, אנטי-כולינרגיים (גיל 65+: קוגניציה), מיאנסרין, מפרוטילין, דוקספין	החלטה מקומית (הצעה)	-
נוירו-8	השלמות 2 (2.11.2026)	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	בוספירון, אנטגוניסטי אורקסין, גפנטים, נרטריפטן, מילנציפרן, רבוקסטין, אופיקפון, סלג'ילין, רילוזול (ALT). רופא/ה בלבד: אפומורפין/טטרבנזין, תרופות אפילפסיה מומחה, נרקולפסיה	החלטה מקומית (הצעה)	-
כללי-13	חידוש ע"י רופא/ה בלבד	-	רואקוטן (רופא/ת עור בלבד), ממריצים, אופיואידים ובנזודיאזפינים: הכלי מציג הודעה ולא רשימת בדיקות	החלטה מקומית	-
כללי-21	תרופות מומחה נוספות	-	מטוקלופרמיד ממושך, ממריצים/מודפיניל, ביולוגיות, טרשת נפוצה, אונקולוגיה, יל"ד ריאתי/IPF, סירולימוס, הורמון גדילה, המטולוגיה, CF, טפמידיס/מבקמטן: הודעה בלבד, חידוש ע"י רופא/ה	החלטה מקומית	-
מעקב-1	ליתיום: תדירות	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	רמה, קריאטינין/eGFR, נתרן, TSH וסידן מ-6 החודשים האחרונים	החלטה מקומית (הצעה)	-
מעקב-2	ליתיום: ערכים	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	רמה 0.6-1.0 ← תקין. מחוץ לטווח, Na חריג או eGFR <60 ← חידוש לחודש + הודעה. רמה ≥1.5 ← ערך חמור. תרופה חדשה שמעלה רמה ← הודעה	החלטה מקומית (הצעה)	-
מעקב-5	קלוזפין (לפונקס)	ספירת דם כל שבוע ב-18 השבועות הראשונים, אחר כך לפחות פעם בחודש; ניפוק רק עם ספירה תקינה	רפואן מחדש רק בשלב החודשי, לחודש אחד, עם ספירה מ-4 השבועות האחרונים. WBC 3,000-3,500 או נויטרופילים 1,500-2,000 ← הודעה. מתחת ← ערך חמור, דחוף	הנחיה + החלטה מקומית (ספי הספירה: הצעה)	עלון לצרכן לפונקס (עודכן 12/2020)
מעקב-13	נוגדי פסיכוזה נוספים	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	הלופרידול, פליפרידון, קריפרזין, זיפרזידון, פרפנזין: מעקב מטבולי כמו בשאר; אק"ג בגיל 50+ בהלופרידול וזיפרזידון	החלטה מקומית (הצעה)	-
מעקב-14	נוגדי פסיכוזה ותיקים	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	אמיסולפריד, סולפיריד, פלופנזין, זוקלופנתיקסול, קלוטיאפין, לבומפרומזין: מעקב מטבולי כמו בשאר	החלטה מקומית (הצעה)	-
מעקב-15	נוגדי פסיכוזה נוספים (2)	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	ברקספיפרזול, אסנפין, אילופרידון, סרטינדול (אק"ג כל 3 חודשים), תיורידזין	החלטה מקומית (הצעה)	-

5.ה רשימת התרופות (לסימון)

#	שם	גנרי	קבוצה	התאמה	אושר	הערות
5.1	מירטזפין	Mirtazapine	נוגד דיכאון	מתאים	☐	
5.2	טרזודון	Trazodone	נוגד דיכאון / שינה	מתאים	☐	
5.3	בופרופיון	Bupropion	נוגד דיכאון / גמילה מעישון	מתאים	☐	
5.4	וורטיוקסטין	Vortioxetine	נוגד דיכאון	מתאים	☐	
5.5	פלובוקסמין	Fluvoxamine	SSRI	מתאים	☐	
5.6	אמיטריפטילין	Amitriptyline	נוגד דיכאון טריציקלי	מתאים	☐	
5.7	נורטריפטילין	Nortriptyline	נוגד דיכאון טריציקלי	מתאים	☐	
5.8	קלומיפרמין	Clomipramine	נוגד דיכאון טריציקלי	מתאים	☐	
5.9	אטומוקסטין	Atomoxetine	ADHD · לא ממריץ	בתנאים	☐	
5.10	גואנפצין	Guanfacine	ADHD · לא ממריץ	בתנאים	☐	
5.11	ורניקלין	Varenicline	גמילה מעישון (קורס)	מתאים	☐	
5.12	מלטונין	Melatonin	שינה	מתאים	☐	
5.13	מיאנסרין	Mianserin	נוגד דיכאון	מתאים	☐	
5.14	מפרוטילין	Maprotiline	נוגד דיכאון טטרציקלי	מתאים	☐	

#	שם	גנרי	קבוצה	התאמה	אושר	הערות
5.15	דוקספין	Doxepin	נוגד דיכאון טריציקלי / שינה	מתאים	☐	
5.16	בוספירון	Buspirone	נוגד חרדה	מתאים	☐	
5.17	דרידורקסנט	Daridorexant	שינה · אנטגוניסט אורקסין	בתנאים	☐	
5.18	למבורקסנט	Lemborexant	שינה · אנטגוניסט אורקסין	בתנאים	☐	
5.19	מילנציפרן	Milnacipran	SNRI	מתאים	☐	
5.20	רבוקסטין	Reboxetine	נוגד דיכאון (NRI)	מתאים	☐	
5.21	אסציטלופרם	Escitalopram	SSRI	מתאים	☐	
5.22	ציטלופרם	Citalopram	SSRI	מתאים	☐	
5.23	סרטרלין	Sertraline	SSRI	מתאים	☐	
5.24	פלואוקסטין	Fluoxetine	SSRI	מתאים	☐	
5.25	פרוקסטין	Paroxetine	SSRI	מתאים	☐	
5.26	ונלפקסין	Venlafaxine	SNRI	מתאים	☐	
5.27	דולוקסטין	Duloxetine	SNRI	מתאים	☐	
5.28	מתילפנידאט (מבוגרים)	Methylphenidate (adults)	ADHD · ממריץ (סם מסוכן)	בתנאים	☐	
5.29	מתילפנידאט (ילדים ובני נוער)	Methylphenidate (children)	ADHD · ממריץ (סם מסוכן)	בתנאים	☐	
5.30	ליסדקסאמפטמין (מבוגרים)	Lisdexamfetamine (adults)	ADHD · ממריץ (סם מסוכן)	בתנאים	☐	
5.31	ליסדקסאמפטמין (ילדים ובני נוער)	Lisdexamfetamine (children)	ADHD · ממריץ (סם מסוכן)	בתנאים	☐	
5.32	בנזודיאזפינים ותרופות שינה	Benzodiazepines / Z-drugs	מרגיעים ותרופות שינה	הכנה לאישור רופא/ה	☐	
5.33	מלחי אמפטמין (מבוגרים)	Amphetamine salts (adults)	ADHD · ממריץ (סם מסוכן)	בתנאים	☐	
5.34	מלחי אמפטמין (ילדים ובני נוער)	Amphetamine salts (children)	ADHD · ממריץ (סם מסוכן)	בתנאים	☐	
5.35	מודפיניל / ארמודפיניל	Modafinil / armodafinil	תרופות ערנות	רופא/ה בלבד	☐	
5.36	ליתיום	Lithium carbonate	מייצב מצב רוח	בתנאים ⚗	☐	
5.37	קלוזפין	Clozapine	נוגד פסיכוזה (מעקב ספירת דם חובה)	בתנאים ⚗	☐	
5.38	אולנזפין	Olanzapine	נוגד פסיכוזה	בתנאים ⚗	☐	
5.39	קוטיאפין	Quetiapine	נוגד פסיכוזה	בתנאים ⚗	☐	
5.40	ריספרידון	Risperidone	נוגד פסיכוזה	בתנאים ⚗	☐	
5.41	אריפיפרזול	Aripiprazole	נוגד פסיכוזה	בתנאים ⚗	☐	
5.42	הלופרידול	Haloperidol	נוגד פסיכוזה	בתנאים ⚗	☐	
5.43	פליפרידון	Paliperidone	נוגד פסיכוזה	בתנאים ⚗	☐	
5.44	קריפרזין	Cariprazine	נוגד פסיכוזה	בתנאים ⚗	☐	
5.45	זיפרזידון	Ziprasidone	נוגד פסיכוזה	בתנאים ⚗	☐	
5.46	פרפנזין	Perphenazine	נוגד פסיכוזה	בתנאים ⚗	☐	
5.47	אמיסולפריד	Amisulpride	נוגד פסיכוזה	בתנאים ⚗	☐	

#	שם	גנרי	קבוצה	התאמה	אושר	הערות
5.48	סולפיריד	Sulpiride	נוגד פסיכוזה	בתנאים ⚗	☐	
5.49	פלופנזין	Fluphenazine	נוגד פסיכוזה	בתנאים ⚗	☐	
5.50	זוקלופנתיקסול	Zuclopenthixol	נוגד פסיכוזה	בתנאים ⚗	☐	
5.51	קלוטיאפין	Clotiapine	נוגד פסיכוזה	בתנאים ⚗	☐	
5.52	לבומפרומזין	Levomepromazine	נוגד פסיכוזה	בתנאים ⚗	☐	
5.53	ברקספיפרזול	Brexpiprazole	נוגד פסיכוזה	בתנאים ⚗	☐	
5.54	אסנפין	Asenapine	נוגד פסיכוזה	בתנאים ⚗	☐	
5.55	אילופרידון	Iloperidone	נוגד פסיכוזה	בתנאים ⚗	☐	
5.56	סרטינדול	Sertindole	נוגד פסיכוזה	בתנאים ⚗	☐	
5.57	תיורידזין	Thioridazine	נוגד פסיכוזה	בתנאים ⚗	☐	

1.5 פירוט מלא

5.1 מירטזפין · Mirtazapine מתאים

נוגד דיכאון

שמות מסחריים (2)	מירו · Miro | מירטא טבע · Mirta Teva
נימוק / הערה	ישנוניות, עלייה במשקל; נתרן בגיל 65+

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	נתרן תקין (גיל 65+) שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה?	נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
2	אין החמרה מתועדת	ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	נתרן שנתי בגיל 65+
תלונות בפנייה או ברשומה	מחשבות אובדניות ← דחוף; החמרה במצב הרוח או אי-שקט קשה ← לרופא; חום או כאב גרון ← לרופא - ספירת דם
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.2 טרזודון · Trazodone מתאים

נוגד דיכאון / שינה

שמות מסחריים (2)	טריטיקו · Trittico | טרזודיל · Trazodil
נימוק / הערה	סחרחורת ונפילות בגיל מבוגר

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	נתרן תקין (גיל 65+) שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה?	נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
2	אין החמרה מתועדת	ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	אין נפילות או הזיות מתועדות	ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	נתרן שנתי בגיל 65+
תלונות בפנייה או ברשומה	מחשבות אובדניות ← דחוף; החמרה במצב הרוח או אי-שקט קשה ← לרופא; זקפה ממושכת וכואבת ← דחוף - מיון
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.3 בופרופיון · Bupropion מתאים

נוגד דיכאון / גמילה מעישון

שמות מסחריים (3)	וולבוטרין Wellbutrin · XR	זיבן · Zyban	בופרופיון · Bupropion Hydrochloride
נימוק / הערה	מוריד סף פרכוס; ל"ד

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין החמרה מתועדת	ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
2	מדידת ל"ד מתועדת	מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
3	ל"ד מתחת ל-140/90	מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
10	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): פרכוסים בעבר; אנורקסיה או בולימיה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	ל"ד שנתי
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	פרכוסים בעבר; אנורקסיה או בולימיה
תלונות בפנייה או ברשומה	מחשבות אובדניות ← דחוף; החמרה במצב הרוח או אי-שקט קשה ← לרופא; פרכוס ← דחוף - הפסקה
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.4 **וורטיוקסטין** · Vortioxetine מתאים

נוגד דיכאון

שמות מסחריים (1)	ברינטליקס · Brintellix
נימוק / הערה	נתרן בגיל 65+

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**נתרן תקין (גיל 65+)** שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה?	נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
2	**אין החמרה מתועדת**	ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	נתרן שנתי בגיל 65+
תלונות בפנייה או ברשומה	מחשבות אובדניות ← דחוף; החמרה במצב הרוח או אי-שקט קשה ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.5 פלובוקסמין · Fluvoxamine מתאים

SSRI

שמות מסחריים (1)	פבוקסיל · Favoxil
נימוק / הערה	אינטראקציות רבות (תאופילין, קלוזפין, טיזנידין)

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	נתרן תקין (גיל 65+) שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה?	נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
2	אין החמרה מתועדת	ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	נתרן שנתי בגיל 65+
תלונות בפנייה או ברשומה	מחשבות אובדניות ← דחוף; החמרה במצב הרוח או אי-שקט קשה ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.6 אמיטריפטילין · Amitriptyline מתאים

נוגד דיכאון טריציקלי

שמות מסחריים (1)	אמיטריפטילין טבע · Amitriptyline Teva
נימוק / הערה	רעיל במנת יתר; QT, נפילות, עצירות ואצירת שתן בגיל מבוגר

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	נתרן תקין (גיל 65+) שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה?	נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
2	אין החמרה מתועדת	ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	אק"ג מתועד שאלה: המטופל/ת בגיל 50 ומעלה או עם מחלת לב?	אק"ג מ-12 החודשים האחרונים ללא QTc מוארך. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
4	אין נפילות או הזיות מתועדות	ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אק"ג בגיל 50+ או במחלת לב
תלונות בפנייה או ברשומה	מחשבות אובדניות ← דחוף; החמרה במצב הרוח או אי-שקט קשה ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף; אצירת שתן או עצירות קשה ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.7 נורטריפטילין · Nortriptyline מתאים

נוגד דיכאון טריציקלי

שמות מסחריים (1)	נורטילין · Nortylin
נימוק / הערה	רעיל במנת יתר; QT, נפילות, עצירות ואצירת שתן בגיל מבוגר

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	נתרן תקין (גיל 65+) שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה?	נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
2	אין החמרה מתועדת	ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	אק"ג מתועד שאלה: המטופל/ת בגיל 50 ומעלה או עם מחלת לב?	אק"ג מ-12 החודשים האחרונים ללא QTc מוארך. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
4	אין נפילות או הזיות מתועדות	ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אק"ג בגיל 50+ או במחלת לב
תלונות בפנייה או ברשומה	מחשבות אובדניות ← דחוף; החמרה במצב הרוח או אי-שקט קשה ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף; אצירת שתן או עצירות קשה ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.8 קלומיפרמין · Clomipramine מתאים

נוגד דיכאון טריציקלי

שמות מסחריים (2)	אנאפרניל · Anafranil | אנאפרניל SR · Anafranil SR
נימוק / הערה	רעיל במנת יתר; QT, נפילות, עצירות ואצירת שתן בגיל מבוגר

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	נתרן תקין (גיל 65+) שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה?	נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
2	אין החמרה מתועדת	ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	אק"ג מתועד שאלה: המטופל/ת בגיל 50 ומעלה או עם מחלת לב?	אק"ג מ-12 החודשים האחרונים ללא QTc מוארך. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
4	אין נפילות או הזיות מתועדות	ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אק"ג בגיל 50+ או במחלת לב
תלונות בפנייה או ברשומה	מחשבות אובדניות ← דחוף; החמרה במצב הרוח או אי-שקט קשה ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף; אצירת שתן או עצירות קשה ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.9 אטומוקסטין · Atomoxetine בתנאים

ADHD · לא ממריץ

שמות מסחריים (2)	אטומיק · Atomic | אטומוקסימד · Atomoximed
נימוק / הערה	ל"ד ודופק; מחשבות אובדניות בצעירים

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין החמרה מתועדת	ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
2	מדידת ל"ד מתועדת	מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
3	ל"ד מתחת ל-140/90	מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	דופק מתחת ל-100	דופק במדידה האחרונה מתחת ל-100. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	ל"ד ודופק כל 6 חודשים
תלונות בפנייה או ברשומה	מחשבות אובדניות ← דחוף; החמרה במצב הרוח או אי-שקט קשה ← לרופא; צהבת או שתן כהה ← דחוף; דפיקות לב ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.10 גואנפצין · Guanfacine בתנאים

ADHD · לא ממריץ

שמות מסחריים (1)	גואנפצין מדומי · Guanfacine Medomie
נימוק / הערה	לא נעצר בפתאומיות (עלייה חדה בל"ד). ל"ד נמוך ודופק איטי

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	ל"ד ודופק מתועדים	מדידת ל"ד ודופק מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	דופק במנוחה תקין	במדידה האחרונה דופק במנוחה תקין. חריג: מתחת ל-55 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים	
3	אין עילפון מתועד	ברשומה או בפנייה אין עילפון או סחרחורת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 OP = 2 אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	ל"ד ודופק כל 6 חודשים
ספי החזרה לרופא/ה	דופק מתחת ל-55
ערך חמור	דופק מתחת ל-50
תלונות בפנייה או ברשומה	עילפון או סחרחורת ← דחוף; ישנוניות קשה ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.11 ורניקלין · Varenicline מתאים

גמילה מעישון (קורס)

שמות מסחריים (2)	צ'מפיקס · Champix | אפו-ורניקלין · Apo-Varenicline
נימוק / הערה	קורס 12 שבועות (עד 24 אם נגמל/ה)

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	בתוך משך הקורס	סך הטיפול עד 12 שבועות, או עד 24 שבועות עם החלטה מתועדת של הרופא/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	אין החמרה מתועדת	ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
5	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
תלונות בפנייה או ברשומה	מחשבות אובדניות ← דחוף; החמרה במצב הרוח או אי-שקט קשה ← לרופא; בחילות קשות ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.12 מלטונין · Melatonin מתאים

שינה

שמות מסחריים (3)	סירקדין · Circadin | מלטונין אינובמד · Melatonin Inovamed | סלנייטו · Slenyto (ילדים - ע"י מומחה)
נימוק / הערה	סירקדין: גיל 55+; ילדים (סלנייטו) - רק ע"י מומחה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
3	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
4	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
5	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
6	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
תלונות בפנייה או ברשומה	ישנוניות ביום ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.13 מיאנסרין · Mianserin מתאים

נוגד דיכאון

שמות מסחריים (1)	בונסרין · Bonserin
נימוק / הערה	אגרנולוציטוזיס נדירה; נתרן בגיל 65+

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	נתרן תקין (גיל 65+) שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה?	נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
2	אין החמרה מתועדת	ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	אין חום או כאב גרון	ברשומה או בפנייה אין חום, כאב גרון או פצעים בפה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 OP = 2 אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	נתרן שנתי בגיל 65+
תלונות בפנייה או ברשומה	מחשבות אובדניות ← דחוף; החמרה במצב הרוח או אי-שקט קשה ← לרופא; חום או כאב גרון ← דחוף - ספירת דם
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.14 מפרוטילין · Maprotiline מתאים

נוגד דיכאון טטרציקלי

שמות מסחריים (1)	מלודיל · Melodil
נימוק / הערה	מוריד סף פרכוס; QT

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	נתרן תקין (גיל 65+) שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה?	נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
2	אין החמרה מתועדת	ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	אק"ג מתועד שאלה: המטופל/ת בגיל 50 ומעלה או עם מחלת לב?	אק"ג מ-12 החודשים האחרונים ללא QTc מוארך. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
4	אין נפילות או הזיות מתועדות	ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אק"ג בגיל 50+
תלונות בפנייה או ברשומה	מחשבות אובדניות ← דחוף; החמרה במצב הרוח או אי-שקט קשה ← לרופא; פרכוס ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.15 דוקספין · Doxepin מתאים

נוגד דיכאון טריציקלי / שינה

שמות מסחריים (1)	גילקס · Gilex
נימוק / הערה	כמו טריציקליים: QT, נפילות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	נתרן תקין (גיל 65+) שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה?	נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
2	אין החמרה מתועדת	ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	אק"ג מתועד שאלה: המטופל/ת בגיל 50 ומעלה או עם מחלת לב?	אק"ג מ-12 החודשים האחרונים ללא QTc מוארך. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
4	אין נפילות או הזיות מתועדות	ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 OP = 2 אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אק"ג בגיל 50+
תלונות בפנייה או ברשומה	מחשבות אובדניות ← דחוף; החמרה במצב הרוח או אי-שקט קשה ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.16 בוספירון · Buspirone מתאים

נוגד חרדה

שמות מסחריים (1)	סורבון · Sorbon
נימוק / הערה	ללא תלות; אינטראקציה עם מעכבי MAO

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין החמרה מתועדת	ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
2	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
5	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
6	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
7	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
תלונות בפנייה או ברשומה	מחשבות אובדניות ← דחוף; החמרה במצב הרוח או אי-שקט קשה ← לרופא; סחרחורת ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.17 דרידורקסנט · Daridorexant בתנאים

שינה · אנטגוניסט אורקסין

שמות מסחריים (1)	קיוויויק · Quviviq
נימוק / הערה	פחות תלות מבנזודיאזפינים; לא עם אלכוהול. אסור בנרקולפסיה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין נפילות או הזיות מתועדות	ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
9	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): נרקולפסיה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	נרקולפסיה
תלונות בפנייה או ברשומה	ישנוניות ביום או שיתוק שינה ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.18 למבורקסנט · Lemborexant בתנאים

שינה · אנטגוניסט אורקסין

שמות מסחריים (1)	דייויגו · Dayvigo
נימוק / הערה	פחות תלות מבנזודיאזפינים; לא עם אלכוהול. אסור בנרקולפסיה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין נפילות או הזיות מתועדות	ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
9	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): נרקולפסיה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	נרקולפסיה
תלונות בפנייה או ברשומה	ישנוניות ביום או שיתוק שינה ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.19 מילנציפרן · Milnacipran מתאים

SNRI

שמות מסחריים (1)	מילנאבניר · Miln-Avenir
נימוק / הערה	ל"ד ודופק; נתרן בגיל 65+

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	נתרן תקין (גיל 65+) שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה?	נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
2	אין החמרה מתועדת	ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	מדידת ל"ד מתועדת	מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
4	ל"ד מתחת ל-140/90	מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	ל"ד שנתי; נתרן בגיל 65+
תלונות בפנייה או ברשומה	מחשבות אובדניות ← דחוף; החמרה במצב הרוח או אי-שקט קשה ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.20 רבוקסטין · Reboxetine מתאים

נוגד דיכאון (NRI)

שמות מסחריים (1)	אדרונקס · Edronax
נימוק / הערה	ל"ד, דופק ואצירת שתן

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	נתרן תקין (גיל 65+) שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה?	נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
2	אין החמרה מתועדת	ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	מדידת ל"ד מתועדת	מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
4	ל"ד מתחת ל-140/90	מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	ל"ד שנתי
תלונות בפנייה או ברשומה	מחשבות אובדניות ← דחוף; החמרה במצב הרוח או אי-שקט קשה ← לרופא; קושי במתן שתן ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.21 **אסציטלופרם** · Escitalopram (מתאים)

SSRI

שמות מסחריים (4)	ציפרלקס · Cipralex	אסטו · Esto	אסציטאלופרם טבע · Escitalopram Teva	אסציטאלופרם מדו · Escitalopram Medo
נימוק / הערה	נתרן בגיל 65+; החמרה או מחשבות אובדניות ← דחוף

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**נתרן תקין (גיל 65+)** שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה?	נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
2	**אין החמרה מתועדת**	ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	נתרן שנתי בגיל 65+
תלונות בפנייה או ברשומה	מחשבות אובדניות ← דחוף; בלבול או חולשה (נתרן נמוך) ← לרופא; דימומים ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.22 **ציטלופרם** · Citalopram מתאים

SSRI

שמות מסחריים (3)	ציפראמיל · Cipramil	רסיטל · Recital	ציטאלופרם טבע · Citalopram Teva
נימוק / הערה	נתרן בגיל 65+; החמרה או מחשבות אובדניות ← דחוף

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**נתרן תקין (גיל 65+)** שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה?	נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
2	**אין החמרה מתועדת**	ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	נתרן שנתי בגיל 65+
תלונות בפנייה או ברשומה	מחשבות אובדניות ← דחוף; בלבול או חולשה (נתרן נמוך) ← לרופא; דימומים ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.23 סרטרלין · Sertraline מתאים

SSRI

שמות מסחריים (3)	לוסטרל · Lustral | סרנדה · Serenada | סרטרלין טבע · Sertraline Teva
נימוק / הערה	נתרן בגיל 65+; החמרה או מחשבות אובדניות ← דחוף

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	נתרן תקין (גיל 65+) שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה?	נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
2	אין החמרה מתועדת	ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	נתרן שנתי בגיל 65+
תלונות בפנייה או ברשומה	מחשבות אובדניות ← דחוף; בלבול או חולשה (נתרן נמוך) ← לרופא; דימומים ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.24 פלואוקסטין · Fluoxetine מתאים

SSRI

שמות מסחריים (3)	פריזמה · Prizma | פלוטין · Flutine | פלואוקסטין ג'י.אל. · Fluoxetine G.L.
נימוק / הערה	נתרן בגיל 65+; החמרה או מחשבות אובדניות ← דחוף

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	נתרן תקין (גיל 65+) שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה?	נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
2	אין החמרה מתועדת	ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	נתרן שנתי בגיל 65+
תלונות בפנייה או ברשומה	מחשבות אובדניות ← דחוף; בלבול או חולשה (נתרן נמוך) ← לרופא; דימומים ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.25 פרוקסטין · Paroxetine מתאים

SSRI

שמות מסחריים (3)	סרוקסט · Seroxat | פאקסט · Paxxet | פרוטין · Parotin
נימוק / הערה	נתרן בגיל 65+; החמרה או מחשבות אובדניות ← דחוף

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	נתרן תקין (גיל 65+) שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה?	נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
2	אין החמרה מתועדת	ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	נתרן שנתי בגיל 65+
תלונות בפנייה או ברשומה	מחשבות אובדניות ← דחוף; בלבול או חולשה (נתרן נמוך) ← לרופא; דימומים ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.26 ונלפקסין · Venlafaxine מתאים

SNRI

שמות מסחריים (3)	אפקסור Efexor XR · XR	ויפאקס · Viepax	וונלה · Venla
נימוק / הערה	נתרן בגיל 65+; החמרה או מחשבות אובדניות ← דחוף

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	נתרן תקין (גיל 65+) שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה?	נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
2	אין החמרה מתועדת	ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	ל"ד מתחת ל-140/90	מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	נתרן שנתי בגיל 65+ ; ל"ד
תלונות בפנייה או ברשומה	מחשבות אובדניות ← דחוף; בלבול או חולשה (נתרן נמוך) ← לרופא; דימומים ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.27 דולוקסטין · Duloxetine מתאים

SNRI

שמות מסחריים (4)	דולוקס טבע · Dulox Teva | דולוקסטין מדו · Duloxetine Medo | דולוקסטין אס.קיי. · Duloxetine S.K. | דולוקסטין סנדוז · Duloxetine Sandoz
נימוק / הערה	נתרן בגיל 65+; החמרה או מחשבות אובדניות ← דחוף

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	נתרן תקין (גיל 65+) שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה?	נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
2	אין החמרה מתועדת	ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	נתרן שנתי בגיל 65+
תלונות בפנייה או ברשומה	מחשבות אובדניות ← דחוף; בלבול או חולשה (נתרן נמוך) ← לרופא; דימומים ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.28 מתילפנידאט (מבוגרים) · Methylphenidate (adults) בתנאים

ADHD · ממריץ (סם מסוכן)

שמות מסחריים (11)	ריטלין · Ritalin	ריטלין LA · Ritalin LA	קונסרטה · Concerta	רפנידאט · Rephenidate	פנידין · Phenidin	תרופן · Tarophen	מטדקס XR · Metadex XR	מתילפנידאט טבע · Methylphenidate Teva	מתילפנידאט סנדוז · Methylphenidate Sandoz	ריאבניר LA · Riavenir LA	קוויליואנט XR · Quillivant XR
נימוק / הערה	סם מסוכן: מחודש ע"י רפואן רק כשרשום בתרופות הקבועות, עם אבחנה מצורפת למרשם. אפשר ל-3 חודשים (מרשמים עתידיים).

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	רשומה בתרופות הקבועות	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהתרופה רשומה בתרופות הקבועות ונרשמה בעבר ע"י רופא/ה. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
2	אבחנה מתועדת ומצורפת למרשם	אבחנת ADHD (או נרקולפסיה) ברשימת האבחנות, ומצורפת למרשם ("ADD במעקב שלי"). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	עברו כ-3 חודשים מהמרשם הקודם	תרופה עם פוטנציאל התמכרות: בקשה לפני שעברו כ-3 חודשים, או רכישות מעבר לכמות שנרשמה ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	ילדים: משקל, גובה, דופק ול"ד כל 6 חודשים
תלונות בפנייה או ברשומה	ירידה בתיאבון ובמשקל ← לרופא; דפיקות לב, כאב בחזה או עילפון ← דחוף; מחשבות אובדניות או שינוי חד במצב הרוח ← דחוף
מקור	החלטה מקומית (3.11.2026); NICE NG87 (מעקב בילדים)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.29 מתילפנידאט (ילדים ובני נוער) · Methylphenidate (children) בתנאים

ADHD · ממריץ (סם מסוכן)

שמות מסחריים (11)	ריטלין · Ritalin	ריטלין LA · Ritalin LA	קונסרטה · Concerta	רפנידאט · Rephenidate	פנידין · Phenidin	תרופן · Tarophen	מטדקס XR · Metadex XR	מתילפנידאט טבע · Methylphenidate Teva	מתילפנידאט סנדוז · Methylphenidate Sandoz	ריאבניר LA · Riavenir LA	קוויליואנט XR · Quillivant XR
נימוק / הערה	סם מסוכן: מחודש ע"י רפואן רק כשרשום בתרופות הקבועות, עם אבחנה מצורפת למרשם. אפשר ל-3 חודשים (מרשמים עתידיים). בילדים גם משקל, גובה, דופק ול"ד כל 6 חודשים.

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	רשומה בתרופות הקבועות	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהתרופה רשומה בתרופות הקבועות ונרשמה בעבר ע"י רופא/ה. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
2	אבחנה מתועדת ומצורפת למרשם	אבחנת ADHD (או נרקולפסיה) ברשימת האבחנות, ומצורפת למרשם ("ADD במעקב שלי"). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	משקל וגובה מתועדים	משקל וגובה מ-6 החודשים האחרונים (עקומת גדילה). אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
4	דופק ול"ד מתועדים	דופק ול"ד מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
5	אין ירידה במשקל או האטה בגדילה	המשקל לא ירד והגדילה לא הואטה לעומת המדידה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	עברו כ-3 חודשים מהמרשם הקודם	תרופה עם פוטנציאל התמכרות: בקשה לפני שעברו כ-3 חודשים, או רכישות מעבר לכמות שנרשמה ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
8	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
9	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
10	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
11	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
12	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	ילדים: משקל, גובה, דופק ול"ד כל 6 חודשים
תלונות בפנייה או ברשומה	ירידה בתיאבון ובמשקל ← לרופא; דפיקות לב, כאב בחזה או עילפון ← דחוף; מחשבות אובדניות או שינוי חד במצב הרוח ← דחוף
מקור	החלטה מקומית (3.11.2026); NICE NG87 (מעקב בילדים)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.30 **ליסדקסאמפטמין (מבוגרים)** · Lisdexamfetamine (adults) בתנאים

ADHD · ממריץ (סם מסוכן)

שמות מסחריים (5)	ויואנס · Vyvanse · ליסדקס טבע · Lisdex Teva · ליסדקסא אס.קיי. · Lisdexa S.K. · ליסין · Lissin · תרומין · Taromine
נימוק / הערה	סם מסוכן: מחודש ע"י רפואן רק כשרשום בתרופות הקבועות, עם אבחנה מצורפת למרשם. אפשר ל-3 חודשים (מרשמים עתידיים).

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	רשומה בתרופות הקבועות	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהתרופה רשומה בתרופות הקבועות ונרשמה בעבר ע"י רופא/ה. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
2	אבחנה מתועדת ומצורפת למרשם	אבחנת ADHD (או נרקולפסיה) ברשימת האבחנות, ומצורפת למרשם ("ADD במעקב שלי"). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	מרשם ראשון ע"י המומחה המתאים	אטנט, אדרל או ויואנס: המרשם הראשון ניתן ע"י נוירולוג/ית או פסיכיאטר/ית. מעבר מריטלין לאטנט — רק בהמלצת מומחה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	עברו כ-3 חודשים מהמרשם הקודם	תרופה עם פוטנציאל התמכרות: בקשה לפני שעברו כ-3 חודשים, או רכישות מעבר לכמות שנרשמה ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	ילדים: משקל, גובה, דופק ול"ד כל 6 חודשים
תלונות בפנייה או ברשומה	ירידה בתיאבון ובמשקל ← לרופא; דפיקות לב, כאב בחזה או עילפון ← דחוף; מחשבות אובדניות או שינוי חד במצב הרוח ← דחוף
מקור	החלטה מקומית (3.11.2026); NICE NG87 (מעקב בילדים)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.31 ליסדקסאמפטמין (ילדים ובני נוער) · Lisdexamfetamine (children) בתנאים

ADHD · ממריץ (סם מסוכן)

שמות מסחריים (5)	ויואנס · Vyvanse · ליסדקס טבע · Lisdex Teva · ליסדקסא אס.קיי. · Lisdexa S.K. · ליסין · Lissin · תרומין · Taromine
נימוק / הערה	סם מסוכן: מחודש ע"י רפואן רק כשרשום בתרופות הקבועות, עם אבחנה מצורפת למרשם. אפשר ל-3 חודשים (מרשמים עתידיים). בילדים גם משקל, גובה, דופק ול"ד כל 6 חודשים.

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	רשומה בתרופות הקבועות	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהתרופה רשומה בתרופות הקבועות ונרשמה בעבר ע"י רופא/ה. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
2	אבחנה מתועדת ומצורפת למרשם	אבחנת ADHD (או נרקולפסיה) ברשימת האבחנות, ומצורפת למרשם ("ADD במעקב שלי"). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	מרשם ראשון ע"י המומחה המתאים	אטנט, אדרל או ויואנס: המרשם הראשון ניתן ע"י נוירולוג/ית או פסיכיאטר/ית. מעבר מריטלין לאטנט — רק בהמלצת מומחה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	משקל וגובה מתועדים	משקל וגובה מ-6 החודשים האחרונים (עקומת גדילה). אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
5	דופק ול"ד מתועדים	דופק ול"ד מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
6	אין ירידה במשקל או האטה בגדילה	המשקל לא ירד והגדילה לא הואטה לעומת המדידה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
7	עברו כ-3 חודשים מהמרשם הקודם	תרופה עם פוטנציאל התמכרות: בקשה לפני שעברו כ-3 חודשים, או רכישות מעבר לכמות שנרשמה ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
9	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
10	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
11	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
12	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
13	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	ילדים: משקל, גובה, דופק ול"ד כל 6 חודשים
תלונות בפנייה או ברשומה	ירידה בתיאבון ובמשקל ← לרופא; דפיקות לב, כאב בחזה או עילפון ← דחוף; מחשבות אובדניות או שינוי חד במצב הרוח ← דחוף
מקור	החלטה מקומית (3.11.2026); NICE NG87 (מעקב בילדים)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.32 בנזודיאזפינים ותרופות שינה · Benzodiazepines / Z-drugs

הכנה לאישור רופא/ה

מרגיעים ותרופות שינה

שמות מסחריים (24)	קלונקס · Clonex · קלומד · Clomed · לוריוון · Lorivan · אסיול · Assival · קסנאגיס · Xanagis · אלפרליד · Alpralid · קסנאקס XR · Xanax XR · בונדורמין · Bondormin · סטילנוקס · Stilnox · אמביאן Ambien · CR · זודורם · Zodorm · ריווטריל · Rivotril · קלונזפאם אמ.בי.איי · Clonazepam MBI · אימובן · Imovane · נוקטורנו · Nocturno · נוקטורנו פורטה · Nocturno Forte · זופיקלון גרינדקס · Zopiclone Grindeks · אסיול חדש · Assival New · אסיול טבע · Assival Teva · דיאזפם גרינדקס · Diazepam Grindeks · לורזפאם מדו · Lorazepam Medo · ואבן · Vaben · ברוטיזולאם טבע · Brotizolam Teva · פריזיום · Frisium (קלובזם)
נימוק / הערה	ההחלטה בידי הרופא/ה. הרפואן אוסף את הנתונים, מסמן אותם ומעביר סיכום.

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	משך הנטילה ורציפות תועדו	כמה זמן נוטל/ת ואם ברצף — לפי הרכישות והרשומה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	השימוש לא נעשה תכוף יותר	לפי הרכישות: אין עלייה בתדירות לאחרונה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	תיעוד שיחה על שינה או חרדה	ברשומה יש שיחה על הרגלי שינה, ניסיון טיפול אחר או הפניה למעבדת שינה (ומתי). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	עברו כ-3 חודשים מהמרשם הקודם	תרופה עם פוטנציאל התמכרות: בקשה לפני שעברו כ-3 חודשים, או רכישות מעבר לכמות שנרשמה ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	

תלונות בפנייה או ברשומה	נפילות או בלבול (בגיל מבוגר) ← לרופא; בקשה מוקדמת או אובדן מרשם ← לרופא
מקור	ספר חפיפה עוזרי רופא; החלטה מקומית (3.11.2026)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.33 **מלחי אמפטמין (מבוגרים)** · Amphetamine salts (adults) בתנאים

ADHD · ממריץ (סם מסוכן)

שמות מסחריים (2)	אטנט · Attent | אטנט XR · Attent XR
נימוק / הערה	סם מסוכן: מחודש ע"י רפואן רק כשרשום בתרופות הקבועות, עם אבחנה מצורפת למרשם. אפשר ל-3 חודשים (מרשמים עתידיים).

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**רשומה בתרופות הקבועות**	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהתרופה רשומה בתרופות הקבועות ונרשמה בעבר ע"י רופא/ה. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
2	**אבחנה מתועדת ומצורפת למרשם**	אבחנת ADHD (או נרקולפסיה) ברשימת האבחנות, ומצורפת למרשם ("ADD במעקב שלי"). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	**מרשם ראשון ע"י המומחה המתאים**	אטנט, אדרל או ויואנס: המרשם הראשון ניתן ע"י נוירולוג/ית או פסיכיאטר/ית. מעבר מריטלין לאטנט — רק בהמלצת מומחה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	**עברו כ-3 חודשים מהמרשם הקודם**	תרופה עם פוטנציאל התמכרות: בקשה לפני שעברו כ-3 חודשים, או רכישות מעבר לכמות שנרשמה ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
5	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	ילדים: משקל, גובה, דופק ול"ד כל 6 חודשים
תלונות בפנייה או ברשומה	ירידה בתיאבון ובמשקל ← לרופא; דפיקות לב, כאב בחזה או עילפון ← דחוף; מחשבות אובדניות או שינוי חד במצב הרוח ← דחוף
מקור	החלטה מקומית (3.11.2026); NICE NG87 (מעקב בילדים)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.34 מלחי אמפטמין (ילדים ובני נוער) · Amphetamine salts (children) בתנאים

ADHD · ממריץ (סם מסוכן)

שמות מסחריים (2)	אטנט · Attent | אטנט XR · Attent XR
נימוק / הערה	סם מסוכן: מחודש ע"י רפואן רק כשרשום בתרופות הקבועות, עם אבחנה מצורפת למרשם. אפשר ל-3 חודשים (מרשמים עתידיים). בילדים גם משקל, גובה, דופק ול"ד כל 6 חודשים.

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	רשומה בתרופות הקבועות	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהתרופה רשומה בתרופות הקבועות ונרשמה בעבר ע"י רופא/ה. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
2	אבחנה מתועדת ומצורפת למרשם	אבחנת ADHD (או נרקולפסיה) ברשימת האבחנות, ומצורפת למרשם ("ADD במעקב שלי"). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	מרשם ראשון ע"י המומחה המתאים	אטנט, אדרל או ויואנס: המרשם הראשון ניתן ע"י נוירולוג/ית או פסיכיאטר/ית. מעבר מריטלין לאטנט — רק בהמלצת מומחה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	משקל וגובה מתועדים	משקל וגובה מ-6 החודשים האחרונים (עקומת גדילה). אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
5	דופק ול"ד מתועדים	דופק ול"ד מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
6	אין ירידה במשקל או האטה בגדילה	המשקל לא ירד והגדילה לא הואטה לעומת המדידה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
7	עברו כ-3 חודשים מהמרשם הקודם	תרופה עם פוטנציאל התמכרות: בקשה לפני שעברו כ-3 חודשים, או רכישות מעבר לכמות שנרשמה ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
9	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
10	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
11	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
12	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
13	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	ילדים: משקל, גובה, דופק ול"ד כל 6 חודשים
תלונות בפנייה או ברשומה	ירידה בתיאבון ובמשקל ← לרופא; דפיקות לב, כאב בחזה או עילפון ← דחוף; מחשבות אובדניות או שינוי חד במצב הרוח ← דחוף
מקור	החלטה מקומית (3.11.2026); NICE NG87 (מעקב בילדים)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.35 מודפיניל / ארמודפיניל · Modafinil / armodafinil רופא/ה בלבד

תרופות ערנות

שמות מסחריים (3)	פרוויג'יל · Provigil | מודפיניל מדוכמי · Modafinil Medochemie | נוביג'יל · Nuvigil (ארמודפיניל)
נימוק / הערה	מודפיניל וארמודפיניל לערנות (נרקולפסיה) במרשם מיוחד. חידוש ע"י רופא/ה בלבד.
הנחיה	**מודפיניל וארמודפיניל לערנות (נרקולפסיה) במרשם מיוחד. חידוש ע"י רופא/ה בלבד.**

מקור	-

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.36 **ליתיום** · Lithium carbonate בתנאים מעקב מעבדה צמוד

מייצב מצב רוח

שמות מסחריים (2)	ליקרביום · Licarbium | פריאדל · Priadel (לאימות מול מאגר משרד הבריאות)
נימוק / הערה	נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. לא נעצר ע"י רפואן, מלבד רמה רעילה. הרפואן לא משנה מינון

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	רמת ליתיום מתועדת	בדיקה מ-6 החודשים האחרונים, 12 שעות אחרי המנה. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	רמת התרופה בדם בטווח	בבדיקה האחרונה רמת התרופה בדם בטווח. חריג: רמה מחוץ לטווח 0.6-1.0 mmol/L ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: רמה 1.5 mmol/L ומעלה ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: רמה 1.5 mmol/L ומעלה ← לא מחדשים	
3	נתרן (Na) תקין	בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
4	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <60 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
5	בדיקות כל 6 חודשים	מ-6 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, נתרן, TSH, סידן. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
6	אין תרופה חדשה שמעלה רמה	ברשימת התרופות אין NSAIDs, מעכב ACE, ARB או משתן שנוסף מאז הבדיקה האחרונה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
7	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
8	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
9	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
10	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
11	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
12	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
13	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
14	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	רמת ליתיום כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, נתרן, TSH וסידן כל 6 חודשים
ספי החזרה לרופא/ה	רמה מחוץ לטווח 0.6-1.0 mmol/L; Na מחוץ לטווח המעבדה; eGFR <60
ערך חמור	רמה 1.5 mmol/L ומעלה
תלונות בפנייה או ברשומה	רעד חדש או מוגבר, בחילות, שלשולים, בלבול או חוסר יציבות (חשד לרעילות) ← דחוף - לרופא עכשיו; שתייה ומתן שתן מרובים ← לרופא; הקאות או שלשול עם התייבשות ← דחוף - בדיקת רמה
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.37 קלוזפין · Clozapine בתנאים מעקב מעבדה צמוד

נוגד פסיכוזה (מעקב ספירת דם חובה)

שמות מסחריים (2)	לפונקס · Leponex | לוזפין · Lozapine
נימוק / הערה	נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. ניפוק חודשי בלבד, רק עם ספירת דם תקינה מהחודש האחרון. חידוש מלא = חודש אחד

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	ספירת דם מהחודש האחרון	WBC ונויטרופילים מ-4 השבועות האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה	בבדיקה האחרונה ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה. חריג: WBC 3,000-3,500 או נויטרופילים 1,500-2,000 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: WBC מתחת ל-3,000 או נויטרופילים מתחת ל-1,500 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: WBC מתחת ל-3,000 או נויטרופילים מתחת ל-1,500 ← לא מחדשים	
3	שלב חודשי (מעל 18 שבועות טיפול)	הטיפול נמשך יותר מ-18 שבועות (בשלב הראשון: ניפוק שבועי ע"י הצוות המטפל). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	אין חום או זיהום מתועד	ברשומה או בפנייה אין חום, כאב גרון או זיהום. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	ספירת דם (WBC, נויטרופילים) כל שבוע ב-18 השבועות הראשונים, ואחר כך לפחות פעם בחודש
ספי החזרה לרופא/ה	WBC 3,000-3,500 או נויטרופילים 1,500-2,000
ערך חמור	WBC מתחת ל-3,000 או נויטרופילים מתחת ל-1,500
תלונות בפנייה או ברשומה	חום, כאב גרון או זיהום ← דחוף - ספירת דם היום; כאב בחזה, קוצר נשימה או דופק מהיר (חשד לדלקת שריר הלב) ← דחוף; עצירות קשה או כאבי בטן ← לרופא, דחוף; פרכוס ← דחוף
מקור	עלון לצרכן לפונקס (עודכן 12/2020)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.38 אולנזפין · Olanzapine בתנאים מעקב מעבדה צמוד

נוגד פסיכוזה

שמות מסחריים (4)	זיפרקסה · Zyprexa | זיפרקסה ולוטב · Zyprexa Velotab | זאפה · Zappa | אולנזפין טבע · Olanzapine Teva
נימוק / הערה	נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מעקב מטבולי מתועד	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	ללא החמרה מטבולית	אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי
תלונות בפנייה או ברשומה	נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; ישנוניות קשה ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.39 קווטיאפין · Quetiapine בתנאים מעקב מעבדה צמוד

נוגד פסיכוזה

שמות מסחריים (5)	סרוקואל · Seroquel | סרוקואל XR · Seroquel XR | קווטיאפין טבע · Quetiapine Teva | קווטיאפין סנדוז · Quetiapine Sandoz | קווטיאפין אינובמד SR · Quetiapine Inovamed SR
נימוק / הערה	נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מעקב מטבולי מתועד	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	ללא החמרה מטבולית	אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי
תלונות בפנייה או ברשומה	נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; ישנוניות קשה ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.40 ריספרידון · Risperidone בתנאים מעקב מעבדה צמוד

נוגד פסיכוזה

שמות מסחריים (3)	ריספרדל · Risperdal | ריספרידקס · Risperidex | ריספונד · Rispond
נימוק / הערה	נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מעקב מטבולי מתועד	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	ללא החמרה מטבולית	אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי
תלונות בפנייה או ברשומה	נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; ישנוניות קשה ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.41 אריפיפרזול · Aripiprazole

בתנאים | מעקב מעבדה צמוד

נוגד פסיכוזה

שמות מסחריים (3)	אריפיפרזול מדו · Aripiprazole Medo | אריפיפרזול סנדוז · Aripiprazole Sandoz | אריפלי · Ariply
נימוק / הערה	נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מעקב מטבולי מתועד	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	ללא החמרה מטבולית	אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי
תלונות בפנייה או ברשומה	נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; ישנוניות קשה ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.42 הלופרידול · Haloperidol בתנאים מעקב מעבדה צמוד

נוגד פסיכוזה

שמות מסחריים (3)	הלדול · Haldol | הלופר · Haloper | הלדול דקאנואס · Haldol Decanoas (זריקת מאגר)
נימוק / הערה	נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי. מאריך QT; תופעות חוץ-פירמידליות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מעקב מטבולי מתועד	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	ללא החמרה מטבולית	אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	אק"ג מתועד שאלה: המטופל/ת בגיל 50 ומעלה או עם מחלת לב?	אק"ג מ-12 החודשים האחרונים ללא QTc מוארך. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
4	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי; אק"ג בגיל 50+ או במחלת לב
תלונות בפנייה או ברשומה	נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.43 פליפרידון · Paliperidone בתנאים מעקב מעבדה צמוד

נוגד פסיכוזה

שמות מסחריים (4)	אינווגה · Invega | פליפרידון טבע · Paliperidone Teva | קספליון · Xeplion (זריקת מאגר) | טרוויקטה · Trevicta (זריקת מאגר)
נימוק / הערה	נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי. מינון לפי כליות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מעקב מטבולי מתועד	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	ללא החמרה מטבולית	אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי; קריאטינין שנתי
תלונות בפנייה או ברשומה	נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.44 קריפרזין · Cariprazine בתנאים מעקב מעבדה צמוד

נוגד פסיכוזה

שמות מסחריים (1)	ריאגילה · Reagila
נימוק / הערה	נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מעקב מטבולי מתועד	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	ללא החמרה מטבולית	אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי
תלונות בפנייה או ברשומה	נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.45 זיפרזידון · Ziprasidone בתנאים מעקב מעבדה צמוד

נוגד פסיכוזה

שמות מסחריים (1)	גאודון · Geodon
נימוק / הערה	נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי. מאריך QT

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מעקב מטבולי מתועד	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	ללא החמרה מטבולית	אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	אק"ג מתועד שאלה: המטופל/ת בגיל 50 ומעלה או עם מחלת לב?	אק"ג מ-12 החודשים האחרונים ללא QTc מוארך. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
4	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי; אק"ג
תלונות בפנייה או ברשומה	נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.46 פרפנזין · Perphenazine בתנאים מעקב מעבדה צמוד

נוגד פסיכוזה

שמות מסחריים (1)	פרפנאן · Perphenan
נימוק / הערה	נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי. תופעות חוץ-פירמידליות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מעקב מטבולי מתועד	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	ללא החמרה מטבולית	אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי
תלונות בפנייה או ברשומה	נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.47 אמיסולפריד · Amisulpride

בתנאים | מעקב מעבדה צמוד

נוגד פסיכוזה

שמות מסחריים (2)	פרייד · Pride | אמיסולפריד מדו · Amisulpride Medo
נימוק / הערה	נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי. מינון לפי כליות; פרולקטין; QT

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מעקב מטבולי מתועד	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	ללא החמרה מטבולית	אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	אק"ג מתועד שאלה: המטופל/ת בגיל 50 ומעלה או עם מחלת לב?	אק"ג מ-12 החודשים האחרונים ללא QTc מוארך. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
4	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי; קריאטינין שנתי
תלונות בפנייה או ברשומה	נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.48 סולפיריד · Sulpiride בתנאים מעקב מעבדה צמוד

נוגד פסיכוזה

שמות מסחריים (2)	מודאל · Modal | מודאל פורטה · Modal Forte
נימוק / הערה	נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי. פרולקטין

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מעקב מטבולי מתועד	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	ללא החמרה מטבולית	אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי
תלונות בפנייה או ברשומה	נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.49 פלופנזין · Fluphenazine בתנאים מעקב מעבדה צמוד

נוגד פסיכוזה

שמות מסחריים (1)	פלודקאט · Fludecate (זריקת מאגר)
נימוק / הערה	נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי. תופעות חוץ-פירמידליות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מעקב מטבולי מתועד	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	ללא החמרה מטבולית	אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי
תלונות בפנייה או ברשומה	נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.50 זוקלופנתיקסול · Zuclopenthixol

בתנאים | מעקב מעבדה צמוד

נוגד פסיכוזה

שמות מסחריים (2)	קלופיקסול · Clopixol | קלופיקסול דפו · Clopixol Depot (זריקת מאגר)
נימוק / הערה	נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי. תופעות חוץ-פירמידליות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מעקב מטבולי מתועד	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	ללא החמרה מטבולית	אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי
תלונות בפנייה או ברשומה	נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.51 קלוטיאפין · Clotiapine בתנאים מעקב מעבדה צמוד

נוגד פסיכוזה

שמות מסחריים (1)	אנטומין · Entumin
נימוק / הערה	נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי. ישנוניות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מעקב מטבולי מתועד	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	ללא החמרה מטבולית	אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי
תלונות בפנייה או ברשומה	נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.52 לבומפרומזין · Levomepromazine בתנאים מעקב מעבדה צמוד

נוגד פסיכוזה

שמות מסחריים (1)	רונקסין · Ronexine
נימוק / הערה	נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי. ישנוניות ויל"ד אורתוסטטי

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מעקב מטבולי מתועד	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	ללא החמרה מטבולית	אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	אין נפילות או הזיות מתועדות	ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי
תלונות בפנייה או ברשומה	נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.53 ברקספיפרזול · Brexpiprazole בתנאים מעקב מעבדה צמוד

נוגד פסיכוזה

שמות מסחריים (1)	ריקסלטי · Rexulti
נימוק / הערה	נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מעקב מטבולי מתועד	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	ללא החמרה מטבולית	אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי
תלונות בפנייה או ברשומה	נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.54 אסנפין · Asenapine

בתנאים | מעקב מעבדה צמוד

נוגד פסיכוזה

שמות מסחריים (1)	סאפריס · Saphris (תת-לשוני)
נימוק / הערה	נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מעקב מטבולי מתועד	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	ללא החמרה מטבולית	אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי
תלונות בפנייה או ברשומה	נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.55 אילופרידון · Iloperidone בתנאים מעקב מעבדה צמוד

נוגד פסיכוזה

שמות מסחריים (1)	פנאפט · Fanapt
נימוק / הערה	נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי. מאריך QT

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מעקב מטבולי מתועד	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	ללא החמרה מטבולית	אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	אק"ג מתועד שאלה: המטופל/ת בגיל 50 ומעלה או עם מחלת לב?	אק"ג מ-12 החודשים האחרונים ללא QTc מוארך. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
4	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי; אק"ג
תלונות בפנייה או ברשומה	נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.56 סרטינדול · Sertindole בתנאים מעקב מעבדה צמוד

נוגד פסיכוזה

שמות מסחריים (1)	סרדולקט · Serdolect
נימוק / הערה	נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי. מאריך QT: אק"ג חובה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מעקב מטבולי מתועד	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	ללא החמרה מטבולית	אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	אק"ג מ-3 החודשים האחרונים	אק"ג מ-3 החודשים האחרונים עם QTc מתחת ל-450 (גברים) או 470 (נשים). אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
4	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי; אק"ג כל 3 חודשים
תלונות בפנייה או ברשומה	נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

5.57 תיורידזין · Thioridazine בתנאים מעקב מעבדה צמוד

נוגד פסיכוזה

שמות מסחריים (1)	רידזין · Ridazin
נימוק / הערה	נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי. מאריך QT מאוד

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מעקב מטבולי מתועד	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	ללא החמרה מטבולית	אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	אק"ג מתועד שאלה: המטופל/ת בגיל 50 ומעלה או עם מחלת לב?	אק"ג מ-12 החודשים האחרונים ללא QTc מוארך. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
4	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי; אק"ג
תלונות בפנייה או ברשומה	נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

6. עיכול וכבד

20 תרופות · מתאים: 12 · בתנאים: 4 · רופא/ה בלבד: 4 · גרסה 2 · חלוקה לפי מערכות · 2.11.2026

מקורות: הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020; ACOG 2023 (סיכום AFP). שאר התחומים: החלטה מקומית

6.א כללים

- חידוש רגיל: 3 חודשים
- ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה פעם בשנה
- עד 3 חידושים רצופים, ואז ביקור רופא
- אין התווית נגד ← תמיד מחדשים לפחות לחודש אחד
- חסרה מדידה, בדיקה או ביקורת שנתית: חידוש לחודש אחד + זימון למרפאה
- חריגה מספי ההחזרה: חידוש לחודש אחד + הודעה לרופא/ה
- התווית נגד או ערך חמור: לא מחדשים, הודעה לרופא/ה (הסף של כל תרופה מופיע ברשימה שלה)
- רפואן לא משנה מינון ולא מחליף תרופה. "מעקב מעבדה צמוד" = תרופה עם בדיקות תכופות — לבדוק בקפידה
- מעכבי משאבת פרוטונים: נדרשת התוויה מתועדת לטיפול ממושך
- דם בצואה, ירידה במשקל או שינוי חדש ביציאות ← הודעה לרופא/ה

6.ג בדיקות משותפות

שלב	נושא	מה בודקים	קריטריון	אם לא מתקיים	מקור
לפני כל חידוש	בדיקת מעקב	לפי התרופה	שומנים: LDL; לבותירוקסין: TSH; אלופורינול/פבוקסוסטט: חומצה אורית — מ-12 החודשים האחרונים	אין ← חידוש לחודש + זימון לבדיקה	הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52; החלטה כללי-1
לפני כל חידוש	ערך המעקב	לעומת הבדיקה הקודמת או היעד	LDL לא עלה ב-30% ומעלה; TSH בטווח המעבדה; חומצה אורית מתחת ל-6	לא ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה	החלטות כללי-2-4
לפני כל חידוש	רכישות	כיסוי ימים ב-6 החודשים האחרונים	80% מהימים ומעלה	פחות ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה	כמו ביל"ד
לפני כל חידוש	ביקורת שנתית	ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה	ב-12 החודשים האחרונים	אין ← חידוש לחודש + זימון לביקורת	כמו ביל"ד
לפני כל חידוש	רצף חידושים	כמה חידושים רצופים מאז ביקור רופא	פחות מ-3	3 ← ביקור רופא	כמו ביל"ד

6.ד החלטות

#	נושא	מה ההנחיה אומרת	ההחלטה לפרוטוקול	סוג	מקור
כללי-1	בדיקות מעקב	שומנים: פרופיל כל 6-12 חודשים אחרי השגת היעד. TSH וחומצה אורית: לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	LDL, TSH וחומצה אורית מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש + זימון	החלטה מקומית (הצעה)	הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52
כללי-7	אלופורינול ופבוקסוסטט	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	חומצה אורית ≥6 ← הודעה. אלופורינול: eGFR <30 ← הודעה (מינון). פריחה ← התווית נגד, דחוף	החלטה מקומית (הצעה)	-
כללי-12	תרופות כרוניות נוספות (2)	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	בזאפיברט, גבפנטין, פרגבלין, SSRI/SNRI (נתרן בגיל 65+), מעכבי ארומטאז, טמוקסיפן, רלוקסיפן, טרבינפין ואיטרקונזול (קורס): לפי הרשימה של כל תרופה	החלטה מקומית (הצעה)	-
כללי-16	ברזל, B12, חומצה פולית	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	ברזל: ספירת דם ופריטין מ-6 חודשים; טיפול מעל 6 חודשים בלי התוויה ← הודעה. B12: רמה שנתית	החלטה מקומית (הצעה)	-

#	נושא	מה ההנחיה אומרת	ההחלטה לפרוטוקול	סוג	מקור
כללי-18	גסטרו ואנדוקרינולוגיה	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	מסאלזין: קריאטינין שנתי. הידרוקורטיזון: לא נעצר, הנחיות מחלה. אלפקלצידול וסינקלצט: סידן. דסמופרסין: נתרן	החלטה מקומית (הצעה)	-
כללי-19	תרופות מומחה	-	אריתרופויאטין, קושרי זרחן ואשלגן, HIV, הפטיטיס B, ציקלוספורין/טקרולימוס, אפרמילסט ואציטרטין: הודעה בלבד, חידוש ע"י רופא/ה	החלטה מקומית	-
כללי-20	השלמות מהמאגר (2.11.2026)	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	טרזוסין, פינסטריד, אינקליסירן, ורדנאפיל, טיפות לגלאוקומה (ביקורת עיניים שנתית; טימולול: דופק ואסתמה), NSAID ממושך (כליות, אשלגן, ל"ד, דימום, הגנת קיבה), אנטיהיסטמינים, ציננריזין, דומפרידון, מבברין, סידן, מידודרין, פנטוקסיפילין, דיפירידמול, ולציקלוביר מונע, חומצה זולדרונית	החלטה מקומית (הצעה)	-
כללי-21	תרופות מומחה נוספות	-	מטוקלופרמיד ממושך, ממריצים/מודפיניל, ביולוגיות, טרשת נפוצה, אונקולוגיה, יל"ד ריאתי/IPF, סירולימוס, הורמון גדילה, המטולוגיה, CF, טפמידיס/מבקמטן: הודעה בלבד, חידוש ע"י רופא/ה	החלטה מקומית	-
כללי-22	השלמות 2 מהמאגר (2.11.2026)	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	ויטמין D, בטאהיסטין, חומצה במפדואית, אומגה 3/איקוזפנט, ציפרופיברט, וריסיגואט, ניטרוגליצירין תת-לשוני, פוזולינטנט/אלינזנטנט (ALT), דואביב, אינטראוסה, סיאנה, אורליסטט, פרוקלופריד, משלשלים, טטרציקלינים ממושכים, מניעת זיהומי שתן, משככי כאב ממושכים, ביקרבונט. רופא/ה בלבד: פנטרמין, בונות עצם, הפרינים, תרופות עצם בכליות, אנלוגי סומטוסטטין, הפטיטיס C/D, מחלות נדירות	החלטה מקומית (הצעה)	-

6.ה רשימת התרופות (לסימון)

#	שם	גנרי	קבוצה	התאמה	אושר	הערות
6.1	אומפרזול	Omeprazole	קיבה · מעכב משאבת פרוטונים	מתאים	☐	
6.2	אזומפרזול	Esomeprazole	קיבה · מעכב משאבת פרוטונים	מתאים	☐	
6.3	לנסופרזול	Lansoprazole	קיבה · מעכב משאבת פרוטונים	מתאים	☐	
6.4	פנטופרזול	Pantoprazole	קיבה · מעכב משאבת פרוטונים	מתאים	☐	
6.5	דקסלנסופרזול	Dexlansoprazole	קיבה · מעכב משאבת פרוטונים	מתאים	☐	
6.6	מסאלזין (בבליעה)	Mesalazine (oral)	IBD · 5-ASA	בתנאים	☐	
6.7	בודזוניד (בבליעה)	Budesonide (oral)	סטרואיד בפעילות מקומית	בתנאים	☐	
6.8	חומצה אורסודאוקסיכולית	Ursodeoxycholic acid	מחלות כבד כולסטטיות / אבני מרה	מתאים	☐	
6.9	לקטולוז	Lactulose	משלשל / אנצפלופתיה כבדית	מתאים	☐	
6.10	פמוטידין	Famotidine	חוסם H2	מתאים	☐	
6.11	פנקראטין	Pancreatin	אנזימי לבלב	מתאים	☐	
6.12	ריפקסימין	Rifaximin	אנטיביוטיקה במעי	בתנאים	☐	
6.13	תרופות נגד הפטיטיס B	Hepatitis B antivirals	אנטי-ויראלי	רופא/ה בלבד	☐	
6.14	דומפרידון	Domperidone	פרוקינטי	בתנאים	☐	
6.15	מטוקלופרמיד	Metoclopramide	פרוקינטי	רופא/ה בלבד	☐	
6.16	מבברין	Mebeverine	נוגד עוויתות (IBS)	מתאים	☐	

#	שם	גנרי	קבוצה	התאמה	אושר	הערות
6.17	פרוקלופריד	Prucalopride	עצירות כרונית	מתאים	☐	
6.18	משלשלים	Laxatives	עצירות	מתאים	☐	
6.19	תרופות נגד הפטיטיס C ו-D	Hepatitis C / D antivirals	אנטי-ויראלי	רופא/ה בלבד	☐	
6.20	תרופות מומחה נוספות	Other specialist drugs	מומחה	רופא/ה בלבד	☐	

1.6 פירוט מלא

6.1 **אומפרזול** · Omeprazole מתאים

קיבה · מעכב משאבת פרוטונים

שמות מסחריים (3)	לוסק · Losec | אומפרדקס · Omepradex | אומפרה · Omepra
נימוק / הערה	התוויה מתועדת לטיפול ממושך

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**התוויה מתועדת לטיפול ממושך**	ברשומה מתועדת התוויה לטיפול ממושך (רפלוקס קשה, ושט בארט, היצרות, או הגנה עם NSAID/נוגדי טסיות/סטרואידים). אין ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה לשקול הפחתה או הפסקה.	
2	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
5	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
6	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
7	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	שלשולים מתמשכים ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

6.2 **אזומפרזול** · Esomeprazole מתאים

קיבה · מעכב משאבת פרוטונים

שמות מסחריים (3)	נקסיום · Nexium | אסופרים · Esoprim | אסומפראזול אינובמד · Esomeprazole Inovamed
נימוק / הערה	התוויה מתועדת לטיפול ממושך

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**התוויה מתועדת לטיפול ממושך**	ברשומה מתועדת התוויה לטיפול ממושך (רפלוקס קשה, ושט בארט, היצרות, או הגנה עם NSAID/נוגדי טסיות/סטרואידים). אין ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה לשקול הפחתה או הפסקה.	
2	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
5	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
6	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
7	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	שלשולים מתמשכים ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

6.3 **לנסופרזול** · Lansoprazole מתאים

קיבה · מעכב משאבת פרוטונים

שמות מסחריים (2)	לנטון · Lanton | לנסו טבע · Lanso Teva
נימוק / הערה	התוויה מתועדת לטיפול ממושך

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**התוויה מתועדת לטיפול ממושך**	ברשומה מתועדת התוויה לטיפול ממושך (רפלוקס קשה, ושט בארט, היצרות, או הגנה עם NSAID/נוגדי טסיות/סטרואידים). אין ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה לשקול הפחתה או הפסקה.	
2	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
5	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
6	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
7	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	שלשולים מתמשכים ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

6.4 **פנטופרזול** · Pantoprazole מתאים

קיבה · מעכב משאבת פרוטונים

שמות מסחריים (2)	קונטרולוק · Controloc | פנטופרזול קלצקס · Pantoprazole Kalceks
נימוק / הערה	התוויה מתועדת לטיפול ממושך

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**התוויה מתועדת לטיפול ממושך**	ברשומה מתועדת התוויה לטיפול ממושך (רפלוקס קשה, ושט בארט, היצרות, או הגנה עם NSAID/נוגדי טסיות/סטרואידים). אין ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה לשקול הפחתה או הפסקה.	
2	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
5	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
6	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
7	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	שלשולים מתמשכים ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

6.5 דקסלנסופרזול · Dexlansoprazole מתאים

קיבה · מעכב משאבת פרוטונים

שמות מסחריים (1)	דקסילנט · Dexilant
נימוק / הערה	התוויה מתועדת לטיפול ממושך

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	התוויה מתועדת לטיפול ממושך	ברשומה מתועדת התוויה לטיפול ממושך (רפלוקס קשה, ושט בארט, היצרות, או הגנה עם NSAID/נוגדי טסיות/סטרואידים). אין ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה לשקול הפחתה או הפסקה.	
2	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
5	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
6	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
7	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	שלשולים מתמשכים ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

6.6 מסאלזין (בבליעה) · Mesalazine (oral) בתנאים

IBD · 5-ASA

שמות מסחריים (4)	אסאקול · Asacol	מזוונט · Mezavant	פנטסה · Pentasa	רפאסאל · Rafassal
נימוק / הערה	נפריטיס נדירה: קריאטינין שנתי

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	קריאטינין מתועד	קריאטינין/eGFR מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה ב-30% ומעלה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י גסטרואנטרולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
6	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	קריאטינין שנתי; ספירת דם שנתית
ספי החזרה לרופא/ה	קריאטינין עלה ב-30% ומעלה
ערך חמור	eGFR <30
תלונות בפנייה או ברשומה	דם בצואה או שלשולים מחמירים ← לרופא; חום וכאב בטן ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

6.7 **בודזוניד (בבליעה)** · Budesonide (oral) בתנאים

סטרואיד בפעילות מקומית

שמות מסחריים (3)	בודסון · Budeson | קורטימנט · Cortiment | ג'ורבזה · Jorveza (EoE)
נימוק / הערה	קורס לפי הגסטרואנטרולוג/ית; טיפול ממושך ← עצם וסוכר

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**בתוך משך הטיפול שנקבע**	בתוך משך הטיפול שנקבע ע"י הגסטרואנטרולוג/ית. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	**טיפול כרוני במינון קבוע**	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י גסטרואנטרולוג/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
5	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	חום או זיהום ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

6.8 חומצה אורסודאוקסיכולית · Ursodeoxycholic acid מתאים

מחלות כבד כולסטטיות / אבני מרה

שמות מסחריים (2)	אורסופאלק · Ursofalk | אורסוליט · Ursolit
נימוק / הערה	תפקודי כבד

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	תפקודי כבד מתועדים	ALT ופוספטזה בסיסית מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	תפקודי כבד (ALT) תקין	בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 2 מהגבול העליון או עלייה לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	תפקודי כבד שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	ALT מעל פי 2 מהגבול העליון או עלייה לעומת הקודם
תלונות בפנייה או ברשומה	צהבת או גרד ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

6.9 **לקטולוז** · Lactulose מתאים

משלשל / אנצפלופתיה כבדית

שמות מסחריים (3)	לקטורז · Lacturaz | לבולק · Laevolac | אבילק · Avilac
נימוק / הערה	באנצפלופתיה כבדית לא מפסיקים

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
3	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
4	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
5	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
6	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
תלונות בפנייה או ברשומה	בלבול או ישנוניות (מחלת כבד) ← דחוף; שלשולים מרובים ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

6.10 **פמוטידין** · Famotidine מתאים

חוסם H2

שמות מסחריים (3)	פאמו · Famo | גאסטרו · Gastro | פמוטידין טבע · Famotidine Teva
נימוק / הערה	מינון לפי כליות; התוויה לטיפול ממושך

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**התוויה מתועדת לטיפול ממושך**	התוויה מתועדת לטיפול ממושך. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
5	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
6	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
7	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	צואה שחורה או הקאה דמית ← דחוף; קושי בבליעה או ירידה במשקל ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

6.11 **פנקראטין** · Pancreatin מתאים

אנזימי לבלב

שמות מסחריים (1)	קראון · Creon
נימוק / הערה	אי-ספיקת לבלב מתועדת

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**אי-ספיקת לבלב מתועדת**	אבחנה מתועדת של אי-ספיקת לבלב או CF. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
5	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
6	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
7	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

6.12 ריפקסימין · Rifaximin בתנאים

אנטיביוטיקה במעי

שמות מסחריים (1)	לורמיקס · Lormyx (לאימות מול מאגר משרד הבריאות)
נימוק / הערה	למניעת אנצפלופתיה כבדית - ע"י הכבד; IBS - קורס

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	התוויה מתועדת	מניעת אנצפלופתיה כבדית שנקבעה ע"י היחידה, או קורס שנקבע ע"י רופא/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ה מומחה/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
תלונות בפנייה או ברשומה	בלבול (מחלת כבד) ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

6.13 תרופות נגד הפטיטיס B · Hepatitis B antivirals רופא/ה בלבד

אנטי-ויראלי

שמות מסחריים (10)	וירואד · Viread | טנופוביר טבע · Tenofovir Teva | ומלידי · Vemlidy | אנטקאביר טבע · Entecavir Teva | אנטאבניר · Enteavenir | אנטקאביר סנדוז · Entecavir Sandoz | אנטקאביר אס.קיי. · Entecavir S.K. | אנטקאביר אינובמד · Entecavir Inovamed | אנטקאביר-תרימה · Entecavir-Trima | זפיקס · Zeffix
נימוק / הערה	טיפול בהפטיטיס B נקבע ומנוטר ע"י מרפאת הכבד. אסור להפסיק (התלקחות). להעביר לרופא/ה.
הנחיה	**טיפול בהפטיטיס B נקבע ומנוטר ע"י מרפאת הכבד. אסור להפסיק (התלקחות). להעביר לרופא/ה.**

מקור	-

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

6.14 דומפרידון · Domperidone בתנאים

פרוקינטי

שמות מסחריים (1)	מוטיליום · Motilium
נימוק / הערה	מאריך QT. מומלץ לטווח קצר בלבד; טיפול ממושך רק בהחלטת רופא/ה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	התוויה מתועדת לטיפול ממושך	החלטה מתועדת של הרופא/ה על טיפול ממושך (למשל גסטרופרזיס). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	אק"ג מתועד שאלה: גיל 60 ומעלה או מחלת לב?	אק"ג מ-12 החודשים האחרונים ללא QTc מוארך. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
3	אין תרופה נוספת שמאריכה QT	ברשימת התרופות אין קלריתרומיצין, אריתרומיצין, נוגד פטרת אזולי, אמיודרון או ציטלופרם. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אק"ג בגיל 60+ או במחלת לב
תלונות בפנייה או ברשומה	דפיקות לב או עילפון ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

6.15 מטוקלופרמיד · Metoclopramide רופא/ה בלבד

פרוקינטי

שמות מסחריים (1)	פראמין · Pramin
נימוק / הערה	מטוקלופרמיד מעל 12 שבועות מסוכן (דיסקינזיה מאוחרת). טיפול ממושך - חידוש ע"י רופא/ה בלבד.
הנחיה	**מטוקלופרמיד מעל 12 שבועות מסוכן (דיסקינזיה מאוחרת). טיפול ממושך - חידוש ע"י רופא/ה בלבד.**

מקור	-

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

6.16 **מבברין** · Mebeverine מתאים

נוגד עוויתות (IBS)

שמות מסחריים (1)	קולוטאל · Colotal
נימוק / הערה	בטוח

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
3	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
4	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
5	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
6	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
תלונות בפנייה או ברשומה	דם בצואה, ירידה במשקל או שינוי חדש ביציאות מגיל 50 ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

6.17 פרוקלופריד · Prucalopride מתאים

עצירות כרונית

שמות מסחריים (1)	רזולור · Resolor
נימוק / הערה	אם אין שיפור אחרי 4 שבועות ← הערכה מחדש

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין החמרה מתועדת	ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
2	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
5	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
6	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
7	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
תלונות בפנייה או ברשומה	מחשבות אובדניות ← דחוף; החמרה במצב הרוח או אי-שקט קשה ← לרופא; דם בצואה או ירידה במשקל ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

6.18 משלשלים · Laxatives מתאים

עצירות

שמות מסחריים (8)	נורמלקס · Normalax | פגלקס · Peglax | רגולקס · Regulax | אגיולקס · Agiolax | אגיוקור · Agiocur | לקסעדין · Laxadin | קונטלקס · Contalax | אאוקרבון · Eucarbon
נימוק / הערה	בטוחים; שינוי חדש ביציאות מגיל 50 ← בירור

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
3	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
4	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
5	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
6	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
תלונות בפנייה או ברשומה	דם בצואה, ירידה במשקל או שינוי חדש ביציאות ← לרופא; כאב בטן חזק או הקאות ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

6.19 תרופות נגד הפטיטיס C ו-D · Hepatitis C / D antivirals רופא/ה בלבד

אנטי-ויראלי

שמות מסחריים (4)	אפקלוזה · Epclusa | ווסווי · Vosevi | מבירט · Maviret | הפקלודקס · Hepcludex
נימוק / הערה	טיפול בהפטיטיס C או D ניתן ע"י מרפאת הכבד. להעביר לרופא/ה.
הנחיה	**טיפול בהפטיטיס C או D ניתן ע"י מרפאת הכבד. להעביר לרופא/ה.**

מקור	-

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

6.20 תרופות מומחה נוספות · Other specialist drugs רופא/ה בלבד

מומחה

שמות מסחריים (4)	אוקליבה · Ocaliva | ליבדלזי · Livdelzi | ואנראפיה · Vanrafia | פבהלטה · Fabhalta
נימוק / הערה	תרופות לכבד (PBC) ולכליות במעקב מומחה. להעביר לרופא/ה.
הנחיה	**תרופות לכבד (PBC) ולכליות במעקב מומחה. להעביר לרופא/ה.**

מקור	-

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

7. כליות ודרכי שתן

22 תרופות · מתאים: 16 · רופא/ה בלבד: 4 · בתנאים: 2 · גרסה 2 · חלוקה לפי מערכות · 2.11.2026

מקורות: הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020; ACOG 2023 (סיכום AFP). שאר התחומים: החלטה מקומית; עלון לצרכן לפונקס (עודכן 12/2020). שאר התרופות: החלטה מקומית

7.א כללים

- חידוש רגיל: 3 חודשים
- ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה פעם בשנה
- עד 3 חידושים רצופים, ואז ביקור רופא
- אין התווית נגד ← תמיד מחדשים לפחות לחודש אחד
- חסרה מדידה, בדיקה או ביקורת שנתית: חידוש לחודש אחד + זימון למרפאה
- חריגה מספי ההחזרה: חידוש לחודש אחד + הודעה לרופא/ה
- התווית נגד או ערך חמור: לא מחדשים, הודעה לרופא/ה (הסף של כל תרופה מופיע ברשימה שלה)
- רפואן לא משנה מינון ולא מחליף תרופה. "מעקב מעבדה צמוד" = תרופה עם בדיקות תכופות — לבדוק בקפידה
- מעכבי PDE5: ניטרטים = התווית נגד
- אנטי-כולינרגיים לשלפוחית: גיל 75+ ← אישור רופא/ה; אצירת שתן ← דחוף
- תרופות לאי-ספיקת כליות מתקדמת (ESA, קושרים): חידוש ע"י רופא/ה בלבד

7.ג בדיקות משותפות

שלב	נושא	מה בודקים	קריטריון	אם לא מתקיים	מקור
לפני כל חידוש	רכישות	כיסוי ימים ב-6 החודשים האחרונים	80% מהימים ומעלה	פחות ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה	כמו ביל"ד
לפני כל חידוש	ביקורת שנתית	ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה	ב-12 החודשים האחרונים	אין ← חידוש לחודש + זימון לביקורת	כמו ביל"ד
לפני כל חידוש	רצף חידושים	כמה חידושים רצופים מאז ביקור רופא	פחות מ-3	3 ← ביקור רופא	כמו ביל"ד

7.ד החלטות

#	נושא	מה ההנחיה אומרת	ההחלטה לפרוטוקול	סוג	מקור
כללי-15	שלפוחית רגיזה ו-PDE5	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	אנטי-כולינרגיים: גיל 75+ ← אישור רופא/ה; אצירת שתן ← דחוף. מירבגרון: ל"ד מתחת ל-160/100. PDE5: ניטרטים = התווית נגד	החלטה מקומית (הצעה)	-
כללי-19	תרופות מומחה	-	אריתרופויאטין, קושרי זרחן ואשלגן, HIV, הפטיטיס B, ציקלוספורין/טקרולימוס, אפרמילסט ואציטרטין: הודעה בלבד, חידוש ע"י רופא/ה	החלטה מקומית	-
כללי-20	השלמות מהמאגר (2.11.2026)	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	טרזוסין, פינסטריד, אינקליסירן, ורדנאפיל, טיפות לגלאוקומה (ביקורת עיניים שנתית; טימולול: דופק ואסתמה), NSAID ממושך (כליות, אשלגן, ל"ד, דימום, הגנת קיבה), אנטיהיסטמינים, ציננריזין, דומפרידון, מבברין, סידן, מידודרין, פנטוקסיפילין, דיפירידמול, ולציקלוביר מונע, חומצה זולדרונית	החלטה מקומית (הצעה)	-
כללי-22	השלמות 2 מהמאגר (2.11.2026)	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	ויטמין D, בטאהיסטין, חומצה במפדואית, אומגה 3/איקוזפנט, ציפרופיברט, וריסיגואט, ניטרוגליצרין תת-לשוני, פזולינטנט/אלינזנטנט (ALT), דואביב, אינטראזוסה, סיאנה, אורליסטט, פרוקלופריד, משלשלים, טטרציקלינים ממושכים, מניעת זיהומי שתן, משככי כאב ממושכים, ביקרבונט. רופא/ה בלבד: פנטרמין, בונות עצם, הפרינים, תרופות עצם בכליות, אנלוגי סומטוסטטין, הפטיטיס C/D, מחלות נדירות	החלטה מקומית (הצעה)	-
מעקב-3	דיגוקסין: תדירות	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	רמה מ-12 החודשים האחרונים; אשלגן וקריאטינין מ-6 החודשים האחרונים	החלטה מקומית (הצעה)	-
מעקב-12	תרופות למעקב צמוד נוספות	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	מתימזול/PTU, לפלונומיד, אזתיופרין, סולפסלזין, מיקופנולט, מעכבי JAK, הידרוקסיאוריאה, הידרוקסיכלורוקווין, נוגדי פסיכוזה, טסטוסטרון, סטרואידים כרוניים, ניטרופורנטואין, קולכיצין, דנוסומאב, טריפרטייד: בדיקות לפי התרופה; חריגה ← חודש + הודעה; ערך חמור ← לא מחדשים	החלטה מקומית (הצעה)	-

7.ה רשימת התרופות (לסימון)

#	שם	גנרי	קבוצה	התאמה	אושר	הערות
7.1	טמסולוסין	Tamsulosin	ערמונית · חוסם אלפא	מתאים	☐	
7.2	אלפוזוסין	Alfuzosin	ערמונית · חוסם אלפא	מתאים	☐	
7.3	דוטסטריד	Dutasteride	ערמונית · מעכב 5-אלפא רדוקטאז	מתאים	☐	
7.4	דוטסטריד + טמסולוסין	Dutasteride + Tamsulosin	ערמונית · מעכב 5-אלפא רדוקטאז + חוסם אלפא	מתאים	☐	
7.5	סוליפנצין	Solifenacin	שלפוחית רגיזה · אנטי-כולינרגי	מתאים	☐	
7.6	טולטרודין	Tolterodine	שלפוחית רגיזה · אנטי-כולינרגי	מתאים	☐	
7.7	פזוטרודין	Fesoterodine	שלפוחית רגיזה · אנטי-כולינרגי	מתאים	☐	
7.8	טרוספיום	Trospium	שלפוחית רגיזה · אנטי-כולינרגי	מתאים	☐	
7.9	אוקסיבוטינין	Oxybutynin	שלפוחית רגיזה · אנטי-כולינרגי	מתאים	☐	
7.10	מירבגרון	Mirabegron	שלפוחית רגיזה · אגוניסט בטא-3	מתאים	☐	
7.11	סילדנאפיל	Sildenafil	מעכב PDE5	מתאים	☐	
7.12	טדלפיל	Tadalafil	מעכב PDE5	מתאים	☐	
7.13	מעודדי ייצור דם (אריתרופויאטין)	Erythropoiesis-stimulating agents	ESA	רופא/ה בלבד	☐	
7.14	קושרי זרחן	Phosphate binders	אי-ספיקת כליות	רופא/ה בלבד	☐	
7.15	קושרי אשלגן	Potassium binders	היפרקלמיה	רופא/ה בלבד	☐	
7.16	טרזוסין	Terazosin	ערמונית · חוסם אלפא	מתאים	☐	
7.17	פינסטריד	Finasteride	ערמונית · מעכב 5-אלפא רדוקטאז	מתאים	☐	
7.18	ורדנאפיל	Vardenafil	מעכב PDE5	מתאים	☐	
7.19	מניעת זיהומי שתן	UTI prophylaxis	מניעה ממושכת	מתאים	☐	
7.20	סודיום ביקרבונט (טבליות)	Sodium bicarbonate (tablets)	חמצת במחלת כליות	בתנאים	☐	
7.21	תרופות למחלת עצם בכליות	CKD bone-mineral drugs	נפרולוגיה	רופא/ה בלבד	☐	
7.22	ניטרופורנטואין (מניעה)	Nitrofurantoin (prophylaxis)	אנטיביוטיקה למניעת זיהומי שתן	בתנאים ⚗	☐	

7.ו פירוט מלא

7.1 **טמסולוסין** · Tamsulosin מתאים

ערמונית · חוסם אלפא

שמות מסחריים (4)	פרומניקס · Promnix | טמסולין · Tamsulin | טמסו פי.אר. טבע · Tamsu P.R. Teva | טמסולוסין אינובמד · Tamsulosin Inovamed
נימוק / הערה	ללא מעקב מעבדה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
3	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
4	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
5	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
6	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	סחרחורת בעמידה או נפילות ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

7.2 **אלפוזוסין** · Alfuzosin מתאים

ערמונית · חוסם אלפא

שמות מסחריים (3)	קסטרל · Xatral | אלפו-קל Alfu-Kal XL · XL | אלפוזוסין ER טבע · Alfuzosin ER Teva
נימוק / הערה	ללא מעקב מעבדה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
3	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
4	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
5	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
6	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	סחרחורת בעמידה או נפילות ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

7.3 **דוטסטריד** · Dutasteride מתאים

ערמונית · מעכב 5-אלפא רדוקטאז

שמות מסחריים (4)	אבודרט · Avodart | ערמוניה · Armonia | דוטסטריד תרו · Dutasteride Taro | דוטאסטריד טבע · Dutasteride Teva
נימוק / הערה	ללא מעקב מעבדה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
3	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
4	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
5	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
6	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
7	**אין התווית נגד**	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): מטופלת (אישה). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי (PSA יורד בכמחצית)
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	מטופלת (אישה)
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

7.4 דוטסטריד + טמסולוסין · Dutasteride + Tamsulosin מתאים

ערמונית · מעכב 5-אלפא רדוקטאז + חוסם אלפא

שמות מסחריים (6)	דואודרט · Duodart | ערמוניה פלוס · Armonia Plus | דופרוסט · Duprost | דוטלוסין טבע · Dutalosin Teva | דוטרסין אס.קיי · Dutarsin S.K. | דוטאסטמד · Dutastamed
נימוק / הערה	ללא מעקב מעבדה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
3	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
4	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
5	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
6	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
7	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): מטופלת (אישה). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי (PSA יורד בכמחצית); אין מעקב מעבדה שגרתי
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	מטופלת (אישה)
תלונות בפנייה או ברשומה	סחרחורת בעמידה או נפילות ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

7.5 סוליפנצין · Solifenacin מתאים

שלפוחית רגיזה · אנטי-כולינרגי

שמות מסחריים (3)	סוליפנאסין מדו · Solifenacin Medo | סוליפנאסין תרימה · Solifenacin Trima | טאמסולופן · Tamsulofen (עם טמסולוסין)
נימוק / הערה	תופעות קוגניטיביות בגיל מבוגר

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**אין ירידה קוגניטיבית מתועדת** שאלה: המטופל/ת בגיל 75 ומעלה?	אין ירידה קוגניטיבית או בלבול מתועדים, והרופא/ה אישר/ה המשך טיפול בשנה האחרונה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
2	**אין אצירת שתן מתועדת**	ברשומה או בפנייה אין קושי במתן שתן או אצירת שתן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
9	**אין התווית נגד**	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): גלאוקומה עם זווית צרה; אצירת שתן. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	גלאוקומה עם זווית צרה; אצירת שתן
תלונות בפנייה או ברשומה	קושי במתן שתן ← דחוף; בלבול או ירידה בזיכרון ← לרופא; כאב עיניים ← דחוף; עצירות קשה ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

7.6 טולטרודין · Tolterodine מתאים

שלפוחית רגיזה · אנטי-כולינרגי

שמות מסחריים (2)	דטרוסיטול Detrusitol SR · SR | טולטרודין אי.אר. מדומי · Tolterodine E.R. Medomie
נימוק / הערה	תופעות קוגניטיביות בגיל מבוגר

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין ירידה קוגניטיבית מתועדת שאלה: המטופל/ת בגיל 75 ומעלה?	אין ירידה קוגניטיבית או בלבול מתועדים, והרופא/ה אישר/ה המשך טיפול בשנה האחרונה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
2	אין אצירת שתן מתועדת	ברשומה או בפנייה אין קושי במתן שתן או אצירת שתן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
9	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): גלאוקומה עם זווית צרה; אצירת שתן. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	גלאוקומה עם זווית צרה; אצירת שתן
תלונות בפנייה או ברשומה	קושי במתן שתן ← דחוף; בלבול או ירידה בזיכרון ← לרופא; כאב עיניים ← דחוף; עצירות קשה ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

7.7 פזוטרודין · Fesoterodine מתאים

שלפוחית רגיזה · אנטי-כולינרגי

שמות מסחריים (4)	טוביאז · Toviaz | פסוטרמד · Fesotermed | תרופז · Tarofes | טרודו · Trudo
נימוק / הערה	תופעות קוגניטיביות בגיל מבוגר

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין ירידה קוגניטיבית מתועדת שאלה: המטופל/ת בגיל 75 ומעלה?	אין ירידה קוגניטיבית או בלבול מתועדים, והרופא/ה אישר/ה המשך טיפול בשנה האחרונה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
2	אין אצירת שתן מתועדת	ברשומה או בפנייה אין קושי במתן שתן או אצירת שתן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
9	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): גלאוקומה עם זווית צרה; אצירת שתן. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	גלאוקומה עם זווית צרה; אצירת שתן
תלונות בפנייה או ברשומה	קושי במתן שתן ← דחוף; בלבול או ירידה בזיכרון ← לרופא; כאב עיניים ← דחוף; עצירות קשה ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

7.8 טרוספיום · Trospium מתאים

שלפוחית רגיזה · אנטי-כולינרגי

שמות מסחריים (4)	ספזמקס · Spasmex | ספסמו-ליט · Spasmo-Lyt | טרוסמוליט · Trosmolyt | טרוספס · Trospas
נימוק / הערה	תופעות קוגניטיביות בגיל מבוגר (פחות חודר למוח)

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין ירידה קוגניטיבית מתועדת שאלה: המטופל/ת בגיל 75 ומעלה?	אין ירידה קוגניטיבית או בלבול מתועדים, והרופא/ה אישר/ה המשך טיפול בשנה האחרונה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
2	אין אצירת שתן מתועדת	ברשומה או בפנייה אין קושי במתן שתן או אצירת שתן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
9	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): גלאוקומה עם זווית צרה; אצירת שתן. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	גלאוקומה עם זווית צרה; אצירת שתן
תלונות בפנייה או ברשומה	קושי במתן שתן ← דחוף; בלבול או ירידה בזיכרון ← לרופא; כאב עיניים ← דחוף; עצירות קשה ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

7.9 אוקסיבוטינין · Oxybutynin מתאים

שלפוחית רגיזה · אנטי-כולינרגי

שמות מסחריים (2)	נוביטרופן · Novitropan | וסוקס · Vesoxx (לשלפוחית)
נימוק / הערה	תופעות קוגניטיביות בגיל מבוגר — הכי פחות מתאים בגיל מבוגר

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין ירידה קוגניטיבית מתועדת שאלה: המטופל/ת בגיל 75 ומעלה?	אין ירידה קוגניטיבית או בלבול מתועדים, והרופא/ה אישר/ה המשך טיפול בשנה האחרונה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
2	אין אצירת שתן מתועדת	ברשומה או בפנייה אין קושי במתן שתן או אצירת שתן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
9	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): גלאוקומה עם זווית צרה; אצירת שתן. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	גלאוקומה עם זווית צרה; אצירת שתן
תלונות בפנייה או ברשומה	קושי במתן שתן ← דחוף; בלבול או ירידה בזיכרון ← לרופא; כאב עיניים ← דחוף; עצירות קשה ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

7.10 **מירבגרון** · Mirabegron מתאים

שלפוחית רגיזה · אגוניסט בטא-3

שמות מסחריים (3)	בטמיגה · Betmiga | מיראבגרון אס.קיי. · Mirabegron S.K. | מירבגרון סנדוז · Mirabegron Sandoz
נימוק / הערה	אסור בל"ד לא מאוזן (180/110 ומעלה)

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**מדידת ל"ד מתועדת**	מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	**ל"ד מתחת ל-160/100**	מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-160/100. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	ל"ד שנתי
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב ראש או דפיקות לב ← לרופא; קושי במתן שתן ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

7.11 **סילדנאפיל** · Sildenafil מתאים

מעכב PDE5

שמות מסחריים (6)	ויאגרה · Viagra | סילדזן · Sildazen | סילדנאפיל טבע · Sildenafil Teva | סליידר · Slider | תרים · Tarim | ויה-אבניר · Via-Avenir
נימוק / הערה	אסור עם ניטרטים. רווטיו (יל"ד ריאתי) - רק ע"י היחידה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**אין כאב חזה מתועד**	ברשומה או בפנייה אין כאב בחזה במאמץ. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
2	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
3	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
4	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
5	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
6	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
7	**אין התווית נגד**	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): ניטרטים (איזוסורביד, ניטרוגליצרין); ריוציגואט (אדמפס). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	ניטרטים (איזוסורביד, ניטרוגליצרין); ריוציגואט (אדמפס)
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב בחזה ← דחוף - מיון, לא לקחת ניטרט; זקפה מעל 4 שעות ← דחוף; ירידה פתאומית בראייה או בשמיעה ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

7.12 **טדלפיל** · Tadalafil מתאים

מעכב PDE5

שמות מסחריים (5)	סיאליס · Cialis | טאדאייר · Tadair | טאדאלאמד · Tadalamed | טדאליס טבע · Tadalis Teva | טאדם · Tadam
נימוק / הערה	אסור עם ניטרטים. רווטיו (יל"ד ריאתי) - רק ע"י היחידה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין כאב חזה מתועד	ברשומה או בפנייה אין כאב בחזה במאמץ. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
2	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
3	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
4	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
5	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
6	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
7	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): ניטרטים (איזוסורביד, ניטרוגליצרין); ריוציגואט (אדמפס). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	ניטרטים (איזוסורביד, ניטרוגליצרין); ריוציגואט (אדמפס)
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב בחזה ← דחוף - מיון, לא לקחת ניטרט; זקפה מעל 4 שעות ← דחוף; ירידה פתאומית בראייה או בשמיעה ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

7.13 **מעודדי ייצור דם (אריתרופויאטין)** · Erythropoiesis-stimulating agents רופא/ה בלבד

ESA

שמות מסחריים (3)	אראנספ · Aranesp | אפרקס · Eprex | בינוקריט · Binocrit
נימוק / הערה	מעודדי ייצור דם נקבעים ומנוטרים ע"י נפרולוג/ית או המטולוג/ית. להעביר לרופא/ה.
הנחיה	**מעודדי ייצור דם נקבעים ומנוטרים ע"י נפרולוג/ית או המטולוג/ית. להעביר לרופא/ה.**

מקור	-

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

7.14 **קושרי זרחן** · Phosphate binders רופא/ה בלבד

אי-ספיקת כליות

שמות מסחריים (4)	רנוולה · Renvela | סבלמר תרו · Sevelamer Taro | פוסרנול · Fosrenol | וולפורו · Velphoro
נימוק / הערה	קושרי זרחן נקבעים ע"י הנפרולוג/ית לפי זרחן וסידן. להעביר לרופא/ה.
הנחיה	**קושרי זרחן נקבעים ע"י הנפרולוג/ית לפי זרחן וסידן. להעביר לרופא/ה.**

מקור	-

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

7.15 קושרי אשלגן · Potassium binders רופא/ה בלבד

היפרקלמיה

שמות מסחריים (2)	לוקלמה · Lokelma | ולטסה · Veltassa
נימוק / הערה	קושרי אשלגן ניתנים לפי רמת אשלגן עדכנית. חידוש ע"י רופא/ה בלבד.
הנחיה	**קושרי אשלגן ניתנים לפי רמת אשלגן עדכנית. חידוש ע"י רופא/ה בלבד.**

מקור	-

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

7.16 טרזוסין · Terazosin מתאים

ערמונית · חוסם אלפא

שמות מסחריים (2)	היטרין · Hytrin | טרזוסין טבע · Terazosin Teva
נימוק / הערה	ללא מעקב מעבדה; סחרחורת בעמידה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
3	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
4	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
5	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
6	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	סחרחורת בעמידה או נפילות ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

7.17 פינסטריד · Finasteride מתאים

ערמונית · מעכב 5-אלפא רדוקטאז

שמות מסחריים (1)	פינסטרייד טבע · Finasteride Teva (1 מ"ג - נשירת שיער)
נימוק / הערה	ללא מעקב מעבדה. 1 מ"ג = נשירת שיער; PSA יורד בחצי

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
3	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
4	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
5	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
6	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
7	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): מטופלת (אישה). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי (PSA יורד בכמחצית)
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	מטופלת (אישה)
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

7.18 ורדנאפיל · Vardenafil מתאים

מעכב PDE5

שמות מסחריים (1)	בי-און · B-On
נימוק / הערה	אסור עם ניטרטים

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין כאב חזה מתועד	ברשומה או בפנייה אין כאב בחזה במאמץ. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
2	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
3	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
4	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
5	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
6	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
7	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): ניטרטים (איזוסורביד, ניטרוגליצרין); ריוציגואט (אדמפס). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	ניטרטים (איזוסורביד, ניטרוגליצרין); ריוציגואט (אדמפס)
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב בחזה ← דחוף - מיון, לא לקחת ניטרט; זקפה מעל 4 שעות ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

7.19 מניעת זיהומי שתן · UTI prophylaxis מתאים

מניעה ממושכת

שמות מסחריים (3)	מתנאמין היפורט אמ.בי.איי · Hiprex (Methenamine Hippurate MBI) | מטרקס אס.קיי · Metherex S.K | דיספטיל · Diseptyl (טרימתופרים-סולפה)
נימוק / הערה	מניעה שנקבעה ע"י רופא/ה; הערכה מחדש כל 6-12 חודשים

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מניעה שהוערכה בשנה האחרונה	החלטת רופא/ה על מניעה ב-12 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	קריאטינין מתועד	קריאטינין/eGFR ואשלגן מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
3	אשלגן (K) תקין	בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מעל 5.0 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
4	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <30 (לבדיקה) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	קריאטינין שנתי; טרימתופרים-סולפה: אשלגן
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <30 (לבדיקה); K מעל 5.0
תלונות בפנייה או ברשומה	פריחה ← דחוף - הפסקה; חום וכאב מותני ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

7.20 **סודיום ביקרבונט (טבליות)** · Sodium bicarbonate (tablets) בתנאים

חמצת במחלת כליות

שמות מסחריים (1)	סודיום ביקרבונט רקח · Sodium Bicarbonate Rekah
נימוק / הערה	נקבע לפי ביקרבונט בדם; בצקות ול"ד

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	ביקרבונט מתועד	ביקרבונט וקריאטינין מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	ביקרבונט בטווח	ביקרבונט בדם 22-29. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ה מומחה/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
6	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	ביקרבונט וקריאטינין כל 6 חודשים
תלונות בפנייה או ברשומה	בצקות או קוצר נשימה ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

7.21 **תרופות למחלת עצם בכליות** · CKD bone-mineral drugs רופא/ה בלבד

נפרולוגיה

שמות מסחריים (5)	פאריקלציטול אינובמד · Paricalcitol Inovamed | פרקל · Parkal | רקסטול · Rextol | זמפלר · Zemplar | פארסביב · Parsabiv
נימוק / הערה	פאריקלציטול ואטלקלצטיד נקבעים ע"י הנפרולוג/ית לפי סידן, זרחן ו-PTH. להעביר לרופא/ה.
הנחיה	**פאריקלציטול ואטלקלצטיד נקבעים ע"י הנפרולוג/ית לפי סידן, זרחן ו-PTH. להעביר לרופא/ה.**

מקור	-

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

7.22 ניטרופורנטואין (מניעה) · Nitrofurantoin (prophylaxis) בתנאים מעקב מעבדה צמוד

אנטיביוטיקה למניעת זיהומי שתן

שמות מסחריים (1)	ניטרופורנטואין רז · Nitrofurantoin Raz
נימוק / הערה	מניעה ממושכת בלבד, שנקבעה ע"י רופא/ה. סיכון לפגיעה ריאתית וכבדית

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	בדיקות מתועדות	קריאטינין/eGFR ו-ALT מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חמור: eGFR <45 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התוויות נגד
3	תפקודי כבד (ALT) תקין	בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 2 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
4	אין תסמיני ריאות מתועדים	ברשומה או בפנייה אין שיעול או קוצר נשימה חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
5	פחות מ-6 חודשי מניעה רצופים	המניעה נמשכת פחות מ-6 חודשים מאז ההערכה האחרונה של הרופא/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
7	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
8	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשמניעה ממושכת שנקבעה ע"י רופא/ה. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
9	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
10	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
11	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
12	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	קריאטינין ו-ALT כל 6 חודשים
ספי החזרה לרופא/ה	ALT מעל פי 2 מהגבול העליון
ערך חמור	eGFR <45
תלונות בפנייה או ברשומה	שיעול או קוצר נשימה ← דחוף; נימול בידיים או ברגליים ← לרופא; צהבת ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

8. בריאות האישה

15 תרופות · בתנאים: 9 · מתאים: 6 · גרסה 2 · חלוקה לפי מערכות · 2.11.2026

מקורות: הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020; ACOG 2023 (סיכום AFP). שאר התחומים: החלטה מקומית

8.א כללים

- חידוש רגיל: 3 חודשים
- ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה פעם בשנה
- עד 3 חידושים רצופים, ואז ביקור רופא
- אין התווית נגד ← תמיד מחדשים לפחות לחודש אחד
- חסרה מדידה, בדיקה או ביקורת שנתית: חידוש לחודש אחד + זימון למרפאה
- חריגה מספי ההחזרה: חידוש לחודש אחד + הודעה לרופא/ה
- התווית נגד או ערך חמור: לא מחדשים, הודעה לרופא/ה (הסף של כל תרופה מופיע ברשימה שלה)
- רפואן לא משנה מינון ולא מחליף תרופה. "מעקב מעבדה צמוד" = תרופה עם בדיקות תכופות — לבדוק בקפידה
- דימום וגינלי לא סדיר ← הודעה דחופה
- אסטרוגן מערכתי כשיש רחם: חייב פרוגסטוגן
- אמצעי מניעה משולב: עישון בגיל 35+, מיגרנה עם הילה או פקקת בעבר = התווית נגד

8.ג בדיקות משותפות

שלב	נושא	מה בודקים	קריטריון	אם לא מתקיים	מקור
לפני כל חידוש	רכישות	כיסוי ימים ב-6 החודשים האחרונים	80% מהימים ומעלה	פחות ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה	כמו ביל"ד
לפני כל חידוש	ביקורת שנתית	ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה	ב-12 החודשים האחרונים	אין ← חידוש לחודש + זימון לביקורת	כמו ביל"ד
לפני כל חידוש	רצף חידושים	כמה חידושים רצופים מאז ביקור רופא	פחות מ-3	3 ← ביקור רופא	כמו ביל"ד

8.ד החלטות

#	נושא	מה ההנחיה אומרת	ההחלטה לפרוטוקול	סוג	מקור
כללי-14	הורמונים לנשים	NAMS 2022: אסטרוגן מערכתי עם רחם ← פרוגסטוגן; דימום לא סדיר ← בירור; התוויות נגד: סרטן שד, פקקת, אוטם/שבץ, מחלת כבד	אסטרוגן בלי פרוגסטוגן כשיש רחם ← הודעה דחופה; ממוגרפיה לפי התוכנית; ל"ד שנתי. אמצעי מניעה משולב: ל"ד מתחת ל-140/90, עישון בגיל 35+, מיגרנה עם הילה ופקקת = התווית נגד	הנחיה + החלטה מקומית	NAMS 2022; נייר העמדה הישראלי לטיפול הורמונלי (בפרויקט)
כללי-20	השלמות מהמאגר (2.11.2026)	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	טרזוסין, פינסטריד, אינקליסירן, ורדנאפיל, טיפות לגלאוקומה (ביקורת עיניים שנתית; טימולול: דופק ואסתמה), NSAID ממושך (כליות, אשלגן, ל"ד, דימום, הגנת קיבה), אנטיהיסטמינים, ציננריזין, דומפרידון, מבברין, סידן, מידודרין, פנטוקסיפילין, דיפירידמול, ולציקלוביר מונע, חומצה זולדרונית	החלטה מקומית (הצעה)	-
כללי-22	השלמות 2 מהמאגר (2.11.2026)	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	ויטמין D, בטאהיסטין, חומצה במפדואית, אומגה 3/איקוזפנט, ציפרופיברט, וריסיגואט, ניטרוגליצרין תת-לשוני, פזולינטנט/אלינזנטנט (ALT), דואביב, אינטראוסה, סיאנה, אורליסטט, פרוקלופריד, משלשלים, טטרציקלינים ממושכים, מניעת זיהומי שתן, משככי כאב ממושכים, ביקרבונט. רופא/ה בלבד: פנטרמין, בונות עצם, הפרינים, תרופות עצם בכליות, אנלוגי סומטוסטטין, הפטיטיס C/D, מחלות נדירות	החלטה מקומית (הצעה)	-

8.ה רשימת התרופות (לסימון)

#	שם	גנרי	קבוצה	התאמה	אושר	הערות
8.1	אסטרדיול (מערכתי)	Estradiol (systemic)	טיפול הורמונלי במנופאוזה · אסטרוגן	בתנאים	☐	
8.2	אסטרדיול + דידרוגסטרון	Estradiol + dydrogesterone	טיפול הורמונלי במנופאוזה · משולב	בתנאים	☐	
8.3	אסטרדיול + נורתיסטרון	Estradiol + norethisterone	טיפול הורמונלי במנופאוזה · משולב	בתנאים	☐	
8.4	אסטרדיול + דרוספירנון	Estradiol + drospirenone	טיפול הורמונלי במנופאוזה · משולב	בתנאים	☐	
8.5	אסטרדיול + נורגסטרל	Estradiol + norgestrel	טיפול הורמונלי במנופאוזה · משולב	בתנאים	☐	
8.6	פרוגסטרון ופרוגסטינים (בבליעה)	Progesterone / progestogens (oral)	פרוגסטוגן	מתאים	☐	
8.7	אסטרדיול (נרתיקי)	Estradiol (vaginal)	אסטרוגן מקומי	מתאים	☐	
8.8	אמצעי מניעה הורמונלי משולב	Combined hormonal contraception	גלולה, טבעת או מדבקה משולבת	מתאים	☐	
8.9	גלולה פרוגסטטיבית	Progestogen-only pill	אמצעי מניעה	מתאים	☐	
8.10	דיאנוגסט	Dienogest	אנדומטריוזיס	בתנאים	☐	
8.11	פזולינטנט	Fezolinetant	גלי חום · אנטגוניסט NK3	בתנאים	☐	
8.12	אלינזנטנט	Elinzanetant	גלי חום · אנטגוניסט NK3	בתנאים	☐	
8.13	אסטרוגנים מצומדים + בזדוקסיפן	Conjugated estrogens + bazedoxifene	טיפול הורמונלי במנופאוזה (TSEC)	בתנאים	☐	
8.14	פרסטרון (נרתיקי)	Prasterone (vaginal)	DHEA מקומי	מתאים	☐	
8.15	מדרוקסיפרוגסטרון (זריקת מאגר)	Medroxyprogesterone (depot injection)	אמצעי מניעה בזריקה	מתאים	☐	

1.8 פירוט מלא

8.1 **אסטרדיול (מערכתי)** · Estradiol (systemic) בתנאים

טיפול הורמונלי במנופאוזה · אסטרוגן

שמות מסחריים (3)	אסטרופם · Estrofem | אסטרוג'ל · Oestrogel | אוורל · Evorel (מדבקה)
נימוק / הערה	רחם קיים ← חייב פרוגסטוגן. דימום לא סדיר ← בירור

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**פרוגסטוגן ברשימה** שאלה: יש רחם (לא עברה כריתת רחם)?	ברשימת התרופות יש פרוגסטרון (אוטרוגסטן, דופסטון) או התקן מירנה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
2	**אין דימום וגינלי לא סדיר**	ברשומה או בפנייה אין דימום וגינלי לא סדיר (או דימום אחרי גיל המעבר). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	**ממוגרפיה לפי התוכנית**	גיל 50-74: ממוגרפיה מ-24 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
4	**מדידת ל"ד מתועדת**	מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
5	**ל"ד מתחת ל-140/90**	מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
7	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
8	**טיפול כרוני במינון קבוע**	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
9	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
10	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
11	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
12	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
13	**אין התווית נגד**	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): סרטן שד או סרטן רגיש לאסטרוגן; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי; אוטם לב או שבץ; מחלת כבד פעילה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	ממוגרפיה לפי התוכנית; ל"ד שנתי
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	סרטן שד או סרטן רגיש לאסטרוגן; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי; אוטם לב או שבץ; מחלת כבד פעילה
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב ונפיחות ברגל או קוצר נשימה ← דחוף; גוש בשד ← לרופא; דימום וגינלי ← לרופא; כאב ראש חדש וחזק ← דחוף
מקור	NAMS 2022; נייר העמדה הישראלי לטיפול הורמונלי (בפרויקט)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

8.2 אסטרדיול + דידרוגסטרון · Estradiol + dydrogesterone בתנאים

טיפול הורמונלי במנופאוזה · משולב

שמות מסחריים (2)	פמוסטון · Femoston | פמוסטון קונטי · Femoston Conti
נימוק / הערה	אסטרוגן + פרוגסטוגן. דימום לא סדיר ← בירור

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין דימום וגינלי לא סדיר	ברשומה או בפנייה אין דימום וגינלי לא סדיר (או דימום אחרי גיל המעבר). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	ממוגרפיה לפי התוכנית	גיל 74-50: ממוגרפיה מ-24 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
3	מדידת ל"ד מתועדת	מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
4	ל"ד מתחת ל-140/90	מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
12	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): סרטן שד או סרטן רגיש לאסטרוגן; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי; אוטם לב או שבץ; מחלת כבד פעילה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	ממוגרפיה לפי התוכנית; ל"ד שנתי
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	סרטן שד או סרטן רגיש לאסטרוגן; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי; אוטם לב או שבץ; מחלת כבד פעילה
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב ונפיחות ברגל או קוצר נשימה ← דחוף; גוש בשד ← לרופא; דימום וגינלי ← לרופא; כאב ראש חדש וחזק ← דחוף
מקור	NAMS 2022; נייר העמדה הישראלי לטיפול הורמונלי (בפרויקט)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

8.3 אסטרדיול + נורתיסטרון · Estradiol + norethisterone בתנאים

טיפול הורמונלי במנופאוזה · משולב

שמות מסחריים (4)	אקטיבל · Activelle | נובופם · Novofem | אביאנה · Eviana | אוורל קונטי · Evorel Conti (מדבקה)
נימוק / הערה	אסטרוגן + פרוגסטוגן. דימום לא סדיר ← בירור

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין דימום וגינלי לא סדיר	ברשומה או בפנייה אין דימום וגינלי לא סדיר (או דימום אחרי גיל המעבר). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	ממוגרפיה לפי התוכנית	גיל 74-50: ממוגרפיה מ-24 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
3	מדידת ל"ד מתועדת	מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
4	ל"ד מתחת ל-140/90	מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
12	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): סרטן שד או סרטן רגיש לאסטרוגן; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי; אוטם לב או שבץ; מחלת כבד פעילה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	ממוגרפיה לפי התוכנית; ל"ד שנתי
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	סרטן שד או סרטן רגיש לאסטרוגן; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי; אוטם לב או שבץ; מחלת כבד פעילה
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב ונפיחות ברגל או קוצר נשימה ← דחוף; גוש בשד ← לרופא; דימום וגינלי ← לרופא; כאב ראש חדש וחזק ← דחוף
מקור	NAMS 2022; נייר העמדה הישראלי לטיפול הורמונלי (בפרויקט)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

8.4 אסטרדיול + דרוספירנון · Estradiol + drospirenone בתנאים

טיפול הורמונלי במנופאוזה · משולב

שמות מסחריים (1)	אנג'ליק · Angeliq
נימוק / הערה	אסטרוגן + פרוגסטוגן. דימום לא סדיר ← בירור

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין דימום וגינלי לא סדיר	ברשומה או בפנייה אין דימום וגינלי לא סדיר (או דימום אחרי גיל המעבר). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	ממוגרפיה לפי התוכנית	גיל 74-50: ממוגרפיה מ-24 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
3	מדידת ל"ד מתועדת	מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
4	ל"ד מתחת ל-140/90	מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
12	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): סרטן שד או סרטן רגיש לאסטרוגן; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי; אוטם לב או שבץ; מחלת כבד פעילה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	ממוגרפיה לפי התוכנית; ל"ד שנתי
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	סרטן שד או סרטן רגיש לאסטרוגן; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי; אוטם לב או שבץ; מחלת כבד פעילה
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב ונפיחות ברגל או קוצר נשימה ← דחוף; גוש בשד ← לרופא; דימום וגינלי ← לרופא; כאב ראש חדש וחזק ← דחוף
מקור	NAMS 2022; נייר העמדה הישראלי לטיפול הורמונלי (בפרויקט)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

8.5 אסטרדיול + נורגסטרל · Estradiol + norgestrel בתנאים

טיפול הורמונלי במנופאוזה · משולב

שמות מסחריים (1)	פרוגילוטון · Progyluton
נימוק / הערה	אסטרוגן + פרוגסטוגן. דימום לא סדיר ← בירור

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין דימום וגינלי לא סדיר	ברשומה או בפנייה אין דימום וגינלי לא סדיר (או דימום אחרי גיל המעבר). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	ממוגרפיה לפי התוכנית	גיל 74-50: ממוגרפיה מ-24 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
3	מדידת ל"ד מתועדת	מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
4	ל"ד מתחת ל-140/90	מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
12	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): סרטן שד או סרטן רגיש לאסטרוגן; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי; אוטם לב או שבץ; מחלת כבד פעילה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	ממוגרפיה לפי התוכנית; ל"ד שנתי
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	סרטן שד או סרטן רגיש לאסטרוגן; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי; אוטם לב או שבץ; מחלת כבד פעילה
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב ונפיחות ברגל או קוצר נשימה ← דחוף; גוש בשד ← לרופא; דימום וגינלי ← לרופא; כאב ראש חדש וחזק ← דחוף
מקור	NAMS 2022; נייר העמדה הישראלי לטיפול הורמונלי (בפרויקט)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

8.6 פרוגסטרון ופרוגסטינים (בבליעה) · Progesterone / progestogens (oral) מתאים

פרוגסטוגן

שמות מסחריים (4)	אוטרוגסטן · Utrogestan | דופסטון · Duphaston | פרוברה · Provera | פרימולוט-נור · Primolut-Nor
נימוק / הערה	בדרך כלל כהגנה על הרחם עם אסטרוגן, או בהתוויה גינקולוגית

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	התוויה מתועדת	ניתן יחד עם אסטרוגן, או התוויה גינקולוגית מתועדת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	אין דימום וגינלי לא סדיר	ברשומה או בפנייה אין דימום וגינלי לא סדיר (או דימום אחרי גיל המעבר). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
תלונות בפנייה או ברשומה	דימום וגינלי לא סדיר ← לרופא; כאב ונפיחות ברגל ← דחוף
מקור	NAMS 2022; נייר העמדה הישראלי לטיפול הורמונלי (בפרויקט)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

8.7 **אסטרדיול (נרתיקי)** · Estradiol (vaginal) מתאים

אסטרוגן מקומי

שמות מסחריים (1)	וגיפם · Vagifem
נימוק / הערה	מינון נמוך; אינו מחייב פרוגסטוגן

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**אין דימום וגינלי לא סדיר**	ברשומה או בפנייה אין דימום וגינלי לא סדיר (או דימום אחרי גיל המעבר). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
2	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
5	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
6	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
7	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
תלונות בפנייה או ברשומה	דימום וגינלי ← לרופא
מקור	NAMS 2022; נייר העמדה הישראלי לטיפול הורמונלי (בפרויקט)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

8.8 אמצעי מניעה הורמונלי משולב · Combined hormonal contraception מתאים

גלולה, טבעת או מדבקה משולבת

שמות מסחריים (23)	מיקרוגינון · Microgynon | יסמין · Yasmin | יסמין פלוס · Yasmin Plus | יאז · Yaz | יאז פלוס · Yaz Plus | ליז · Liz | מרסילון · Mercilon | פמינט · Feminet | הרמונט · Harmonet | מינולט · Minulet | מליאן · Meliane | גינרה · Gynera | קלייר · Qlair | זואלי · Zoely | בלארה · Belara | מינס · Minesse | פלורט · Floret | פליים · Flame | נקסטלה · Nextela | נובארינג · Nuvaring (טבעת) | אוורה · Evra (מדבקה) | דיאנה · Diane (ציפרוטרון) | אסטל · Estelle-35 (ציפרוטרון)
נימוק / הערה	ל"ד, עישון, מיגרנה עם הילה ופקקת בעבר

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מדידת ל"ד מתועדת	מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	ל"ד מתחת ל-140/90	מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	לא מעשנת, או מתחת לגיל 35	אין עישון מתועד בגיל 35 ומעלה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
10	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): פקקת ורידים או תסחיף ריאתי בעבר; מיגרנה עם הילה (אורה); עישון בגיל 35 ומעלה; סרטן שד; אוטם לב או שבץ; מחלת כבד פעילה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	ל"ד שנתי
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	פקקת ורידים או תסחיף ריאתי בעבר; מיגרנה עם הילה (אורה); עישון בגיל 35 ומעלה; סרטן שד; אוטם לב או שבץ; מחלת כבד פעילה
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב ונפיחות ברגל או קוצר נשימה ← דחוף; כאב ראש חזק חדש או הפרעות ראייה ← דחוף; כאב בחזה ← דחוף - מיון
מקור	WHO/CDC MEC (החלטה מקומית)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

8.9 גלולה פרוגסטטיבית · Progestogen-only pill מתאים

אמצעי מניעה

שמות מסחריים (3)	סרזט · Cerazette | דיאמילה · Diamilla | פומיניק · Fominic
נימוק / הערה	מתאימה גם כשאסטרוגן אסור

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
3	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
4	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
5	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
6	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
7	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): סרטן שד. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	סרטן שד
תלונות בפנייה או ברשומה	דימום לא סדיר ממושך ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

8.10 **דיאנוגסט** · Dienogest בתנאים

אנדומטריוזיס

שמות מסחריים (1)	ויזאבל · Visabelle
נימוק / הערה	נקבע ע"י גינקולוג/ית

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**אין דימום וגינלי לא סדיר**	ברשומה או בפנייה אין דימום וגינלי לא סדיר (או דימום אחרי גיל המעבר). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
2	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	**טיפול כרוני במינון קבוע**	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י גינקולוג/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
5	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
תלונות בפנייה או ברשומה	דיכאון ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

8.11 **פזולינטנט** · Fezolinetant בתנאים

גלי חום · אנטגוניסט NK3

שמות מסחריים (1)	ואוזה · Veoza
נימוק / הערה	לא הורמונלי. סיכון לפגיעה כבדית: ALT לפני ובחודשים הראשונים

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	ALT מתועד	ALT בתוך 3 החודשים האחרונים בשנה הראשונה, אחר כך שנתי. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	תפקודי כבד (ALT) תקין	בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: ALT מעל פי 5 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: ALT מעל פי 5 מהגבול העליון ← לא מחדשים	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
6	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	ALT לפני הטיפול, אחרי 1, 2, 3 חודשים ואז לפי תסמינים
ספי החזרה לרופא/ה	ALT מעל פי 3 מהגבול העליון
ערך חמור	ALT מעל פי 5 מהגבול העליון
תלונות בפנייה או ברשומה	צהבת, שתן כהה, גרד או כאב בטן ← דחוף - הפסקה
מקור	NAMS 2022; נייר העמדה הישראלי לטיפול הורמונלי (בפרויקט)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

8.12 **אלינזנטנט** · Elinzanetant בתנאים

גלי חום · אנטגוניסט NK3

שמות מסחריים (1)	לינקואט · Lynkuet
נימוק / הערה	לא הורמונלי. סיכון לפגיעה כבדית: ALT לפני ובחודשים הראשונים

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	ALT מתועד	ALT בתוך 3 החודשים האחרונים בשנה הראשונה, אחר כך שנתי. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	תפקודי כבד (ALT) תקין	בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: ALT מעל פי 5 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: ALT מעל פי 5 מהגבול העליון ← לא מחדשים	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
6	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	ALT לפני הטיפול, אחרי 1, 2, 3 חודשים ואז לפי תסמינים
ספי החזרה לרופא/ה	ALT מעל פי 3 מהגבול העליון
ערך חמור	ALT מעל פי 5 מהגבול העליון
תלונות בפנייה או ברשומה	צהבת, שתן כהה, גרד או כאב בטן ← דחוף - הפסקה
מקור	NAMS 2022; נייר העמדה הישראלי לטיפול הורמונלי (בפרויקט)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

8.13 אסטרוגנים מצומדים + בזדוקסיפן · Conjugated estrogens + bazedoxifene בתנאים

טיפול הורמונלי במנופאוזה (TSEC)

שמות מסחריים (1)	דואביב · Duavive
נימוק / הערה	לא צריך פרוגסטוגן. דימום לא סדיר ← בירור

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין דימום וגינלי לא סדיר	ברשומה או בפנייה אין דימום וגינלי לא סדיר (או דימום אחרי גיל המעבר). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	ממוגרפיה לפי התוכנית	גיל 74-50: ממוגרפיה מ-24 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
3	מדידת ל"ד מתועדת	מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
4	ל"ד מתחת ל-140/90	מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
12	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): סרטן שד; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי; אוטם לב או שבץ; מחלת כבד פעילה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	ממוגרפיה לפי התוכנית; ל"ד שנתי
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	סרטן שד; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי; אוטם לב או שבץ; מחלת כבד פעילה
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב ונפיחות ברגל או קוצר נשימה ← דחוף; גוש בשד ← לרופא; דימום וגינלי ← לרופא; כאב ראש חדש וחזק ← דחוף
מקור	NAMS 2022; נייר העמדה הישראלי לטיפול הורמונלי (בפרויקט)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

8.14 פרסטרון (נרתיקי) · Prasterone (vaginal) מתאים

DHEA מקומי

שמות מסחריים (1)	אינטראروסה · Intrarosa
נימוק / הערה	מקומי; דימום ← בירור

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין דימום וגינלי לא סדיר	ברשומה או בפנייה אין דימום וגינלי לא סדיר (או דימום אחרי גיל המעבר). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
2	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
5	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
6	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
7	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
תלונות בפנייה או ברשומה	דימום וגינלי ← לרופא
מקור	NAMS 2022; נייר העמדה הישראלי לטיפול הורמונלי (בפרויקט)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

8.15 מדרוקסיפרוגסטרון (זריקת מאגר) · Medroxyprogesterone (depot injection) מתאים

אמצעי מניעה בזריקה

שמות מסחריים (1)	סיאנה · Sayana
נימוק / הערה	זריקה כל 13 שבועות. ירידה בצפיפות עצם בשימוש ממושך

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	הזריקה בזמן	הזריקה הקודמת ניתנה לפני 13 שבועות לכל היותר (עד 14 שבועות). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
2	פחות משנתיים, או החלטה מתועדת	פחות משנתיים של שימוש, או החלטה מתועדת של הרופא/ה להמשך. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
9	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): סרטן שד. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	סרטן שד
תלונות בפנייה או ברשומה	דימום ממושך ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

9. שלד, מפרקים וכאב

20 תרופות · מתאים: 3 · בתנאים: 14 · הכנה לאישור רופא/ה: 1 · רופא/ה בלבד: 2 · גרסה 2 · חלוקה לפי מערכות · 2.11.2026

מקורות: הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020; ACOG 2023 (סיכום AFP). שאר התחומים: החלטה מקומית; עלון לצרכן לפונקס (עודכן 12/2020). שאר התרופות: החלטה מקומית

9.א כללים

- חידוש רגיל: 3 חודשים
- ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה פעם בשנה
- עד 3 חידושים רצופים, ואז ביקור רופא
- אין התווית נגד ← תמיד מחדשים לפחות לחודש אחד
- חסרה מדידה, בדיקה או ביקורת שנתית: חידוש לחודש אחד + זימון למרפאה
- חריגה מספי ההחזרה: חידוש לחודש אחד + הודעה לרופא/ה
- התווית נגד או ערך חמור: לא מחדשים, הודעה לרופא/ה (הסף של כל תרופה מופיע ברשימה שלה)
- רפואן לא משנה מינון ולא מחליף תרופה. "מעקב מעבדה צמוד" = תרופה עם בדיקות תכופות — לבדוק בקפידה
- ביספוספונט: eGFR <35 = ערך חמור; 5 שנות טיפול ← הודעה
- אופיואידים: חידוש ע"י רופא/ה בלבד
- NSAID ממושך: כליות, אשלגן, ל"ד, דימום והגנת קיבה
- מתוטרקסט ו-DMARD: ספירת דם ותפקודי כבד לפי התרופה; חום או זיהום ← דחוף

9.ג בדיקות משותפות

שלב	נושא	מה בודקים	קריטריון	אם לא מתקיים	מקור
לפני כל חידוש	בדיקת מעקב	לפי התרופה	שומנים: LDL; לבותירוקסין: TSH; אלופורינול/פבוקסוסטט: חומצה אורית — מ-12 החודשים האחרונים	אין ← חידוש לחודש + זימון לבדיקה	הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52; החלטה כללי-1
לפני כל חידוש	ערך המעקב	לעומת הבדיקה הקודמת או היעד	LDL לא עלה ב-30% ומעלה; TSH בטווח המעבדה; חומצה אורית מתחת ל-6	לא ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה	החלטות כללי-4-2
לפני כל חידוש	רכישות	כיסוי ימים ב-6 החודשים האחרונים	80% מהימים ומעלה	פחות ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה	כמו בי"ל
לפני כל חידוש	ביקורת שנתית	ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה	ב-12 החודשים האחרונים	אין ← חידוש לחודש + זימון לביקורת	כמו בי"ל
לפני כל חידוש	רצף חידושים	כמה חידושים רצופים מאז ביקור רופא	פחות מ-3	3 ← ביקור רופא	כמו בי"ל
החזרה מיידית לרופא	פריחה	מופיע בפנייה או ברשומה (אלופורינול)	פריחה או תגובה עורית	הפסקה, דחוף	החלטה כללי-7

9.ד החלטות

#	נושא	מה ההנחיה אומרת	ההחלטה לפרוטוקול	סוג	מקור
כללי-1	בדיקות מעקב	שומנים: פרופיל כל 6-12 חודשים אחרי השגת היעד. TSH וחומצה אורית: לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	LDL, TSH וחומצה אורית מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש + זימון	החלטה מקומית (הצעה)	הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52
כללי-7	אלופורינול ופבוקסוסטט	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	חומצה אורית ≥6 ← הודעה. אלופורינול: eGFR <30 ← הודעה (מינון). פריחה ← התווית נגד, דחוף	החלטה מקומית (הצעה)	-

#	נושא	מה ההנחיה אומרת	ההחלטה לפרוטוקול	סוג	מקור
כללי-9	ביספוספונטים	להפסיק אחרי 5 שנים טיפול פומי בסיכון שאינו גבוה; עד 10 שנים בסיכון גבוה. אסור ב-eGFR ≤35	5 שנות טיפול ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. eGFR <35 ← ערך חמור	הנחיה	ACOG 2023 (סיכום AFP) עמ' 101-102
כללי-12	תרופות כרוניות נוספות (2)	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	בזאפיברט, גבפנטין, פרגבלין, SSRI/SNRI (נתרן בגיל 65+), מעכבי ארומטאז, טמוקסיפן, רלוקסיפן, טרבינפין ואיטרקונזול (קורס): לפי הרשימה של כל תרופה	החלטה מקומית (הצעה)	-
כללי-13	חידוש ע"י רופא/ה בלבד	-	רואקוטן (רופא/ת עור בלבד), ממריצים, אופיואידים ובנזודיאזפינים: הכלי מציג הודעה ולא רשימת בדיקות	החלטה מקומית	-
כללי-16	ברזל, B12, חומצה פולית	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	ברזל: ספירת דם ופריטין מ-6 חודשים; טיפול מעל 6 חודשים בלי התוויה ← הודעה. B12: רמה שנתית	החלטה מקומית (הצעה)	-
כללי-19	תרופות מומחה	-	אריתרופויאטין, קושרי זרחן ואשלגן, HIV, הפטיטיס B, ציקלוספורין/טקרולימוס, אפרמילסט ואציטרטין: הודעה בלבד, חידוש ע"י רופא/ה	החלטה מקומית	-
כללי-20	השלמות מהמאגר (2.11.2026)	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	טרזוסין, פינסטריד, אינקליסירן, ורדנאפיל, טיפות לגלאוקומה (ביקורת עיניים שנתית; טימולול: דופק ואסתמה), NSAID ממושך (כליות, אשלגן, ל"ד, דימום, הגנת קיבה), אנטיהיסטמינים, ציננריזין, דומפרידון, מבברין, סידן, מידודרין, פנטוקסיפילין, דיפירידמול, ולציקלוביר מונע, חומצה זולדרונית	החלטה מקומית (הצעה)	-
כללי-22	השלמות 2 מהמאגר (2.11.2026)	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	ויטמין D, בטאהיסטין, חומצה במפדואית, אומגה 3/איקוזפנט, ציפרופיברט, וריסיגואט, ניטרוגליצרין תת-לשוני, פזולינטנט/אלינזנטנט (ALT), דואביב, אינטראזוסה, סיאנה, אורליסטט, פרוקלופריד, משלשלים, טטרציקלינים ממושכים, מניעת זיהומי שתן, משככי כאב ממושכים, ביקרבונט. רופא/ה בלבד: פנטרמין, בונות עצם, הפרינים, תרופות עצם בכליות, אנלוגי סומטוסטטין, הפטיטיס C/D, מחלות נדירות	החלטה מקומית (הצעה)	-
מעקב-8	מתוטרקסט	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	ספירת דם, ALT וקריאטינין מ-3 החודשים האחרונים; מינון שבועי מתועד; ללא טרימתופרים. היריון ← התווית נגד	החלטה מקומית (הצעה)	-
מעקב-12	תרופות למעקב צמוד נוספות	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	מתימזול/PTU, לפלונומיד, אזתיופרין, סולפסלזין, מיקופנולט, מעכבי JAK, הידרוקסיאוריאה, הידרוקסיכלורוקווין, נוגדי פסיכוזה, טסטוסטרון, סטרואידים כרוניים, ניטרופורנטואין, קולכיצין, דנוסומאב, טריפרטייד: בדיקות לפי התרופה; חריגה ← חודש + הודעה; ערך חמור ← לא מחדשים	החלטה מקומית (הצעה)	-

9.ה רשימת התרופות (לסימון)

#	שם	גנרי	קבוצה	התאמה	אושר	הערות
9.1	אלופורינול	Allopurinol	שיגדון · מעכב קסנטין אוקסידאז	מתאים	☐	
9.2	פבוקסוסטט	Febuxostat	שיגדון · מעכב קסנטין אוקסידאז	בתנאים	☐	
9.3	אלנדרונט	Alendronate	אוסטאופורוזיס · ביספוספונט	בתנאים	☐	
9.4	ריזדרונט	Risedronate	אוסטאופורוזיס · ביספוספונט	בתנאים	☐	
9.5	רלוקסיפן	Raloxifene	אוסטאופורוזיס · SERM	בתנאים	☐	
9.6	אופיואידים	Opioids	משככי כאב אופיואידים	הכנה לאישור רופא/ה	☐	

#	שם	גנרי	קבוצה	התאמה	אושר	הערות
9.7	אפרמילסט	Apremilast	מעכב PDE4	רופא/ה בלבד	☐	
9.8	חומצה זולדרונית (אוסטאופורוזיס)	Zoledronic acid (osteoporosis)	ביספוספונט לעירוי (פעם בשנה)	בתנאים	☐	
9.9	פרצטמול / דיפירון (טיפול ממושך)	Paracetamol / dipyrone (chronic)	משככי כאב	מתאים	☐	
9.10	תרופות בונות עצם במעקב מומחה	Osteoanabolic (specialist)	אוסטאופורוזיס - מומחה	רופא/ה בלבד	☐	
9.11	מתוטרקסט פומי	Methotrexate (oral)	אנטי-מטבוליט (מינון שבועי)	בתנאים ⚗	☐	
9.12	לפלונומיד	Leflunomide	DMARD	בתנאים ⚗	☐	
9.13	סולפסלזין	Sulfasalazine	DMARD / IBD	בתנאים ⚗	☐	
9.14	טופסיטיניב	Tofacitinib	מעכב JAK	בתנאים ⚗	☐	
9.15	בריסיטיניב	Baricitinib	מעכב JAK	בתנאים ⚗	☐	
9.16	אופדסיטיניב	Upadacitinib	מעכב JAK	בתנאים ⚗	☐	
9.17	הידרוקסיכלורוקווין	Hydroxychloroquine	נוגד מלריה / DMARD	מתאים ⚗	☐	
9.18	קולכיצין (טיפול כרוני)	Colchicine (chronic)	נוגד דלקת	בתנאים ⚗	☐	
9.19	דנוסומאב (אוסטאופורוזיס)	Denosumab (osteoporosis)	נוגדן RANKL (זריקה כל 6 חודשים)	בתנאים ⚗	☐	
9.20	טריפרטייד	Teriparatide	אנלוג PTH (זריקה יומית)	בתנאים ⚗	☐	

9.ו פירוט מלא

9.1 **אלופורינול** · Allopurinol מתאים

שיגדון · מעכב קסנטין אוקסידאז

שמות מסחריים (2)	אלוריל · Alloril | זילוריק · Zyloric (לאימות מול מאגר משרד הבריאות)
נימוק / הערה	יעד חומצה אורית; פריחה ← הפסקה ודחוף

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	חומצה אורית מתועדת	בדיקה מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	חומצה אורית ביעד	מתחת ל-6 מ"ג/ד"ל. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
6	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <30 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
11	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): פריחה או תגובה עורית לתרופה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	חומצה אורית וקריאטינין שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <30 (לבדיקת מינון)
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	פריחה או תגובה עורית לתרופה
תלונות בפנייה או ברשומה	פריחה בעור ← הפסקה, דחוף; התקפי גאוט חוזרים ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

9.2 פבוקסוסטט · Febuxostat בתנאים

שיגדון · מעכב קסנטין אוקסידאז

שמות מסחריים (1)	פבאוריק · Feburic
נימוק / הערה	רק טיפול כרוני קבוע. קו שני; אזהרה במחלת לב

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	חומצה אורית מתועדת	בדיקה מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	חומצה אורית ביעד	מתחת ל-6 מ"ג/ד"ל. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
6	טיפול כרוני	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
11	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): פריחה או תגובה עורית לתרופה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	חומצה אורית וקריאטינין שנתי
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	פריחה או תגובה עורית לתרופה
תלונות בפנייה או ברשומה	פריחה בעור ← הפסקה, דחוף; התקפי גאוט חוזרים ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

9.3 **אלנדרונט** · Alendronate בתנאים

אוסטאופורוזיס · ביספוספונט

שמות מסחריים (4)	פוסאלאן · Fosalan | מקסיבון · Maxibone | בינוסטו · Binosto | פוסאוונס · Fosavance
נימוק / הערה	רק טיפול כרוני קבוע. עד 5 שנות טיפול; אחר כך החלטת רופא על הפסקה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	משך טיפול פחות מ-5 שנים	משך הטיפול בביספוספונט פחות מ-5 שנים. 5 שנים ומעלה ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה לשקול הפסקה זמנית.	
2	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, סידן. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
5	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חמור: eGFR <35 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התוויות נגד
6	טיפול כרוני	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
11	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): סידן נמוך; מחלת ושט פעילה או קושי להישאר זקוף 30 דקות. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התוויות נגד

מעקב מעבדה	קריאטינין וסידן שנתי
ערך חמור	eGFR <35
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	סידן נמוך; מחלת ושט פעילה או קושי להישאר זקוף 30 דקות
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב בבליעה או צרבת חדשה ← לרופא; כאב בירך או במפשעה ← לרופא; כאב או חשיפת עצם בלסת ← לרופא
מקור	ACOG 2023 (סיכום AFP) עמ' 101-102

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

9.4 ריזדרונט · Risedronate בתנאים

אוסטאופורוזיס · ביספוספונט

שמות מסחריים (2)	ריבון · Ribone | ריזדרונייט אס.קיי. · Risedronate S.K.
נימוק / הערה	רק טיפול כרוני קבוע. עד 5 שנות טיפול; אחר כך החלטת רופא על הפסקה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	משך טיפול פחות מ-5 שנים	משך הטיפול בביספוספונט פחות מ-5 שנים. 5 שנים ומעלה ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה לשקול הפסקה זמנית.	
2	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	בדיקות שנתיות	בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, סידן. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות.	זימון
5	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חמור: eGFR <35 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד
6	טיפול כרוני	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
11	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): סידן נמוך; מחלת ושט פעילה או קושי להישאר זקוף 30 דקות. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	קריאטינין וסידן שנתי
ערך חמור	eGFR <35
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	סידן נמוך; מחלת ושט פעילה או קושי להישאר זקוף 30 דקות
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב בבליעה או צרבת חדשה ← לרופא; כאב בירך או במפשעה ← לרופא; כאב או חשיפת עצם בלסת ← לרופא
מקור	ACOG 2023 (סיכום AFP) עמ' 101-102

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

9.5 רלוקסיפן · Raloxifene בתנאים

אוסטאופורוזיס · SERM

שמות מסחריים (1)	ראלוקסיפן טבע · Raloxifene Teva
נימוק / הערה	אסור באירוע תרומבואמבולי בעבר

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
3	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
4	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
5	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
6	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
7	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
8	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): פקקת ורידים או תסחיף ריאתי בעבר; שבץ או אירוע מוחי חולף בעבר. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	פקקת ורידים או תסחיף ריאתי בעבר; שבץ או אירוע מוחי חולף בעבר
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב ונפיחות ברגל ← דחוף; גלי חום ← לרופא
מקור	ACOG 2023 (סיכום AFP) עמ' 102

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

9.6 **אופיואידים** · Opioids הכנה לאישור רופא/ה

משככי כאב אופיואידים

שמות מסחריים (29)	אוקסיקונטין · OxyContin	מ.י.ר. · M.I.R.	מ.סי.ר · MCR · טרמדקס · Tramadex	טרמל · Tramal	בוטרנס · Butrans	סובוטקס · Subutex	סובוקסון · Suboxone	בובידל · Buvidal	מתדון · Methadone	טרגין · Targin	פרקוסט · Percocet	אוקסיקוד · Oxycod	אוקסין-אבניר · Oxyn-Avenir	פנטה · Fenta	פנטאדול · Fentadol	אורמורפ · Oramorph	דרופיזול · Dropizol	רוקסט · Rokacet	רוקסט פלוס · Rokacet Plus	קוד-אקמול · Cod-Acamol	קודיקל · Codical	רקוד · Rekod	נורופן פלוס · Nurofen Plus	טרמדקס או.די · Tramadex OD	טרמדקס פלאשטב · Tramadex Flashtab	טרמל רטרד · Tramal Retard	טרמדול מדוכמי · Tramadol Medochemie	הידרומורפון קלצקס · Hydromorphone Kalceks
נימוק / הערה	אופיואיד: הרפואן בודק אבחנת כאב, התאמה לתרופה ומרווח זמן, ומכין סיכום. האישור הסופי בידי הרופא/ה.

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אבחנת כאב מתועדת	אבחנת כאב ברשימת האבחנות הקבועות או בביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	האבחנה מתאימה לתרופה	האבחנה מצדיקה את האופיואיד ואת המינון (למשל כאב סרטני, כאב גב כרוני). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	האבחנה מצורפת למרשם	אבחנת הכאב מצורפת למרשם עצמו. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	עברו כ-3 חודשים מהמרשם הקודם	תרופה עם פוטנציאל התמכרות: בקשה לפני שעברו כ-3 חודשים, או רכישות מעבר לכמות שנרשמה ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	

תלונות בפנייה או ברשומה	ישנוניות, בלבול או נשימה איטית ← דחוף; עצירות קשה ← לרופא; בקשה מוקדמת או אובדן מרשם ← לרופא
מקור	החלטה מקומית (3.11.2026)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

9.7 **אפרמילסט** · Apremilast רופא/ה בלבד

מעכב PDE4

שמות מסחריים (3)	אוטזלה · Otezla	אפרמיל · Apremil	אפרמילסט סנדוז · Apremilast Sandoz
נימוק / הערה	נקבע ע"י רופא/ת עור או ראומטולוג/ית. חידוש ע"י רופא/ה (ירידה במשקל, דיכאון).
הנחיה	**נקבע ע"י רופא/ת עור או ראומטולוג/ית. חידוש ע"י רופא/ה (ירידה במשקל, דיכאון).**

מקור	-

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

9.8 **חומצה זולדרונית (אוסטאופורוזיס)** · Zoledronic acid (osteoporosis) בתנאים

ביספוספונט לעירוי (פעם בשנה)

שמות מסחריים (3)	אקלסטה · Aclasta | חומצה זולדרונית תרו · Zoledronic Acid Taro | חומצה זולדרונית פרזניוס · Zoledronic Acid Fresenius
נימוק / הערה	קריאטינין וסידן לפני כל עירוי; אחרי 3 עירויים - הערכה מחדש

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	קריאטינין וסידן מתועדים	קריאטינין/eGFR וסידן מהחודש שלפני העירוי. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <45 (לבדיקה) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <35 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <35 ← לא מחדשים	
3	סידן לא נמוך	סידן בטווח המעבדה (סידן נמוך = לא נותנים). לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה.	התווית נגד
4	פחות מ-3 עירויים	פחות מ-3 עירויים מאז ההחלטה האחרונה של הרופא/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ה. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	קריאטינין, סידן וויטמין D לפני כל מנה
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <45 (לבדיקה)
ערך חמור	eGFR <35
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב או חשיפת עצם בלסת ← לרופא; כאב בירך או במפשעה ← לרופא
מקור	ACOG 2023 (סיכום AFP) עמ' 101-102

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

9.9 **פרצטמול / דיפירון (טיפול ממושך)** · Paracetamol / dipyrone (chronic) מתאים

משככי כאב

שמות מסחריים (6)	אקמול · Acamol	אברול · Abrol	אופטלגין · Optalgin	אופטלגין טבע · Optalgin Teva	דולרגין · Dulergin	וי-דלגין · V-Dalgin
נימוק / הערה	פרצטמול: עד 3 גרם ביום (2 גרם במחלת כבד או אלכוהול). דיפירון: אגרנולוציטוזיס נדירה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין חום או כאב גרון (דיפירון)	ברשומה או בפנייה אין חום, כאב גרון או פצעים בפה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
2	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
5	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
6	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
7	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה שגרתי
תלונות בפנייה או ברשומה	חום, כאב גרון או פצעים בפה (דיפירון) ← דחוף - ספירת דם; צהבת ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

9.10 **תרופות בונות עצם במעקב מומחה** · Osteoanabolic (specialist) רופא/ה בלבד

אוסטאופורוזיס - מומחה

שמות מסחריים (2)	איבניטי · Evenity	אלדינוס · Eladynos
נימוק / הערה	רומוסוזומאב ואבלופרטייד נקבעים ע"י מומחה/ית לעצם, במסגרת קורס מוגבל. להעביר לרופא/ה.
הנחיה	**רומוסוזומאב ואבלופרטייד נקבעים ע"י מומחה/ית לעצם, במסגרת קורס מוגבל. להעביר לרופא/ה.**

מקור	-

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

9.11 מתוטרקסט פומי · Methotrexate (oral) בתנאים מעקב מעבדה צמוד

אנטי-מטבוליט (מינון שבועי)

שמות מסחריים (2)	מתוטרקסאט אבווה · Methotrexat Ebewe | מטוטרקס · Metotrex
נימוק / הערה	נקבע ע"י ראומטולוג/ית או רופא/ת עור. מינון שבועי בלבד. התווית נגד בהיריון

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	בדיקות מ-3 החודשים האחרונים	ספירת דם, ALT וקריאטינין מ-3 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה	בבדיקה האחרונה ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה. חריג: WBC מתחת ל-3,500 או טסיות מתחת ל-150,000 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-100,000 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-100,000 ← לא מחדשים	
3	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <60 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים	
4	תפקודי כבד (ALT) תקין	בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 2 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים	
5	מינון שבועי מתועד	המרשם מנוסח כמינון פעם בשבוע, ביום קבוע, עם חומצה פולית. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
6	אין טרימתופרים	ברשימת התרופות אין טרימתופרים/ספטרין שנוסף. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
7	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
8	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
9	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ה מומחה/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
10	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
11	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
12	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
13	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
14	אין התווית נגד	אין התווית נגד: היריון או תכנון היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	ספירת דם, ALT וקריאטינין כל 3 חודשים
ספי החזרה לרופא/ה	WBC מתחת ל-3,500 או טסיות מתחת ל-150,000; ALT מעל פי 2 מהגבול העליון; eGFR <60
ערך חמור	WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-100,000; ALT מעל פי 3 מהגבול העליון; eGFR <30
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון
תלונות בפנייה או ברשומה	פצעים בפה, חום או כאב גרון ← דחוף - ספירת דם; שיעול או קוצר נשימה חדשים ← דחוף; בחילות ממושכות ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

9.12 **לפלונומיד** · Leflunomide בתנאים מעקב מעבדה צמוד

DMARD

שמות מסחריים (1)	ערבה · Arava
נימוק / הערה	נקבע ע"י ראומטולוג/ית. התווית נגד בהיריון

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	בדיקות מ-3 החודשים האחרונים	ספירת דם, ALT ומדידת ל"ד מ-3 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה	בבדיקה האחרונה ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה. חריג: WBC מתחת ל-3,500 או טסיות מתחת ל-150,000 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-100,000 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-100,000 ← לא מחדשים	
3	תפקודי כבד (ALT) תקין	בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 2 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים	
4	ל"ד מתחת ל-140/90	מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	אין חום או זיהום מתועד	ברשומה או בפנייה אין חום, כאב גרון, פצעים בפה או זיהום. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
6	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
7	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
8	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ה מומחה/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
9	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 OP = 2 אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
10	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
11	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
12	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
13	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	ספירת דם, ALT ול"ד כל 3 חודשים
ספי החזרה לרופא/ה	WBC מתחת ל-3,500 או טסיות מתחת ל-150,000; ALT מעל פי 2 מהגבול העליון
ערך חמור	WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-100,000; ALT מעל פי 3 מהגבול העליון
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון
תלונות בפנייה או ברשומה	חום או זיהום ← דחוף; שיעול או קוצר נשימה חדשים ← דחוף; שלשולים מתמשכים ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

9.13 סולפסלזין · Sulfasalazine בתנאים מעקב מעבדה צמוד

DMARD / IBD

שמות מסחריים (2)	סלאזופירין · Salazopyrin | סלאזופירין אי.אן. · Salazopyrin EN
נימוק / הערה	ספירת דם ו-ALT

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	בדיקות מתועדות	ספירת דם ו-ALT מ-3 החודשים האחרונים (אחרי שנת טיפול: מ-6 החודשים האחרונים). אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה	בבדיקה האחרונה ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה. חריג: WBC מתחת ל-3,500 או טסיות מתחת ל-150,000 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-100,000 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-100,000 ← לא מחדשים	
3	תפקודי כבד (ALT) תקין	בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 2 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים	
4	אין חום או זיהום מתועד	ברשומה או בפנייה אין חום, כאב גרון, פצעים בפה או זיהום. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ה מומחה/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	ספירת דם ו-ALT כל 3 חודשים בשנה הראשונה, אחר כך כל 6 חודשים
ספי החזרה לרופא/ה	WBC מתחת ל-3,500 או טסיות מתחת ל-150,000; ALT מעל פי 2 מהגבול העליון
ערך חמור	WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-100,000; ALT מעל פי 3 מהגבול העליון
תלונות בפנייה או ברשומה	חום, כאב גרון או פריחה ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

9.14 טופסיטיניב · Tofacitinib בתנאים מעקב מעבדה צמוד

מעכב JAK

שמות מסחריים (4)	קסלג'אנז · Xeljanz	קסלג'אנז XR · Xeljanz XR	טופסיטיניב תרו · Tofacitinib Taro	טופסיטיניב טבע · Tofacitinib Teva
נימוק / הערה	נקבע ע"י ראומטולוג/ית, גסטרואנטרולוג/ית או רופא/ת עור. סיכון לזיהומים, פקקת ואירועי לב

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	בדיקות מתועדות	ספירת דם ו-ALT מ-3 החודשים האחרונים; שומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה	בבדיקה האחרונה ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה. חריג: WBC מתחת ל-3,500 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: WBC מתחת ל-2,000 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: WBC מתחת ל-2,000 ← לא מחדשים	
3	המוגלובין (Hb) תקין	בבדיקה האחרונה המוגלובין (Hb) תקין. חריג: Hb מתחת ל-9 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: Hb מתחת ל-8 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: Hb מתחת ל-8 ← לא מחדשים	
4	תפקודי כבד (ALT) תקין	בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 2 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים	
5	אין חום או זיהום מתועד	ברשומה או בפנייה אין חום, כאב גרון, פצעים בפה או זיהום (כולל שלבקת חוגרת). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
6	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
7	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
8	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ה מומחה/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
9	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
10	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
11	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
12	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
13	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי בעבר. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	ספירת דם ו-ALT כל 3 חודשים; שומנים שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	WBC מתחת ל-3,500; Hb מתחת ל-9; ALT מעל פי 2 מהגבול העליון
ערך חמור	WBC מתחת ל-2,000; Hb מתחת ל-8; ALT מעל פי 3 מהגבול העליון
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי בעבר
תלונות בפנייה או ברשומה	חום או זיהום ← דחוף; כאב ונפיחות ברגל או קוצר נשימה (חשד לפקקת) ← דחוף; פריחה שלפוחיתית (שלבקת) ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

9.15 בריסיטיניב · Baricitinib

בתנאים | מעקב מעבדה צמוד

מעכב JAK

שמות מסחריים (1)	אולומיאנט · Olumiant
נימוק / הערה	נקבע ע"י ראומטולוג/ית, גסטרואנטרולוג/ית או רופא/ת עור. סיכון לזיהומים, פקקת ואירועי לב

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	בדיקות מתועדות	ספירת דם ו-ALT מ-3 החודשים האחרונים; שומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה	בבדיקה האחרונה ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה. חריג: WBC מתחת ל-3,500 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: WBC מתחת ל-2,000 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: WBC מתחת ל-2,000 ← לא מחדשים	
3	המוגלובין (Hb) תקין	בבדיקה האחרונה המוגלובין (Hb) תקין. חריג: Hb מתחת ל-9 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: Hb מתחת ל-8 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: Hb מתחת ל-8 ← לא מחדשים	
4	תפקודי כבד (ALT) תקין	בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 2 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים	
5	אין חום או זיהום מתועד	ברשומה או בפנייה אין חום, כאב גרון, פצעים בפה או זיהום (כולל שלבקת חוגרת). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
6	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
7	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
8	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ה מומחה/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
9	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
10	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
11	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
12	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
13	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי בעבר. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	ספירת דם ו-ALT כל 3 חודשים; שומנים שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	WBC מתחת ל-3,500; Hb מתחת ל-9; ALT מעל פי 2 מהגבול העליון
ערך חמור	WBC מתחת ל-2,000; Hb מתחת ל-8; ALT מעל פי 3 מהגבול העליון
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי בעבר
תלונות בפנייה או ברשומה	חום או זיהום ← דחוף; כאב ונפיחות ברגל או קוצר נשימה (חשד לפקקת) ← דחוף; פריחה שלפוחיתית (שלבקת) ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

9.16 אופדסיטיניב · Upadacitinib בתנאים מעקב מעבדה צמוד

מעכב JAK

שמות מסחריים (1)	רינבוק · Rinvoq
נימוק / הערה	נקבע ע"י ראומטולוג/ית, גסטרואנטרולוג/ית או רופא/ת עור. סיכון לזיהומים, פקקת ואירועי לב

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	בדיקות מתועדות	ספירת דם ו-ALT מ-3 החודשים האחרונים; שומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה	בבדיקה האחרונה ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה. חריג: WBC מתחת ל-3,500 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: WBC מתחת ל-2,000 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: WBC מתחת ל-2,000 ← לא מחדשים	
3	המוגלובין (Hb) תקין	בבדיקה האחרונה המוגלובין (Hb) תקין. חריג: Hb מתחת ל-9 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: Hb מתחת ל-8 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: Hb מתחת ל-8 ← לא מחדשים	
4	תפקודי כבד (ALT) תקין	בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 2 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים	
5	אין חום או זיהום מתועד	ברשומה או בפנייה אין חום, כאב גרון, פצעים בפה או זיהום (כולל שלבקת חוגרת). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
6	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
7	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
8	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ה מומחה/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
9	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
10	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
11	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
12	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
13	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי בעבר. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	ספירת דם ו-ALT כל 3 חודשים; שומנים שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	WBC מתחת ל-3,500; Hb מתחת ל-9; ALT מעל פי 2 מהגבול העליון
ערך חמור	WBC מתחת ל-2,000; Hb מתחת ל-8; ALT מעל פי 3 מהגבול העליון
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי בעבר
תלונות בפנייה או ברשומה	חום או זיהום ← דחוף; כאב ונפיחות ברגל או קוצר נשימה (חשד לפקקת) ← דחוף; פריחה שלפוחיתית (שלבקת) ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

9.17 הידרוקסיכלורוקווין · Hydroxychloroquine מתאים מעקב מעבדה צמוד

נוגד מלריה / DMARD

שמות מסחריים (1)	פלקווניל · Plaquenil
נימוק / הערה	בדיקת עיניים שנתית אחרי 5 שנות טיפול (או מההתחלה בסיכון גבוה)

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	בדיקת עיניים מ-12 החודשים האחרונים שאלה: הטיפול נמשך 5 שנים ומעלה, או שיש eGFR <60 או טמוקסיפן?	בדיקת עיניים (OCT ושדה ראייה) מ-12 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
2	קריאטינין מתועד	קריאטינין/eGFR מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
3	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <60 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
4	אין שינוי בראייה מתועד	ברשומה או בפנייה אין ירידה או שינוי בראייה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	בדיקת עיניים (OCT ושדה ראייה) שנתית; קריאטינין שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <60 (לבדיקת מינון)
תלונות בפנייה או ברשומה	ירידה או שינוי בראייה ← דחוף - רופא/ת עיניים; פריחה ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

9.18 קולכיצין (טיפול כרוני) · Colchicine (chronic) בתנאים מעקב מעבדה צמוד

נוגד דלקת

שמות מסחריים (1)	קולכיצין · Colchicine
נימוק / הערה	מינון לפי כליות; אינטראקציות מסוכנות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	קריאטינין מתועד	קריאטינין/eGFR מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <60 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים	
3	אין תרופה חדשה עם אינטראקציה	ברשימת התרופות אין קלריתרומיצין, ורפמיל, דילטיאזם, ציקלוספורין או נוגד פטרת אזולי. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	קריאטינין שנתי
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <60 (לבדיקת מינון)
ערך חמור	eGFR <30
תלונות בפנייה או ברשומה	שלשולים או הקאות ← לרופא; כאבי שרירים או חולשה ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

9.19 דנוסומאב (אוסטאופורוזיס) · Denosumab (osteoporosis) בתנאים מעקב מעבדה צמוד

נוגדן RANKL (זריקה כל 6 חודשים)

שמות מסחריים (2)	פרוליה · Prolia | ג'ובונטי · Jubbonti
נימוק / הערה	אסור לדחות מנה או להפסיק ללא ביספוספונט (עלייה חדה בשברים). סידן לפני כל מנה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	סידן וקריאטינין מתועדים	מהחודש שלפני המנה. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	סידן בטווח	סידן בטווח המעבדה (סידן נמוך = התווית נגד). לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה.	התווית נגד
3	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <30 (סיכון לסידן נמוך) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
4	המנה בזמן	המנה הקודמת ניתנה לפני כ-6 חודשים, לא באיחור של יותר מחודש. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני שנקבע ע"י רופא/ה. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	סידן וקריאטינין לפני כל מנה
ספי החזרה לרופא/ה	eGFR <30 (סיכון לסידן נמוך)
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב או חשיפת עצם בלסת ← לרופא; כאב בירך או במפשעה ← לרופא; עוויתות או נימול (סידן נמוך) ← דחוף
מקור	ACOG 2023 (סיכום AFP) עמ' 101

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

9.20 טריפרטייד · Teriparatide בתנאים מעקב מעבדה צמוד

אנלוג PTH (זריקה יומית)

שמות מסחריים (4)	פורטאו · Forteo | טרוזה · Terrosa | טריפראטייד טבע · Teriparatide Teva | טריפראטייד קמהדע · Teriparatide Kamada
נימוק / הערה	נקבע ע"י רופא/ה מומחה/ית. עד 24 חודשים בחיים, ואחר כך תרופה אנטי-רזורבטיבית

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	פחות מ-24 חודשי טיפול	משך הטיפול הכולל בחיים פחות מ-24 חודשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
2	סידן מתועד	סידן מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
3	סידן בטווח	סידן בטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ה מומחה/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 OP = 2 אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
11	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): סרטן עצם או גרורות בעצם; הקרנות לשלד; מחלת פאג'ט. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	סידן שנתי
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	סרטן עצם או גרורות בעצם; הקרנות לשלד; מחלת פאג'ט
תלונות בפנייה או ברשומה	סחרחורת אחרי הזריקה ← לרופא; עוויתות שרירים ← לרופא
מקור	ACOG 2023 (סיכום AFP) עמ' 102

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

10. דם וויטמינים

7 תרופות · מתאים: 5 · רופא/ה בלבד: 1 · בתנאים: 1 · גרסה 2 · חלוקה לפי מערכות · 2.11.2026

מקורות: הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020; ACOG 2023 (סיכום AFP). שאר התחומים: החלטה מקומית; עלון לצרכן לפונקס (עודכן 12/2020). שאר התרופות: החלטה מקומית

10.א כללים

- חידוש רגיל: 3 חודשים
- ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה פעם בשנה
- עד 3 חידושים רצופים, ואז ביקור רופא
- אין התווית נגד ← תמיד מחדשים לפחות לחודש אחד
- חסרה מדידה, בדיקה או ביקורת שנתית: חידוש לחודש אחד + זימון למרפאה
- חריגה מספי ההחזרה: חידוש לחודש אחד + הודעה לרופא/ה
- התווית נגד או ערך חמור: לא מחדשים, הודעה לרופא/ה (הסף של כל תרופה מופיע ברשימה שלה)
- רפואן לא משנה מינון ולא מחליף תרופה. "מעקב מעבדה צמוד" = תרופה עם בדיקות תכופות — לבדוק בקפידה
- ברזל מעל 6 חודשים בלי התוויה מתועדת ← הודעה

10.ג בדיקות משותפות

שלב	נושא	מה בודקים	קריטריון	אם לא מתקיים	מקור
לפני כל חידוש	בדיקת מעקב	לפי התרופה	שומנים: LDL; לבותירוקסין: TSH; אלופורינול/פבוקוסוסטט: חומצה אורית — מ-12 החודשים האחרונים	אין ← חידוש לחודש + זימון לבדיקה	הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52; החלטה כללי-1
לפני כל חידוש	ערך המעקב	לעומת הבדיקה הקודמת או היעד	LDL לא עלה ב-30% ומעלה; TSH בטווח המעבדה; חומצה אורית מתחת ל-6	לא ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה	החלטות כללי-2-4
לפני כל חידוש	רכישות	כיסוי ימים ב-6 החודשים האחרונים	80% מהימים ומעלה	פחות ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה	כמו ביל"ד
לפני כל חידוש	ביקורת שנתית	ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה	ב-12 החודשים האחרונים	אין ← חידוש לחודש + זימון לביקורת	כמו ביל"ד
לפני כל חידוש	רצף חידושים	כמה חידושים רצופים מאז ביקור רופא	פחות מ-3	3 ← ביקור רופא	כמו ביל"ד

10.ד החלטות

#	נושא	מה ההנחיה אומרת	ההחלטה לפרוטוקול	סוג	מקור
כללי-1	בדיקות מעקב	שומנים: פרופיל כל 6-12 חודשים אחרי השגת היעד. TSH וחומצה אורית: לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	TSH, LDL וחומצה אורית מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש + זימון	החלטה מקומית (הצעה)	הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52
כללי-7	אלופורינול ופבוקוסוסטט	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	חומצה אורית ≥6 ← הודעה. אלופורינול: eGFR <30 ← הודעה (מינון). פריחה ← התווית נגד, דחוף	החלטה מקומית (הצעה)	-
כללי-16	ברזל, B12, חומצה פולית	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	ברזל: ספירת דם ופריטין מ-6 חודשים; טיפול מעל 6 חודשים בלי התוויה ← הודעה. B12: רמה שנתית	החלטה מקומית (הצעה)	-
כללי-18	גסטרו ואנדוקרינולוגיה	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	מסאלזין: קריאטינין שנתי. הידרוקורטיזון: לא נעצר, הנחיות מחלה. אלפקלצידול וסינקלצט: סידן. דסמופרסין: נתרן	החלטה מקומית (הצעה)	-

#	נושא	מה ההנחיה אומרת	ההחלטה לפרוטוקול	סוג	מקור
כללי-20	השלמות מהמאגר (2.11.2026)	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	טרזוסין, פינסטריד, אינקליסירן, ורדנאפיל, טיפות לגלאוקומה (ביקורת עיניים שנתית; טימולול: דופק ואסתמה), NSAID ממושך (כליות, אשלגן, ל"ד, דימום, הגנת קיבה), אנטיהיסטמינים, ציננריזין, דומפרידון, מבברין, סידן, מידודרין, פנטוקסיפילין, דיפירידמול, ולציקלוביר מונע, חומצה זולדרונית	החלטה מקומית (הצעה)	-
כללי-22	השלמות 2 מהמאגר (2.11.2026)	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	ויטמין D, בטאהיסטין, חומצה במפדואית, אומגה 3/איקוזפנט, ציפרופיברט, וריסיגואט, ניטרוגליצרין תת-לשוני, פזולינטנט/אלינזנטנט (ALT), דואביב, אינטראזוסה, סיאנה, אורליסטט, פרוקלופריד, משלשלים, טטרציקלינים ממושכים, מניעת זיהומי שתן, משככי כאב ממושכים, ביקרבונט. רופא/ה בלבד: פנטרמין, בונות עצם, הפרינים, תרופות עצם בכליות, אנלוגי סומטוסטטין, הפטיטיס C/D, מחלות נדירות	החלטה מקומית (הצעה)	-
מעקב-1	ליתיום: תדירות	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	רמה, קריאטינין/eGFR, נתרן, TSH וסידן מ-6 החודשים האחרונים	החלטה מקומית (הצעה)	-
מעקב-12	תרופות למעקב צמוד נוספות	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	מתימזול/PTU, לפלונומיד, אזתיופרין, סולפסלזין, מיקופנולט, מעכבי JAK, הידרוקסיאוריאה, הידרוקסיכלורוקווין, נוגדי פסיכוזה, טסטוסטרון, סטרואידים כרוניים, ניטרופורנטואין, קולכיצין, דנוסומאב, טריפרטייד: בדיקות לפי התרופה; חריגה ← חודש + הודעה; ערך חמור ← לא מחדשים	החלטה מקומית (הצעה)	-

10.ה רשימת התרופות (לסימון)

#	שם	גנרי	קבוצה	התאמה	אושר	הערות
10.1	ברזל (בבליעה)	Iron (oral)	תוסף ברזל	מתאים	☐	
10.2	ויטמין B12	Vitamin B12	ויטמין	מתאים	☐	
10.3	חומצה פולית	Folic acid	ויטמין	מתאים	☐	
10.4	סידן (בבליעה)	Calcium (oral)	תוסף סידן	מתאים	☐	
10.5	תרופות המטולוגיות במעקב מומחה	Haematology specialist drugs	המטולוגיה	רופא/ה בלבד	☐	
10.6	ויטמין D	Vitamin D	ויטמין	מתאים	☐	
10.7	הידרוקסיאוריאה	Hydroxyurea	מעכב מח עצם	בתנאים ⚗	☐	

10.ו פירוט מלא

10.1 **ברזל (בבליעה)** · Iron (oral) מתאים

תוסף ברזל

שמות מסחריים (7)	תרדיפרון · Tardyferon | פרו 15 סירופ · Ferro 15 Syrup | פרוקל · Ferrocal | פריפול · Ferrifol (עם חומצה פולית) | פולקס · Folex (עם חומצה פולית) | פולירון · Foliron (עם חומצה פולית) | איירון קאר · Iron Care
נימוק / הערה	חוסר ברזל: טיפול עד 3 חודשים אחרי תיקון ההמוגלובין. טיפול ממושך ← לברר את הסיבה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	ספירת דם ופריטין מתועדים	ספירת דם ופריטין מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	Hb לא ירד	המוגלובין לא ירד לעומת הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	משך מתאים	פחות מ-6 חודשי טיפול, או התוויה כרונית מתועדת (למשל דימום וסתי, ניתוח בריאטרי). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
7	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
8	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
9	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	ספירת דם ופריטין כל 3-6 חודשים
תלונות בפנייה או ברשומה	צואה שחורה או דם בצואה ← דחוף; כאבי בטן או עצירות ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

10.2 ויטמין B12 · Vitamin B12 מתאים

ויטמין

שמות מסחריים (2)	ויטמין בי 12 סטרופ · Vitamine B12 Sterop (זריקה) | טריבמין · Tribemin (B1+B6+B12)
נימוק / הערה	תוספים בבליעה רבים אינם תרופות רשומות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	רמת B12 מתועדת	רמת B12 מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	רמה בטווח	רמת B12 בטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	רמת B12 שנתית
תלונות בפנייה או ברשומה	נימול בידיים או ברגליים ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

10.3 חומצה פולית · Folic acid מתאים

ויטמין

שמות מסחריים (3)	חומצה פולית · Folic Acid | פולי · Foli | פולקס · Folex (עם ברזל - ראו ברזל)
נימוק / הערה	היריון או תכנון היריון, מתוטרקסט, אנמיה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	התוויה מתועדת	היריון או תכנון היריון, טיפול במתוטרקסט, או אנמיה מתועדת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
5	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
6	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
7	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

10.4 **סידן (בבליעה)** · Calcium (oral) מתאים

תוסף סידן

שמות מסחריים (2)	קלצימור · Calcimore	קלציום-D-סורס · Calcium-D-Source (עם ויטמין D)
נימוק / הערה	לרוב עם טיפול לאוסטאופורוזיס

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
3	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
4	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
5	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
6	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
7	סידן לא גבוה	אם נבדק: סידן לא מעל טווח המעבדה. לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	סידן לפי הצורך
תלונות בפנייה או ברשומה	עצירות ← לרופא; כאב גב חד או דם בשתן (אבנים) ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

10.5 **תרופות המטולוגיות במעקב מומחה** · Haematology specialist drugs רופא/ה בלבד

המטולוגיה

שמות מסחריים (16)	דפרסירוקס תרו · Deferasirox Taro	דפראסירוקס טבע · Deferasirox Teva	דפירוקס · Defirox	אקסג'ייד · Exjade	דפריפרון תרו · Deferiprone Taro	פריפרוקס תמיסה · Ferriprox Oral Solution	פריפרוקס טבליות · Ferriprox	אלטופ · Eltop	אלטרובניר · Eltrovenir	רבולייד · Revolade	אופזורו · Optzuro	אנגריד · Anagrid	ג'קאבי · Jakavi	רוקסובניר · Ruxovenir	רוקסול · Ruxxol	טבליס · Tavalisse
נימוק / הערה	תרופות אלה נקבעות ומנוטרות ע"י ההמטולוג/ית (ספירות ותפקודי כבד). להעביר לרופא/ה.
הנחיה	**תרופות אלה נקבעות ומנוטרות ע"י ההמטולוג/ית (ספירות ותפקודי כבד). להעביר לרופא/ה.**

מקור	-

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

10.6 ויטמין D · Vitamin D מתאים

ויטמין

שמות מסחריים (2)	ויטה די · Vita D	ריאלדי · Rayaldee (קלצידיול)
נימוק / הערה	בטוח במינון רגיל; מינון גבוה ← סידן

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
3	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
4	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
5	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
6	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
7	סידן לא גבוה	אם נבדק: סידן לא מעל טווח המעבדה. לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	רמת ויטמין D לפי הצורך
תלונות בפנייה או ברשומה	צמא, בחילות או בלבול ← לרופא - סידן
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

10.7 הידרוקסיאוריאה · Hydroxyurea בתנאים מעקב מעבדה צמוד

מעכב מח עצם

שמות מסחריים (1)	הידרוקסיאוריאה מדאק · Hydroxyurea Medac
נימוק / הערה	נקבע ע"י המטולוג/ית. התווית נגד בהיריון

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	ספירת דם מ-3 החודשים האחרונים	ספירת דם מ-3 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה	בבדיקה האחרונה ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה. חריג: WBC מתחת ל-3,500 או טסיות מתחת ל-150,000 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-100,000 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-100,000 ← לא מחדשים	
3	המוגלובין (Hb) תקין	בבדיקה האחרונה המוגלובין (Hb) תקין. חריג: Hb מתחת ל-9 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: Hb מתחת ל-8 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: Hb מתחת ל-8 ← לא מחדשים	
4	אין חום או זיהום מתועד	ברשומה או בפנייה אין חום, כאב גרון, פצעים בפה או זיהום. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
7	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י המטולוג/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
8	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
9	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
10	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
11	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
12	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	ספירת דם כל 1-3 חודשים (לפי ההמטולוג/ית)
ספי החזרה לרופא/ה	WBC מתחת ל-3,500 או טסיות מתחת ל-150,000; Hb מתחת ל-9
ערך חמור	WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-100,000; Hb מתחת ל-8
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון
תלונות בפנייה או ברשומה	חום או זיהום ← דחוף; פצעים ברגליים ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

11. עיניים ועור

9 תרופות · מתאים: 2 · רופא/ה בלבד: 2 · בתנאים: 5 · גרסה 2 · חלוקה לפי מערכות · 2.11.2026

מקורות: הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020; ACOG 2023 (סיכום AFP). שאר התחומים: החלטה מקומית

11.א כללים

- חידוש רגיל: 3 חודשים
- ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה פעם בשנה
- עד 3 חידושים רצופים, ואז ביקור רופא
- אין התווית נגד ← תמיד מחדשים לפחות לחודש אחד
- חסרה מדידה, בדיקה או ביקורת שנתית: חידוש לחודש אחד + זימון למרפאה
- חריגה מספי ההחזרה: חידוש לחודש אחד + הודעה לרופא/ה
- התווית נגד או ערך חמור: לא מחדשים, הודעה לרופא/ה (הסף של כל תרופה מופיע ברשימה שלה)
- רפואן לא משנה מינון ולא מחליף תרופה. "מעקב מעבדה צמוד" = תרופה עם בדיקות תכופות — לבדוק בקפידה
- טיפות לגלאוקומה: ביקורת שנתית אצל רופא/ת עיניים; טימולול: דופק ואסתמה
- רואקוטן ואציטרטין: רופא/ת עור בלבד
- נוגדי פטרת וטטרציקלינים: רק בתוך משך הקורס

11.ג בדיקות משותפות

שלב	נושא	מה בודקים	קריטריון	אם לא מתקיים	מקור
לפני כל חידוש	רכישות	כיסוי ימים ב-6 החודשים האחרונים	80% מהימים ומעלה	פחות ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה	כמו ביל"ד
לפני כל חידוש	ביקורת שנתית	ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה	ב-12 החודשים האחרונים	אין ← חידוש לחודש + זימון לביקורת	כמו ביל"ד
לפני כל חידוש	רצף חידושים	כמה חידושים רצופים מאז ביקור רופא	פחות מ-3	3 ← ביקור רופא	כמו ביל"ד

11.ד החלטות

#	נושא	מה ההנחיה אומרת	ההחלטה לפרוטוקול	סוג	מקור
כללי-6	מעכבי משאבת פרוטונים	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	נדרשת התוויה מתועדת לטיפול ממושך. אין ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה לשקול הפחתה	החלטה מקומית (הצעה)	-
כללי-11	מעכבי PCSK9 (רפאטה, פראלואנט)	בסל באינדיקציות מצומצמות; רוב המטופלים דרך שב"ן או ביטוח. סבילות טובה, תגובה מקומית	בתנאים: אישור מימון בתוקף וטיפול כרוני; מעקב LDL כמו בסטטין. אין אישור ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה	החלטה מקומית (הצעה)	הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 (פרק מעכבי PCSK9)
כללי-12	תרופות כרוניות נוספות (2)	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	בזאפיברט, גבפנטין, פרגבלין, SSRI/SNRI (נתרן בגיל 65+), מעכבי ארומטאז, טמוקסיפן, רלוקסיפן, טרבינפין ואיטרקונזול (קורס): לפי הרשימה של כל תרופה	החלטה מקומית (הצעה)	-
כללי-13	חידוש ע"י רופא/ה בלבד	-	רואקוטן (רופא/ת עור בלבד), ממריצים, אופיואידים ובנזודיאזפינים: הכלי מציג הודעה ולא רשימת בדיקות	החלטה מקומית	-
כללי-19	תרופות מומחה	-	אריתרופויאטין, קושרי זרחן ואשלגן, HIV, הפטיטיס B, ציקלוספורין/טקרולימוס, אפרמילסט ואציטרטין: הודעה בלבד, חידוש ע"י רופא/ה	החלטה מקומית	-
כללי-20	השלמות מהמאגר (2.11.2026)	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	טרזוסין, פינסטריד, אינקליסירן, ורדנאפיל, טיפות לגלאוקומה (ביקורת עיניים שנתית; טימולול: דופק ואסתמה), NSAID ממושך (כליות, אשלגן, ל"ד, דימום, הגנת קיבה), אנטיהיסטמינים, ציננריזין, דומפרידון, מבברין, סידן, מידודרין, פנטוקסיפילין, דיפירידמול, ולציקלוביר מונע, חומצה זולדרונית	החלטה מקומית (הצעה)	-

#	נושא	מה ההנחיה אומרת	ההחלטה לפרוטוקול	סוג	מקור
כללי-22	השלמות 2 מהמאגר (2.11.2026)	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	ויטמין D, בטאהיסטין, חומצה במפדואית, אומגה 3/איקוזפנט, ציפרופיברט, וריסיגואט, ניטרוגליצרין תת-לשוני, פוזולינטנט/אלינזנטנט (ALT), דואביב, אינטראוסה, סיאנה, אורליסטט, פרוקלופריד, משלשלים, טטרציקלינים ממושכים, מניעת זיהומי שתן, משככי כאב ממושכים, ביקרבונט. רופא/ה בלבד: פנטרמין, בונות עצם, הפרינים, תרופות עצם בכליות, אנלוגי סומטוסטטין, הפטיטיס C/D, מחלות נדירות	החלטה מקומית (הצעה)	-

11.ה רשימת התרופות (לסימון)

#	שם	גנרי	קבוצה	התאמה	אושר	הערות
11.1	איטרקונזול	Itraconazole	נוגד פטרת (קורס)	מתאים	☐	
11.2	איזוטרטינואין (רואקוטן)	Isotretinoin	רטינואיד פומי	רופא/ה בלבד	☐	
11.3	אציטרטין	Acitretin	רטינואיד פומי	רופא/ה בלבד	☐	
11.4	אנלוג פרוסטגלנדין (טיפות עיניים)	Prostaglandin analogue (eye drops)	גלאוקומה	בתנאים	☐	
11.5	טימולול (טיפות עיניים)	Timolol (eye drops)	גלאוקומה · חוסם בטא	בתנאים	☐	
11.6	מעכב קרבוניק אנהידרז (טיפות עיניים)	Carbonic anhydrase inhibitor (eye drops)	גלאוקומה	בתנאים	☐	
11.7	ברימונידין (טיפות עיניים)	Brimonidine (eye drops)	גלאוקומה · אגוניסט אלפא	בתנאים	☐	
11.8	שילוב לגלאוקומה עם טימולול	Glaucoma combination with timolol	גלאוקומה · שילוב	בתנאים	☐	
11.9	דוקסיציקלין / מינוציקלין (קורס ממושך)	Doxycycline / minocycline (long course)	טטרציקלין לאקנה או לרוזציאה	מתאים	☐	

11.ו פירוט מלא

11.1 **איטרקונזול** · Itraconazole מתאים

נוגד פטרת (קורס)

שמות מסחריים (1)	איטרנול · Itranol
נימוק / הערה	קורס לפי הרופא/ה. אסור באי-ספיקת לב; אינטראקציות רבות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	בתוך משך הקורס	בתוך משך הקורס שנקבע ע"י הרופא/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	ALT (בקורס מעל חודש)	ALT מהחודש האחרון, אם הקורס ארוך מחודש. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
3	תפקודי כבד (ALT) תקין	בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 2 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
4	אין תרופה עם אינטראקציה	ברשימת התרופות אין סימבסטטין, קולכיצין, מידזולם, נוגד קרישה ישיר או טיקגרלור. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
5	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
6	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): אי-ספיקת לב. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	

מעקב מעבדה	ALT בקורס מעל חודש
ספי החזרה לרופא/ה	ALT מעל פי 2 מהגבול העליון
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	אי-ספיקת לב
תלונות בפנייה או ברשומה	קוצר נשימה או בצקות ← דחוף; צהבת או שתן כהה ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

11.2 **איזוטרטינואין (רואקוטן)** · Isotretinoin רופא/ה בלבד

רטינואיד פומי

שמות מסחריים (3)	קיורטן · Curatane | איזובניר · Isovenir | רואקוטן · Roaccutane (לאימות מול מאגר משרד הבריאות)
נימוק / הערה	איזוטרטינואין (רואקוטן) מחודש רק ע"י רופא/ת עור, במסגרת תוכנית מניעת היריון ומעקב מעבדה. להעביר את הבקשה לרופא/ת העור המטפל/ת.
הנחיה	**איזוטרטינואין (רואקוטן) מחודש רק ע"י רופא/ת עור, במסגרת תוכנית מניעת היריון ומעקב מעבדה. להעביר את הבקשה לרופא/ת העור המטפל/ת.**
מקור	-

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

11.3 **אציטרטין** · Acitretin רופא/ה בלבד

רטינואיד פומי

שמות מסחריים (1)	ניאוטיגאזון · Neotigason
נימוק / הערה	אציטרטין מחודש רק ע"י רופא/ת עור: טרטוגני עד 3 שנים אחרי הפסקה, ומחייב מעקב שומנים ותפקודי כבד. להעביר לרופא/ת העור.
הנחיה	**אציטרטין מחודש רק ע"י רופא/ת עור: טרטוגני עד 3 שנים אחרי הפסקה, ומחייב מעקב שומנים ותפקודי כבד. להעביר לרופא/ת העור.**
מקור	-

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

11.4 **אנלוג פרוסטגלנדין (טיפות עיניים)** · Prostaglandin analogue (eye drops) בתנאים

גלאוקומה

שמות מסחריים (11)	קסאלטן · Xalatan | גלאוטן · Glautan | לתרו · Lataro | לטנו-אבניר · Latano-Avenir | ויזולטה · Vyzulta | טרבתן · Travatan | טרבופרוסט אס.קיי. · Travoprost S.K. | לומיגן · Lumigan (לאימות מול מאגר משרד הבריאות) | בימטופרוסט טבע · Bimatoprost Teva | בימטופרוסט אס.קיי. · Bimatoprost S.K. | ספלוטן · Saflutan
נימוק / הערה	ביקורת שנתית אצל רופא/ת עיניים

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	ביקורת אצל רופא/ת עיניים	ביקור אצל רופא/ת עיניים ב-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ת עיניים, אותו טיפול ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה; ביקורת עיניים שנתית
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב עין, אודם או ירידה פתאומית בראייה ← דחוף - רופא/ת עיניים / מיון עיניים; קוצר נשימה (טימולול) ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

11.5 **טימולול (טיפות עיניים)** · Timolol (eye drops) בתנאים

גלאוקומה · חוסם בטא

שמות מסחריים (1)	וי-אופטיק · V-Optic
נימוק / הערה	נספג: האטת דופק וסימפונות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	ביקורת אצל רופא/ת עיניים	ביקור אצל רופא/ת עיניים ב-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	דופק במנוחה תקין	במדידה האחרונה דופק במנוחה תקין. חריג: מתחת ל-55 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים	
3	אין אסתמה או COPD	אין אבחנת אסתמה או COPD (טימולול נספג ועלול לגרום להתכווצות סימפונות). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ת עיניים, אותו טיפול ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה; ביקורת עיניים שנתית
ספי החזרה לרופא/ה	דופק מתחת ל-55
ערך חמור	דופק מתחת ל-50
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב עין, אודם או ירידה פתאומית בראייה ← דחוף - רופא/ת עיניים / מיון עיניים; קוצר נשימה (טימולול) ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

11.6 מעכב קרבוניק אנהידרז (טיפות עיניים) · Carbonic anhydrase inhibitor (eye drops) בתנאים

גלאוקומה

שמות מסחריים (4)	דורזופט · Dorzopt | דורזולאמיד אס.קיי. · Dorzolamide S.K | ברינזולאמיד אס.קיי. · Brinzolamide S.K. | אזופט · Azopt (לאימות מול מאגר משרד הבריאות)
נימוק / הערה	ביקורת שנתית

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	ביקורת אצל רופא/ת עיניים	ביקור אצל רופא/ת עיניים ב-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ת עיניים, אותו טיפול ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה; ביקורת עיניים שנתית
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב עין, אודם או ירידה פתאומית בראייה ← דחוף - רופא/ת עיניים / מיון עיניים; קוצר נשימה (טימולול) ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

11.7 **ברימונידין (טיפות עיניים)** · Brimonidine (eye drops) בתנאים

גלאוקומה · אגוניסט אלפא

שמות מסחריים (3)	אלפאגן פי · Alphagan P	ברימונידין טבע · Brimonidine Teva	סימברינזה · Simbrinza (עם ברינזולאמיד)
נימוק / הערה	ביקורת שנתית

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	ביקורת אצל רופא/ת עיניים	ביקור אצל רופא/ת עיניים ב-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ת עיניים, אותו טיפול ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה; ביקורת עיניים שנתית
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב עין, אודם או ירידה פתאומית בראייה ← דחוף - רופא/ת עיניים / מיון עיניים; קוצר נשימה (טימולול) ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

11.8 שילוב לגלאוקומה עם טימולול · Glaucoma combination with timolol בתנאים

גלאוקומה · שילוב

שמות מסחריים (12)	קסלאקום · Xalacom | לתרו-טים · Lataro-Tim | דואוטרב · Duotrav | גאנפורט · Ganfort | בימטילול טבע · Bimatilol Teva | בימאטול אס.קיי. · Bimatol S.K. | קוסופט · Cosopt | דורזטול-אבניר · Dorzatol-Avenir | דורזולאמיד טימולול תרו · Dorzolamide Timolol Taro | אזרגה · Azarga | ברינזוטול אס.קיי. · Brinzotol S.K | קומביגן · Combigan
נימוק / הערה	מכיל טימולול: דופק וסימפונות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	ביקורת אצל רופא/ת עיניים	ביקור אצל רופא/ת עיניים ב-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	דופק במנוחה תקין	במדידה האחרונה דופק במנוחה תקין. חריג: מתחת ל-55 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים	
3	אין אסתמה או COPD	אין אבחנת אסתמה או COPD (טימולול נספג ועלול לגרום להתכווצות סימפונות). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ת עיניים, אותו טיפול ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה; ביקורת עיניים שנתית
ספי החזרה לרופא/ה	דופק מתחת ל-55
ערך חמור	דופק מתחת ל-50
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב עין, אודם או ירידה פתאומית בראייה ← דחוף - רופא/ת עיניים / מיון עיניים; קוצר נשימה (טימולול) ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

11.9 **דוקסיציקלין / מינוציקלין (קורס ממושך)** · Doxycycline / minocycline (long course) מתאים

טטרציקלין לאקנה או לרוזציאה

שמות מסחריים (3)	דוקסילין · Doxylin | דוקסי · Doxy | מינוציקלין · Minocycline
נימוק / הערה	קורס עד 3-4 חודשים; לא בהיריון ולא מתחת לגיל 8

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	בתוך משך הטיפול שנקבע	סך הטיפול עד 4 חודשים, או החלטה מתועדת של הרופא/ה להמשך. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	אין מעקב מעבדה
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב ראש חזק עם הפרעות ראייה ← דחוף; כוויות שמש חזקות ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

12. חיסון, זיהומים ומומחים

13 תרופות · בתנאים: 6 · רופא/ה בלבד: 6 · מתאים: 1 · גרסה 2 · חלוקה לפי מערכות · 2.11.2026

מקורות: הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020; ACOG 2023 (סיכום AFP). שאר התחומים: החלטה מקומית; עלון לצרכן לפונקס (עודכן 12/2020). שאר התרופות: החלטה מקומית

12.א כללים

- חידוש רגיל: 3 חודשים
- ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה פעם בשנה
- עד 3 חידושים רצופים, ואז ביקור רופא
- אין התווית נגד ← תמיד מחדשים לפחות לחודש אחד
- חסרה מדידה, בדיקה או ביקורת שנתית: חידוש לחודש אחד + זימון למרפאה
- חריגה מספי ההחזרה: חידוש לחודש אחד + הודעה לרופא/ה
- התווית נגד או ערך חמור: לא מחדשים, הודעה לרופא/ה (הסף של כל תרופה מופיע ברשימה שלה)
- רפואן לא משנה מינון ולא מחליף תרופה. "מעקב מעבדה צמוד" = תרופה עם בדיקות תכופות — לבדוק בקפידה
- רוב התרופות כאן מחודשות ע"י רופא/ה או מומחה/ית בלבד
- חום או זיהום בתרופה מדכאת חיסון ← הודעה דחופה

12.ג בדיקות משותפות

שלב	נושא	מה בודקים	קריטריון	אם לא מתקיים	מקור
לפני כל חידוש	בדיקת מעקב	לפי התרופה	שומנים: LDL; לבותירוקסין: TSH; אלופורינול/פבוקסוסטט: חומצה אורית — מ-12 החודשים האחרונים	אין ← חידוש לחודש + זימון לבדיקה	הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52; החלטה כללי-1
לפני כל חידוש	ערך המעקב	לעומת הבדיקה הקודמת או היעד	LDL לא עלה ב-30% ומעלה; TSH בטווח המעבדה; חומצה אורית מתחת ל-6	לא ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה	החלטות כללי-4-2
לפני כל חידוש	רכישות	כיסוי ימים ב-6 החודשים האחרונים	80% מהימים ומעלה	פחות ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה	כמו ביל"ד
לפני כל חידוש	ביקורת שנתית	ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה	ב-12 החודשים האחרונים	אין ← חידוש לחודש + זימון לביקורת	כמו ביל"ד
לפני כל חידוש	רצף חידושים	כמה חידושים רצופים מאז ביקור רופא	פחות מ-3	3 ← ביקור רופא	כמו ביל"ד
החזרה מיידית לרופא	פריחה	מופיע בפנייה או ברשומה (אלופורינול)	פריחה או תגובה עורית	הפסקה, דחוף	החלטה כללי-7

12.ד החלטות

#	נושא	מה ההנחיה אומרת	ההחלטה לפרוטוקול	סוג	מקור
כללי-1	בדיקות מעקב	שומנים: פרופיל כל 6- 12 חודשים אחרי השגת היעד. TSH וחומצה אורית: לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	LDL, TSH וחומצה אורית מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש + זימון	החלטה מקומית (הצעה)	הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52
כללי-6	מעכבי משאבת פרוטונים	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	נדרשת התוויה מתועדת לטיפול ממושך. אין ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה לשקול הפחתה	החלטה מקומית (הצעה)	-

#	נושא	מה ההנחיה אומרת	ההחלטה לפרוטוקול	סוג	מקור
כללי-7	אלופורינול ופבוקסוסטט	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	חומצה אורית ≥6 ← הודעה. אלופורינול: eGFR <30 ← הודעה (מינון). פריחה ← התווית נגד, דחוף	החלטה מקומית (הצעה)	-
כללי-11	מעכבי PCSK9 (רפאטה, פראלואנט)	בסל באינדיקציות מצומצמות; רוב המטופלים דרך שב"ן או ביטוח. סבילות טובה, תגובה מקומית	בתנאים: אישור מימון בתוקף וטיפול כרוני; מעקב LDL כמו בסטטין. אין אישור ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה	החלטה מקומית (הצעה)	הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 (פרק מעכבי PCSK9)
כללי-12	תרופות כרוניות נוספות (2)	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	בזאפיברט, גבפנטין, פרגבלין, SSRI/SNRI (נתרן בגיל 65+), מעכבי ארומטאז, טמוקסיפן, רלוקסיפן, טרבינפין ואיטרקונזול (קורס): לפי הרשימה של כל תרופה	החלטה מקומית (הצעה)	-
כללי-16	ברזל, B12, חומצה פולית	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	ברזל: ספירת דם ופריטין מ-6 חודשים; טיפול מעל 6 חודשים בלי התוויה ← הודעה. B12: רמה שנתית	החלטה מקומית (הצעה)	-
כללי-20	השלמות מהמאגר (2.11.2026)	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	טרזוסין, פינסטריד, אינקליסירן, ורדנאפיל, טיפות לגלאוקומה (ביקורת עיניים שנתית; טימולול: דופק ואסתמה), NSAID ממושך (כליות, אשלגן, ל"ד, דימום, הגנת קיבה), אנטיהיסטמינים, ציננריזין, דומפרידון, מבברין, סידן, מידודרין, פנטוקסיפילין, דיפירידמול, ולציקלוביר מונע, חומצה זולדרונית	החלטה מקומית (הצעה)	-
כללי-21	תרופות מומחה נוספות	-	מטוקלופרמיד ממושך, ממריצים/מודפיניל, ביולוגיות, טרשת נפוצה, אונקולוגיה, יל"ד ריאתי/IPF, סירולימוס, הורמון גדילה, המטולוגיה, CF, טפמידיס/מבקמטן: הודעה בלבד, חידוש ע"י רופא/ה	החלטה מקומית	-
כללי-22	השלמות 2 מהמאגר (2.11.2026)	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	ויטמין D, בטאהיסטין, חומצה במפדואית, אומגה 3/איקוזפנט, ציפרופיברט, וריסיגואט, ניטרוגליצירין תת-לשוני, פוזולינטנט/אלינזנטנט (ALT), דואביב, אינטראروסה, סיאנה, אורליסטט, פרוקלופריד, משלשלים, טטרציקלינים ממושכים, מניעת זיהומי שתן, משככי כאב ממושכים, ביקרבונט. רופא/ה בלבד: פנטרמין, בונות עצם, הפרינים, תרופות עצם בכליות, אנלוגי סומטוסטטין, הפטיטיס C/D, מחלות נדירות	החלטה מקומית (הצעה)	-
מעקב-12	תרופות למעקב צמוד נוספות	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	מתימזול/PTU, לפלונומיד, אזתיופרין, סולפסלזין, מיקופנולט, מעכבי JAK, הידרוקסיאוריאה, הידרוקסיכלורוקווין, נוגדי פסיכוזה, טסטוסטרון, סטרואידים כרוניים, ניטרופורנטואין, קולכיצין, דנוסומאב, טריפרטייד: בדיקות לפי התרופה; חריגה ← חודש + הודעה; ערך חמור ← לא מחדשים	החלטה מקומית (הצעה)	-

12.ה רשימת התרופות (לסימון)

#	שם	גנרי	קבוצה	התאמה	אושר	הערות
12.1	לטרוזול	Letrozole	מעכב ארומטאז	בתנאים	☐	
12.2	אנסטרוזול	Anastrozole	מעכב ארומטאז	בתנאים	☐	
12.3	אקסמסטן	Exemestane	מעכב ארומטאז	בתנאים	☐	
12.4	טמוקסיפן	Tamoxifen	SERM (אונקולוגיה)	בתנאים	☐	
12.5	תרופות נגד HIV	HIV antiretrovirals	אנטי-רטרו-ויראלי	רופא/ה בלבד	☐	
12.6	מעכבי קלצינאורין	Calcineurin inhibitors	מדכא חיסון	רופא/ה בלבד	☐	
12.7	ולציקלוביר / אציקלוביר (טיפול מונע)	Valaciclovir / aciclovir (suppression)	אנטי-ויראלי	מתאים	☐	
12.8	תרופות ביולוגיות	Biologic drugs	נוגדנים ותרופות ביולוגיות	רופא/ה בלבד	☐	

#	שם	גנרי	קבוצה	התאמה	אושר	הערות
12.9	תרופות אונקולוגיות ובמעקב אונקולוגי	Oral oncology and hormonal cancer therapy	אונקולוגיה	רופא/ה בלבד	☐	
12.10	מדכאי חיסון להשתלה (mTOR)	Transplant immunosuppressants (mTOR)	מדכא חיסון	רופא/ה בלבד	☐	
12.11	תרופות למחלות נדירות	Rare metabolic / orphan drugs	מחלות מטבוליות ונדירות	רופא/ה בלבד	☐	
12.12	אזתיופרין	Azathioprine	מדכא חיסון	בתנאים ⚗	☐	
12.13	מיקופנולט	Mycophenolate	מדכא חיסון	בתנאים ⚗	☐	

12.ו פירוט מלא

12.1 **לטרוזול** · Letrozole בתנאים

מעכב ארומטאז

שמות מסחריים (4)	פמרה · Femara | לטרוזול דקסל · Letrozole Dexcel | לטרוזול פרמוז · Letrozole Farmoz | לטרוזול טבע · Letrozole Teva
נימוק / הערה	נקבע ע"י אונקולוג/ית. צפיפות עצם

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**צפיפות עצם מתועדת**	צפיפות עצם מ-24 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	**רכישות**	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	**ביקורת שנתית במרפאה**	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	**טיפול כרוני במינון קבוע**	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י אונקולוג/ית, במסגרת משך הטיפול שנקבע. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
5	**כמות, יחידות ותדירות**	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	**אין התראת אינטראקציה**	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	**רצף חידושים**	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	**החידוש השלישי ברצף** שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	צפיפות עצם כל שנתיים
תלונות בפנייה או ברשומה	כאבי פרקים קשים ← לרופא; שבר ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

12.2 אנסטרוזול · Anastrozole בתנאים

מעכב ארומטאז

שמות מסחריים (2)	ארימידקס · Arimidex | אנסטרוזול טבע · Anastrozole Teva
נימוק / הערה	נקבע ע"י אונקולוג/ית. צפיפות עצם

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	צפיפות עצם מתועדת	צפיפות עצם מ-24 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י אונקולוג/ית, במסגרת משך הטיפול שנקבע. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	צפיפות עצם כל שנתיים
תלונות בפנייה או ברשומה	כאבי פרקים קשים ← לרופא; שבר ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

12.3 אקסמסטן · Exemestane בתנאים

מעכב ארומטאז

שמות מסחריים (2)	ארומזין · Aromasin | אקסמזין-ויט · Exemasin-Vit
נימוק / הערה	נקבע ע"י אונקולוג/ית. צפיפות עצם

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	צפיפות עצם מתועדת	צפיפות עצם מ-24 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י אונקולוג/ית, במסגרת משך הטיפול שנקבע. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	צפיפות עצם כל שנתיים
תלונות בפנייה או ברשומה	כאבי פרקים קשים ← לרופא; שבר ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

12.4 טמוקסיפן · Tamoxifen בתנאים

SERM (אונקולוגיה)

שמות מסחריים (1)	טמוקסיפן טבע · Tamoxifen Teva
נימוק / הערה	נקבע ע"י אונקולוג/ית. דימום וגינלי ← דחוף

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין דימום וגינלי חדש	ברשומה או בפנייה אין דימום וגינלי לא סדיר (בעיקר אחרי גיל המעבר). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
2	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
4	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י אונקולוג/ית, במסגרת משך הטיפול שנקבע. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
9	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): פקקת ורידים או תסחיף ריאתי פעיל. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	בדיקה גינקולוגית לפי תסמינים
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	פקקת ורידים או תסחיף ריאתי פעיל
תלונות בפנייה או ברשומה	כאב ונפיחות ברגל או קוצר נשימה ← דחוף; דימום וגינלי ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

12.5 תרופות נגד HIV · HIV antiretrovirals רופא/ה בלבד

אנטי-רטרו-ויראלי

שמות מסחריים (26)	ביקטארווי · Biktarvy | דסקובי · Descovy | טרובדה · Truvada | אודפסיי · Odefsey | ג'נדברה · Gendevra | סטריבילד · Stribild | טיויקיי · Tivicay | טריומק · Triumeq | דובאטו · Dovato | ג'ולוקה · Juluca | דלסטריגו · Delstrigo | אמטריציטבין/טנופוביר טבע · Emtricitabine/Tenofovir Teva | אמפוביר אס.קיי. · Emfovir S.K | אבקויר לאמיבודין תרו · Abacavir Lamivudine Taro | זיאגן טבליות · Ziagen | אפיביר · Epivir | אפיביר תמיסה לשתיה · Epivir Oral Solution | רזולסטה · Rezolsta | אדוראנט · Edurant | רקמביס · Rekambys | ווקבריה זריקה · Vocabria Injection | ווקבריה טבליות · Vocabria | אייסנטרס · Isentress | פיפלטרו · Pifeltro | סאנלנקה טבליות מצופות · Sunlenca | סאנלנקה תמיסה להזרקה · Sunlenca Solution For Inection
נימוק / הערה	טיפול ב-HIV ומניעה (PrEP) ניתנים ע"י מרפאת האיידס או מרפאת PrEP. להעביר לרופא/ה.
הנחיה	**טיפול ב-HIV ומניעה (PrEP) ניתנים ע"י מרפאת האיידס או מרפאת PrEP. להעביר לרופא/ה.**

מקור	-

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

12.6 מעכבי קלצינאורין · Calcineurin inhibitors רופא/ה בלבד

מדכא חיסון

שמות מסחריים (7)	סנדאימון ניאורל · Sandimmun Neoral | דקסימון · Deximune | פרוגרף · Prograf | אדבגרף · Advagraf | טקרוסל · Tacrocel | דייליפורט · Dailiport | אקרולימוס פי.אר. · Acrolimus PR
נימוק / הערה	ציקלוספורין וטקרולימוס במתן סיסטמי מנוטרים ברמה בדם ע"י יחידת ההשתלות או המומחה/ית. להעביר לרופא/ה.
הנחיה	**ציקלוספורין וטקרולימוס במתן סיסטמי מנוטרים ברמה בדם ע"י יחידת ההשתלות או המומחה/ית. להעביר לרופא/ה.**
מקור	-

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

12.7 ולציקלוביר / אציקלוביר (טיפול מונע) · Valaciclovir / aciclovir (suppression) מתאים

אנטי-ויראלי

שמות מסחריים (6)	ולטרקס · Valtrex | זובירקס · Zovirax | אציקלו-וי · Acyclo-V | ציקלוביר · Cyclovir | אציקלובניר · Acyclovenir | אציקלוביר ויז'ן · Aciclovir Vision
נימוק / הערה	טיפול מונע בהרפס חוזר; הערכה מחדש פעם בשנה. מינון לפי כליות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	טיפול מונע שהוערך בשנה האחרונה	החלטת רופא/ה על טיפול מונע ב-12 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	קריאטינין מתועד שאלה: גיל 65 ומעלה או מחלת כליות?	קריאטינין/eGFR מ-12 החודשים האחרונים, eGFR 30 ומעלה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
3	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
7	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
8	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	קריאטינין שנתי בגיל 65+
תלונות בפנייה או ברשומה	בלבול (בגיל מבוגר) ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

12.8 **תרופות ביולוגיות** · Biologic drugs רופא/ה בלבד

נוגדנים ותרופות ביולוגיות

שמות מסחריים (72)	אדאלימומאב קמהדע · Adalimumab Kamada	אמג'ויטה · Amgevita	אמספאריטי · Amsparity	הוליו · Hulio	יומירה · Humira	היירימוז · Hyrimoz	היירימוז אייץ'. סי. אף · Hyrimoz Hcf	אידסיו · Idacio	יופלימה · Yuflyma	אנברל · Enbrel	אנברל אבקה וממס · Enbrel Powder And Solvent	ארלזי · Erelzi	נפקסטו · Nepexto	סימזיה · Cimzia	גולימומאב קמהדע · Golimumab Kamada	סימפוני · Simponi	אימולדוזה · Imuldosa	אימולדוזה מזרק מוכן לשימוש · Imuldosa Pre-Filled Syringe	סטלרה · Stelara	סטלרה עט מוכן לשימוש · Stelara Pre-Filled Pen	סטלרה מזרק מוכן לשימוש · Stelara Prefilled Syringe	סטקימה · Steqeyma	סטקימה מזרק מוכן לשימוש · Steqeyma Prefilled Syringe	אוסטקינומאב קמהדע · Ustekinumab Kamada	אוסטקינומאב קמהדע מזרק מוכן לשימוש · Ustekinumab Kamada	וזלנה · Wezlana	וזלנה מזרק מוכן לשימוש · Wezlana Prefilled Syringe	יסינטק · Yesintek	יסינטק מזרק מוכן לשימוש · Yesintek Pre-Filled Syringe	קוסנטיקס תמיסה להזרקה · Cosentyx Solution For Injection	טאלץ · Taltz	טרמפיה · Tremfya	סקיריזי · Skyrizi	אילומיה · Ilumya	בימזלקס · Bimzelx	אומבו · Omvoh	דופיקסנט · Dupixent	אבגליס · Ebglyss	אומליקלו · Omlyclo	זולאייר פי.אף.אס · Xolair Pfs	זולאייר · Xolair	נוקלה אבקה להכנת תמיסה להזרקה · Nucala Powder For Solution For Injection	נוקלה תמיסה להזרקה · Nucala Solution For Injection	פסנרה · Fasenra	סינקאייר · Cinqair	טזספייר · Tezspire	אקטמרה · Actemra	אבטוזמה · Avtozma	קבזרה · Kevzara	אורנסיה · Orencia	אנטיביו תוך ורידי · Entyvio I.V	אנטיביו תת עורי · Entyvio S.C	סאפנלו · Saphnelo	בנליסטה תוך ורידי · Benlysta I.V	בנליסטה תת-עורי · Benlysta S.C	איימוביג · Aimovig	אמגליטי · Emgality	אג'ובי · Ajovy	איקסיפי · Ixifi	רמיקד · Remicade	רמסימה · Remsima	מבטרה · Mabthera	ריקסתון · Rixathon	רוקסיאנס · Ruxience	טרוקסימה · Truxima	סוליריס · Soliris	אולטומיריס · Ultomiris	ואייפטי · Vyepti	סוטיקטו · Sotyktu	סיבינקו · Cibinqo	ליטפולו · Litfulo	ולסיפיטי · Velsipity
נימוק / הערה	תרופות ביולוגיות נקבעות ומנוטרות ע"י הרופא/ה המומחה/ית ודורשות אישור מימון. להעביר לרופא/ה.
הנחיה	**תרופות ביולוגיות נקבעות ומנוטרות ע"י הרופא/ה המומחה/ית ודורשות אישור מימון. להעביר לרופא/ה.**

מקור	-

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

12.9 **תרופות אונקולוגיות ובמעקב אונקולוגי** · Oral oncology and hormonal cancer therapy (רופא/ה בלבד)

אונקולוגיה

שמות מסחריים (68)	אבירטרון - תרימה · Abiraterone - Trima	אבירטרון מדומי · Abiraterone Medomie	אבירטרון אס.קיי · Abiraterone S.K	אבירטרון סנדוז · Abiraterone Sandoz	אבירטרון תרו · Abiraterone Taro	אבירטרון טבע · Abiraterone Teva	אביטאבניר · Abitavenir	אביבניר · Abivenir	אקיגה · Akeega	יונסה · Yonsa	זייטיגה · Zytiga	אנז-אבניר · Enz-Avenir	אנזלוטמיד דקסל · Enzalutamide Dexcel	אנזלוטמיד סנדוז · Enzalutamide Sandoz	אנזלוטמיד טבע · Enzalutamide Teva	אקסטנדי · Xtandi	ארלידה · Erleada	נובקה · Nubeqa	ביקאלוטמיד טבע · Bicalutamide Teva	קזודקס · Casodex	זולדקס · Zoladex	זולדקס אל.אי. · Zoladex La	קמסבי · Camcevi	אליגרד · Eligard	דקפפטיל · Decapeptyl	דקפפטיל סי.אר. · Decapeptyl C.R.	דקפפטיל דפו · Decapeptyl Depot	פירמגון · Firmagon	אייברנס כמוסות · Ibrance	פלבו טבע כמוסות · Palbo Teva	קיסקלי · Kisqali	ריבוציקליב טבע · Ribociclib Teva	ורזניו · Verzenio	קפסיטבין אינובמד · Capecitabine Inovamed	קפסיטבין תרו · Capecitabine Taro	קפציטבין טבע · Capecitabine Teva	גליבק · Glivec	אימרם · Imarem	אימטיניב - תרימה · - Imatinib Trima	אימטיניב תרו · Imatinib Taro	אימטיניב טבע · Imatinib Teva	טסיגנה · Tasigna	דסטיניב אס.קיי · Dasatinib S.K.	דסטיניב סנדוז · Dasatinib Sandoz	דסטיניב תרו · Dasatinib Taro	דסטיניב טבע · Dasatinib Teva	טאגריסו · Tagrisso	לינפארזה · Lynparza	לנלידומיד אס.קיי. · Lenalidomide S.K.	לנלידומיד תרו · Lenalidomide Taro	לנלידומיד טבע · Lenalidomide Teva	אימברוביקה · Imbruvica	אימברוביקה תרחיף לבליעה · Imbruvica Oral Suspension	טמו · Temo	טמודאל · Temodal	פסלודקס · Faslodex	פולבניר · Fulvenir	פולבסטרנט · Fulvestrant	פולווסטרנט אוור פארמה · Fulvestrant Ever Pharma	פולבסטרנט רומפארם · Fulvestrant Rompharm	פולבסטרנט סנדוז · Fulvestrant Sandoz	פולבסטראנט טבע · Fulvestrant Teva	פיקריי · Piqray	אפיניטור · Afinitor	סרטיקן · Certican	אוורולימוס תרו · Everolimus Taro	אברולימוס טבע · Everolimus Teva	אבטור · Evetor
נימוק / הערה	תרופות אונקולוגיות (כולל זריקות הורמונליות לסרטן ערמונית) נקבעות ע"י האונקולוג/ית. להעביר לרופא/ה.
הנחיה	**תרופות אונקולוגיות (כולל זריקות הורמונליות לסרטן ערמונית) נקבעות ע"י האונקולוג/ית. להעביר לרופא/ה.**
מקור	-

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

12.10 **מדכאי חיסון להשתלה (mTOR)** · Transplant immunosuppressants (mTOR) (רופא/ה בלבד)

מדכא חיסון

שמות מסחריים (2)	רפמיון · Rapamune	רפמיון תמיסה · Rapamune Solution
נימוק / הערה	סירולימוס נקבע ומנוטר ברמה בדם ע"י יחידת ההשתלות. להעביר לרופא/ה.
הנחיה	**סירולימוס נקבע ומנוטר ברמה בדם ע"י יחידת ההשתלות. להעביר לרופא/ה.**
מקור	-

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

12.11 **תרופות למחלות נדירות** · Rare metabolic / orphan drugs רופא/ה בלבד

מחלות מטבוליות ונדירות

שמות מסחריים (20)	טריאנטין הידרוכלוריד מדומי · Trientine Hcl Medomie	טריאנטין רז · Trientine Raz	ווילנטין · Willentine	ניטיזינון דיפארמה · Nitisinone Dipharma	אורפדין · Orfadin	קובן · Kuvan	סאפרופטרין אינובמד · Sapropterin Inovamed	סאפרופטרין אס.קיי · Sapropterin S.K	ספרופטרין טבע · Sapropterin Teva	ציסטגון · Cystagon	גאלאפולד · Galafold	סרדלגה · Cerdelga	מיגלוסטאט דיפארמה · Miglustat Dipharma	מיגלוסטט ג'י.אל. · Miglustat G.L.	זבסקה · Zavesca	לוג'וקסטה · Lojuxta	אבקיזה · Evkeeza	גאטקס · Gattex	אימסיברי · Imcivree	חומצה כנודאוקסיכולית לדיאנט · Chenodeoxycholic Acid Leadiant
נימוק / הערה	תרופות למחלות נדירות נקבעות ומנוטרות ע"י מרכז מומחה. להעביר לרופא/ה.
הנחיה	**תרופות למחלות נדירות נקבעות ומנוטרות ע"י מרכז מומחה. להעביר לרופא/ה.**
מקור	-

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

12.12 אזתיופרין · Azathioprine

בתנאים | מעקב מעבדה צמוד

מדכא חיסון

שמות מסחריים (1)	אימוראן · Imuran
נימוק / הערה	נקבע ע"י רופא/ה מומחה/ית. אסור עם אלופורינול או פבוקסוסטט ללא התאמת מינון

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	בדיקות מ-3 החודשים האחרונים	ספירת דם ו-ALT מ-3 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה	בבדיקה האחרונה ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה. חריג: WBC מתחת ל-3,500 או טסיות מתחת ל-150,000 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-100,000 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-100,000 ← לא מחדשים	
3	תפקודי כבד (ALT) תקין	בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 2 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים	
4	אין אלופורינול או פבוקסוסטט	ברשימת התרופות אין אלופורינול או פבוקסוסטט. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
5	אין חום או זיהום מתועד	ברשומה או בפנייה אין חום, כאב גרון, פצעים בפה או זיהום. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
6	אין היריון	אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
7	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
8	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
9	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ה מומחה/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
10	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
11	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
12	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
13	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה

מעקב מעבדה	ספירת דם ו-ALT כל 3 חודשים
ספי החזרה לרופא/ה	WBC מתחת ל-3,500 או טסיות מתחת ל-150,000; ALT מעל פי 2 מהגבול העליון
ערך חמור	WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-100,000; ALT מעל פי 3 מהגבול העליון
תלונות בפנייה או ברשומה	חום או זיהום ← דחוף; חבורות או דימומים ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

12.13 מיקופנולט · Mycophenolate בתנאים מעקב מעבדה צמוד

מדכא חיסון

שמות מסחריים (5)	סלספט · CellCept | מיקופנולט טבע · Mycophenolate Teva | מיפורטיק · Myfortic | מיקופנוליק אסיד אינובמד · Mycophenolic Acid Inovamed | מיקופנוליק אסיד אופק · Mycophenolic Acid Ofek
נימוק / הערה	נקבע ומנוטר ע"י יחידת ההשתלות או הראומטולוג/ית. התווית נגד בהיריון

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	ספירת דם מ-3 החודשים האחרונים	ספירת דם מ-3 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
2	ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה	בבדיקה האחרונה ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה. חריג: WBC מתחת ל-3,500 או טסיות מתחת ל-150,000 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-100,000 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-100,000 ← לא מחדשים	
3	אין חום או זיהום מתועד	ברשומה או בפנייה אין חום, כאב גרון, פצעים בפה או זיהום. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
4	רכישות	התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
5	ביקורת שנתית במרפאה	המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה.	זימון
6	טיפול כרוני במינון קבוע	תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י יחידת ההשתלות או רופא/ה מומחה/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה.	
7	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
8	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	
9	רצף חידושים	מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא.	
10	החידוש השלישי ברצף שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה?	בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה".	שאלה
11	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): היריון או תכנון היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד

מעקב מעבדה	ספירת דם כל 3 חודשים (לפי היחידה המטפלת)
ספי החזרה לרופא/ה	WBC מתחת ל-3,500 או טסיות מתחת ל-150,000
ערך חמור	WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-100,000
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	היריון או תכנון היריון
תלונות בפנייה או ברשומה	חום או זיהום ← דחוף; שלשולים ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

13. תרופות שאינן כרוניות

5 תרופות · הכנה לאישור רופא/ה: 5 · גרסה 2 · חלוקה לפי מערכות · 2.11.2026

מקורות: הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020; ACOG 2023 (סיכום AFP). שאר התחומים: החלטה מקומית

13.א כללים

- חידוש רגיל: 3 חודשים
- ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה פעם בשנה
- עד 3 חידושים רצופים, ואז ביקור רופא
- אין התווית נגד ← תמיד מחדשים לפחות לחודש אחד
- חסרה מדידה, בדיקה או ביקורת שנתית: חידוש לחודש אחד + זימון למרפאה
- חריגה מספי ההחזרה: חידוש לחודש אחד + הודעה לרופא/ה
- התווית נגד או ערך חמור: לא מחדשים, הודעה לרופא/ה (הסף של כל תרופה מופיע ברשימה שלה)
- רפואן לא משנה מינון ולא מחליף תרופה. "מעקב מעבדה צמוד" = תרופה עם בדיקות תכופות — לבדוק בקפידה
- כל בקשה בלשונית זו מוכנה ע"י הרפואן ומאושרת ע"י הרופא/ה. לא מפיקים באופן עצמאי
- בקשה להמרת מרשם שנכתב בכתב יד: מציגים לרופא/ה לפענוח. לא מפענחים ולא מקלידים לבד.
- הסיכום לרופא/ה: איפה תועד, תאריך, שם הרופא/ה ותפקידו/ה, האבחנה וההמלצה
- נוגדי דלקת חזקים: לבדוק כיב קיבה בעבר ותפקוד כליות. טרבינפין: ALT לפני ואחרי חודש
- משחה סטרואידלית: לא לשימוש כרוני; כשמאושרת — ההוראה הקבועה נכנסת להודעה למטופל/ת

13.ג בדיקות משותפות

שלב	נושא	מה בודקים	קריטריון	אם לא מתקיים	מקור
לפני כל חידוש	בדיקת מעקב	לפי התרופה	שומנים: LDL; לבותירוקסין: TSH; אלופורינול/פבוקסוסטט: חומצה אורית — מ-12 החודשים האחרונים	אין ← חידוש לחודש + זימון לבדיקה	הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52; החלטה כללי-1
לפני כל חידוש	רכישות	כיסוי ימים ב-6 החודשים האחרונים	80% מהימים ומעלה	פחות ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה	כמו ביל"ד
לפני כל חידוש	ביקורת שנתית	ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה	ב-12 החודשים האחרונים	אין ← חידוש לחודש + זימון לביקורת	כמו ביל"ד
לפני כל חידוש	רצף חידושים	כמה חידושים רצופים מאז ביקור רופא	פחות מ-3	3 ← ביקור רופא	כמו ביל"ד
החזרה מיידית לרופא	דימום	מופיע בפנייה או ברשומה (נוגדי טסיות)	צואה שחורה, דם בצואה, דימום משמעותי	דחוף - לרופא עכשיו	החלטה כללי-5

13.ד החלטות

#	נושא	מה ההנחיה אומרת	ההחלטה לפרוטוקול	סוג	מקור
כללי-5	נוגדי טסיות	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	אספירין 75-100 מ"ג בלבד. נוגד קרישה במקביל ← הודעה. דימום ← התווית נגד. קלופידוגרל רק כטיפול כרוני לטווח ארוך	החלטה מקומית (הצעה)	-
כללי-12	תרופות כרוניות נוספות (2)	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	בזאפיברט, גבפנטין, פרגבלין, SSRI/SNRI (נתרן בגיל 65+), מעכבי ארומטאז, טמוקסיפן, רלוקסיפן, טרבינפין ואיטרקונזול (קורס): לפי הרשימה של כל תרופה	החלטה מקומית (הצעה)	-
כללי-20	השלמות מהמאגר (2.11.2026)	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט	טרזוסין, פינסטריד, אינקליסירן, ורדנאפיל, טיפות לגלאוקומה (ביקורת עיניים שנתית; טימולול: דופק ואסתמה), NSAID ממושך (כליות, אשלגן, ל"ד, דימום, הגנת קיבה), אנטיהיסטמינים, ציננריזין, דומפרידון, מבברין, סידן, מידודרין, פנטוקסיפילין, דיפירידמול, ולציקלוביר מונע, חומצה זולדרונית	החלטה מקומית (הצעה)	-

13.ה רשימת התרופות (לסימון)

#	שם	גנרי	קבוצה	התאמה	אושר	הערות
13.1	טרבינפין (טבליות)	Terbinafine (oral)	נוגד פטרת (קורס)	הכנה לאישור רופא/ה	☐	
13.2	נוגדי דלקת חזקים (במרשם)	NSAIDs (strong, prescription)	NSAID	הכנה לאישור רופא/ה	☐	
13.3	תרופה שאינה ברשימה הקבועה	Drug not on the chronic list	כל תרופה שלא רשומה כתרופה קבועה	הכנה לאישור רופא/ה	☐	
13.4	טיפות עיניים עם סטרואיד	Steroid eye drops	סטרואיד מקומי לעין	הכנה לאישור רופא/ה	☐	
13.5	משחות וקרמים עם סטרואיד	Topical steroids	סטרואיד מקומי לעור	הכנה לאישור רופא/ה	☐	

13.ו פירוט מלא

13.1 **טרבינפין (טבליות)** · Terbinafine (oral) הכנה לאישור רופא/ה

נוגד פטרת (קורס)

שמות מסחריים (6)	טרבינאפין טבע · Terbinafine Teva | טרבינא טבע · Terbina Teva | דרמסיל · Dermasil | מדוסיל · Medosil | פטיר · Patir (לוודא טבליות) | טרקלרה · Terclara (לוודא טבליות)
נימוק / הערה	קורס בלבד: עד 12 שבועות בציפורני רגליים, 6 שבועות בציפורני ידיים. ALT לפני הטיפול ואחרי חודש. האישור בידי הרופא/ה.

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	ALT לפני הטיפול ואחרי חודש	ALT לפני תחילת הקורס ואחרי חודש טיפול. חסר ← זימון לבדיקה.	זימון
2	תפקודי כבד (ALT) תקין	בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 2 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
3	בתוך משך הקורס	סך הטיפול עד 12 שבועות (ציפורני רגליים) או 6 שבועות (ידיים). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): מחלת כבד פעילה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד
5	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
6	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	

מעקב מעבדה	ALT לפני הטיפול
ספי החזרה לרופא/ה	ALT מעל פי 2 מהגבול העליון
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	מחלת כבד פעילה
תלונות בפנייה או ברשומה	צהבת, שתן כהה או חולשה ← דחוף - הפסקה; אובדן טעם ← לרופא; פריחה ← לרופא
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

13.2 נוגדי דלקת חזקים (במרשם) · NSAIDs (strong, prescription) הכנה לאישור רופא/ה

NSAID

שמות מסחריים (16)	אביטרן טבע · Abitren Teva	בטרן SR · Betaren SR	קטאפלם · Cataflam	אולפן · Olfen	נקסין · Naxyn	נרוסין · Narocin	נפרוסן · Naprocen	פוינט · Point	ארקוקסיה · Arcoxia	ארקו-טבע · Arco-Teva	אטוריקוקסיב דקסל · Etoricoxib Dexcel	אטוריקוקסיב תרו · Etoricoxib Taro	אטוריקוקסיב סנדוז · Etoricoxib Sandoz	סלקוקס · Celcox	אתופן · Etopan	אתופן XL · Etopan XL
נימוק / הערה	לא תרופה כרונית: האישור בידי הרופא/ה. לפני ההצגה הרפואן בודק כיב קיבה בעבר ותפקוד כליות.

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין כיב קיבה או דימום בעבר	ברשומה אין כיב פפטי או דימום ממערכת העיכול. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	קריאטינין מתועד	קריאטינין/eGFR ואשלגן מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
3	אשלגן (K) תקין	בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מעל 5.0 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K 5.5 ומעלה ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: K 5.5 ומעלה ← לא מחדשים	
4	תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין	בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה ב-30% ומעלה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה.	
5	מדידת ל"ד מתועדת	מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
6	ל"ד מתחת ל-140/90	מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
7	אין נוגד קרישה במקביל	ברשימת התרופות אין נוגד קרישה (קומדין, אליקוויס, קסרלטו, פרדקסה). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
8	אין דימום מתועד	ברשומה או בפנייה אין צואה שחורה, דם בצואה או דימום משמעותי. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה.	
9	הגנה על הקיבה שאלה: גיל 65 ומעלה, כיב בעבר או אספירין/סטרואיד במקביל?	מעכב משאבת פרוטונים ברשימת התרופות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	שאלה
10	אין התווית נגד	אין התווית נגד (מצב שמוציא מהפרוטוקול): אי-ספיקת לב; כיב פעיל או דימום ממערכת העיכול; eGFR מתחת ל-30. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.	התווית נגד
11	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
12	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	

מעקב מעבדה	קריאטינין ואשלגן שנתי; ל"ד
ספי החזרה לרופא/ה	K מעל 5.0; קריאטינין עלה ב-30% ומעלה
ערך חמור	K 5.5 ומעלה
מצבים שמוציאים מהפרוטוקול	אי-ספיקת לב; כיב פעיל או דימום ממערכת העיכול; eGFR מתחת ל-30
תלונות בפנייה או ברשומה	צואה שחורה או הקאה דמית ← דחוף; בצקות או קוצר נשימה ← לרופא; כאב בחזה ← דחוף
מקור	לא מופיע בהנחיות שבפרויקט

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

13.3 תרופה שאינה ברשימה הקבועה · Drug not on the chronic list הכנה לאישור רופא/ה

כל תרופה שלא רשומה כתרופה קבועה

שמות מסחריים (7)	תרופה נוספת | תרופה לא קבועה | המלצת יועץ | מכתב שחרור | המרת מרשם | תכשיר גנרי | החלפה לגנרי
נימוק / הערה	כל תרופה שאינה ברשימה הקבועה (כולל המלצת יועץ/ת, מכתב שחרור, המרת מרשם או מעבר לגנרי) מוצגת לרופא/ה לפני שמתחילים. הרפואן מכין סיכום: איפה תועד, תאריך, שם הרופא/ה ותפקידו/ה, האבחנה וההמלצה.

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	מקור מתועד להמלצה	ביקור, מכתב יועץ/ת או סיכום אשפוז שבו הומלצה התרופה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	פרטי המקור נרשמו	תאריך, שם הרופא/ה ותפקידו/ה, האבחנה וההמלצה — נרשמו בביקור. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	לא כמות גדולה של תרופות חדשות	הבקשה כוללת תרופה אחת או שתיים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
4	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
5	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	

תלונות בפנייה או ברשומה	בקשה לתרופה בלי מקור מתועד ← שיחה עם המטופל/ת או בקשה למסמך, ואז לרופא/ה
מקור	ספר חפיפה עוזרי רופא; החלטה מקומית (3.11.2026)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

13.4 טיפות עיניים עם סטרואיד · Steroid eye drops הכנה לאישור רופא/ה

סטרואיד מקומי לעין

שמות מסחריים (8)	פרד פורטה · Pred Forte | אף-אם-אל ליקויפילם · FML Liquifilm | לוטמקס · Lotemax | מקסיטרול · Maxitrol (עם אנטיביוטיקה) | סטרודקס · Sterodex | דקסאקורט פורטה · Dexacort Forte | דתאמיצין · Dethamycin (עם אנטיביוטיקה) | זיילט · Zylet (עם אנטיביוטיקה)
נימוק / הערה	טיפול ממושך ללא השגחה מעלה לחץ תוך-עיני. רק כשרופא/ת עיניים קבע/ה טיפול לתקופה ארוכה; אחרת — המלצה חדשה מרופא/ת העיניים.

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	קבוע ע"י רופא/ת עיניים לתקופה ארוכה	סיכום רופא/ת עיניים שקובע טיפול ממושך, ומשך הטיפול לא עבר. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	ביקורת עיניים מתועדת	ביקור אצל רופא/ת עיניים בתקופה שנקבעה במעקב. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה.	זימון
3	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
4	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	

תלונות בפנייה או ברשומה	כאב עין, ירידה בראייה או אודם ← דחוף - רופא/ת עיניים
מקור	ספר חפיפה עוזרי רופא; החלטה מקומית (3.11.2026)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

13.5 משחות וקרמים עם סטרואיד · Topical steroids הכנה לאישור רופא/ה

סטרואיד מקומי לעור

שמות מסחריים (16)	דרמובט · Dermovate	קלובטאזול-תרימה · Clobetasol-Trima	בטאקורטן · Betacorten	בטנובט · Betnovate	דיפרוג'נטה · Diprogenta (עם אנטיביוטיקה)	דיפרוסאליק · Diprosalic	אלוקום · Elocom	אדוונטן · Advantan (לאימות)	נרידרם · Neriderm	טבעדרם · Tevaderm	דקטקורט · Daktacort (עם נוגד פטרת)	הידרואגיסטן · Hydroagisten	דרמקומבין · Dermacombin	ציקלודרם C · Cicloderm C	דייבובט · Daivobet (עם קלציפוטריול)	בטאקלציפ טבע · Betacalcip Teva
נימוק / הערה	שימוש ממושך עלול לגרום לדילול ופגיעה בעור. לא לשימוש כרוני. כשמרשם מאושר — הוראה קבועה למטופל/ת.

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	לא שימוש כרוני	לפי הרכישות: אין שימוש רצוף ממושך באותה משחה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
2	אזור הטיפול ידוע	ידוע על איזה אזור מורחים (פנים או קפלי עור — זהירות מיוחדת). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה.	
3	כמות, יחידות ותדירות	לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה.	
4	אין התראת אינטראקציה	כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה.	

תלונות בפנייה או ברשומה	דילול עור, פצעים או החמרה ← לרופא
מקור	ספר חפיפה עוזרי רופא; החלטה מקומית (3.11.2026)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

14. אישורים

13 פריטים · מתאים: 5 · בתנאים: 2 · הכנה לאישור רופא/ה: 2 · רופא/ה בלבד: 4 · גרסה 1 · 2.11.2026

מקורות: חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 07/2024 "מתן תעודות מחלה" (16.7.2024, בתוקף מ-1.9.2024); חוק זכויות החולה. שאר הערכים: החלטה מקומית

14.א כללים

- הרפואן מפיק רק את סוגי האישורים שמסומנים "מתאים לרפואן", בשם הרופא/ה המטפל/ת ובהנחייתו/ה
- כל אישור מתועד ברשומה: סוג, תאריכים, מה נבדק ומי הפיק
- אישור מחלה: בלי אבחנה. נוסח: "עקב בעיה רפואית הרשומה בתיק הרפואי"
- לא מפיקים אישור שמתחיל בעתיד. ההתחלה: היום, או מחר אם הפנייה הגיעה היום
- אישור קצר: עד 4 ימים, ולא יותר מ-4 ימי מחלה קצרים בכל 7 ימים
- רטרואקטיבי: רק לימים שמתועדים ברשומה. בלי תיעוד: רופא/ה בלבד
- מעל 4 ימים: רק לפי המלצה כתובה ברשומה. מעל 30 ימים לאותה מחלה: רופא/ה בלבד
- מידע לצד שלישי ומחלת בן/בת זוג או הורה: רק בהסכמת המטופל/ת
- כשירות, נפגע בעבודה: הרפואן מכין, הרופא/ה מאשר/ת. נשק (הצהרה), נהיגה, פטורים: רופא/ה בלבד
- סימן אזהרה בפנייה: לא מסתפקים באישור, העברה מיידית לרופא/ה
- לפני כל אישור: לבדוק את הפניות מ-5 הימים האחרונים (בקשה כפולה או חריגה ← לרופא/ה)
- אישור בריאות: נדרש ביקור במרפאה בשנה האחרונה; אחרת זימון
- קנאביס: לא מטופל ע"י רפואן, לרופא/ה

14.ג בדיקות משותפות

שלב	נושא	מה בודקים	קריטריון	אם לא מתקיים	מקור
לפני כל אישור	זהות המבקש/ת	מטופל/ת, הורה של קטין או מי שיש לו הסכמה	המבקש/ת מורשה לקבל את המסמך	לא ← לא מופק	חוק זכויות החולה סעיף 20
לפני כל אישור	סימני אזהרה	קריאת הפנייה	אין כאב בחזה, קוצר נשימה, סימן נוירולוגי, מחשבות אובדניות ועוד	יש ← העברה מיידית לרופא/ה	החלטה מקומית
לפני כל אישור	סוג האישור	לפי הטבלה בלשונית "חיפוש"	מתאים לרפואן או בתנאים שמתקיימים	לא ← הכנה והעברה לרופא/ה	נוהל רפואן
אישורי מחלה	תאריך התחלה	יום הפנייה	היום או קודם; לא עתידי	עתידי ← לא מופק	חוזר 07/2024
אישורי מחלה	אורך וחלון 7 ימים	אישורים קודמים ברשומה	עד 4 ימים; לא יותר מ-4 ימים קצרים ב-7 ימים	לא ← מפגש עם רופא/ה (גם מרחוק)	חוזר 07/2024
אישורי מחלה	ימים רטרואקטיביים	תיעוד לאותם ימים	כל יום מכוסה בתיעוד	לא ← רופא/ה בלבד	חוזר 07/2024
אישורי מחלה	נוסח	גוף האישור	בלי אבחנה	תיקון לפני ההפקה	חוזר 07/2024
אחרי ההפקה	תיעוד והודעה	רשומה והודעה למטופל/ת	נרשם ברשומה; הודעה נשלחה	—	חוזר 07/2024 (חובת תיעוד)

14.ד החלטות

#	נושא	מה ההנחיה אומרת	ההחלטה לפרוטוקול	סוג	מקור
1	אישור קצר ללא מפגש	רופא/ה רשאי/ת לחתום על אישור עד 4 ימים לאחר פנייה דיגיטלית, ללא מפגש	הרפואן מפיק אישור קצר בשם הרופא/ה ובהנחייתו/ה, כשכל התנאים מתקיימים	החלטה מקומית (הצעה) — לאישור משפטי	חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 07/2024 "מתן תעודות מחלה" (16.7.2024, בתוקף מ-1.9.2024)
2	חלון 7 ימים	לא יותר מ-4 ימי מחלה באישורים קצרים בכל 7 ימים	חריגה ← מפגש עם רופא/ה (גם מרחוק)	הנחיה	חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 07/2024 "מתן תעודות מחלה" (16.7.2024, בתוקף מ-1.9.2024)

#	נושא	מה ההנחיה אומרת	ההחלטה לפרוטוקול	סוג	מקור
3	רטרואקטיבי	עם תיעוד: לימים שהרשומה תומכת בהם. בלי תיעוד: לפי שיקול רפואי ולחודש הקלנדרי הקודם בלבד	הרפואן: רק עם תיעוד. בלי תיעוד: רופא/ה בלבד	הכרעה	חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 07/2024 "מתן תעודות מחלה" (16.7.2024, בתוקף מ-1.9.2024)
4	אישור עתידי	אסור לתת אישור שמתחיל בעתיד; מותר מהיום שאחרי הפנייה	כמו בהנחיה	הנחיה	חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 07/2024 "מתן תעודות מחלה" (16.7.2024, בתוקף מ-1.9.2024)
5	מעל 4 ימים	רופא/ה רשאי/ת בלי מפגש כשהרשומה מראה צורך (למשל אחרי ניתוח); קבוצות חריגות מוגדרות	הרפואן רק לפי המלצה כתובה ובמספר הימים שבה; אחרת רופא/ה	החלטה מקומית (הצעה)	חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 07/2024 "מתן תעודות מחלה" (16.7.2024, בתוקף מ-1.9.2024)
6	מעל 30 ימים	נדרשת המלצת מומחה/ית בכתב או חתימת מנהל/ת רפואי/ת	רופא/ה בלבד	הנחיה	חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 07/2024 "מתן תעודות מחלה" (16.7.2024, בתוקף מ-1.9.2024)
7	אבחנה באישור	אסור לציין אבחנה; נוסח ניטרלי	כמו בהנחיה	הנחיה	חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 07/2024 "מתן תעודות מחלה" (16.7.2024, בתוקף מ-1.9.2024)
8	אישור מנהלי עצמי בקופה	לקופה מותר להפיק אישור קצר בלי חתימת רופא: עד 4 פעמים ו-10 ימים בשנה, עד שבוע אחורה, למחלת העובד/ת בלבד	הרפואן לא מפנה לשירות במקום אישור שעומד בתנאים. אפשר לציין אותו בהודעה למטופל/ת — לדיון	החלטה מקומית (לדיון)	חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 07/2024 "מתן תעודות מחלה" (16.7.2024, בתוקף מ-1.9.2024); תקנות דמי מחלה (נוהל לתשלום), תיקון 2024
9	אישורים חוזרים	לא מופיע	3 אישורים ומעלה ב-3 חודשים ← הודעה לרופא/ה לפני הנפקה	החלטה מקומית (הצעה)	—
10	מחלת בן/בת זוג או הורה	החוזר עוסק במחלת העובד/ת; מחלת בן משפחה לפי תקנות דמי מחלה	רק בהסכמת החולה הבגיר/ה; בתיק החולה; בלי אבחנה	החלטה מקומית (הצעה)	חוק זכויות החולה סעיף 20
11	אישור בריאות	לא מופיע	הרפואן מכין; הרופא/ה מאשר/ת. בדיקה גופנית ב-6 חודשים. ספורט תחרותי מחוץ לפרוטוקול	החלטה מקומית (מכלי הרפואן)	כלי רפואן
12	רשומה ריקה	לא מופיע	נוסח: "ללא מחלות רקע וללא טיפול תרופתי קבוע הידועים ברשומה"	החלטה מקומית (הצעה)	—
13	נשק, נהיגה, פטורים	לא מופיע	הצהרת נשק: פנים אל פנים. נהיגה ופטורים: רופא/ה בלבד	החלטה מקומית	כלי רפואן
14	היסטוריית בקשות	-	בקשה זהה או חריגה ב-5 הימים האחרונים ← לרופא/ה	החלטה מקומית (3.11.2026)	ספר חפיפה עוזרי רופא
15	אישור מחלה ממושך	-	רק לפי ביקור אחרון או מכתב יועץ/ת שתואמים את התלונה ואת מספר הימים	החלטה מקומית (3.11.2026)	ספר חפיפה עוזרי רופא
16	קנאביס	-	לא מטופל ע"י רפואן	החלטה מקומית (3.11.2026)	ספר חפיפה עוזרי רופא
17	אישור בריאות	-	ביקור במרפאה בשנה האחרונה (במקום בדיקה גופנית ב-6 חודשים)	החלטה מקומית (3.11.2026)	ספר חפיפה עוזרי רופא

14.ה רשימת סוגי אישורים (לסימון)

#	שם		קבוצה	התאמה	אושר	הערות
14.1	אישור מחלה קצר (עד 4 ימים)		אישורי מחלה · מחלת המטופל/ת	מתאים	☐	

#	שם		קבוצה	התאמה	אושר	הערות
14.2	אישור מחלה ממושך או המשך (מעל 4 ימים)		אישורי מחלה · מחלת המטופל/ת	בתנאים	☐	
14.3	מחלת ילד/ה (היעדרות הורה)		אישורי מחלה · בן/בת משפחה	מתאים	☐	
14.4	מחלת בן/בת זוג או הורה		אישורי מחלה · בן/בת משפחה	בתנאים	☐	
14.5	אישור בריאות (כשירות)		אישורי כשירות	הכנה לאישור רופא/ה	☐	
14.6	סיכום מידע רפואי		סיכומים ומידע לצד שלישי	מתאים	☐	
14.7	אישור רפואי לגורם שלישי		סיכומים ומידע לצד שלישי	מתאים	☐	
14.8	תעודה לנפגע בעבודה (ב.ל. 250)		מסמכים משפטיים	הכנה לאישור רופא/ה	☐	
14.9	רישיון נשק: סיכום מידע רפואי		מסמכים משפטיים	מתאים	☐	
14.10	רישיון נשק: הצהרת רופא/ה מטפל/ת		מסמכים משפטיים	רופא/ה בלבד	☐	
14.11	רישיון נהיגה (טופס ירוק, חידוש, דיווח)		מסמכים משפטיים	רופא/ה בלבד	☐	
14.12	פטור או התאמות (ספורט, עבודה, צבא, לימודים)		אישורי כשירות	רופא/ה בלבד	☐	
14.13	קנאביס (אישור, סיכום או רישיון)		אישורים · רופא/ה בלבד	רופא/ה בלבד	☐	

14.ו פירוט מלא

14.1 אישור מחלה קצר (עד 4 ימים) מתאים

אישורי מחלה · מחלת המטופל/ת

נקרא גם	אישור מחלה | ימי מחלה | תעודת מחלה | יום מחלה
נימוק / הערה	אישור קצר מותר ללא מפגש עם רופא/ה; הרפואן מפיק בשם הרופא/ה ובהנחייתו/ה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**לא מתחיל בעתיד**	אישור שמתחיל בתאריך עתידי אסור. אפשר שהאישור יתחיל ביום שאחרי הפנייה. לא מתקיים ← לא מופקים, הודעה למטופל/ת לפנות ביום ההיעדרות.	התוויית נגד
2	**אין בקשה כפולה**	בקשה כפולה, בקשה שכבר טופלה או דפוס חריג ← לא מפיקים; לבדיקת הרופא/ה.	התוויית נגד
3	**עד 4 ימים**	אישור קצר: עד 4 ימים רצופים. מעל 4 ← לפי "אישור מחלה ממושך" או לרופא/ה.	
4	**חלון 7 ימים**	מעל 4 ימים באישורים קצרים בתוך 7 ימים ← לא מופקים, נדרש מפגש עם רופא/ה (גם בווידאו, בטלפון או בהתכתבות).	זימון
5	**ימים רטרואקטיביים מתועדים** שאלה: האם האישור כולל ימים שלפני יום הפנייה?	רטרואקטיבי רק למספר הימים שהרשומה תומכת בו. בלי תיעוד ← לרופא/ה: רק רופא/ה רשאי/ת, מנימוק רפואי ורק לחודש הקלנדרי הקודם.	שאלה
6	**אין סימני אזהרה בפנייה**	יש סימן אזהרה ← לא מסתפקים באישור: העברה מיידית לרופא/ה.	התוויית נגד
7	**אין דפוס חוזר**	3 אישורים ומעלה ב-3 חודשים ← הודעה לרופא/ה לפני הנפקה.	
8	**נוסח ללא אבחנה**	האישור לא כולל אבחנה או פרט רפואי. האבחנה והאישור נרשמים ברשומה הרפואית.	

תלונות בפנייה או ברשומה	כאב בחזה, קוצר נשימה, חולשה או הפרעת דיבור חדשה ← דחוף: לרופא/ה מיד או מוקד/מיון; מחשבות אובדניות או מצוקה נפשית קשה ← דחוף: לרופא/ה מיד; חום מעל 3 ימים או החמרה למרות טיפול ← לרופא/ה לפני הנפקה
מקור	חוזר 07/2024 סעיפים: אישור קצר, חלון 7 ימים, רטרואקטיבי, תוכן האישור

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

14.2 אישור מחלה ממושך או המשך (מעל 4 ימים) בתנאים

אישורי מחלה · מחלת המטופל/ת

נקרא גם	המשך אישור מחלה | הארכת אישור מחלה | אחרי ניתוח | מכתב שחרור
נימוק / הערה	רק כשביקור אחרון או מכתב יועץ/ת תואמים את התלונה ואת אורך ההיעדרות; אחרת לרופא/ה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**לא מתחיל בעתיד**	אישור שמתחיל בתאריך עתידי אסור. אפשר שהאישור יתחיל ביום שאחרי הפנייה. לא מתקיים ← לא מופקים, הודעה למטופל/ת לפנות ביום ההיעדרות.	התוויית נגד
2	**אין בקשה כפולה**	בקשה כפולה, בקשה שכבר טופלה או דפוס חריג ← לא מפיקים; לבדיקת הרופא/ה.	התוויית נגד
3	**ביקור או מכתב יועץ/ת תואמים**	לחפש ברישומי הביקורים, בביקורי יועצים, במידע הכרונולוגי ובפורטל. יש ← מפיקים לפיו. אין ← לרופא/ה (אפשר לבקש מהמטופל/ת מסמך).	
4	**תואם להמלצה**	האישור לא חורג מההמלצה. חריגה ← לרופא/ה.	
5	**עד 30 ימים לאותה מחלה**	מעל 30 ימים ← רופא/ה בלבד: נדרשת המלצת מומחה/ית בכתב או חתימת מנהל/ת רפואי/ת.	התוויית נגד
6	**ימים רטרואקטיביים מתועדים** שאלה: האם האישור כולל ימים שלפני יום הפנייה?	רטרואקטיבי רק למספר הימים שהרשומה תומכת בו. בלי תיעוד ← לרופא/ה: רק רופא/ה רשאי/ת, מנימוק רפואי ורק לחודש הקלנדרי הקודם.	שאלה
7	**אין סימני אזהרה בפנייה**	יש סימן אזהרה ← לא מסתפקים באישור: העברה מיידית לרופא/ה.	התוויית נגד
8	**נוסח ללא אבחנה**	האישור לא כולל אבחנה או פרט רפואי. האבחנה והאישור נרשמים ברשומה הרפואית.	

תלונות בפנייה או ברשומה	כאב בחזה, קוצר נשימה, חולשה או הפרעת דיבור חדשה ← דחוף: לרופא/ה מיד או מוקד/מיון; מחשבות אובדניות או מצוקה נפשית קשה ← דחוף: לרופא/ה מיד; חום מעל 3 ימים או החמרה למרות טיפול ← לרופא/ה לפני הנפקה
מקור	חוזר 07/2024 סעיפים: אישור ממושך, אוכלוסיות חריגות, 30 ימים

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

14.3 מחלת ילד/ה (היעדרות הורה) מתאים

אישורי מחלה · בן/בת משפחה

נקרא גם	ילד חולה | מחלת ילד | הבן שלי חולה | הבת שלי חולה | היעדרות מהגן
נימוק / הערה	אותם כללים כמו אישור קצר; האישור מופק בתיק הילד/ה. אין חלופה של אישור מנהלי עצמי

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	בתיק הילד/ה, ע"י הורה	המבקש/ת אינו/ה הורה רשום/ה ← לא מופק, לבירור במזכירות.	התווית נגד
2	אין בקשה כפולה	בקשה כפולה, בקשה שכבר טופלה או דפוס חריג ← לא מפיקים; לבדיקת הרופא/ה.	התווית נגד
3	לא מתחיל בעתיד	אישור שמתחיל בתאריך עתידי אסור. אפשר שהאישור יתחיל ביום שאחרי הפנייה. לא מתקיים ← לא מופקים, הודעה למטופל/ת לפנות ביום ההיעדרות.	התווית נגד
4	עד 4 ימים	אישור קצר: עד 4 ימים רצופים. מעל 4 ← לפי "אישור מחלה ממושך" או לרופא/ה.	
5	חלון 7 ימים	מעל 4 ימים באישורים קצרים בתוך 7 ימים ← לא מופקים, נדרש מפגש עם רופא/ה (גם בווידאו, בטלפון או בהתכתבות).	זימון
6	ימים רטרואקטיביים מתועדים שאלה: האם האישור כולל ימים שלפני יום הפנייה?	רטרואקטיבי רק למספר הימים שהרשומה תומכת בו. בלי תיעוד ← לרופא/ה: רק רופא/ה רשאי/ת, מנימוק רפואי ורק לחודש הקלנדרי הקודם.	שאלה
7	אין סימני אזהרה אצל הילד/ה	יש סימן אזהרה ← העברה מיידית לרופא/ה.	התווית נגד
8	נוסח ללא אבחנה	האישור לא כולל אבחנה או פרט רפואי. האבחנה והאישור נרשמים ברשומה הרפואית.	

תלונות בפנייה או ברשומה	תינוק/ת מתחת לגיל 3 חודשים עם חום ← דחוף: לרופא/ה מיד או מיון; ישנוניות, קוצר נשימה, התייבשות או פריחה שלא מחווירה ← דחוף: לרופא/ה מיד
מקור	חוזר 07/2024 (כללי אישור קצר ורטרואקטיבי); תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

14.4 מחלת בן/בת זוג או הורה בתנאים

אישורי מחלה · בן/בת משפחה

נקרא גם	מחלת בן זוג | מחלת בת זוג | מחלת הורה | ליווי הורה
נימוק / הערה	מותר רק בהסכמת החולה הבגיר/ה; האישור מופק בתיק החולה, בלי אבחנה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	הסכמת החולה	מידע על מחלת בגיר/ה נמסר לבן משפחה רק בהסכמתו/ה. אין ← לא מופק.	התווית נגד
2	אין בקשה כפולה	בקשה כפולה, בקשה שכבר טופלה או דפוס חריג ← לא מפיקים; לבדיקת הרופא/ה.	התווית נגד
3	לא מתחיל בעתיד	אישור שמתחיל בתאריך עתידי אסור. אפשר שהאישור יתחיל ביום שאחרי הפנייה. לא מתקיים ← לא מופקים, הודעה למטופל/ת לפנות ביום ההיעדרות.	התווית נגד
4	עד 4 ימים	אישור קצר: עד 4 ימים רצופים. מעל 4 ← לפי "אישור מחלה ממושך" או לרופא/ה.	
5	ימים רטרואקטיביים מתועדים שאלה: האם האישור כולל ימים שלפני יום הפנייה?	רטרואקטיבי רק למספר הימים שהרשומה תומכת בו. בלי תיעוד ← לרופא/ה: רק רופא/ה רשאי/ת, מנימוק רפואי ורק לחודש הקלנדרי הקודם.	שאלה
6	אין סימני אזהרה בפנייה	יש סימן אזהרה ← לא מסתפקים באישור: העברה מיידית לרופא/ה.	התווית נגד
7	נוסח ללא אבחנה	האישור לא כולל אבחנה או פרט רפואי. האבחנה והאישור נרשמים ברשומה הרפואית.	

תלונות בפנייה או ברשומה	כאב בחזה, קוצר נשימה, חולשה או הפרעת דיבור חדשה ← דחוף: לרופא/ה מיד או מוקד/מיון; מחשבות אובדניות או מצוקה נפשית קשה ← דחוף: לרופא/ה מיד; חום מעל 3 ימים או החמרה למרות טיפול ← לרופא/ה לפני הנפקה
מקור	חוזר 07/2024; חוק זכויות החולה סעיף 20. התנאי של הסכמה: החלטה מקומית

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

14.5 אישור בריאות (כשירות) הכנה לאישור רופא/ה

אישורי כשירות

נקרא גם	אישור כשירות | כשיר | חדר כושר | מילואים | אישור לעבודה
נימוק / הערה	קביעת כשירות היא החלטה רפואית: הרפואן מכין, הרופא/ה מאשר/ת וחותם/ת. נדרש ביקור במרפאה בשנה האחרונה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**מטרה וטופס**	חסר ← לבקש מהמטופל/ת את הטופס לפני ההכנה.	
2	**ביקור במרפאה בשנה האחרונה**	אין ← זימון לביקור לפני הכנת האישור.	זימון
3	**אין בקשה כפולה**	בקשה כפולה, בקשה שכבר טופלה או דפוס חריג ← לא מפיקים; לבדיקת הרופא/ה.	התווית נגד
4	**אין בירור או אירוע פתוח**	יש ← לציין בהעברה לרופא/ה.	
5	**לא ספורט תחרותי**	ספורט תחרותי ← מחוץ לפרוטוקול, לרופא/ה.	התווית נגד

מקור	נוהל רפואן (כלי רפואן: בדיקה גופנית ב-6 חודשים). שאר התנאים: החלטה מקומית (הצעה)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

14.6 סיכום מידע רפואי מתאים

סיכומים ומידע לצד שלישי

נקרא גם	סיכום רפואי | סיכום מידע | תמצית רשומה
נימוק / הערה	הפקה אוטומטית מהרשומה (אבחנות, תרופות קבועות, רגישויות), בלי חוות דעת

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**המבקש/ת מורשה**	מידע רפואי נמסר לצד שלישי רק בהסכמת המטופל/ת (חוק זכויות החולה, סעיף 20). אין הסכמה ← לא מופק.	התווית נגד
2	**אין בקשה כפולה**	בקשה כפולה, בקשה שכבר טופלה או דפוס חריג ← לא מפיקים; לבדיקת הרופא/ה.	התווית נגד
3	**תמצית בלבד**	הגורם המבקש רוצה חוות דעת, הערכת תפקוד או כשירות ← לרופא/ה.	התווית נגד
4	**הרשומה עדכנית**	סתירה בולטת (תרופה שהופסקה, אבחנה שגויה) ← לרופא/ה לתיקון לפני ההפקה.	
5	**קנאביס: נוסח ניטרלי** שאלה: האם הסיכום מיועד לבקשת רישיון קנאביס?	רק כשהבקשה לקנאביס. אין המלצה, הערכה או מילוי טופס רישיון.	שאלה

מקור	חוק זכויות החולה סעיפים 18, 20; נוהל רפואן. נוסח הקנאביס: כלי רפואן

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

14.7 אישור רפואי לגורם שלישי מתאים

סיכומים ומידע לצד שלישי

נקרא גם	ביטוח לאומי | חברת ביטוח | רופא שיניים | אישור רפואי
נימוק / הערה	כשהגורם מבקש מידע מהרשומה בלבד; שאלון או חוות דעת עוברים לרופא/ה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**המבקש/ת מורשה**	מידע רפואי נמסר לצד שלישי רק בהסכמת המטופל/ת (חוק זכויות החולה, סעיף 20). אין הסכמה ← לא מופק.	התווית נגד
2	**אין בקשה כפולה**	בקשה כפולה, בקשה שכבר טופלה או דפוס חריג ← לא מפיקים; לבדיקת הרופא/ה.	התווית נגד
3	**לא שאלון ולא חוות דעת**	שאלון, הצהרה או חוות דעת ← לרופא/ה.	התווית נגד
4	**רשומה ריקה: נוסח זהיר** שאלה: האם הרשומה ריקה מאבחנות ותרופות?	לא לכתוב "בריא/ה" או "ללא מחלות" בלי הסייג "הידועים ברשומה".	שאלה

מקור	חוק זכויות החולה סעיף 20; נוהל רפואן. הסייג "הידועים ברשומה": החלטה מקומית (הצעה)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

14.8 תעודה לנפגע בעבודה (ב.ל. 250) הכנה לאישור רופא/ה

מסמכים משפטיים

נקרא גם	תאונת עבודה | נפגעתי בעבודה | תעודה רפואית לנפגע
נימוק / הערה	מסמך משפטי: הרפואן מכין, הרופא/ה מאשר/ת לפני ההפקה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**הפגיעה מתועדת**	אין תיעוד ← זימון לבדיקה במרפאה.	זימון
2	**אין בקשה כפולה**	בקשה כפולה, בקשה שכבר טופלה או דפוס חריג ← לא מפיקים; לבדיקת הרופא/ה.	התווית נגד
3	**ימים לפי המלצה**	אין המלצה ← הרופא/ה קובע/ת.	
4	**לא מתחיל בעתיד**	אישור שמתחיל בתאריך עתידי אסור. אפשר שהאישור יתחיל ביום שאחרי הפנייה. לא מתקיים ← לא מופקים, הודעה למטופל/ת לפנות ביום ההיעדרות.	התווית נגד

מקור	כלי רפואן ("דורש אישור מקדים של הרופא/ה"). החלטה מקומית

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

14.9 רישיון נשק: סיכום מידע רפואי מתאים

מסמכים משפטיים

נקרא גם	נשק | רישיון נשק
נימוק / הערה	השלב הראשון הוא סיכום מידע רפואי בלבד

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**המבקש/ת מורשה**	מידע רפואי נמסר לצד שלישי רק בהסכמת המטופל/ת (חוק זכויות החולה, סעיף 20). אין הסכמה ← לא מופק.	התווית נגד
2	**אין בקשה כפולה**	בקשה כפולה, בקשה שכבר טופלה או דפוס חריג ← לא מפיקים; לבדיקת הרופא/ה.	התווית נגד
3	**סיכום בלבד**	הצהרת רופא/ה ← רופא/ה בלבד, במפגש פנים אל פנים.	התווית נגד

תלונות בפנייה או ברשומה	אמירה על פגיעה בעצמו/ה או באחרים ← דחוף: לרופא/ה מיד
מקור	כלי רפואן (אישור לנשק). החלטה מקומית

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

14.10 רישיון נשק: הצהרת רופא/ה מטפל/ת רופא/ה בלבד

מסמכים משפטיים

נקרא גם	הצהרת בריאות לנשק
נימוק / הערה	מחייבת מעבר על כל התיק במפגש פנים אל פנים
הנחיה	**רופא/ה בלבד, במפגש פנים אל פנים. הרפואן מודיע/ה למטופל/ת לקבוע תור ומפיק/ה רק סיכום מידע אם התבקש.**
מקור	כלי רפואן. החלטה מקומית

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

14.11 רישיון נהיגה (טופס ירוק, חידוש, דיווח) רופא/ה בלבד

מסמכים משפטיים

נקרא גם	טופס ירוק | רישיון נהיגה | רשות הרישוי
נימוק / הערה	קביעת כשירות לנהיגה היא החלטה רפואית
הנחיה	**רופא/ה בלבד. הרפואן מעביר/ה את הבקשה לרופא/ה ומודיע/ה למטופל/ת שייתכן שיידרש ביקור.**
מקור	החלטה מקומית

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

14.12 פטור או התאמות (ספורט, עבודה, צבא, לימודים) רופא/ה בלבד

אישורי כשירות

נקרא גם	פטור מספורט | התאמות | פטור | הקלות בעבודה
נימוק / הערה	פטור או התאמה הם המלצה רפואית שהרופא/ה קובע/ת
הנחיה	**רופא/ה בלבד. אם יש המלצת יועץ/ת ברשומה, לצרף אותה להעברה לרופא/ה.**
מקור	החלטה מקומית

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

14.13 קנאביס (אישור, סיכום או רישיון) רופא/ה בלבד

אישורים · רופא/ה בלבד

נקרא גם	קנאביס | קנאביס רפואי | רישיון קנאביס
נימוק / הערה	החלטה 3.11.2026: הרפואן לא מטפל בבקשות קנאביס
הנחיה	**בקשות לקנאביס (אישור, סיכום מידע, חידוש רישיון) — לא מטופלות ע"י רפואן. להעביר לרופא/ה.**
מקור	החלטה מקומית (3.11.2026)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

15. פניות דיגיטליות

13 פריטים · מתאים: 2 · בתנאים: 1 · הכנה לאישור רופא/ה: 1 · רופא/ה בלבד: 9 · גרסה 1 · 2.11.2026

מקורות: המדריך למדריך ברפואת המשפחה, מכבי (2017), עמ' 32-34: "כיצד נלמד מתמחים לקיים ביקורים וירטואליים איכותיים", ד"ר גליה מאירי וד"ר תמי ברמן (ינואר 2016)

15.א כללים

- ביקור וירטואלי הוא ביקור לכל דבר: מתעדים, מציינים שזו פנייה מקוונת, רושמים אבחנה
- לפני המענה: קוראים את הרשומה — ביקורים אחרונים, גורמי סיכון, בדיקות ורפואה מונעת
- פנייה מקוונת איננה רק "הוצאת מרשמים כי זה מה שביקשו"
- מתאים: חידוש תרופות כרוניות למאוזן/ת, הפניה לבדיקות מעקב, סיכום מידע, אישורים לפי הפרוטוקול
- מסרבים: דחוף, תסמין חדש, ממצא גופני, מטופל/ת לא מוכר/ת או לא מאוזן/ת, סוגיה נפשית, בקשה מורכבת או טופס מורכב, מרשם לא מנומק
- סירוב: מנומק ומנומס, מציע חלופה (ביקור, שיחה טלפונית, וידאו). אפשר לאשר עם הסתייגות ("בעתיד...")
- תשובה: מלאה, ברורה, תמציתית, בעברית תקנית; בלי ראשי תיבות (סונר, US, ת"ל); הנחיות מפורשות — מה לעשות ומתי
- מענה רק בערוץ הרשמי (מערכת הפניות של מכבי), לא ב-WhatsApp או SMS אישי
- דחוף: לא מחכים — הנחיה מיידית למוקד/מיון והודעה מיידית לרופא/ה

15.ב תוצאות אפשריות

תוצאה	נוסח בתיעוד
טופל ע"י רפואן ונענה	תוצאה: הפנייה טופלה ע"י רפואן לפי הפרוטוקול ונענתה.
הוכן והועבר לרופא/ה	תוצאה: הפנייה הוכנה והועברה להחלטת הרופא/ה.
סירוב מנומק: זימון לביקור או לשיחה	תוצאה: לא מתאים למענה מקוון. נשלח סירוב מנומק והזמנה לביקור או לשיחה.
דחוף: מוקד/מיון והודעה מיידית לרופא/ה	תוצאה: פנייה דחופה. המטופל/ת הונחה לפנות למוקד/מיון; הרופא/ה עודכן/ה מיד.

15.ג בדיקות משותפות

שלב	נושא	מה בודקים	קריטריון	אם לא מתקיים	מקור
לפני כל מענה	דחיפות	קריאת הפנייה	אין חשד לאירוע לבבי/מוחי, קוצר נשימה, חום גבוה במיוחד, מחשבות אובדניות	יש ← מוקד/מיון + הודעה מיידית לרופא/ה	המדריך למדריך עמ' 32-34
לפני כל מענה	מי פונה	החשבון השולח	המטופל/ת או הורה של קטין/ה	אחר ← לפנות מהחשבון של המטופל/ת	המדריך למדריך עמ' 32-34
לפני כל מענה	סוג הפנייה	לפי הלשונית "חיפוש"	מתאים למענה מקוון	לא ← סירוב מנומק + זימון	המדריך למדריך עמ' 32-34
לפני כל מענה	הרשומה	ביקורים, גורמי סיכון, בדיקות, רפואה מונעת	נקראה; חוסרים בולטים צוינו לרופא/ה	—	המדריך למדריך עמ' 32-34
המענה	נוסח	ההודעה למטופל/ת	מלא, מנומס, תמציתי, עברית תקנית, בלי קיצורים	תיקון לפני שליחה	המדריך למדריך עמ' 32-34
המענה	ערוץ	מערכת הפניות	רק בערוץ הרשמי	—	המדריך למדריך עמ' 32-34 (שיקולי WhatsApp/SMS); החלטה מקומית
אחרי המענה	תיעוד	רשומה	פנייה מקוונת; מידע מערוצים אחרים; אבחנה	—	המדריך למדריך עמ' 32-34

15.ד החלטות

#	נושא	מה ההנחיה אומרת	ההחלטה לפרוטוקול	סוג	מקור
1	מי עונה	המדריך נכתב למתמחים: מענה מקוון רק אחרי 3 חודשים במרפאה ובאישור המדריך	הרפואן עונה רק על סוגי הפניות שמסומנים "מתאים", בשם הרופא/ה ובהנחייתו/ה	החלטה מקומית (הצעה)	המדריך למדריך עמ' 32-34

#	נושא	מה ההנחיה אומרת	ההחלטה לפרוטוקול	סוג	מקור
2	משוב על תוצאות	מסומן בסימן שאלה	רפואן משיב רק כשכל הערכים תקינים ואין שאלה קלינית; אחרת רופא/ה	החלטה מקומית (לדיון)	המדריך למדריך עמ' 32-34
3	אישור מחלה	מסומן בסימן שאלה (2016)	לפי לשונית האישורים (חוזר 07/2024)	הכרעה	המדריך למדריך עמ' 32-34; חוזר 07/2024
4	הפניה לבדיקות	"הפנייה לבדיקות מעקב (סוכר, ליפידים, ממצא בהדמיה)"	מעבדה למעקב: רפואן. הדמיה: מכין, הרופא/ה מאשר/ת	הכרעה	המדריך למדריך עמ' 32-34
5	סירוב	לא כל סירוב אבסולוטי; אפשר לאשר עם הסתייגות; טקסט אוטומטי	הודעות סירוב מוכנות לכל סוג פנייה	הנחיה	המדריך למדריך עמ' 32-34
6	WhatsApp/SMS	שיקולים בעד ונגד, בלי הכרעה	מענה רק בערוץ הרשמי	החלטה מקומית (הצעה)	המדריך למדריך עמ' 32-34
7	זמן מענה	הנחיה למטופלים: "הרופא נדרש לענות תוך 5 ימי עבודה"	לבדוק מול הנוהל הנוכחי של מכבי	לבדיקה	המדריך למדריך עמ' 32-34
8	מענה לפנייה נפשית	לא מופיע מעבר ל"לסרב"	בהודעה: ער"ן 1201 ופנייה מיידית במצוקה קשה	החלטה מקומית (הצעה)	—

15.ה רשימת סוגי פניות (לסימון)

#	שם		קבוצה	התאמה	אושר	הערות
15.1	חידוש מרשם כרוני		פניות מתאימות למענה מקוון	מתאים	☐	
15.2	הפניה לבדיקות מעקב		פניות מתאימות למענה מקוון	בתנאים	☐	
15.3	הפניה להדמיה למעקב אחרי ממצא		פניות מתאימות למענה מקוון	הכנה לאישור רופא/ה	☐	
15.4	משוב על תוצאות בדיקות		פניות מתאימות למענה מקוון	רופא/ה בלבד	☐	
15.5	אישורים וסיכום מידע רפואי		פניות מתאימות למענה מקוון	מתאים	☐	
15.6	בקשות חוזרות לאישורי מחלה		פניות שמסרבים להן	רופא/ה בלבד	☐	
15.7	מרשם חדש שאינו תרופה קבועה		פניות שמסרבים להן	רופא/ה בלבד	☐	
15.8	תסמין או תלונה חדשים		פניות שמסרבים להן	רופא/ה בלבד	☐	
15.9	ממצא גופני או תמונה (פריחה, נגע)		פניות שמסרבים להן	רופא/ה בלבד	☐	
15.10	אישור או טופס רפואי מורכב		פניות שמסרבים להן	רופא/ה בלבד	☐	
15.11	פנייה רגשית או חברתית		פניות שמסרבים להן	רופא/ה בלבד	☐	
15.12	פנייה בשם מטופל/ת אחר/ת		פניות שמסרבים להן	רופא/ה בלבד	☐	
15.13	פנייה דחופה		פניות שמסרבים להן	רופא/ה בלבד	☐	

ו.15 פירוט מלא

15.1 חידוש מרשם כרוני מתאים

פניות מתאימות למענה מקוון

נקרא גם	חידוש מרשם | חידוש תרופות | מרשם קבוע | נגמרו הכדורים
נימוק / הערה	פנייה מתאימה כשהמטופל/ת מאוזן/ת. הבדיקות לכל תרופה: בלשוניות התרופות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין סימני דחיפות	יש ← לא עונים במקוון: הנחיה מיידית למוקד/מיון (101 בחירום) והודעה מיידית לרופא/ה.	התוויית נגד
2	הפנייה על המטופל/ת עצמו/ה	פנייה על בן/בת זוג או בן משפחה בוגר מהחשבון שלך ← לא עונים לגופה; מבקשים לפנות מהחשבון של המטופל/ת.	התוויית נגד
3	מאוזן/ת ומבצע/ת מעקב	לא מאוזן/ת, לא ביצע/ה מעקב או חוסר היענות ← לפי פרוטוקול התרופה: חידוש לחודש וזימון.	זימון
4	עברתי על הרשומה	המדריך: מצפים לקרוא ולהתייחס לביקורים אחרונים, גורמי סיכון, רפואה מונעת ובדיקות. חוסר בולט ← לציין בהודעה לרופא/ה.	
5	תיעוד כביקור	ביקור וירטואלי הוא ביקור לכל דבר: מתעדים, רושמים SOAP כשרלוונטי ומכניסים אבחנה.	

הודעה למטופל/ת	שלום, המרשם חודש וזמין לרכישה בבית המרקחת. ___
מקור	המדריך למדריך עמ' 32-34

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

15.2 הפניה לבדיקות מעקב בתנאים

פניות מתאימות למענה מקוון

נקרא גם	הפניה לבדיקת דם | בדיקות דם | בדיקות מעקב | הפניה לבדיקות
נימוק / הערה	בדיקות מעקב של מחלה ידועה (סוכר, שומנים, תפקודי כליות) לפי פרוטוקול; בירור תלונה חדשה — לא

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין סימני דחיפות	יש ← לא עונים במקוון: הנחיה מיידית למוקד/מיון (101 בחירום) והודעה מיידית לרופא/ה.	התוויית נגד
2	הפנייה על המטופל/ת עצמו/ה	פנייה על בן/בת זוג או בן משפחה בוגר מהחשבון שלך ← לא עונים לגופה; מבקשים לפנות מהחשבון של המטופל/ת.	התוויית נגד
3	מעקב של מצב ידוע	בדיקה לבירור תלונה חדשה ← לא במקוון ע"י רפואן: לרופא/ה או לביקור.	
4	הגיע הזמן	מוקדם מהמקובל ← לרופא/ה.	
5	עברתי על הרשומה	המדריך: מצפים לקרוא ולהתייחס לביקורים אחרונים, גורמי סיכון, רפואה מונעת ובדיקות. חוסר בולט ← לציין בהודעה לרופא/ה.	
6	תיעוד כביקור	ביקור וירטואלי הוא ביקור לכל דבר: מתעדים, רושמים SOAP כשרלוונטי ומכניסים אבחנה.	

הודעה למטופל/ת	שלום, ההפניה לבדיקות ___ הופקה ונמצאת באפליקציה. ניתן לקבוע תור למעבדה דרך האפליקציה.
מקור	המדריך למדריך עמ' 32-34

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

15.3 הפניה להדמיה למעקב אחרי ממצא הכנה לאישור רופא/ה

פניות מתאימות למענה מקוון

נקרא גם	הפניה לאולטרסאונד | הפניה ל-CT | מעקב ממצא | צילום חוזר
נימוק / הערה	המדריך מונה מעקב ממצא בהדמיה כפנייה מתאימה; ההפניה עצמה בהחלטת הרופא/ה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**אין סימני דחיפות**	יש ← לא עונים במקוון: הנחיה מיידית למוקד/מיון (101 בחירום) והודעה מיידית לרופא/ה.	התווית נגד
2	**הפנייה על המטופל/ת עצמו/ה**	פנייה על בן/בת זוג או בן משפחה בוגר מהחשבון שלך ← לא עונים לגופה; מבקשים לפנות מהחשבון של המטופל/ת.	התווית נגד
3	**המלצה כתובה למעקב**	אין המלצה כתובה ← לרופא/ה.	
4	**עברתי על הרשומה**	המדריך: מצפים לקרוא ולהתייחס לביקורים אחרונים, גורמי סיכון, רפואה מונעת ובדיקות. חוסר בולט ← לציין בהודעה לרופא/ה.	
5	**תיעוד כביקור**	ביקור וירטואלי הוא ביקור לכל דבר: מתעדים, רושמים SOAP כשרלוונטי ומכניסים אבחנה.	

מקור	המדריך למדריך עמ' 32-34

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

15.4 משוב על תוצאות בדיקות רופא/ה בלבד

פניות מתאימות למענה מקוון

נקרא גם	תוצאות בדיקות | תוצאות דם | מה יצא בבדיקות | פענוח בדיקות
נימוק / הערה	החלטה 3.11.2026: הרפואן לא משיב למטופל/ת על תוצאות. מסתכל/ת בתוצאות, משווה לבדיקות קודמות ומדווח/ת לרופא/ה
הנחיה	**לא עונים למטופל/ת על תוצאות. מסכמים את התוצאות עם השוואה לבדיקות קודמות ומעבירים לרופא/ה. תוצאות שקופצות בפתיחת התיק: רק "הפסק וסגור", לעולם לא "אשר".**

מקור	המדריך למדריך עמ' 32-34. הכלל "רק כשהכול תקין": החלטה מקומית (לדיון)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

15.5 אישורים וסיכום מידע רפואי מתאים

פניות מתאימות למענה מקוון

נקרא גם	אישור | סיכום מידע | אישור מחלה | טופס
נימוק / הערה	סיכום מידע לצרכים מנהלתיים מתאים; אישור מחלה ואחרים — לפי לשונית האישורים

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**אין סימני דחיפות**	יש ← לא עונים במקוון: הנחיה מיידית למוקד/מיון (101 בחירום) והודעה מיידית לרופא/ה.	התווית נגד
2	**הפנייה על המטופל/ת עצמו/ה**	פנייה על בן/בת זוג או בן משפחה בוגר מהחשבון שלך ← לא עונים לגופה; מבקשים לפנות מהחשבון של המטופל/ת.	התווית נגד
3	**תיעוד כביקור**	ביקור וירטואלי הוא ביקור לכל דבר: מתעדים, רושמים SOAP כשרלוונטי ומכניסים אבחנה.	

מקור	המדריך למדריך עמ' 32-34; חוזר 07/2024 (בלשונית האישורים)

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

15.6 בקשות חוזרות לאישורי מחלה רופא/ה בלבד

פניות שמסרבים להן

נקרא גם	אישורי מחלה חוזרים | שוב אישור מחלה
נימוק / הערה	המדריך: פניות חוזרות ונשנות לאישורי מחלה (מעבר לסביר) — מסרבים ומזמינים לביקור
הנחיה	**לא מפיקים במקוון. סירוב מנומק והזמנה לביקור; עדכון הרופא/ה.**

הודעה למטופל/ת	שלום, בשל פניות חוזרות בנושא, נדרש ביקור במרפאה כדי שהרופא/ה יוכל/תוכל להעריך את המצב ולתת את האישור המתאים. ניתן לקבוע תור דרך האפליקציה או מזכירות המרפאה.
מקור	המדריך למדריך עמ' 32-34

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

15.7 מרשם חדש שאינו תרופה קבועה רופא/ה בלבד

פניות שמסרבים להן

נקרא גם	מרשם חדש | אנטיביוטיקה | תרופה חדשה | מרשם ל
נימוק / הערה	המדריך: בקשה לא מנומקת למרשם שאינו תרופה קבועה — מסרבים
הנחיה	**הרפואן לא מפיק. מעבירים לרופא/ה; אם אין נימוק ברור — סירוב מנומק והזמנה לביקור.**

הודעה למטופל/ת	שלום, כדי לתת מרשם לתרופה חדשה הרופא/ה צריך/ה להכיר את הסיבה ולעיתים גם לבדוק. ניתן לקבוע תור (גם טלפוני או בווידאו) דרך האפליקציה או מזכירות המרפאה.
מקור	המדריך למדריך עמ' 32-34

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

15.8 תסמין או תלונה חדשים רופא/ה בלבד

פניות שמסרבים להן

נקרא גם	חום | כאב | שיעול | לא מרגיש טוב | תסמין
נימוק / הערה	המדריך: תסמינים שמחייבים אנמנזה ובדיקה (חום, כאבים, שיעול) — לא במענה מקוון
הנחיה	**קודם בודקים סימני דחיפות. אין ← סירוב מנומק והזמנה לביקור או לשיחה עם הרופא/ה. יש ← הנחיה מיידית למוקד/מיון והודעה לרופא/ה.**

תלונות בפנייה או ברשומה	חשד לאירוע לבבי או מוחי, קוצר נשימה, חום גבוה במיוחד ← דחוף: מוקד/מיון, 101 בחירום, הודעה מיידית לרופא/ה
הודעה למטופל/ת	שלום, כדי לטפל בתלונה כראוי נדרשים שיחה ובדיקה, ולכן לא ניתן לענות עליה במלואה בפנייה מקוונת. ניתן לקבוע תור (גם טלפוני או בווידאו) דרך האפליקציה או מזכירות המרפאה. אם מופיעים קוצר נשימה, כאב בחזה, חולשה בצד אחד של הגוף או החמרה משמעותית — יש לפנות מיד למוקד או לחדר מיון, ובחירום להתקשר ל-101.
מקור	המדריך למדריך עמ' 32-34

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

15.9 ממצא גופני או תמונה (פריחה, נגע) רופא/ה בלבד

פניות שמסרבים להן

נקרא גם	פריחה | תמונה | נגע בעור | נפיחות | שומה
נימוק / הערה	המדריך: פנייה בנוגע לממצאים גופניים (פריחה) — מסרבים
הנחיה	**הרפואן לא מעריך ממצא. מעבירים לרופא/ה (שמחליט/ה אם התמונה מספיקה) או מזמינים לביקור.**

הודעה למטופל/ת	שלום, הערכת הממצא שתיארת דורשת בדיקה של רופא/ה. ניתן לקבוע תור דרך האפליקציה או מזכירות המרפאה. אם הממצא מתפשט במהירות, מלווה בחום גבוה או בקושי בנשימה — יש לפנות מיד למוקד או לחדר מיון.
מקור	המדריך למדריך עמ' 32-34

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

15.10 אישור או טופס רפואי מורכב רופא/ה בלבד

פניות שמסרבים להן

נקרא גם	ביטוח לאומי | חברת ביטוח | טופס | נכות | חוות דעת
נימוק / הערה	המדריך: בקשה לאישור רפואי מורכב (מכתב לביטוח לאומי) — מסרבים
הנחיה	**רופא/ה בלבד, לרוב בביקור. הרפואן יכול להפיק סיכום מידע רפואי אם זה מה שנדרש (לשונית האישורים).**

הודעה למטופל/ת	שלום, מילוי הטופס דורש מעבר מעמיק על התיק עם הרופא/ה, ולכן נדרש ביקור. ניתן לקבוע תור דרך האפליקציה או מזכירות המרפאה, ולהביא את הטופס לביקור.
מקור	המדריך למדריך עמ' 32-34

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

15.11 פנייה רגשית או חברתית רופא/ה בלבד

פניות שמסרבים להן

נקרא גם	לחץ | דיכאון | חרדה | קשיים | מצוקה
נימוק / הערה	המדריך: סוגיות פסיכוסוציאליות פתוחות או חדשות — לא במענה מקוון
הנחיה	**לרופא/ה באותו יום. מחשבות אובדניות או סכנה לאחר ← דחוף: הודעה מיידית לרופא/ה.**

תלונות בפנייה או ברשומה	מחשבות לפגוע בעצמו/ה או באחרים ← דחוף: הודעה מיידית לרופא/ה; בחירום 101
הודעה למטופל/ת	שלום, תודה ששיתפת. חשוב לנו לשוחח על כך באופן אישי ולא בהודעה, ולכן הרופא/ה יחזור/תחזור אלייך או תתואם לך שיחה בהקדם. אם יש מחשבות לפגוע בעצמך או מצוקה קשה עכשיו — יש לפנות מיד למוקד, לחדר מיון או לער"ן 1201.
מקור	המדריך למדריך עמ' 32-34

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

15.12 פנייה בשם מטופל/ת אחר/ת רופא/ה בלבד

פניות שמסרבים להן

נקרא גם	בשם אשתי | בשם בעלי | בשביל אמא | עבור
נימוק / הערה	המדריך: אין לפנות בנוגע למטופל אחר מהחשבון שלך. הורה של קטין — מותר
הנחיה	**לא עונים לגופה. מבקשים לשלוח מהחשבון של המטופל/ת (או בהרשאה מתועדת).**

הודעה למטופל/ת	שלום, מטעמי סודיות רפואית, פנייה בעניין מטופל/ת אחר/ת צריכה להישלח מהחשבון של המטופל/ת עצמו/ה. נשמח לטפל בה משם.
מקור	המדריך למדריך עמ' 32-34

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

15.13 פנייה דחופה רופא/ה בלבד

פניות שמסרבים להן

נקרא גם	כאב בחזה | קוצר נשימה | חולשה פתאומית | דחוף
נימוק / הערה	המדריך: מקרים דחופים — לא במענה מקוון
הנחיה	**מיד: הודעה למטופל/ת לפנות למוקד או למיון (101 בחירום), והודעה מיידית לרופא/ה. מתעדים את השעה.**

הודעה למטופל/ת	שלום, התיאור בפנייתך מחייב הערכה רפואית מיידית. יש לפנות עכשיו למוקד או לחדר מיון, ובמקרה חירום להתקשר למד"א 101. הרופא/ה עודכן/ה.
מקור	המדריך למדריך עמ' 32-34

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

16. חיסונים

6 פריטים · מתאים: 5 · בתנאים: 1 · גרסה 1 · 3.11.2026

מקורות: ספר חפיפה עוזרי רופא; לאימות מול הנחיות משרד הבריאות ומכבי

16.א כללים

- בודקים זכאות לפי גיל וקבוצת סיכון, את המרווח מהמנות הקודמות (לשונית חיסונים בתיק) ואת המימון (סל או תשלום מלא)
- מטופל/ת שאינו/ה זכאי/ת בסל: אפשר לתת מרשם לרכישה פרטית, עם הסבר
- הפניה לאחיות נדרשת לחיסונים בזריקה — מלבד שינגריקס, שפעת וכלבת, שבהם קובעים תור לאחיות ישירות
- קבוצת סיכון לא ברורה או לא מתועדת: לרופא/ה
- תסמין חדש או סימן אזהרה בפנייה: לא מטפלים כבקשת חיסון, לרופא/ה

16.ב תוצאות אפשריות

תוצאה	נוסח בתיעוד
הופקו מרשם או הפניה לפי הפרוטוקול	תוצאה: הופקו מרשם או הפניה לחיסון לפי הפרוטוקול.
הוכן והועבר לרופא/ה	תוצאה: הבקשה הוכנה והועברה להחלטת הרופא/ה.
לא זכאי/ת או לא מתאים — הוסבר למטופל/ת	תוצאה: לא הופק. הוסבר למטופל/ת (זכאות, מרווח או אפשרות רכישה פרטית).
תסמין או סימן אזהרה — לרופא/ה מיד	תוצאה: לא טופל כבקשת חיסון. הועבר מיד לרופא/ה.

16.ג בדיקות משותפות

שלב	נושא	מה בודקים	קריטריון	אם לא מתקיים	מקור
לפני כל חיסון	זכאות	גיל וקבוצת סיכון מתועדת	לפי החיסון	לא זכאי/ת בסל ← מרשם לרכישה פרטית, או לרופא/ה אם לא ברור	ספר חפיפה
לפני כל חיסון	מנות קודמות	לשונית חיסונים בתיק	מרווח מתאים מהמנה הקודמת	לא מתאים ← לרופא/ה	ספר חפיפה
לפני כל חיסון	הפניה לאחיות	האם נדרשת	בזריקה — כן; שינגריקס, שפעת, כלבת — לא	—	ספר חפיפה

16.ד החלטות

#	נושא	מה ההנחיה אומרת	ההחלטה לפרוטוקול	סוג	מקור
1	לשונית חיסונים	-	הרפואן בודק זכאות, מרווח ומימון ומפיק מרשם או הפניה לפי החיסון	החלטה מקומית (3.11.2026)	ספר חפיפה
2	פרבנר	-	פרבנר 20 בלבד (מחליף את פרבנר 13 במבוגרים)	החלטה מקומית (3.11.2026)	ספר חפיפה

16.ה רשימת חיסונים (לסימון)

#	שם		קבוצה	התאמה	אושר	הערות
16.1	שינגריקס (שלבקת חוגרת)		חיסונים	מתאים	☐	
16.2	גרדסיל 9 (HPV)		חיסונים	מתאים	☐	
16.3	פרבנר 20 (דלקת ריאות)		חיסונים	מתאים	☐	
16.4	פנאומווקס 23		חיסונים	בתנאים	☐	
16.5	חיסון שפעת		חיסונים	מתאים	☐	
16.6	חיסון מונע כלבת (עבודה עם בעלי חיים)		חיסונים	מתאים	☐	

ו.16 פירוט מלא

16.1 שינגריקס (שלבקת חוגרת) מתאים

חיסונים

נקרא גם	שינגריקס | חיסון שלבקת חוגרת | הרפס זוסטר
נימוק / הערה	2 מנות בהפרש 2-6 חודשים. מרשם למנה הראשונה בלבד; למנה השנייה — מרשם נוסף. לא צריך הפניה לאחיות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין סימני דחיפות או תסמין חדש	תסמין חדש או סימן אזהרה ← לרופא/ה.	התוויות נגד
2	זכאות בסל	לא זכאי/ת בסל: אפשר מרשם לרכישה פרטית (בריאים מגיל 50, או מגיל 18 בסיכון אחר) — להסביר שבתשלום מלא.	
3	בדיקת פנקס החיסונים	נמצאה מנה קודמת שלא מתאימה למרווח ← לרופא/ה.	
4	מנה ראשונה או שנייה בזמן	מרווח לא מתאים ← לרופא/ה.	

הודעה למטופל/ת	שלום, הופק עבורך מרשם לחיסון שינגריקס (מנה ___). יש לקנות את החיסון סמוך למועד ההתחסנות ולקבוע בעצמך תור במרפאת האחיות (לא צריך הפניה). את המנה השנייה מקבלים 2-6 חודשים אחרי הראשונה — לפני כן יש לבקש מרשם נוסף.
מקור	ספר חפיפה עוזרי רופא (המרפאה לבריאות המשפחה, קרית אונו); לאימות מול הנחיות משרד הבריאות ומכבי העדכניות

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

16.2 גרדסיל 9 (HPV) מתאים

חיסונים

נקרא גם	גרדסיל 9 | חיסון פפילומה | HPV
נימוק / הערה	בנים ובנות בגיל 9-26. מרשם והפניה לאחיות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	אין סימני דחיפות או תסמין חדש	תסמין חדש או סימן אזהרה ← לרופא/ה.	התוויות נגד
2	גיל 9-26	מחוץ לטווח הגיל ← לרופא/ה.	
3	בדיקת פנקס החיסונים	נמצאה מנה קודמת שלא מתאימה למרווח ← לרופא/ה.	

הודעה למטופל/ת	שלום, הופקו עבורך מרשם לחיסון גרדסיל 9 והפניה לאחיות. ניתן לקבוע תור במרפאת האחיות.
מקור	ספר חפיפה עוזרי רופא (המרפאה לבריאות המשפחה, קרית אונו); לאימות מול הנחיות משרד הבריאות ומכבי העדכניות

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

16.3 פרבנר 20 (דלקת ריאות) מתאים

חיסונים

נקרא גם	פרבנר 20 | חיסון דלקת ריאות | פנאומוקוק
נימוק / הערה	גיל 65 ומעלה, או מגיל 18 בקבוצת סיכון גבוה. חד-פעמי, לפחות שנה אחרי חיסון פנאומוקוק קודם (פנאומווקס או פרבנר 13). מרשם והפניה לאחיות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**אין סימני דחיפות או תסמין חדש**	תסמין חדש או סימן אזהרה ← לרופא/ה.	התווית נגד
2	**גיל או קבוצת סיכון**	קבוצת סיכון לא מתועדת או לא ברורה ← לרופא/ה.	
3	**בדיקת פנקס החיסונים**	נמצאה מנה קודמת שלא מתאימה למרווח ← לרופא/ה.	
4	**לא קיבל/ה פרבנר 20, ועברה שנה מחיסון קודם**	כבר קיבל/ה, או לא עברה שנה ← לא מפיקים.	התווית נגד

הודעה למטופל/ת	שלום, הופקו עבורך מרשם לחיסון פרבנר 20 והפניה לאחיות. ניתן לקבוע תור במרפאת האחיות.
מקור	ספר חפיפה עוזרי רופא (המרפאה לבריאות המשפחה, קרית אונו); לאימות מול הנחיות משרד הבריאות ומכבי העדכניות

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

16.4 פנאומווקס 23 בתנאים

חיסונים

נקרא גם	פנאומווקס | חיסון דלקת ריאות 23
נימוק / הערה	לקבוצות סיכון גבוה מגיל שנתיים. במבוגרים שקיבלו או זכאים לפרבנר 20 — לרופא/ה

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**אין סימני דחיפות או תסמין חדש**	תסמין חדש או סימן אזהרה ← לרופא/ה.	התווית נגד
2	**קבוצת סיכון גבוה מתועדת**	אין ← לרופא/ה.	
3	**בדיקת פנקס החיסונים**	נמצאה מנה קודמת שלא מתאימה למרווח ← לרופא/ה.	
4	**לא מבוגר/ת שזכאי/ת לפרבנר 20**	מבוגר/ת שזכאי/ת לפרבנר 20 ← לרופא/ה.	

הודעה למטופל/ת	שלום, הופקו עבורך מרשם לחיסון פנאומווקס והפניה לאחיות. ניתן לקבוע תור במרפאת האחיות.
מקור	ספר חפיפה עוזרי רופא (המרפאה לבריאות המשפחה, קרית אונו); לאימות מול הנחיות משרד הבריאות ומכבי העדכניות

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

16.5 חיסון שפעת מתאים

חיסונים

נקרא גם	שפעת | חיסון שפעת
נימוק / הערה	מומלץ לכל מגיל 6 חודשים, ובמיוחד מגיל 50 ובקבוצות סיכון. לא צריך הפניה: המטופל/ת קובע/ת תור לאחיות

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**אין סימני דחיפות או תסמין חדש**	תסמין חדש או סימן אזהרה ← לרופא/ה.	התווית נגד

הודעה למטופל/ת	שלום, לחיסון שפעת לא צריך הפניה. ניתן לקבוע תור במרפאת האחיות דרך האפליקציה או מזכירות המרפאה.
מקור	ספר חפיפה עוזרי רופא (המרפאה לבריאות המשפחה, קרית אונו); לאימות מול הנחיות משרד הבריאות ומכבי העדכניות

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

16.6 חיסון מונע כלבת (עבודה עם בעלי חיים) מתאים

חיסונים

נקרא גם	כלבת | חיסון כלבת
נימוק / הערה	לעובדים עם בעלי חיים (וטרינרים, מאלפים, ספרי כלבים, סטודנטים לווטרינריה). לא צריך הפניה: הנחיות באתר מכבי

#	בדיקה	קריטריון ופעולה	סוג
1	**אין סימני דחיפות או תסמין חדש**	תסמין חדש או סימן אזהרה ← לרופא/ה.	התווית נגד
2	**חשיפה תעסוקתית**	חשיפה אחרי נשיכה או שריטה ← לא בקשת חיסון שגרתית: לרופא/ה מיד.	התווית נגד

הודעה למטופל/ת	שלום, לחיסון מונע כלבת לעובדים עם בעלי חיים לא צריך הפניה. ההנחיות לקביעת תור נמצאות באתר מכבי.
מקור	ספר חפיפה עוזרי רופא (המרפאה לבריאות המשפחה, קרית אונו); לאימות מול הנחיות משרד הבריאות ומכבי העדכניות

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____